

الجزء الأول

جريمة التعذيب

عَذِّبْ فِي طِفْلَتِهِ

عَذِّبْ فِي طِفْلَتِهِ

61

نيكلاس مولر

أخصائي نفسي مرخص، ومتخصص في العلاج النفسي/المعالجة النفسية ومعالج نفسي، كما يشغل منصب مدير مركز الصليب الأحمر السويدي لعلاج المتضررين من الحرب والناجين من التعذيب في أوبسالا، حيث يعمل في العلاج النفسي والتحقيق في إصابات التعذيب.

الفصل الأول

المقدمة

كُتبت هذه الأنطولوجيا في إطار مشروع البحث «الأطفال الذين نجوا من التعذيب». وتقدّم المقدمة خلفية موجزة عن مفهوم التعذيب ونشوء الوعي الطبي بالأطفال الذين يتعرضون للعنف. كما تناقش مفهوم التعذيب من منظور نفسي.

في التاريخ الأوروبي، أدخل التعذيب القضائي في شمال إيطاليا خلال القرن الثالث عشر بوصفه وسيلة مفيدة للتعرف إلى المذنبين. ومن هناك انتشر التعذيب القضائي إلى أجزاء واسعة من أوروبا (1). وخلال تلك الفترة انتقل الناس من السعي إلى اعتراف طوعي إلى انتزاع اعتراف، لا بالذنب، بل بتفاصيل ما اتُّهم به الشخص. وقد بُرّر ذلك بالعبارات: “no innocent person can know” («لا يمكن لأي شخص بريء أن يعرف ذلك على نحو معقول»). وكان يُمنع من تجري الاستجواب من طرح أسئلة إيحائية، أي من التلميح إلى الجرائم أو تقديم تفاصيل عنها. لكن اتضح عملياً أن ذلك صعب، إذ كان من الممكن نقل التفاصيل إلى المتهم، بوعي أو من دونه، الذي كان يذكرها تحت وطأة عذاب شديد.

استمر نقد التعذيب قرونًا، وخلال فترة امتدت خمسين عامًا بدأت في بروسيا سنة 2571، حُظر استخدام التعذيب القضائي في أوروبا كلها، ثم اقترح من جديد في مطلع القرن الحادي والعشرين، بعد ما يقارب مئتي عام، وهذه المرة بوصفه وسيلة لمكافحة الإرهاب، وسُمِّي «الاستجابات المعززة».

في ديسمبر 4102 اطلع العالم على مقتطفات من وثائق وكالة الاستخبارات المركزية نفسها، تصف كيف رُبط رجل إلى لوح، ورأسه أخفض من قدميه، ثم صُبَّ الماء في أنفه وفمه لإجباره على الإحساس بالغرق (2). كما وُضع في تابوت حالك السواد 662 ساعة، منها 92 ساعة في صندوق أصغر. وتذكر الوثيقة أن الرجل بكى وتوسل وأظهر توترًا شديدًا إلى درجة أنه لم يعد قادرًا على التواصل بفعالية. وعندما أُلقي القبض في السويد، في نوفمبر 9102، على حميد نوري، وهو موظف إيراني، بتهمة ارتكاب جرائم ضد القانون الدولي والقتل، سمعنا شهادات أشخاص عاشوا التعذيب في سجن غوهر دشت وإيفين في إيران. وبعد استيلاء السلطة في سوريا في ديسمبر 4202، شاهدنا عبر وسائل الإعلام صورًا وقصصًا عما تعرَّض له الناس في سجن صيدنايا. وللأسف، لا تُحصى الأمثلة التاريخية، وهي موجودة في أنحاء العالم، وبينما تقرأ هذه السطور تُضاف أمثلة جديدة...

... والآن. والآن. والآن.

كان المعنى الأصلي التاريخي للتعذيب يقوم على إيلاء الإنسان جسديًا لحمله على الاعتراف بجرائم خطيرة أو كشفها. وعندما اعتُمدت اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تُسمَّى غالبًا إساءة المعاملة، عام 4891، عرِّف التعذيب قانونيًا، فتغيَّر معناه (3):

المادة 1

1. لأغراض هذه الاتفاقية، يُقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول منه، أو من شخص ثالث، على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه هو أو شخص ثالث أو يُشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث، أو لأي سبب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه، عندما يلحق هذا الألم أو العذاب أو يُحرَض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية. ولا يشمل التعذيب الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لها.

إن التعريف مصوغ بصورة مفتوحة نسبيًا، بعبارات مثل العذاب الجسدي أو النفسي الشديد، ولا يقتصر وصف الغرض فيه على الوصول إلى اعترافات، بل يمكن أن يكون الغرض هو العقاب. ومع ذلك، يواجه العامة والمهنيون على السواء صعوبة واضحة في التعامل مع ما صيغ فعلًا في التعريف، ويميلون إلى العودة إلى المعنى التاريخي الأصلي: موظف يجبر شخصًا على الاعتراف باستخدام أساليب مختلفة لإحداث ألم جسدي.

جريمة يصعب الإمساك بها

نعلم أن التعذيب يُبلَّغ عنه في غالبية بلدان العالم (4). ولا توجد أرقام دقيقة لعدد الأفراد المتضررين، لكن الشهادات تعطينا صورة عن شيوعه الشديد في بعض الأماكن. وقد أفاد المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب (TCRI) بأن أكثر من ثمانين ألف شخص غرض عليهم العلاج من إصابات التعذيب خلال عام 4202، وهو ما يعطينا تصورًا عن الحجم (5). وتأتي هذه البيانات من المراكز المنتشرة في العالم والمنسوبة إلى المنظمة.

معظم هذه المراكز مؤسسات صغيرة تعتمد على تمويل يصعب الحصول عليه بصورة متزايدة. وهي لا تغطي إلا جزءاً ضئيلاً من الحاجة القائمة. ومن المؤكد أن العدد غير المبلغ عنه من المتضررين كبير.

ويصعب جمع بيانات عن انتشار التعذيب لأن المفهوم مرتبط بشدة بالأشخاص الذين يفرّون من بلدانهم، ولذلك تخلط الدراسات المتعلقة بهذه الفئة عادة بين الحرب والفرار والتعذيب. وهناك تحدٍ آخر يتمثل في الإمساك بالتعذيب مفاهيمياً، وفي أوجه القصور الكامنة في المفهوم عند تحويله إلى متغيرات وقياسه (6). ومن أمثلة النقد صعوبة تحديد المقصود بالعذاب الشديد وبنية الجاني. وتشدد المادة الأولى من الاتفاقية على مقاصد الجاني (3):

...any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes...

«...أي عمل يُلحق عمداً بشخص عمداً شديداً أو عذاباً شديداً، جسدياً كان أم عقلياً، لمثل تلك الأغراض...».

في الإنجليزية، وهي إحدى اللغات التي صيغ نص الاتفاقية بها أصلاً، تُستخدم كلمتا *pur- and intentionally*؛ وتقابلهما في الترجمة السويدية كلمتا «عن وعي» و«الغرض». وربما لا تلتقط كلمة «عن وعي» معنى كلمة «نية» تماماً، ولعل «عمداً» أنسب. وتأتي كلمة *intention* من اللاتينية *intentio*، بمعنى المدّ أو التصويب نحو شيء، بينما تأتي *purpose* من الفرنسية القديمة *porpos* بمعنى التصويب أو النية. وتُستخدم الكلمتان غالباً بمعنى مترادف، وحتى إن أمكن التمييز بينهما فهما وثيقتا الصلة.

هل يكون الغرض ذا صلة عند تقييم بلوغ موقف ما معايير التعذيب، حين نستطيع إثبات أن الأفعال متعمدة؟ وهل يمكن إلحاق الألم أو العذاب بشخص آخر عمداً من دون غرض الإيذاء؟ وهل لذلك أهمية، ولمن؟ هل تستطيع «النوايا الحسنة» تبرير إساءة المعاملة؟ وإذا رأت دولة ذلك، فهل لا يبلغ الأمر حد التعذيب في هذه الحالات؟

من المرجح أن كثيرًا من الانتهاكات التي تستوفي معايير التعذيب بُرِّرت بأن الأفعال تهدف أولاً إلى المساعدة، كما في التربية داخل الأسرة، ورعاية الأحداث، والمدارس، وتصحيح أسلوب الحياة أو المعتقدات الدينية أو التوجه الجنسي، أو في الرعاية الصحية، من مختلف أشكال التدابير القسرية إلى استئصال الفص الجبهي للدماغ بوصفه مثالاً تاريخياً. كل ذلك بغرض المساعدة.

«استئصال الفص الجبهي... تُجرى العملية للمصابين بالجنون المشاغبين والمزعجين، ولذلك يصعب الاعتناء بهم. يُحدث ثقب عند الصدغ ويُقطع الفص الأمامي للدماغ من الجانبين عبر هذا الثقب. ثم تتغير نفسية المريض... ويصبح بعد ذلك مبتهجاً نسبياً، ويظهر غالباً تحسناً ملحوظاً في حالته. ويكون متعاوناً ومعقولاً إلى حد ما» (7).

ما استئصال الفص الجبهي في عصرنا؟ حتى لو وجدنا مبرراً لإيلاء إنسان آخر من أجل بلوغ أمر نراه أكثر إلحاحاً، فهذا لا يعني أن الفعل لا يستوفي معايير التعذيب، بل يعني فقط أن هذه الأفعال عُذِّت أولوية أعلى. وينبغي منطقياً أن تبقى الجريمة قائمة، وكذلك العقوبة. ومن ثم يصعب تبرير الغرض، أي سبب تنفيذ الفعل، بوصفه معياراً للتعذيب.

والآن.

ألم شديد أو عذاب شديد

على مدى أربعة عقود، التقينا ناجين من التعذيب وعالجناهم في مركز الصليب الأحمر السويدي لعلاج المتضررين من الحرب والناجين من التعذيب. وتفيد الخبرة بأن أشد ما يسبب الألم هو التجربة النفسية المتمثلة في سلب السيطرة على الوضع. ويكتب ديفيد بارلو، أستاذ علم النفس والمرجع في البحث النفسي حول القلق، أن السيطرة أو غيابها هي الآلية الكامنة وراء القابلية للإصابة باضطراب نفسي (8).

إن تجارب العجز وانعدام السيطرة والقدرة على التنبؤ عوامل مركزية في نشوء الضغط النفسي الناجم عن الصدمة (9). وقد بينت الدراسات منذ زمن طويل كيف يتأثر الناس في أوضاع الضغط الذي لا يمكن التحكم فيه، والذي يميل إلى أن يؤدي إلى العجز المتعلم، حتى لاحقاً أمام أوضاع كان من الممكن التحكم فيها (01). ويعني العجز المتعلم، بالتالي، توقع أن يكون الوضع غير قابل للتدبير.

إن التقييم المستمر لوضع صادم سبق عيشه بوصفه خطراً أو تهديداً يزيد أثره الصادم، ويميل من تعرّض للصدمة إلى توقع متزايد لمواجهة أوضاع صادمة منفردة مماثلة في المستقبل (11). وهذا الخوف التوقعي مركزي في الاستجابات للأحداث الصادمة.

والآن. والآن.

مفهوم التعذيب عابر للتخصصات، ويشمل عوامل قانونية ونفسية. وقد صاغ باو بيريز-سالييس، الطبيب النفسي ورئيس تحرير مجلة *Torture Journal* والباحث في الصحة النفسية أثناء العنف السياسي والكوارث، في كتابه *Psychological Torture* تعريفاً نفسياً للتعذيب استناداً إلى مقابلات مع ناجين من التعذيب (6):

التعذيب شكل من أشكال التلاعب بالإنسان، من خلال بث الرعب الناجم عن الألم والإصابة، وسلب الفرد السيطرة على وظائف جسده، والتلاعب بالزمن والبيئة والانطباعات الحسية، بهدف تحطيم الفرد، وبث الخوف فيه، ومعاقبته جسدياً أو نفسياً، وإجباره على تقديم معلومات، وانتزاع إدانة ذاتية منه (ملاحظة المؤلف: تعني الإدانة الذاتية ألا يُجبر المشتبه في ارتكابه جريمة على الإسهام في إدانته بإعطاء معلومات ترجمه)، أو تغيير هوية المحروم من هويته أو نظرتة إلى العالم لتتوافق مع إرادة الجاني.

حتى وإن كان الجاني هو من يضع القواعد، يُعاش التعذيب بوصفه صراعًا جسديًا وفكريًا وعاطفيًا مع الذات، يترك آثارًا دائمة في الفرد، غالبًا في صورة ذنب وعار وذكريات متكررة وآلم محفور في الجسد.

وخلاصة القول، يبدو أن الأفعال «القاسية واللاإنسانية والمهينة»، إلى جانب الإحساس بتهديد الصحة الجسدية والنفسية في بيئة عدائية لا يمكن التحكم فيها، هي العوامل الرئيسية وراء الضرر النفسي المستمر لدى الأشخاص المحرومين من حريتهم. لذلك ينبغي أن تستند الاعتبارات المتعلقة بما يشكل تعذيبًا أثناء الاحتجاز إلى تقييم مدى إسهام هاتين العمليتين كلتيهما في الخوف والعجز لدى الأفراد، لا إلى افتراضات مسبقة عن الأثر النسبي لأساليب منفردة.

وبناءً على هذا التعريف، لا يمكن مساواة التعذيب بالألم، لأن الألم ليس سوى عنصر واحد من عدة عناصر لإثارة الخوف. ومن المتعذر حصر الجريمة في أساليب تعذيب محددة، لأن المجال لا ينفد. والأفضل فهم التعذيب بوصفه وضعًا يبحث فيه الجاني عن حدود الشخص الواقع تحت سيطرته. ويستخدم بيريز-ساليس مفهوم torturing environments («بيئات التعذيب») للابتعاد عن «أساليب التعذيب».

ويشكك بيريز-ساليس في أن الفصل بين التعذيب وإساءة المعاملة يقع على مقياس معين، حيث يقع إلحاق الألم في الطرف الأعلى (التعذيب)، بينما تقع الإهانة في الطرف الأدنى (إساءة المعاملة)، ويشير إلى شهادات تفيد بأن العنف النفسي بدرجة أكبر يؤدي إلى عواقب أشد تدميرًا من العنف القائم على إلحاق الألم (6). ويرى أن التركيز على شدة العذاب وسيلة للتمييز بين إساءة المعاملة منخفضة المستوى والتعذيب مرتفع المستوى أمر غير مفهوم، لأن الأوضاع تؤثر في الأفراد بطرق مختلفة.

وبما ينسجم مع ذلك، نشر أستاذ الطب النفسي متين باشو غلو، الرئيس السابق لقسم دراسات الصدمة في معهد الطب النفسي وعلم النفس وعلوم الأعصاب في كينغز كوليدج لندن، ومؤسس ومدير مركز إسطنبول للعلوم السلوكية، دراسة تُظهر أن الألم في حد ذاته لا يرتبط مباشرة بالاستجابات الصدمية بعد حدث شديد، وأن الفصل بين التعذيب وإساءة المعاملة متعذر عملياً، كما يتعذر الفصل بين التعذيب الجسدي والنفسي؛ فكل عذاب نفسي (21). العذاب حدث نفسي. ومن الصعب معرفة مسبقاً كيف سيعيش شخص ما وضعاً أو كيف سيتأثر به لاحقاً، لأن عوامل فردية كثيرة تدخل في الأمر.

ويرى باشو غلو أيضاً أننا بحاجة إلى الابتعاد عن «الأساليب» المحددة، وفهم أن التعذيب يشمل عوامل كثيرة تزيد خطر العذاب (21). يمكننا افتراض أنه إذا تحقق العامل A، مثل الحرمان الحسي، نتج العامل B، أي انخفاض السيطرة وازدياد الضغط. وما يميز وضع التعذيب أن عوامل متعددة تتفاعل وتؤثر في شدة التجربة: في X (السجن)، و Y (عصابة العينين)، و Z (همس شخص: «هل سبق أن اغتُصبت؟»). وقد تبدو هذه السلسلة مخيفة بلا شك لكل قارئ لهذا النص، لكنها لا تبلغ بالضرورة معايير التعذيب، وقد تُسمى بدلاً من ذلك معاملة قاسية أو لإنسانية أو مهينة، أو إساءة معاملة كما يُلخّص الأمر أحياناً. وهذا يكشف قصور التعريفات السائدة التي تضع التعذيب وإساءة المعاملة في درجتين مختلفتين من الخطورة.

... والآن...

عندما يخترق طرف خارجي، في سياق محدد، حاجز جلدك ويسيطر عليك، ويسلبك تجربة أن تكون إنساناً ويستخدمك شيئاً، فإن الوضع يكون مخيفاً للغاية ومزعجاً للاستقرار، ويرجح أن يؤدي إلى الصدمة.

قد يبدو من غير ذي صلة تعقيد الحدود الفاصلة بين التعذيب وإساءة المعاملة، لكن تسمية الأحداث وكيف نسميها، أي آثار التسمية، تؤثر في موقفنا منها. فقد أجريت دراسة تغيّرت فيها المواقف من التعذيب عندما استُبدل المفهوم بعبارة «الاستجابات المعززة»، وهي عبارة استُخدمت في الولايات المتحدة في مطلع القرن الحادي والعشرين (31). وينطبق الشيء نفسه على الأرجح على تصنيف إساءة المعاملة.

وفي الوقت ذاته، من المهم ألا يُفَرَّغ المفهوم من مضمونه عندما يُستخدم منفصلاً عن التعريفات المختلفة، فينتهي إلى شكل معين من العنف، هو العنف الشبيه بالتعذيب. ويُعطى وزن مفرط لشكل العنف المحدد، وتوصف هذه الأشكال غالباً بأنها أساليب تعذيب، فيُختزل التعذيب من كونه وضعاً خاصاً جداً (X، Y، Z) إلى أفعال عنف نمطية معينة (Z).

إن تعداد الطرق المختلفة التي يمكن بها إيذاء جسد إنساني لا ينتهي، فضلاً عن أنه يحتاج إلى تحديث مستمر، ولا يبدو عملياً في جوهره. وحتى لو كان ممكناً، فلن يلتقط التعذيب قط، بل سيصف أفعال عنف مختلفة فحسب. وفي أسوأ الأحوال، قد يقدّم حجة على أن تجريم التعذيب وطنياً غير ضروري، لأن أفعال العنف مجرّمة أصلاً، مثل الدرجات المختلفة من الاعتداء.

وبدلاً من ذلك، ينبغي فهم المفهوم بوصفه وضعاً، وإيلاء الأهمية للسياق والوظيفة. ويكتب باشو غلو:

«وخلاصة القول، يبدو أن الأفعال القاسية واللاإنسانية والمهينة، والإحساس بتهديد الصحة الجسدية والنفسية في بيئة عدائية لا يمكن التحكم فيها، هما العاملان الرئيسيان وراء الضرر النفسي المستمر لدى المحرومين من حريتهم. لذلك ينبغي أن تستند الاعتبارات المتعلقة بما يشكل تعذيباً أثناء الاحتجاز إلى تقييم مدى إسهام هاتين العمليتين في الخوف والعجز لدى الأفراد، بدلاً من افتراضات مسبقة عن الأثر النسبي لأساليب منفردة» (21).

وفيما يتعلق بالأطفال الذين ينجون من أوضاع تستوفي معايير التعذيب، فالمعلومات محدودة. ويخاطر الأطفال بالتعرض لبينات تعذيب في سياقات فريدة خاصة بهم. وقد جرت محاولات لفهم ماهية هذه البينات، لكنها تميل إلى التوقف عند العنف البالغ القسوة والمنهجي والممتد، من دون حل مسألة مشاركة الدولة، وهي جزء مركزي من تعريف التعذيب في الأمم المتحدة (41). ومن دون إدراج الدولة في التعريف، قد يصعب تقديم حجة تميز التعذيب من الاعتداء الجسيم أو الاغتصاب أو أفعال العنف الأخرى المجرّمة. وحتى في هذه الأدبيات، قد يظل الوصف عالقاً في العنف الجسدي المحدد والشديد، أي في الأساليب.

وتحظى كيفية تفسير عبارة «شخص يتصرف باسم الدولة»، الواردة في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، باهتمام خاص. ففي قضية بارزة عام 7102، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن الشخص الذي يعمل في منظمة تؤدي وظائف شبيهة بوظائف الحكومة على إقليم وسكان مدنيين يمكن اعتباره مستوفياً لمعايير التصرف في دور رسمي، سواء أكانت المنظمة حكومية أم غير حكومية، وسواء وقع ذلك في زمن الحرب أم السلم (51).

أصبح الحكم اليوم سابقة توسّع تفسير من يمكن تحميله المسؤولية، وأدى إلى نقاش مستمر حول كيفية تطبيق التعريف ومحل التركيز: على وضع الجاني أم على طبيعة الفعل. فمن يمكن اعتباره جانيًا وفق التعريف: فاعلاً من الدولة، أم فاعلاً غير حكومي ذي سيطرة شبيهة بالحكومية، أم فاعلاً ذا سيطرة أو سلطة فعالة بغض النظر عن صلته بالدولة (61)؟

وتتبع ذلك أسئلة عن وقوع جماعات مختلفة في بيئات تعذيب مختلفة. كيف يبدو الأمر بالنسبة إلى النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال؟ كيف نفهم أوضاع الرعاية القسرية التي قد يُجبر فيها أفراد، خلافاً لإرادتهم، على إجراءات مخيفة ومؤلمة؟ وماذا عن المدرسة، حيث قد يصبح الطفل عرضة لسخرية المعلم أمام التلاميذ الآخرين أو لتدابير قسرية أخرى؟ كيف نفهم الأوضاع التي يتعرض فيها الطفل للعنف مباشرة أو يشهد تعرض أحد الوالدين له؟ وكيف نفهم الأوضاع التي يُفصل فيها الأطفال عن والديهم؟ هل يُعد وضع أطفال في الثالثة عشرة من العمر في السجن بيئة تعذيب؟ وفي مراكز الإعادة التي أنشئت في السويد خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع التغييرات الكبيرة في سياسة الهجرة، أبلغ عن أوجه قصور مقلقة فيما يخص حماية الأطفال (71). عندما يصف الأطفال والأسر بيئة يشعرون فيها بعدم الأمان والخطر، ويخشون بالغين مجهولين يعانون نفسياً، وحين لا تكون الأماكن التي تقيم فيها الأسر أحياناً مدة طويلة ملائمة للأطفال، فكيف نفهم هذه البيئات؟ ... الآن...

العنف ضد الأطفال: وعي طبي جديد

نعلم أن الأطفال يوضعون في بيئات تعذيب، ليس هناك فحسب بل هنا أيضاً، وأن المعرفة بهذه البيئات قاصرة. ونقع على عاتقنا، نحن العاملين في الرعاية والخدمات الاجتماعية، مسؤولية كبيرة في طرح الأسئلة والتعرّف إلى الحالات وتوثيقها ومتابعتها عندما نلتقي أطفالاً تعرضوا للعنف، لا في سياق الأسرة فقط، بل أيضاً في البيئات التي يكون فيها الأطفال تحت سلطة الآخرين.

وتتوافر الشروط لأن لدينا اليوم واجبات رسمية بالإبلاغ عند القلق من تعرض الأطفال للأذى، نتيجة عمل طويل لرفع مستوى المعرفة. وفي عام 2691 صيغ في مقال راند مفهوم «متلازمة الطفل المُعْنَف» (SCB) (81). ومهد المقال لفهم أن الأطفال كانوا يتعرضون للعنف بمعدل أكبر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا؛ فحتى ذلك الوقت كان إساءة معاملة الأطفال تُعد في الطب أمرًا غير شائع غالبًا. وقد لفت المقال انتباه القراء، الذين نفترض أنهم كانوا أطباء لأنه نُشر في مجلة طبية، إلى أن المهنيين كانوا كثيرًا ما يفتوتون علامات العنف بسبب الجهل والمحظورات.

كان للمقال أثر هائل في ذلك الوقت، وأسهم بقوة في الفهم الطبي والاجتماعي الحالي لإساءة معاملة الأطفال، وأدى في نهاية المطاف إلى سن قوانين إلزامية للإبلاغ في بلدان كثيرة، وإنشاء سلطات لحماية الطفل، ووضع إرشادات للمهنيين. كما منح هذا العمل شرعية طبية للتعرف إلى العنف ضد الأطفال والإبلاغ عنه. ونقل كذلك مسألة العنف ضد الأطفال من اعتبارها شأنًا عائليًا خاصًا إلى مشكلة معترف بها في الصحة العامة والمجتمع، فغيّر أساليب العمل في الرعاية الصحية وأدى إلى انفجار في البحث. ويركز المقال على العنف الجسدي، لكنه يسمي إهمال الرعاية شكلاً من أشكال العنف، وهو ما لم يكن شأنًا في الأدبيات الطبية آنذاك.

وينبغي ذكر أن جون بولي نشر قبل ذلك بأكثر من عقد، عام 1591، بتكليف من منظمة الصحة العالمية، دراسة استعراضية عن تأثير الأطفال بالانفصال عن مقدمي الرعاية الأساسيين (91). وبما أن النص يبلغ من العمر 57 عامًا، فهناك أمور كثيرة يمكن انتقادها اليوم، لكن نتائجه أدت إلى مراجعة أوضاع الأطفال أثناء الإقامة في المستشفيات وفي مؤسسات دور الأيتام، إذ أظهرت النتائج أن الانفصال عن مقدمي الرعاية، وهم الوالدان عادة، يؤثر سلبيًا جدًا في حال الأطفال ووظائفهم.

يرى كثيرون أن متلازمة الطفل المُعَنَّف كانت حدثاً أسهم في واجب الإبلاغ والتشريع، وكذلك في النظر إلى الأطفال بوصفهم أصحاب حقوق خاصة بهم. وبالتزامن المباشر مع ذلك، تأسست عام 7791 منظمة الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم (NACPSI)، حيث اجتمع الباحثون والأطباء والأخصائيون الاجتماعيون والمحامون لفهم العنف ضد الأطفال ومنعه وعلاجه (02). وأصبحت الجمعية حلقة الوصل بين الاكتشاف الطبي وتطوير السياسات الدولية.

وفي عام 9891 اعتُمدت اتفاقية حقوق الطفل (12)، وهي اليوم إحدى أكثر وثائق الحقوق تصديقاً في العالم، ويمكن النظر إليها بوصفها النتيجة القانونية لعقود من البحث الطبي والاجتماعي، وقد أسهم مقال عام 2691 بقوة في مادتها 91:

1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية، والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، ما دام الطفل في رعاية الوالدين أو أحدهما أو الوصي القانوني أو أي شخص آخر يتعهد رعايته.

2. ينبغي أن تشمل تدابير الحماية، حيثما اقتضى ذلك، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية توفر الدعم اللازم للطفل ولمن يتعهد رعايته، وكذلك لأشكال الوقاية الأخرى، ولتحديد حالات سوء معاملة الأطفال والإبلاغ عنها وإحالتها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها، وللتدخل القضائي عند الاقتضاء.

تنص المادة 73 من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي:

لا يجوز إخضاع أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو للعقاب أو للإعدام. ولا يجوز حرمان الطفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ولا يجوز أن يُستخدم ذلك إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة مناسبة (22).

أما اتفاقية مناهضة التعذيب (3)، التي اعتمدت قبل اتفاقية حقوق الطفل ببضع سنوات، فلا تستهدف الأطفال تحديدًا، لكن البحث الذي أعقب متلازمة الطفل المُعْتَفَّ أسهم في توسيع فهم ما يشكل إساءة معاملة، وهو ما يؤثر في تفسير اللجنة للحماية الخاصة للأطفال.

نعرف اليوم العواقب التي يمكن أن يؤدي إليها العنف أثناء الطفولة. وفي مقال رائد آخر صيغ مفهوم «تجارب الطفولة السلبية» (ECA) (22). وتُعد دراسة ECA أكبر دراسة دولية أجريت لفحص انتشار التجارب السلبية أثناء الطفولة وصلتها بالصحة في مرحلة البلوغ. وقد كررت دراسات جديدة دراسة ECA وحصلت على النتائج نفسها. وتشير ECA إلى adverse childhood experience، وتشمل هذه التجارب، من بين أمور أخرى، التعرض للعنف أو مشاهدته، والتعرض للاعتداء الجنسي، والانفصال عن أحد الوالدين بسبب الطلاق أو الاحتجاز أو الفرار أو الوفاة. ويحصل الشخص على نقطة ECA عن كل فئة عاشها.

وتظهر هذه الدراسات علاقة قوية بين عدد تجارب ECA التي عاشها الشخص قبل سن الثالثة وبين سلوكيات الخطر اللاحقة، والمرض النفسي، والإدمان، والمرض الجسدي، أي إن عدد تجارب ECA يرتبط بكل اعتلال صحي. ولدى الأطفال الذين عاشوا ست تجارب ECA أو أكثر انخفاض متوقع في متوسط العمر بمقدار عشرين عامًا. ويمكن تفسير العواقب الصحية بتأثيرها في نظام الضغط لدى الفرد (محور الوطاء-النخامة-الكظر)، إذ يمكن للضغط المزمن أثناء الطفولة أن يؤثر في نمو الدماغ والجهاز الهرموني والمناعة، وأن يسهم في الالتهاب (32).

الأطفال الذين نجوا من التعذيب

من البديهي أن نمنع وضع الأطفال في بيئات تعذيب، وأن نحاسب الجناة، ونحدد الأطفال المتضررين، ونضمن حصولهم على الإنصاف والدعم والعلاج المناسبين. ومع ذلك، لا تزال المعرفة في هذا المجال ناقصة جدًا. ومن ثم فمن المهم مواصلة العمل الذي بدأ في منتصف القرن الماضي لزيادة المعرفة بتعرض الأطفال للأذى واحتياجاتهم. وفي هذه الأنطولوجيا ستطلع على مشروع بحثي بعنوان «الأطفال الذين نجوا من التعذيب»، بدأ عام 2202 بدراسة منهجية للأدبيات بهدف تركيب البحوث والأدبيات غير المنشورة المتعلقة بالكشف والتوثيق ورعاية إصابات التعذيب لدى الأطفال (42).

اقرأ التقرير الأول في المشروع

تامجدبيدي ر، نالين بوز سي. الأطفال الذين نجوا من التعذيب: مراجعة منهجية للأدبيات حول الكشف والتوثيق وعلاج الأطفال المصابين بإصابات التعذيب. مركز الصليب الأحمر للخبرة في إعادة تأهيل المصابين بالتعذيب والحرب؛ 3202. التقرير 4:3202.

تُظهر نتيجة دراسة الأدبيات أن كثيرًا من أدوات الكشف القائمة للأحداث المسببة للصدمة النفسية قاصرة عن تحديد الأطفال الناجين من التعذيب، لأن أدوات كثيرة تفتقر إلى أسئلة عن الفاعلين، مما يصعب تحديد تورط الدولة، وهو معيار مركزي وفق تعريف اتفاقية مناهضة التعذيب. كما تضمنت عدة استمارات في الدراسة مفهوم التعذيب، مما يزيد خطر النتائج المنحرفة، سواء في صورة إجابات إيجابية كاذبة أم سلبية كاذبة.

أما في توثيق إصابات التعذيب لدى الأطفال، فكانت الإصابات الجسدية وحدها هي التي توثق عادة. وهذا رغم علمنا بأن العواقب النفسية للعنف واسعة ومقيدة للحياة؛ ولذلك من المهم أن يشمل التوثيق فحصًا جسديًا ونفسيًا على السواء، لضمان تقليل خطر التقييمات الخاطئة.

عندما يُحدّد طفل ويُفحص، يصبح من المهم أيضاً أن نتمكن من رعاية الإصابات والاحتياجات التي نشأت نتيجة بيئة التعذيب. وتبيّن دراسة الأدبيات أن العلاج السلوكي المعرفي المركز على الصدمة يحقق نتائج واعدة للأطفال في الدراسات، وقد تعرض بعضهم للتعذيب. كما يمكن أن يكون العلاج المكثف للصدمة فعالاً، وهو ما قد يكون ذا صلة خاصة بالأطفال الذين يعيشون في أوضاع غير مستقرة وغير آمنة. وبناءً على استنتاجات دراسة الأدبيات، صُممت المشاريع المعروضة في هذا التقرير بهدف تحسين قدرتنا على اكتشاف الأطفال الذين نجوا من التعذيب وتوثيق حالاتهم ومساعدتهم بأفضل طريقة ممكنة.

... والآن.

المراجع

1. The history of torture. HJ niebgnal. في: S nosniveL، محرر. Torture: a collection. الولايات المتحدة: مطبعة جامعة أكسفورد؛ 4002.
2. Two psychologists' role in CIA torture program comes into focus. JW naginneH، J inafnaT. Los Angeles Times [الإنترنت]. 41 ديسمبر 4102. [تم الاطلاع في 61 أبريل 6202]. متاح من: <https://www.vivalanka.com/newspage/807707ai-two-psychologists-role-cia-torture-program-focus>
3. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. الأمم المتحدة. نيويورك: الأمم المتحدة؛ 4891.
4. منظمة العفو الدولية. Torture in 2014: 30 years of broken promises. لندن: منظمة العفو الدولية؛ 4102.
5. المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب (TCRI). التقرير السنوي 4202.
6. Psychological torture: definition, evaluation and measurement. P selaS-zeréP. نيويورك: روتليدج؛ 7102.
7. Svenska Röda Korsets medicinska uppslagsbok. محرر. G greblhaD، A. P. ستوكهولم: renöS hco tdetsroN. 6591.
8. Anxiety and its disorders: the nature and treatment of anxiety and panic. HD wolraB. الطبعة الثانية. نيويورك: HD wolraB، sserP drofliuG. 4002.
9. Trauma, dissociation and post-traumatic stress disorder. A ecnirPeD، MD naolS، PB xraM، MT enaeK. في: HD wolraB، محرر. The Oxford Handbook of Clinical Psychology. مطبعة جامعة أكسفورد؛ 0102.
10. Effects of inescapable shock upon subsequent escape and avoidance. PEM namgileS، BJ reimrevO. J Comp Physiol Psychol. 33-82:(1)36؛ 7691.
11. Behavioral/cognitive conceptualizations of post-traumatic stress. OB muabhtoR، G eeteketS، BE aoF. Behav Ther. disorder. 671-551:(2)02؛ 9891.
12. A multivariate contextual analysis of torture. M ulğöşab. Am J Orthopsychiatry. 541-531:(2)97؛ 9002.
13. Shaping responses to torture. D ikswokhcsiM، K soiR. Pers Soc Psychol Bull. 649-439:(6)54؛ 9102.
14. Child Torture as a Form of Child Abuse. LS alupaiT، DL reisarF، DN ggoleK، WK namdleF، PS gnilaratS، LB xonK. Journ Child Adol Trauma. 94-73:7؛ 4102.
15. R v Reeves Taylor [2017] UK Supreme Court.
16. Torture by non-state actors. G iloM eL. J Int Crim Justice. 193-363:(2)91؛ 1202.
17. جمعية إنقاذ الأطفال تنتقد سكن الأطفال التابع لمصلحة الهجرة. Dagens Nyheter.
18. The battered-child syndrome. HC epmeK وآخرون. JAMA. 42-71:181؛ 2691.
19. Maternal care and mental health. J yblwoB. Bull World Health Organ. 435-553:3؛ 1591.
20. الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم (NACPSI).
21. الأمم المتحدة. اتفاقية حقوق الطفل. اليونسيف السويد.
22. FR adnA، JV ittileF وآخرون. دراسة ECA. Am J Prev Med. 852-542:(4)41؛ 8991.
23. Maltreated infants and toddlers: Predictors of developmental delay. PR htraB، CE dyoL، AA hguorobracS. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics. 894-984:(6)03؛ 9002.
24. C esoB nélhaN، R idijdmaT. الأطفال الذين نجوا من التعذيب. التقرير 4:3202.

عُذِّبَ فِي طِفُولَتِهِ

43

مادلين سيدليتز هي محامية متخصصة في حقوق الإنسان، تركز على القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي العام. وقد عملت، من بين أمور أخرى، مستشارة أولى مسؤولة عن قضايا اللاجئين والهجرة وقضايا القانون الدولي في القسم السويدي من منظمة العفو الدولية.

الفصل الثاني ما الذي يشكل تعذيبًا للأطفال؟

تتمثل البيئات التي يرتفع فيها خطر تعرض الأطفال للتعذيب بوجه خاص في الحروب والنزاعات، والفرار والهجرة، والاتجار بالبشر والاحتجاز، ومراكز التوقيف والسجون وغيرها من البيئات المغلقة. وتقتضي قابلية الأطفال الخاصة للتعرض للأذى أن تتحمل السلطات العامة مسؤولية أكبر في حماية من تعرضوا للأذى وضمان التعرف إليهم بوصفهم ضحايا جرائم. لكن ما الذي يشكل تعذيبًا للأطفال؟

[صفحة أصلية 53]

هذا الفصل مقدمة قصيرة إلى المفهوم القانوني للتعذيب، مع التركيز على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وما يمكن أن يشكل تعذيباً فيما يتعلق بالأطفال. ويشمل مفهوم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (إساءة المعاملة). ويُستخدم في النص مفهوم «التعذيب»، وأحياناً مع «إساءة معاملة أخرى»، للدلالة على المفهوم بأكمله.

نستعرض القانون الدولي وحقوق الإنسان اللذين نشأ عنهما الحظر المطلق للتعذيب القائم اليوم، ومبدأ عدم الإعادة القسرية المرتبط ارتباطاً وثيقاً بحظر التعذيب، وكيف يتجلى ذلك في الاتفاقيات المختلفة. وناقش الفروق بين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أي إساءة المعاملة، ونستعرض بعض الحالات النموذجية. كما نتناول القواعد المتعلقة بالإفلات من العقاب وأهمية جبر الضرر. ونبحث الفروق بين ما يمكن أن يشكل تعذيباً للأطفال وما يمكن أن يشكل تعذيباً للبالغين، مثلاً من خلال الأسئلة التالية:

- كيف يمكن أن يؤثر العمر في تقييم ما إذا كان حدث ما يُعد تعذيباً؟ • ما مسؤولية الدولة، ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال واتفاقية حقوق الطفل؟ • ما الذي ينبغي التفكير فيه عند لقاء أطفال ربما تعرضوا للتعذيب؟ • ما احتياجات العلاج والحق في جبر الضرر التي قد تكون موجودة؟ • ماذا يعني إفلات الجناة من العقاب بالنسبة إلى الطفل؟

نتحدث في الفصل عن الأطفال الذين ربما تعرضوا للتعذيب في بلدان أخرى قبل وصولهم إلى السويد، وعن الأطفال الذين ربما تعرضوا له في السويد. ويُختتم الفصل بالثغرات المعرفية المحددة بشأن الأطفال والتعذيب، وبواقع عدم استخدام هذا المفهوم، وغياب المناقشات والأحكام في المحاكم الدولية وكذلك في السويد ولدى السلطات السويدية، فضلاً عن توصيات بشأن العمل والبحث المستقبليين في هذا المجال.

الملخص

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أي إساءة المعاملة، محظور بموجب القانون الدولي. ولا توجد أي استثناءات. والتعذيب جريمة على درجة خاصة جداً من الخطورة، ومن المهم ألا تُصنّف على أنها تعذيب إلا الجرائم الأشد خطورة التي تتوافق مع وصف هذه الدرجة من الخطورة.

[صفحة أصلية 63]

يشمل التعذيب الموجه ضد الأطفال حالات أكثر، وأحياناً حالات مختلفة، مقارنة بالتعذيب الموجه ضد البالغين. ويجب دائماً إجراء تقييم فردي وشامل لتحديد ما إذا كان الوضع يعادل التعذيب، كما يجب أن تؤخذ قابلية الأطفال الخاصة للتعرض للأذى في الاعتبار دائماً.

يوجد التعذيب في بلدان أخرى وفي السويد على السواء. وعندما يوجد سبب للاعتقاد بأن طفلاً موجوداً في السويد تعرض للتعذيب، أو، وهو ما يحدث في أغلب الأحيان، لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لإنسانية أو مهينة، ينبغي فتح تحقيق جنائي. وفي الحالات التي يُتاح فيها لطفل طالب للجوء أن يروي أسباب طلب لجوئه، وتظهر ظروف يمكن أن تشكل تعذيباً، يجب التحقيق فيها على نحو أعمق، كما ينبغي أن يخضع الطفل لفحص لإصابات التعذيب وفقاً لقواعد بروتوكول إسطنبول، وهو معيار الأمم المتحدة للتوثيق الطبي لإصابات التعذيب.

وبالمثل، ينبغي أن تتاح فعلياً للأطفال الموجودين في السويد تحت الرعاية أو المحتجزين للاشتباه في ارتكابهم جرائم، والذين يتعرضون لأفعال يمكن أن تشكل تعذيباً، فرصة الحصول على ممثل قانوني وتقديم بلاغ والوصول إلى جبر الضرر. ويجب دائماً على ممثلي الدولة الذين تصلهم معلومات عن أحداث يمكن أن تشكل تعذيباً جسدياً أو نفسياً للأطفال أن يقدموا بلاغاً، أيضاً، إلى سلطات إنفاذ القانون.

ومع ذلك، نادراً ما يُرى الأطفال الذين ربما تعرضوا للتعذيب أو يُسمع صوته أو تُجرى تحقيقات بشأنهم. ويتطلب التحقيق ألا تقل السلطة أو ممثل الدولة من شأن الحدث، بل أن يجرؤ على رؤيته والتصرف بناءً عليه. وفي المحادثات واللقاءات مع المحامين والقضاة وعلماء النفس والسلطات ومنظمات المجتمع المدني، يصرح معظمهم بوجود حاجة إلى إظهار الأطفال الذين ربما تضرروا. وينطبق ذلك على التقارير والتحقيقات، وعلى المحاكم والسلطات. وحتى في المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق الطفل ومنظمات حقوق الإنسان، نادراً ما يجري الحديث عن التعذيب فيما يتعلق بالأطفال.

ويجب أن تكون حقوق الإنسان قابلة للمطالبة بها، لكن الأطفال الذين ربما تعرضوا للتعذيب نادراً ما يحصلون على جبر للضرر. ومن المهم للطفل تحديد هوية الشباب المتضررين، انطلاقاً من الحق في جبر الضرر، بما في ذلك الوصول إلى التدخلات العلاجية ذات الصلة. وهذا جزء مهم أيضاً من العمل على مكافحة إفلات المعذبين من العقاب، ومن التزامات السويد بموجب، من بين أمور أخرى، اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

[صفحة أصلية 73]

مفهوم: الأطفال في سياق قانوني

الأطفال هم جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 81 عامًا (المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل). وتنطبق التزامات خاصة تجاه جميع الأطفال. وتقول اتفاقية حقوق الطفل في ديباجتها، من بين أمور أخرى: «... إذ تضع في اعتبارها أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، سواء قبل الولادة أو بعدها»، كما ورد في إعلان حقوق الطفل.

ما التعذيب، وما المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أي إساءة المعاملة؟

التعذيب اعتداء متعمد ومدبر على جسد الإنسان ونفسيته وكرامته. وفي التعذيب يتعرض الإنسان لألم نفسي وجسدي وإذلال لا يمكن تبريرهما. والتعذيب على درجة خاصة جدًا من الخطورة. ولا يوجد تعريف موحد للتعذيب.

تصف المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (TCMO، erutroT al ertnoC elaidnoM noitasinagro) التعذيب بأنه معاناة جسدية غالبًا، من خلال الاعتداء أو الصدمات الكهربائية مثلاً، واعتداءات جنسية مثل الاغتصاب والإذلال الجنسي. وقد تشكل الظروف اللاإنسانية في مراكز التوقيف، بما في ذلك الاكتظاظ الشديد أو انعدام النظافة أو رفض العلاج الطبي، تعذيبًا أو معاملة لاإنسانية أو مهينة. ومن المهم التأكيد أن التعذيب النفسي يمكن أن يسبب درجة من الألم مساوية للألم الجسدي. وقد تشمل العناصر النفسية، مثلاً، الحرمان من النوم أو العزل المطول أو تهديد الشخص بتعذيب شخص يحبه أو قتله.

[صفحة أصلية 83]

إن تحطيم الأجساد يهدف في نهاية المطاف إلى تدمير العقول. ومن الطبيعي أن يعاني ضحايا التعذيب جسديًا. كما أن الإذلال والعار اللذين يشعرون بهما نتيجة ما اضطروا إلى تحمله يسببان ضررًا كبيرًا ويصعب شفاؤهما. ويمحو التعذيب الثقة بالآخرين، وتعد إعادة بناء هذه الصلة بالمجتمع أمرًا حاسمًا للبدء في إعادة بناء حياة الناجي ومنع انتقال الصدمة إلى الأجيال القادمة (1).

وعليه، فالتعذيب على درجة خاصة جدًا من الخطورة. وله جسامه خاصة وطابع مدبّر ومنهجي. أما الجرائم العنيفة الأخرى، مثل الاعتداء الجسيم والتهديد غير المشروع والإكراه غير المشروع والاختطاف، فلا تُعد في حد ذاتها تعذيبًا، لكنها قد تشكل جزءًا من التعذيب. ويجب دائمًا إجراء تقييم شامل للسياق ولتجربة الفرد لتحديد ما إذا كانت الأفعال تشكل تعذيبًا.

يتعرض الأطفال لأشكال عنف مماثلة لتلك التي يتعرض لها البالغون. ومع ذلك، قد تختلف تقييمات ما يشكل تعذيبًا تبعًا لظروف مختلفة، من بينها هوية الشخص المتعرض له. ومن المهم جدًا ملاحظة أن قابلية الأطفال الخاصة للتعرض للأذى وعمرهم ونضجهم يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

فعتبر الألم والمعاناة أقل بالنسبة إلى الطفل، وقد تدخل أفعال لا تُعد تعذيبًا للبالغ ضمن مفهوم التعذيب عندما يكون المتعرض لها طفلًا.

[صفحة أصلية 93]

عند وضع اتفاقية مناهضة التعذيب، قُدِّمَ للمرة الأولى تعريف قانوني للتعذيب (المادة 1):

«لأغراض هذه الاتفاقية، يُقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يُلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول منه، أو من شخص ثالث، على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه هو أو شخص ثالث أو يُشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث، أو لأي سبب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه، عندما يُلحق هذا الألم أو العذاب أو يُحرَض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية. ولا يشمل التعذيب الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لها».

ولكي يوصف الفعل بأنه تعذيب، يجب إذن أن: • يؤدي إلى عذاب شديد، جسدي أو نفسي. • يكون اعتداءً متعمدًا. • يُرتكب لغرض معين. • ينفذه ممثل للدولة أو للسلطة العامة، أو يقع بتحريض أو موافقة أو إذن من شخص كهذا.

وقد يتعلق الأمر، مثلاً، بالركل والضرب، والإغراق الوهمي، والعزل، والاغتصاب، والصدمات الكهربائية، والضرب العنيف، أو منع الشخص من النوم، والتهديد بالعنف، وإجبار الشخص على مشاهدة تعذيب أقاربه أو أشخاص آخرين، والإعدام الوهمي، أو الامتناع عن فعل، مثل عدم إعطاء السجين الطعام أو الماء.

ينبغي أن يُحجز مفهوم التعذيب، بوصفه مفهومًا كاملاً، لأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان. وهذا يمنحه وصمة خاصة. وكثيرًا ما يعاني الشخص الذي تعرض للتعذيب آثارًا جسدية أو نفسية طوال بقية حياته.

وتشمل الأغراض المذكورة بوجه خاص في المادة 1 انتزاع المعلومات أو الاعتراف، والعقاب والتهديد أو الإكراه، والدوافع القائمة على التمييز. لكنها ليست قائمة حصرية، فقد يتعلق الأمر أيضًا بأغراض أخرى.

[صفحة أصلية 04]

في تعريف التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب، بخلاف الاتفاقية الأوروبية من خلال تفسيرات المحكمة الأوروبية لأحكامها، لا يخضع للمحاكمة إلا ممثلو السلطة العامة، وليس الجناة غير الحكوميين البحتين. وقد تُعد الدولة مسؤولة في بعض الحالات عن عدم حماية شخص من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي ينفذها شخص خاص، كأحد أفراد الأسرة مثلاً.

وينطبق الحظر الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب على التعذيب، وكذلك بالدرجة نفسها على المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

متطلبات اتفاقية مناهضة التعذيب المتعلقة بالفاعل الحكومي

تتضمن اتفاقية مناهضة التعذيب قيداً يستبعد في الأساس الجناة غير الحكوميين. ومن التفسيرات المقدمة لهذا القيد أن القانون الدولي يُنظر إليه غالباً بوصفه متعلقاً بمسؤولية الدول والتزاماتها. وتحدث الاتفاقية عن موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته ممثلاً للسلطة العامة (المادة 1، الفقرة 1، انظر أدناه). وفي الوقت نفسه، فالتعذيب بوصفه جريمة محظورة، بصرف النظر تماماً عن الصفة التي ينفذ بها الشخص الفعل. كما توجد آراء مختلفة في هذا الشأن (2، 3).

فالمحكمة الأوروبية، بوصفها مفسرة لحظر التعذيب الوارد في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية، تنظر مثلاً بطريقة مختلفة إلى الجناة الحكوميين وغير الحكوميين. ومن الممكن تماماً للسويد، عند إدخال التعذيب بوصفه جريمة معاقباً عليها، أن تعتمد تعريفاً يعني أن التعذيب يمكن أن يرتكبه فاعلون غير حكوميين.

ولا يلزم أن يتضمن التشريع السويدي الغرض الخاص الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب. وقد يكون استبعاده منطقيًا، لأن التعذيب يُرتكب دائماً بهدف تحطيم هوية الشخص أو انتهاك سلامته الجسدية أو النفسية، وينبغي أن يكون ذلك كافياً.

[صفحة أصلية 14]

إساءة المعاملة الأخرى

تتضمن المادة 61 من اتفاقية مناهضة التعذيب قواعد بشأن المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أي الأفعال التي لا يمكن وصفها بأنها تعذيب، لكنها تخضع للقواعد والحظر نفسيهما:

«تتعهد كل دولة طرف بمنع، في كل إقليم يخضع لولايتها القضائية، ارتكاب أية أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا ترقى إلى التعذيب كما حُدد في المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية هذه الأعمال أو يحرض عليها أو يوافق عليها أو يسكت عنها. وبوجه خاص، تنطبق الالتزامات الواردة في المواد 01 و11 و21 و31، مع استبدال الإشارات إلى التعذيب بالإشارات إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».

ولا تشترط المادة 61 غرضاً معيناً. ويعني ذلك أن أفعالاً أكثر يمكن وصفها، لهذا السبب أيضاً، بأنها معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، بدلاً من كونها تعذيباً. وسنعود إلى ذلك لاحقاً في النص بوصفه سبباً يجعل تقييم الأطفال أكثر تواتراً على أنهم تعرضوا لإساءة معاملة لا للتعذيب.

ومن ثم، قد تشكل الأفعال التي لا تبلغ درجة الخطورة المطلوبة للتعذيب معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة. ويتعلق الأمر بفروق في الدرجة، ولا يوجد حد واضح أو فروق واضحة تحدد ماهية كل منها. ويجب دائماً إجراء تقييم شامل، والنظر إلى الصورة الكاملة ومن منظور الفرد. وينبغي مراعاة جميع الظروف، ومن الجوانب المهمة، من بين أمور أخرى، مدة استمرار الانتهاك، وآثاره النفسية والجسدية، وعمر الشخص المتعرض له. ويُقال أحياناً إن الفرق يتمثل في درجة شدة الألم.

[صفحة أصلية 24]

ومن المهم مرة أخرى أن نضع في الاعتبار أن الألم ليس جسديًا فقط، بل قد يتعلق بإثارة الخوف وتعريض الشخص للتهديد، وكذلك بأشكال أخرى من التعذيب النفسي. وفيما يتعلق بالأطفال، يجب دائمًا مراعاة قابلية الأطفال الخاصة للتعرض للأذى. وقد ينشأ أيضًا أثر تراكمي للعنف عندما يقترن بظروف أخرى، بحيث تجعل الظروف مجتمعة الطفل معرضًا لإساءة المعاملة.

حظر التعذيب، وعدم الإعادة القسرية، وحقوق الإنسان

حظر التعذيب مطلق، ولا توجد أي استثناءات. ويُعد حظر التعذيب من القواعد الأمرة في القانون الدولي العام (snegoc suj)، ما يعني أن الحظر يشمل جميع الدول، بصرف النظر عن الاتفاقيات التي التزمت بها أو لم تلزم باتباعها واحترامها.

ويشمل حظر التعذيب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتنطبق القواعد نفسها على المفهوم بأكمله، كما ذكر، ويمكن القول إن الأمر يتعلق بفروق في الدرجة. ولذلك من المهم والضروري فحص المفهوم بأكمله في الحالات التي يُحتمل فيها أن يكون شخص قد تعرض للانتهاك.

عن عدم الإعادة القسرية

يرتبط مبدأ عدم الإعادة القسرية ارتباطًا وثيقًا بحظر التعذيب. ويعني هذا المبدأ، المتعلق بعدم الإعادة، حظرًا مطلقًا لإعادة شخص أو نقله أو ترحيله أو تسليمه، أيًا كانت الكلمة المستخدمة، إلى بلد أو منطقة يوجد فيها خطر حقيقي من تعرضه للتعذيب أو لانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان. ويشمل الحظر أيضًا ما يسمى بالإعادة القسرية المتسلسلة، أي خطر إرسال الشخص من بلد أو منطقة إلى مكان آخر يوجد فيه خطر التعرض للانتهاكات. ويُعد المبدأ أحد أحجار الأساس في القانون الدولي للاجئين، لكنه ينطبق بالإضافة إلى ذلك على جميع الناس وفي جميع الأوضاع.

[صفحة أصلية 34]

وهو ما يعني التزامًا دوليًا على جميع الدول تجاه جميع الناس.

وينص قانون الأجانب على مبدأ عدم الإعادة القسرية في الفصل 21، المادة 1:

1. لا يجوز أبدًا تنفيذ إبعاد أو ترحيل أجنبي إلى بلد إذا كان هناك سبب معقول للاعتقاد بأن الأجنبي سيكون هناك معرضًا لخطر الحكم عليه بالإعدام أو تعرضه للعقوبة البدنية أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، أو إذا لم يكن الأجنبي محميًا في ذلك البلد من إرساله إلى بلد آخر يكون فيه معرضًا لمثل هذا الخطر.

وثائق القانون الدولي المتعلقة بحظر التعذيب والإعادة القسرية

في العصر الحديث، ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية، أنشئت مجموعة من وثائق القانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تتضمن حظر التعذيب. وتنطلق هذه الوثائق من حقوق الإنسان، أي الحقوق التي يتمتع بها الأفراد وتقبلها واجبات على الدول. وينبغي أن تكون الحقوق قابلة للمطالبة، وأن توجد لا في النظرية فحسب بل في الممارسة أيضًا.

وقد أدرج حظر التعذيب ومبدأ عدم الإعادة القسرية في عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات التي سبقت اتفاقية مناهضة التعذيب، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 0591، واتفاقيات جنيف لعام 9491، أي القانون الدولي الإنساني أو قوانين الحرب. وفي أجزاء أخرى من العالم، أدرج الحظر، من بين وثائق أخرى، في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.

[صفحة أصلية 44]

ميثاق الأمم المتحدة (5491)

كان ميثاق الأمم المتحدة نقطة انطلاق للعمل المستقبلي في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وقد صيغت فيه أهمية الحقوق وعدم التمييز بحيث تتخلل عمل الأمم المتحدة.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة (8491)

يتكون الإعلان من 03 مادة تتناول حقوقًا مختلفة، من بينها الحق في التحرر من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 5).

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (0591)

تنص المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية على أنه «لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة». وتشمل المادة أيضًا الحماية من الإعادة إلى بلد يخطر فيه الشخص بالتعرض لإساءة معاملة كهذه، وفق تفسير المحكمة الأوروبية لهذه المادة وتطبيقها.

وتوضح اجتهادات المحكمة أن الدولة المتعاقدة ملزمة بعدم تسليم شخص أو ترحيله أو إعادته إلى بلد توجد أسباب جهرية للاعتقاد بأن الشخص المعني يواجه فيه خطرًا حقيقيًا للتعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في البلد المستقبل. وقد أكدت المحكمة الأوروبية انطباق هذا الحكم على طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم والذين سيُرحلون، في قضية شحال ضد المملكة المتحدة، إذ قالت المحكمة:

«من المستقر في اجتهاد المحكمة أن ترحيل دولة متعاقدة لشخص يمكن أن يثير مسألة بموجب المادة 3، ومن ثم يرتب مسؤولية على تلك الدولة بموجب الاتفاقية، عندما توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الشخص المعني، إذا رُحل، سيواجه خطرًا حقيقيًا في ذلك البلد بالتعرض لمعاملة مخالفة للمادة 3. وفي مثل هذه الظروف، تنشئ المادة 3 التزامًا بعدم ترحيل الشخص المعني إلى ذلك البلد».

وكما هو الحال في مبادئ عدم الإعادة القسرية الواردة في الاتفاقيات الأخرى، تحمي المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية من الإعادة إلى بلد قد يتعرض فيه الفرد بدوره لخطر إبعاده إلى التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، أي الإعادة القسرية المتسلسلة. والمادة 3 من المواد التي لا يجوز تقييدها في الاتفاقية الأوروبية، ولذلك فالحماية من الإعادة القسرية مطلقة ولا يجوز تقييدها، مثلًا بسبب أفعال إجرامية خطيرة ارتكبها شخص ما.

[صفحة أصلية 54]

اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، اتفاقية اللاجئين (1591)

يحظر مبدأ عدم الإعادة القسرية، كما نصت عليه المادة 33 من اتفاقية اللاجئين، على الدول أن:

«... تطرد أو ترد لاجئاً، بأي صورة من الصور، إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية».

وتتطبق المادة 33 على اللاجئين وطالبي اللجوء.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (6691)

تنص المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:

«لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إخضاع أي شخص دون رضاه الحر للتجارب الطبية أو العلمية».

وقد ذكرت لجنة حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 02 ما يلي:

«وفقاً للجنة، لا يجوز للدول الأطراف تعريض الأفراد لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عند إعادتهم إلى بلد آخر عن طريق التسليم أو الترحيل أو الإعادة القسرية. وينبغي للدول الأطراف أن تذكر في تقاريرها التدابير التي اتخذتها لهذا الغرض».

[صفحة أصلية 64]

اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اتفاقية مناهضة التعذيب (4891)

تطور اتفاقية مناهضة التعذيب حظر التعذيب وتحدهد بدقة، وهو الحظر الذي كان ملزماً في القانون الدولي والعرف الدولي قبل ذلك أيضاً (snegoc suj). وسبقت الاتفاقية كذلك، عام 5791، اتفاقية بشأن حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ومن الأهمية بمكان أن الاتفاقية تقر بأن حظر التعذيب يخضع للاختصاص العالمي. ويعني ذلك أن على جميع الدول واجب القبض على الشخص المشتبه في ارتكابه الجريمة والتحقيق معه ومقاضاته، بصرف النظر عن مكان ارتكاب الجريمة في العالم وبصرف النظر عن جنسية الشخص.

وتتضمن المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حظراً صريحاً ومطلقاً لترحيل شخص أو إعادته أو تسليمه إلى بلد توجد أسباب جوهريّة للاعتقاد بأنه سيتعرض فيه للتعذيب. ويوضح التعليق العام رقم 1 للجنة مناهضة التعذيب، إلى جانب قراراتها في عدد كبير من الشكاوى الفردية، أن المادة 3 تحمي الشخص من إعادته إلى بلد توجد أسباب جوهريّة للاعتقاد بأنه يواجه فيه خطراً حقيقياً للتعرض للتعذيب في البلد المستقبل أو في بلد ثالث يعيد البلد المستقبل إرساله إليه، أي الإعادة القسرية المتسلسلة. وحظر الإعادة القسرية في المادة 3 من الاتفاقية مطلق.

اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (9891)

تنص المادة 73، الفقرة أ، على ما يلي:

«لا يجوز إخضاع أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا يجوز فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة».

[صفحة أصلية 74]

وقد ذكرت لجنة حقوق الطفل، في تعليقها العام رقم 6، الدول بأن التزاماتها تجاه الأطفال غير المصحوبين تشمل مبدأ عدم الإعادة القسرية كما نصت عليه اتفاقية اللاجئين واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وأكدت اللجنة أيضًا أن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل نفسها تتضمن حماية للأطفال من الإعادة القسرية تشبه الحماية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتنص اللجنة على أنه، عند تنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاقية، لا يجوز للدول إعادة طفل أو ترحيله إلى بلد توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بأن فيه خطرًا حقيقيًا لوقوع ضرر لا يمكن جبره على الطفل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأضرار المشار إليها في المادتين 6 و73 من الاتفاقية، سواء في البلد الذي ستنتم إليه الإعادة أو في أي بلد آخر يمكن أن يُنقل الطفل إليه لاحقًا. وتتنطبق هذه الالتزامات بعدم الإعادة، بصرف النظر عما إذا كانت الانتهاكات الجسيمة للحقوق التي تضمنها الاتفاقية صادرة عن جهات غير حكومية أو كانت هذه الانتهاكات مقصودة مباشرة أو نتيجة غير مباشرة لفعل أو امتناع عن فعل. وينبغي إجراء تقييم خطر هذه الانتهاكات الجسيمة بطريقة تراعي العمر والجنس، وأن يأخذ، مثلاً، في الاعتبار العواقب الخطيرة الخاصة التي تترتب على الأطفال بسبب عدم توفير الغذاء أو الرعاية الكافيين.

استعراض اتفاقية مناهضة التعذيب

تشير ديباجة اتفاقية مناهضة التعذيب إلى ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تشير إلى الدول الأطراف في الاتفاقية التي تريد جعل مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أكثر فعالية في كل أنحاء العالم. وتهدف الاتفاقية، إلى جانب منع التعذيب، إلى مكافحة الإفلات من العقاب وضمان جبر ضرر الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب.

[صفحة أصلية 84]

الجزء الأول

تشكل المواد من 1 إلى 61 القواعد الموضوعية في اتفاقية مناهضة التعذيب. ونستعرض هنا بعضًا منها. وقد تناولنا المادتين 1 و61 بمزيد من التفصيل أعلاه، تحت عنوان «ما التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؟».

اتخاذ التدابير اللازمة

تُلزم الدولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها التدابير الإدارية والقانونية، لمنع أفعال التعذيب. وحظر التعذيب مطلق، ولا يجوز لأي وضع أن يبرر التعذيب. وينطبق ذلك أيضًا على أوامر السلطة أو الموظف الأعلى رتبة (المادة 2).

مبدأ عدم الإعادة القسرية

لا يجوز لأي دولة أن ترحل أو تعيد أو تسلّم شخصًا، أيًا كانت الكلمة المستخدمة، إلى دولة توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه سيكون فيها معرضًا لخطر التعذيب (المادة 3). وهذه هي المادة الاتفاقية الخاصة بمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي عُرض بمزيد من التفصيل أعلاه مع وصف حظر التعذيب وحقوق الإنسان.

جريمة معاقب عليها جنائيًا

على الدولة أن تضمن أن جميع أفعال التعذيب تشكل جريمة بموجب قانون العقوبات لديها، وهو قانون العقوبات في السويد. وينبغي أن ينطبق ذلك أيضًا على الشروع والمساعدة أو المشاركة في التعذيب (المادة 4).

[صفحة أصلية 94]

لم تُدخل السويد هذه الجريمة، مما يعني أنه لا يمكن حاليًا التحقيق أو الادعاء أو إصدار حكم بشأن جريمة التعذيب بوصفها جريمة مستقلة. ومع ذلك، يمكن إصدار حكم عن جرائم نظام روما، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وقد يكون التعذيب جزءًا من هذه الجرائم. وقد تعرضت السويد لانتقادات متكررة من لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وكذلك من عدد من منظمات المجتمع المدني، بسبب ذلك. كما أشار معهد حقوق الإنسان، في مذكرته قبل مراجعة الأمم المتحدة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى أن السويد «لم تعتمد بعد تعريفًا للتعذيب في قانون العقوبات بما يتوافق مع المادة 7 من العهد» (4).

وقد بُحثت المسألة وعولجت في مشاورات رسمية (4)، لكنها لم تؤد إلى أي إجراء تشريعي. واقتُرحت الدراسة إدخال قانون جديد للعقوبة على جرائم التعذيب، يجرم التعذيب بوصفه جريمة خاصة، ويُدخل أحكامًا خاصة بشأن مسؤولية الرؤساء عن منع جرائم التعذيب التي يرتكبها المروءسون والإبلاغ عنها. كما اقترح منح المحاكم السويدية الاختصاص بالحكم في جرائم التعذيب بصرف النظر عن مكان ارتكاب الجريمة وبصرف النظر عن جنسية الجاني أو المدعي، أي اعتماد الاختصاص العالمي، وأخيرًا استثناء جرائم التعذيب من أحكام التقادم.

وبصرف النظر عن الأسباب المختلفة التي أثّرت، فإن غياب نص جنائي خاص بالتعذيب يعني أن السويد لا تفي حاليًا بالمتطلبات المفروضة على جميع الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب.

والتعذيب محظور بموجب الفصل الثاني، المادة 5، من النظام الأساسي للحكم، ولذلك توجد حماية دستورية، وهي أمر إيجابي لكنها غير كافية.

التعليم والمعلومات

تنظم المادة 01 اشتراط أن تضمن الدولة إدراج التعليم والمعلومات عن حظر التعذيب في تدريب جميع العاملين وموظفي السلطات وغيرهم من الأشخاص الذين قد يشاركون، بطرق مختلفة، في أوضاع يكون فيها شخص مقبوضاً عليه أو محتجزاً أو محروماً من حريته. وينبغي إدراج حظر التعذيب في جميع القواعد والتعليمات ذات الصلة. كما ينبغي مراجعة هذه القواعد والتعليمات والأساليب والإجراءات مراجعة منهجية (المادة 11).

التحقيق في فعل تعذيب مشتبه فيه

عندما يوجد «سبب معقول» للاشتباه في ارتكاب فعل تعذيب داخل إقليم الدولة وتحت ولايتها القضائية، يجب على الدولة، من تلقاء نفسها، أن تضمن أن تجري السلطات المختصة تحقيقاً فورياً ونزيهاً (المادة 21).

الحق في تقديم شكوى وفي فحص القضية

يجب أن يكون للشخص الذي يقول إنه تعرض للتعذيب الحق في تقديم شكوى، وفي أن تحقق السلطات المختصة في الدولة في قضيته فوراً وبحياد. وتقع على الدولة مسؤولية ضمان حماية الشخص المتضرر وأي شهود محتملين من جميع أشكال الاعتداء أو التهديد المرتبط بالشكوى أو الشهادة (المادة 31).

وقد يتطلب الأمر، بالنسبة إلى الطفل، تدابير خاصة لضمان حصوله على المعلومات وعلى الدعم القانوني والنفسي الاجتماعي لتقديم بلاغ.

التعويض وجبر الضرر

على الدولة أن تضمن أن يكفل النظام القانوني حصول من تعرض لفعل تعذيب على جبر للضرر وعلى تعويض «منصف وكاف». وينبغي أن يشمل التعويض إعادة التأهيل ووسائل أخرى «لتحقيق أوسع استعادة ممكنة للصحة». وإذا توفي شخص نتيجة فعل تعذيب، فينبغي أن يكون الأشخاص الذين كان يعيّلهم مستحقين للتعويض (المادة 41).

[صفحة أصلية 15]

وفي التعليق العام رقم 3 للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشأن التعويض وجبر الضرر، يرد بخصوص الأطفال بوجه خاص ما يلي:

63. «تؤكد اللجنة كذلك أهمية إتاحة إجراءات مناسبة لمعالجة احتياجات الأطفال، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى وحق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية في جميع المسائل التي تؤثر فيه، بما في ذلك الإجراءات القضائية والإدارية، وإيلاء آراء الطفل الوزن الواجب وفقاً لعمره ونضجه. وينبغي للدول الأطراف أن تضمن توافر تدابير جبر ضرر تراعي احتياجات الطفل وتعزز صحة الطفل وكرامته».

خصوصاً بشأن جبر الضرر ومسؤولية الدولة في اتفاقية مناهضة التعذيب

يكتسب جبر الضرر أهمية كبيرة، وغالباً ما يكون حاسماً، للأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب. وضمان حصول الشخص على جبر الضرر وتيسيره التزام بموجب القانون الدولي، وفق المادة 41 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

41. «تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، أن يحصل ضحية فعل تعذيب على جبر للضرر وعلى حق قابل للإنفاذ في تعويض منصف وكاف، بما في ذلك الوسائل اللازمة لإعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن. وإذا توفي الضحية نتيجة فعل تعذيب، كان للأشخاص الذين كان يعيلهم الحق في التعويض».

ولكي يحصل الشخص على جبر الضرر بكل عناصره، يجب أن يتوافر أيضاً الحق في تقديم شكوى (المادة 31 من الاتفاقية). ويرتبط ذلك بدوره بالالتزام بتجريم التعذيب في التشريع الجنائي (المادة 4)، وهو ما لم تفعله السويد، وبالتحقيق في فعل التعذيب المشتبه فيه (المادة 21).

[صفحة أصلية 25]

والفكرة هي أن يتمكن الشخص المتضرر، إلى أقصى حد ممكن، من العودة إلى الوضع الذي كان فيه قبل تعرضه للتعذيب. ويفترض جبر الضرر أن يكون الحق في تقديم الشكاوى متاحاً فعلياً. وهذا بدوره يفترض أن لدى السلطات المختصة وممثليها نظاماً لاستقبال المعلومات والتعامل مع الأشخاص الذين تعرضوا لأحداث صادمة. وقد يشكل عدم التحقيق في المعلومات المتعلقة بالتعذيب، في بعض الحالات، انتهاكاً لاتفاقية مناهضة التعذيب.

ويتعارض الإفلات من العقاب مع الحق في جبر الضرر، الذي ينبغي أن يشمل أيضاً ضمان عدم التعرض للتعذيب مرة أخرى. وجبر الضرر أداة للفرد والمجتمع على السواء، كما أنه وسيلة للعمل بنشاط ضد التعذيب من خلال ردع الجناة في المستقبل.

حظر استخدام الأدلة الناتجة عن التعذيب

على الدولة أن تضمن عدم الاستناد إلى الأقوال التي أدلي بها نتيجة التعذيب كأدلة في إجراء قضائي، «إلا ضد شخص متهم بالتعذيب، بوصفها دليلاً على أن القول قد أدلي به» (المادة 51).

الجزء الثاني

يتناول الجزء الثاني من الاتفاقية إنشاء لجنة مناهضة التعذيب (TAC) وطريقة عملها، وكيف يمكن للأفراد تقديم شكاوى إلى اللجنة. وبالنسبة إلى الشكاوى المقدمة إلى اللجنة، كما هو الحال مع جميع الشكاوى إلى اللجان والمحاكم الدولية، يجب استنفاد سبل الانتصاف المحلية. أي يجب أن يكون هناك قرار نهائي واجب النفاذ وغير قابل للاستئناف.

وفي قضايا اللجوء قد تطرأ أحياناً معلومات جديدة أو وثائق جديدة بعد صدور قرار نهائي. ومن أمثلة ذلك وثائق التعذيب وفق بروتوكول إسطنبول. وإذا حدث ذلك، ينبغي البدء بتقديم طلب بشأن وجود عائق أمام تنفيذ القرار، وفق قانون الأجانب، لإتاحة فرصة للسلطات السويدية لفحص الظروف الجديدة. ومن الأفضل دائماً التوجه إلى محام متخصص في قانون اللجوء والقانون الدولي للمساعدة في ذلك.

[صفحة أصلية 35]

تتكون اللجنة من عشرة خبراء دوليين يفحصون مدى امتثال الدول الأطراف لالتزامات الاتفاقية. وقد أُثير، في مناسبات عدة أثناء مراجعة السويد، موضوع أن السويد لم تجرّم التعذيب بوصفه جريمة مستقلة. وشملت الانتقادات الأخرى، من بين أمور، طول فترات الاحتجاز والعزل، وترحيل طالبي اللجوء إلى بلدان كان يوجد فيها خطر التعذيب، وأوجه القصور في الوصول إلى الرعاية الصحية للأشخاص المحرومين من حريتهم.

الجزء الثالث

يتناول الجزء الثالث القواعد الرسمية المتعلقة بدخول الاتفاقية حيز النفاذ، والنزاعات وغير ذلك.

استعراض اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل هي الوثيقة الوحيدة الملزمة بموجب القانون الدولي التي تتضمن أحكاماً خاصة بحقوق الإنسان للأطفال. وترتكز الاتفاقية على النظر إلى الأطفال بوصفهم أفراداً يتمتعون بحقوق مستقلة. وهي تنظم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الأطفال.

وتقوم اتفاقية حقوق الطفل، شأنها شأن اتفاقيات الأمم المتحدة كلها، على مبدأ عدم التمييز (المادة 2)، ومبدأ مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في جميع القرارات المتعلقة بالأطفال (المادة 3)، ومبدأ الحق في الحياة والنماء (المادة 6)، ومبدأ احترام آراء الأطفال وحق جميع الأطفال في التعبير عن رأيهم (المادة 21).

ومن ثم، يجب دائماً مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في القرارات والتدابير المتعلقة بالأطفال. وفي المسائل المتعلقة بتعذيب الأطفال أو إساءة معاملتهم، من المهم والضروري معرفة كل من اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل وتطبيقهما.

[صفحة أصلية 45]

تتضمن اتفاقية حقوق الطفل، كما ذكر أعلاه، حظرًا للتعذيب (المادة 73، الفقرة أ)، كما تنص المادة 91 على ما يلي:

1. «تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية، والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، ما دام الطفل في رعاية الوالدين أو أحدهما أو الوصي القانوني أو أي شخص آخر يتعهد رعايته».

ومن المهم النظر إلى اتفاقية حقوق الطفل ككل، مع الالتزامات الخاصة القائمة تجاه الأطفال، عند تقييم ما يمكن أن يشكل تعذيبًا للأطفال. فقد تبلغ التجارب الإجمالية للانتهاكات حد جريمة التعذيب؛ فالتقييم تراكمي. وإذا لم يحرص ممثلو السلطة العامة بنشاط على حماية الأطفال من الأمور التي تشملها، من بين أمور أخرى، المادة 91، وكانت الانتهاكات مستمرة أو متكررة، فقد يتعلق الأمر بانتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب. ويجب دائمًا إجراء تقييمات فردية وشاملة.

وتصدر لجنة حقوق الطفل، التي تفحص، من بين أمور أخرى، امتثال الدول الأطراف للاتفاقية، تعليقات عامة أيضًا لتقديم إرشادات بشأن تفسير أجزاء اتفاقية حقوق الطفل المختلفة.

وقد تُرجمت جميع التعليقات العامة، وعددها حاليًا 52، إلى السويدية وأصبحت متاحة على موقع أمين مظالم الأطفال. ومن التعليقات ذات الصلة الخاصة هنا التعليق العام رقم 6 بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والأطفال المنفصلين عن والديهم خارج بلدهم الأصلي، والذي يبرز فيه الأطفال الجنود أيضًا. فتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة محظور بموجب القانون الدولي ويشكل اليوم جريمة حرب.

ومن التعليقات المهمة بوجه خاص أيضًا: التعليق رقم 8 بشأن حق الطفل في الحماية من العقاب البدني وغيره من أشكال العقاب القاسي أو المهين؛ ورقم 9 بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛ ورقم 01 بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث؛ ورقم 21 بشأن حق الطفل في أن يُسمع؛ ورقم 31 بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف؛ ورقم 51 بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه؛ ورقم 12 بشأن الأطفال في أوضاع الشوارع؛ ورقم 22 بشأن المبادئ العامة لحقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية؛ ورقم 32 بشأن التزامات الدول المتعلقة بحقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة؛ ورقم 42 بشأن حقوق الطفل في نظام العدالة الجنائية. ويوصى، تبعًا للوضع، بدراسة التعليق ذي الصلة للحصول على معرفة أعمق.

[صفحة أصلية 55]

وتوجد ثلاثة بروتوكولات اختيارية لاتفاقية حقوق الطفل، تتعلق بالأطفال في النزاعات المسلحة (رقم 1)، وبيع الأطفال وبيعاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال (رقم 2)، وإمكانية تقديم الأطفال شكاوى إلى لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة في الحالات التي انتهكت فيها حقوق الطفل ولم يحصل الطفل على جبر للضرر في البلد الذي وقع فيه الانتهاك (رقم 3). وقد وقعت السويد البروتوكولين الأول والثاني، لكنها لم توقع الثالث بعد.

وسيكون منح الأطفال الحق في تقديم الشكوى، وبالتالي إتاحة فرصة حقيقية لجبر الضرر عندما تكون الإجراءات السويدية قد أخفقت، أمرًا ذا أهمية كبيرة، كما سيظهر في الوقت نفسه أن حقوق الأطفال تحظى باحترام جاد.

بعض أمثلة السياقات وأوضاع التعرض للأذى التي يرتفع فيها خطر تعرض الأطفال للتعذيب

هناك أوضاع كثيرة يكون فيها الأطفال معرضين لخطر التعذيب. كما يتعرض الأطفال، ولا سيما في المجال الخاص، لخطر خاص ويكونون أكثر قابلية للأذى داخل المنزل، حيث يكون اعتمادهم على الوالدين أو الأوصياء كبيرًا جدًا، وأكبر ما يكون لدى الأطفال الصغار، مع خطر العقاب والعنف والتهديد بالعنف وإجبارهم على مشاهدة أوضاع عنف تنطوي على تعذيب جسدي أو نفسي أو إساءة معاملة أخرى. وقد تصبح مسؤولية الدولة مطروحة عندما تكون الأوضاع مستمرة من دون أن تتصرف السلطات المعنية وتتخذ التدابير اللازمة لحماية الطفل.

إساءة معاملة الأطفال أكثر شيوعًا

ينبغي تفسير تعذيب الأطفال بطريقة تراعي الأطفال وقابليتهم الخاصة للتعرض للأذى. ومن الشائع، لعدة أسباب، أن يشكل الوضع إساءة معاملة لا تعديًا، وينطبق ذلك على الأطفال والبالغين على السواء. ولكي يُعد الفعل إساءة معاملة بموجب المادة 61 من اتفاقية مناهضة التعذيب، لا يشترط، كما ذكر سابقًا، أن يُنفذ الفعل لغرض محدد، كما تُعد إساءة المعاملة فعلًا محظورًا على درجة أقل من الخطورة.

[صفحة أصلية 65]

وهناك أحكام قليلة جدًا فيما يتعلق بالتعذيب وإساءة المعاملة الأخرى.

[صفحة أصلية 75]

ولم تبت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في أي شكوى تتعلق بالأطفال والتعذيب. أما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فقد فصلت في قضية واحدة، هي قضية أيدين ضد تركيا (5). وكانت ظروف تلك القضية تشكل تعذيباً واضحاً، ويرجح أنها كانت ستُعد كذلك حتى بالنسبة إلى شخص بالغ. وكانت القضية تتعلق بفتاة كردية تبلغ 71 عاماً. وقالت المحكمة، من بين أمور أخرى:

38. «أثناء احتجازها، اغتصب شخص لم تُحدّد هويته بعد صاحبة الشكوى. ويجب اعتبار اغتصاب شخص محتجز، عندما يرتكبه موظف حكومي، شكلاً خطيراً ومثيراً للاشمئزاز بوجه خاص من أشكال سوء المعاملة، بالنظر إلى سهولة استغلال الجاني لقابلية الضحية للأذى وضعف قدرتها على المقاومة. وإضافة إلى ذلك، يترك الاغتصاب ندوباً نفسية عميقة لدى الضحية لا تتلاشى بمرور الوقت بالسرعة نفسها التي تتلاشى بها أشكال العنف الجسدي والنفسي الأخرى. كما عانت أيدين الألم الجسدي الحاد الناتج عن الإيلاج القسري، وهو ما لا بد أنه جعلها تشعر بالإذلال والانتهاك جسدياً وعاطفياً».

48. «تعرضت صاحبة الطلب أيضًا لسلسلة من التجارب المخيفة والمهينة للغاية أثناء احتجازها لدى قوات الأمن في مقر الدرك في ديريك، بالنظر إلى جنسها وصغر سنها والظروف التي أُحتُجزت فيها. فقد خُرمَت من حريتها ثلاثة أيام، ولا بد أنها كانت مشوشة ومضطربة بسبب إبقائها معصوبة العينين، وبسبب حالة الألم الجسدي المستمر والقلق النفسي الناجمين عن سوء المعاملة التي تعرضت لها أثناء الاستجوابات، وعن قلقها مما سيحدث لها بعد ذلك. وعرّضت عارية في ظروف مهينة، زاد من حدتها شعورها العام بقابلية التعرض للأذى، وأجبرت في إحدى المرات على الدخول في إطار عجلة، ثم دارت وهي تُرش بالماء تحت ضغط عالٍ».

68. «وفي ضوء ذلك، ترى المحكمة أن تراكم أفعال العنف الجسدي والنفسي، وفعل الاغتصاب القاسي بوجه خاص الذي تعرضت له، شكل تعذيبًا مخالفًا للمادة 3 من الاتفاقية. وكانت المحكمة ستصل إلى هذه النتيجة على أساس أي من هذين العنصرين منفردًا».

وهناك أيضًا بعض القضايا أمام المحكمة الأوروبية التي ألفت فيها الانتباه إلى الالتزام الإيجابي للدولة بحماية الأطفال، في أوضاع عُذِّب فيها الأطفال متعرضين لإساءة المعاملة من والديهم أو أولياء أمورهم، وكان ينبغي للسلطات أن تتصرف لحمايتهم من الانتهاكات. ورغم عدم وجود أحكام قانونية تتناقش الفروق العملية اعتمادًا على كون المتعرض للتعذيب طفلًا أو بالغًا، فمن الواضح أن حماية الأطفال أوسع نطاقًا. فالإلى جانب الحظر المطلق للتعذيب، يجب حماية الأطفال، بموجب المادة 91، من جميع أشكال العنف، بصرف النظر عن السبب وبصرف النظر عن هوية الجاني.

عتبة أقل لتعرض الأطفال للأذى

توجد دائمًا علاقة متبادلة بين مختلف صكوك القانون الدولي. وعند تقييم ما إذا كان فعل موجه ضد طفل يُعد تعذيبًا أو إساءة معاملة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، يجب أن تكون اتفاقية حقوق الطفل حاضرة في التقييم. وهذا يعني أن العتبة التي يبلغ عندها الفعل حد التعذيب أو إساءة المعاملة تكون أقل بالنسبة إلى الطفل منها بالنسبة إلى البالغ.

وبسبب قلة الأحكام التي فُحصت فيها المسألة، ولأن جميع الظروف ذات الصلة في الحالة الفردية يجب أن تُقيم مجتمعة، يصعب تقديم أمثلة محددة وواضحة. ويجب فحص السياق وجميع الظروف ذات الصلة، ومنها عمر الطفل ونضجه وتكوين أسرته وسياقه الاجتماعي والوضع في البلد.

ومن الجوانب التي يمكن إبرازها بوجه خاص مدة الحرمان من الحرية والظروف المحيطة به. فقد يشكل حتى الحرمان القصير جدًا من الحرية، وبالأخص إذا تضمن فصل الطفل عن والديه، إساءة معاملة بالنسبة إلى الطفل، وهو ما قد لا يكون كذلك بالنسبة إلى شخص بالغ.

قلة الأحكام المتعلقة بالأطفال

يُستخدم مفهوم الاعتداء عمومًا في السويد وبلدان أخرى للدلالة على مجموعة كبيرة من الأفعال التي يتعرض لها الأطفال. وفي بعض الحالات، ربما كان سيُستخدم تعريف التعذيب بدلًا منه لو كانت هناك جريمة تعذيب مستقلة معاقب عليها. والسؤال هو ما إذا كانت هناك أي سياقات يُناقش فيها أصلًا مضمون المادة 61 من اتفاقية مناهضة التعذيب، أي المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وعلى السلطات السويدية المكلفة بإنفاذ القانون أن تستخدم التشريعات الجنائية القائمة. ومن الأوصاف الجنائية التي قد تكون ذات صلة: الاعتداء، والاعتداء الجسيم، والاعتداء الجسيم جدًا، الذي تشير فيه المذكرة الحكومية

741:01/9002 أيضًا إلى «الاعتداء ذي الطابع الشبيه بالتعذيب»، والتسبب في إصابة بدنية أو مرض، والاعتصاب، والاختطاف، والحرمان غير المشروع من الحرية، والاتجار بالبشر أو استغلال البشر (6). وبالنسبة إلى الجريمتين الأخيرتين، تكون متطلبات الإثبات أقل إذا ارتُكبت الجريمة ضد شخص يقل عمره عن 81 عامًا.

[صفحة أصلية 95]

وجريمة انتهاك حرمة الطفل جريمة جديدة نسبياً أدخلت عام 1202 بهدف تعزيز الحماية الجنائية للأطفال الذين يشهدون جرائم معينة بين أشخاص تربطهم صلة وثيقة. ويرجع ذلك بدوره إلى أن الأطفال الذين يشهدون العنف بين الوالدين مثلاً يواجهون خطراً متزايداً للإصابة باعتلال نفسي وجسدي. وتعني هذه الجريمة أن السماح للأطفال بمشاهدة بعض الجرائم أصبح فعلاً معاقباً عليه. وفي مثل هذه الحالة يصبح الطفل مدعياً، ويحق له الحصول على ممثل قانوني للضحية. وتندرج جريمة انتهاك حرمة الطفل ضمن جريمة انتهاك حرمة الأسرة الجسيم.

وتوجد أحكام قليلة تتعلق بالأطفال الذين تعرضوا للاعتداء وغيره من أشكال العنف، استخدمت فيها المحكمة مفهوم التعذيب أو العنف الشبيه بالتعذيب. ومن هذه الأحكام حكم صادر عن محكمة استئناف سفيا (7). وتتعلق القضية بطفلين تعرضا لعنف شديد جداً من أنواع مختلفة. وشمل الحكم جريمة انتهاك حرمة الطفل والاعتداء الجسيم جداً والحرمان غير المشروع من الحرية. وكتبت المحكمة، من بين أمور أخرى:

«تُعد الأفعال الواردة في النقطتين 1 و2 اعتداءً جسيماً جداً، لأن المتهمين أظهروا، من خلال السلوك المذكور أعلاه تجاه طفل صغير قريب منهم لا حول له ولا قوة، انعدام رحمة بالغاً، وتسببوا له في معاناة شديدة جداً، أو أظهروا قسوة أو خشونة خاصتين». [...] «لقد حرم WA و AP طفلين صغيرين من حريتهما في منزلهما لمدة شهر، واعتدبا عليهما بلا رحمة بطريقة يمكن في جزء منها مساواتها بالتعذيب».

أكثر الأوضاع شيوعاً المرتبطة بالجناة الحكوميين

التعذيب في الحروب والنزاعات

في أوضاع الحرب والنزاع، عندما تنهار الهياكل المجتمعية أو تكون قاصرة، يزداد خطر تعرض الأطفال للتعذيب وغيره من الانتهاكات. وبالطبع، تختلف الأوضاع كثيراً تبعاً للبلد ونوع النزاع. ومن الأمثلة التي قد تشكل تعذيباً: العنف المسلح وغيره، والتهديد بالعنف المباشر ضد الطفل أو ضد والديه أو أقاربه الآخرين، وإجبار الطفل على تعريض الآخرين للتعذيب و/أو على أن يصبح جندياً طفلاً، والعنف الجنسي، وفصل الطفل عن والديه، والحرمان من الحرية، والعزل، وشهادة التعذيب والعنف الآخر.

وقد يتأثر الأطفال نتيجة تعذيب موجه ضد الآخرين، لكنهم قد يتضررون أيضاً، بطبيعة الحال، بسبب نشاطهم الخاص وأنشطتهم السياسية أو غيرها. وقد يكون إخضاع الطفل لاستجواب على يد الشرطة أو الجيش، ولا سيما إذا تضمن عناصر تهديد أو عنف، مخيفاً جداً له وقد يؤدي كذلك إلى إصابته بالصدمة. وقد يؤدي هذا الوضع، إلى جانب عدة أوضاع أخرى مذكورة، إلى اختلاف التقييم بحسب كون الشخص طفلاً، وبحسب صغر سنه، أو بالغاً. ويكون احتمال اعتبار الأوضاع إساءة معاملة، أو تعذيباً في بعض الحالات، أكبر بالنسبة إلى الطفل منه بالنسبة إلى البالغ.

التعذيب أثناء الفرار والهجرة

تجبر الحروب والنزاعات الناس على الفرار. وإضافة إلى الأوضاع المذكورة سابقاً، يمكن أن نضيف طرق الفرار الخطرة وأحياناً المميتة. وقد يستغرق الفرار وقتاً طويلاً جداً، أشهراً وأحياناً سنوات، يعيش خلالها الأطفال في حالة من عدم اليقين وانعدام الأمان، بدرجة شبه مستمرة. ولا توجد طرق آمنة وقانونية كثيرة للوصول إلى الحماية.

[صفحة أصلية 16]

وقد تبلغ الرحلة الخطرة، مثل الصعود قسراً إلى قارب مكتظ أو غير صالح للملاحة تقريباً، أو الاختباء في صندوق شاحنة مع خطر فقدان الحياة، مستوى التعذيب. وهناك وضع آخر ينطوي أيضاً على إعادة قسرية محظورة بموجب القانون الدولي، وهو ما يسمى عمليات الدفع إلى الوراء. فإجبار قارب يحمل لاجئين ومهاجرين، متجهاً من ليبيا إلى أوروبا مثلاً، على العودة إلى ليبيا يتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية. وقد تبلغ الرحلة الخطرة، مثل الصعود قسراً إلى قارب مكتظ أو غير صالح للملاحة تقريباً، أو الاختباء في صندوق شاحنة مع خطر فقدان الحياة، مستوى التعذيب. وهناك وضع آخر ينطوي أيضاً على إعادة قسرية محظورة بموجب القانون الدولي، وهو ما يسمى عمليات الدفع إلى الوراء. فإجبار قارب يحمل لاجئين ومهاجرين، متجهاً من ليبيا إلى أوروبا مثلاً، على العودة إلى ليبيا يتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية.

وليبيا من أخطر بلدان العالم على اللاجئين والمهاجرين، وقد أبلغت منظمات، منها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وأطباء بلا حدود، عن ذلك بوجه خاص. وهناك خطر حقيقي من تعرض الأطفال في ليبيا للتعذيب من خلال حرمانهم من حريتهم واحتجازهم في مراكز احتجاز أو سجون بانسة، من دون الحصول على الرعاية الصحية أو ما يكفي من الطعام والماء، وتعريضهم للعنف وأشكال مختلفة من الانتهاك.

وفي حكم المحكمة الأوروبية في قضية هيرسي وآخرين ضد إيطاليا، رقم 90/56772، الغرفة الكبرى، قالت المحكمة، من بين أمور أخرى، إن إيطاليا كانت تعلم أو كان ينبغي أن تعلم أن الأشخاص المعنيين، وهم إريتريون وصوماليون فروا من ليبيا باتجاه إيطاليا وأوروبا، سيواجهون خطر التعرض لمعاملة لاإنسانية أو مهينة في ليبيا. وتونس بلد آخر حالي من بين بلدان كثيرة.

وقد يكون الأطفال الذين يتعرضون لعمليات الدفع إلى الوراء قد تعرضوا بالفعل للانتهاكات، ولذلك يعرفون ما الذي يُجبرون على العودة إليه. وبصرف النظر عن تسمية الوضع عملية دفع إلى الوراء أو عدم تسميته كذلك، يمكن ملاحظة أن عدداً متزايداً من الناس يُوقفون في طريقهم إلى أوروبا. وهذا يؤثر في الأطفال بشدة. كما تشهد عدداً متزايداً من حالات ما يسمى الإرجاع القسري من البحر، أي منع الأشخاص من مغادرة بلدهم.

[صفحة أصلية 26]

وتوجد المخاطر نفسها التي يتعرض لها الأطفال الفارون لدى الأطفال المهاجرين، أي الأطفال الذين لا يغادرون بلدهم بسبب خطر الاضطهاد، بل لأسباب قوية أخرى، مثل عدم توافر فرص كسب الرزق أو التعليم أو الرعاية. والتعرض للتعذيب وإساءة المعاملة على طريق الفرار أو الهجرة، حتى على يد ممثلي السلطات وغيرهم من الفاعلين الخاصين، أمر شائع. ويكون الأطفال الذين يفرون أو يهاجرون وحدهم من دون ولي أمر أكثر تعرضًا للأذى، وأكثر اعتمادًا على المهربين. وتتعرض المخاطر نفسها التي يتعرض لها الأطفال الفارون لدى الأطفال المهاجرين، أي الأطفال الذين لا يغادرون بلدهم بسبب خطر الاضطهاد، بل لأسباب قوية أخرى، مثل عدم توافر فرص كسب الرزق أو التعليم أو الرعاية. والتعرض للتعذيب وإساءة المعاملة على طريق الفرار أو الهجرة، حتى على يد ممثلي السلطات وغيرهم من الفاعلين الخاصين، أمر شائع. ويكون الأطفال الذين يفرون أو يهاجرون وحدهم من دون ولي أمر أكثر تعرضًا للأذى، وأكثر اعتمادًا على المهربين.

التعذيب المرتبط بالاتجار بالبشر

الطفل الذي يقع ضحية للاتجار بالبشر هو من أكثر الأشخاص اختفاءً عن أنظار المجتمع. ويعبر جزء كبير من الاتجار بالبشر، سواء لأغراض جنسية أو غيرها، الحدود الدولية. ورغم أن ممثلي الدولة قد يغضون الطرف أحيانًا، مثلًا عند مراقبة الحدود، فإن الجناة غير حكوميين. وكثيرًا ما لا يتصل الطفل بأي سلطات أو مؤسسات اجتماعية، ويكون بالكامل تحت رحمة البالغين الذين يستغلونه. ومع ذلك، فمسؤولية الدولة في التصرف عند الاشتباه واضحة وكبيرة.

التعذيب في الاحتجاز والسجون والبيئات المغلقة الأخرى

تتطوي جميع أشكال البيئات المغلقة على مخاطر كبيرة لتعرض الأطفال للتعذيب. وقد يتضرر الأطفال بشدة حتى من فترات قصيرة من الاحتجاز أو الحبس، ويختبرون الألم والمعاناة بطرق تختلف عن البالغين. ويؤدي عدم فهم سبب حرمانهم من الحرية إلى تعزيز العواقب السلبية. وتختلف مخاطر التعرض لأشكال مختلفة من المعاناة الشديدة بحسب مكان الحرمان من الحرية في العالم وبحسب نوعه. وقد تكون عواقب فترات الحرمان القصيرة من الحرية كبيرة. انظر أيضًا الدراسة العالمية للأمم المتحدة بشأن الأطفال المحرومين من الحرية (9102).

وقد صرح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بأن الظروف القاسية في الاحتجاز يمكن أن تشكل تعذيبًا لبعض الأطفال بسبب قابلية الأطفال الخاصة للتعرض للأذى (8). وليس من غير المألوف أن يكون الأطفال الذين يأتون إلى السويد ويطلبون اللجوء قد عاشوا نوعًا من الحبس أو الاحتجاز في بلدهم الأصلي أو أثناء طريق الفرار.

[صفحة أصلية 36]

الفئات المهمشة في المجتمع، والأقليات الإثنية والدينية

لطالما تمتعت الأقليات، بمن فيها الأشخاص عديمو الجنسية، بحماية أسوأ أو معدومة من التعرض للانتهاكات، في جميع الأزمنة وبصرف النظر عن مكان وجودها في العالم. وينتمي عدد كبير نسبياً من الأطفال الذين يأتون إلى السويد ويطلبون اللجوء، أو الموجودين فيها دون أوراق، إلى مثل هذه الفئات في بلدانهم الأصلية. ومن المهم بوجه خاص النظر إلى الآثار التراكمية للمضايقة والانتهاكات والاضطهاد. وكما هو الحال دائماً، يجب إجراء تقييم شامل لتحديد ما إذا كان الطفل قد تعرض للتعذيب.

المخاطر في السياقات السويدية

نستعرض هنا ثلاثة أمثلة مرتبطة بالسويد: • عملية اللجوء، عندما يكون الانتهاك قد وقع في بلد آخر، لكن قصور إجراءات اللجوء قد يؤدي في أسوأ الأحوال إلى إجبار الطفل على العودة إلى وضع يوجد فيه خطر حقيقي من تعرضه للتعذيب. • البيانات المغلقة، ولا سيما المرتبطة بمجلس المؤسسات الحكومي (SiS)، حيث توجد أو وُجدت أوضاع ينبغي التحقيق فيها في إطار قواعد اتفاقية مناهضة التعذيب. • الأطفال في مراكز التوقيف والسجون.

يتعلق المثال الأول بأوضاع وقع فيها انتهاك، لكن قد توجد فيها أيضاً مخاطر مستقبلية. أما المثالان الآخران فيتعلقان بمخاطر وقوع التعذيب.

مخاطر عملية اللجوء

بعد تسجيل الشخص طالباً للجوء تبدأ عملية اللجوء نفسها. ويجب أن تكون جميع فحوص طلبات اللجوء فردية، كما يحق للجمع، بالغين وأطفالاً، الحصول على فحص وقرار خاصين بهم.

[صفحة أصلية 46]

يوجد على موقع مصلحة الهجرة السويدية معلومات موجهة إلى الأطفال، سواء الأطفال الموجودين مع أسرهم أو الأطفال غير المصحوبين، تحت عنوان «لك، بصفتك طفلاً، وقد تقدمت بطلب لجوء» (9). وتستعرض المعلومات الخطوات المختلفة، منذ وصول الشخص إلى السويد وطوال عملية اللجوء.

وفيما يتعلق بتحقيق اللجوء للأطفال الذين يطلبون اللجوء مع أولياء أمورهم، نقول المعلومات، من بين أمور أخرى:

«تحقيق اللجوء هو محادثة تتاح لك ولأسرتك فيها فرصة الحديث أكثر عن سبب رغبتكم في الحصول على اللجوء في السويد. وقد يستغرق تحقيق اللجوء مع الأسرة عدة ساعات، ولذلك قد تبقون في مصلحة الهجرة طوال اليوم. وينبغي أن تحضروا إلى التحقيق ما يسمى بالأدلة، وهي وثائق الهوية وغيرها مما يثبت صحة ما تقولونه.

ويتولى شخص من مصلحة الهجرة التحقيق ويكتب ما تتحدثون عنه في محضر. وإذا كان لديكم ممثل قانوني عام، فيمكنه مرافقتكم إلى تحقيق اللجوء. ويترجم مترجم شفوي ما تقولونه حتى يفهم بعضكم بعضاً.

وسيشارك الموظف المسؤول في مصلحة الهجرة عما عشتموه في بلدكم الأصلي، وما تعتقدون أنه سيحدث إذا عدتم إليه. كما سيطرح عليكم أسئلة عن هوياتكم وعن كيفية وصولكم إلى السويد.

وربما سمعتم هذه الأسئلة من قبل، لكن ستتاح لكم الآن مدة أطول لذكر تفاصيل أكثر مما أتيح لكم في المحادثات السابقة.

ويحق للأطفال أيضاً أن يتحدثوا.

وتنص اتفاقية حقوق الطفل على أن لك الحق في التحدث إذا أردت ذلك، وأن على جميع البالغين الذين يتخذون قرارات تؤثر في الأطفال أن يفكروا في ما هو الأفضل للطفل. وهذا يعني أن على مصلحة الهجرة أن تستمع باهتمام خاص إلى ما عاشه الأطفال طالبو اللجوء. فقد تكون للأطفال أسباب لجوء مختلفة عن أسباب والديهم. ولذلك يرغب الموظف المسؤول أيضاً في مقابلتك، إذا أردت ذلك وإذا وافق والداك. وإذا رغبت، يمكنك اصطحاب والديك أو شخص بالغ آخر تشعر معه بالأمان.

[صفحة أصلية 56]

وعندما تحقق مصلحة الهجرة في أسباب لجوئك، يجب على الموظف المسؤول تكييف التحقيق وفق عمرك ونضجك وصحتك. وإذا لم تفهم سؤالاً، فأخبره بذلك. ومن المهم أيضاً أن تخبره إذا لم تفهم المترجم. وإذا لم ترغب في الكلام إطلاقاً، فهذا مقبول أيضاً؛ إذ يمكن للموظف أن يسأل والديك عما عشته. وربما تُطرح عليك أسئلة عن أمور يصعب أو يجرح الحديث عنها. ومن المهم أن تقول الحقيقة لمصلحة الهجرة، حتى لو كان الأمر صعباً. وإذا طُرح عليك السؤال نفسه عدة مرات، فهذا لا يعني أنك أجبت إجابة خاطئة، بل يعني أن الموظف يحتاج إلى مزيد من المعلومات ويرغب فعلاً في فهم قصتك. وإذا احتجت إلى استراحة، فيمكنك أن تطلبها».

وليس من غير الإشكالي أن تكتب مصلحة الهجرة وتقول: «إذا لم ترغب في الكلام إطلاقاً، فهذا مقبول أيضاً؛ إذ يمكن للموظف أن يسأل والديك عما عشته». فنظراً إلى واجب مصلحة الهجرة في التحقيق، وإلى حق الطفل في الحصول على فحص فردي لأسباب لجونه، ينبغي أن تكون المعلومات الموجهة إلى الأطفال أكثر تخصيصاً لهم، وأن تشرح أسباب لجوء الأطفال الخاصة والحقوق التي يتمتع بها الطفل فيما يتعلق بعملية اللجوء تحديداً. ونعلم، فضلاً عن ذلك، أن الأطفال قد يتعرضون لانتهاكات لا يخبرون والديهم بها، وقد يكون الوالدان أنفسهم من الجناة. وكثير من البالغين ناجون من التعذيب وقد يكونون مصابين بالصدمة. وقد تجعل ولاءات الطفل أو خوفه من الآخرين لا يخبر بما تعرض له. كما قد يجد الوالدان، بسبب تجاربهما الخاصة، صعوبة في الانتباه الكامل إلى احتياجات الطفل.

وبالنسبة إلى الأطفال الذين وصلوا إلى السويد دون ولي أمر، ترد، من بين أمور أخرى، المعلومات التالية:

«تحقيق اللجوء هو محاثة تتاح لك فيها فرصة الحديث أكثر عن سبب رغبتك في الحصول على اللجوء في السويد. وتريد مصلحة الهجرة أن تسمع قصتك أنت عما عشته، وما تعتقد أنه سيحدث لك إذا اضطرت إلى العودة. [...] ويستغرق تحقيق اللجوء ساعتين إلى ثلاث ساعات، وستُطرح عليك أسئلة عن أمور قد يصعب أو يجرح الحديث عنها. ومن المهم أن تقول الحقيقة لمصلحة الهجرة، حتى لو كان الأمر صعباً. وإذا احتجت إلى استراحة، فيمكنك طلبها.

وعندما تحقق مصلحة الهجرة في أسباب لجونك، يجب على الموظف المسؤول أن يحاول تكييف التحقيق وفق عمرك ونضجك وصحتك. وإذا لم تفهم سؤالاً، فأخبره بذلك. ومن المهم أيضاً أن تخبره إذا لم تفهم المترجم.

وفي تحقيق اللجوء، ستُطرح عليك أسئلة عن هويتك وأسرتك وما عشته في بلدك الأصلي، وكيف وصلت إلى السويد، وما تعتقد أنه سيحدث إذا اضطرت إلى العودة. وربما سمعت هذه الأسئلة من قبل، لكن ستتاح لك الآن فرصة الحديث أكثر بكثير مما تحدثت به في محادثتك السابقة مع مصلحة الهجرة. وسيسأل الموظف أسئلة متابعة ويطلب منك ذكر مزيد من التفاصيل حتى يفهم قصتك حقاً. حاول الإجابة عن جميع الأسئلة بأكبر قدر ممكن من الدقة. وإذا طُرح عليك السؤال نفسه عدة مرات، فهذا لا يعني أنك أجبت إجابة خاطئة، بل يعني أن الموظف يحتاج إلى مزيد من المعلومات».

ويرد في الموقف القانوني لمصلحة الهجرة، «الاستماع إلى الأطفال» (01)، ما يلي:

«فيما يتعلق بالأطفال الموجودين مع أسرهم، وبخطر وقوع الطفل في وضع صعب بسبب التناقض في المعلومات الواردة في القضية، ينبغي اعتبار مصلحة الطفل الفضلى أرجح من حاجة التحقيق، بحيث لا ينبغي لمصلحة الهجرة أن تجري تحقيقات مع الأطفال بهدف إثبات عدم صحة الأسباب التي استند إليها أولياء أمورهم. ومن ثم ينبغي التحقيق في أي مؤشرات على تناقض المعلومات أو ما شابه ذلك في قضية ولي الأمر، لا من خلال التحقيق مع الطفل.

وبدلاً من ذلك، يمكن أن يركز التحقيق مع الطفل على ظروف أخرى. وقد توجد ظروف أخرى تجعل الأطفال في وضع صعب أو معرضين للآذى. فقد يكون الطفل، مثلاً، مصاباً بصدمة بسبب ما عايشه، أو ضحية جريمة أو اعتداء جنسي أو عنف أو أشكال أخرى من الاعتداء، أو شاهد عنفاً، مثل العنف داخل الأسرة.

[صفحة أصلية 76]

وعندما يكون الأمر كذلك، من المهم في وضع التحقيق إدراك أن تطبيق حق الطفل في التعبير عن رأيه بطريقة غير حساسة قد تكون له عواقب سلبية، ولا سيما في الحالات التي تتعلق بأطفال صغار جدًا. ويجب اختيار الأسئلة وطريقة طرحها باحترام لما عاشه الطفل. ويجب ممارسة الحق في أن يُسمع بطريقة تحمي الطفل. وفي مثل هذا الوضع ينبغي للمحقق أن يكون شديد الانتباه إلى ما يستطيع الطفل روايته وما قد يكون في مصلحة الطفل في وضع التحقيق. وقد يكون من المهم بوجه خاص التفكير في شكل التحقيق، وعدد فترات الاستراحة، واختيار المترجم، والممثل القانوني العام، وغير ذلك.

أما الأطفال غير المصحوبين، فالوضع مختلف قليلًا، لأنهم يفتقرون عادة إلى شخص يستطيع أن يشرح ما حدث لهم قبل وصولهم إلى السويد. وهذا يعني أن على المحقق أن يبحث جميع جوانب القضية، كما في قضايا اللجوء عمومًا.

ومن دون تقديم دعم مناسب لموظفي اللجوء في مصلحة الهجرة للتحدث مع الأطفال، يخاطر الموقف القانوني، رغم حسن نيته، بأن يؤدي إلى عدم الاستماع إلى الأطفال خوفًا من احتمال إلحاق الضرر بهم. ومن المرجح أن تكون رعاية الطفل، وعدم اليقين بشأن كيفية التحدث مع الأطفال، إلى جانب ضيق الوقت وضعف أولوية المسألة من جانب الإدارة، من أكبر أسباب عدم منح الأطفال غالبًا فحص اللجوء الفردي الذي يحق لهم. وقد يكون دليل للمحادث، مثل الدليل المذكور في الفصل الثالث، مفيدًا هنا.

قلما يحصل الطفل على فحص فردي

يتجه فحص اللجوء إلى المستقبل. والغرض من تحقيق اللجوء هو تحديد ما إذا كان الشخص يحتاج إلى الحماية لأنه، إذا عاد إلى بلده الأصلي أو البلد الذي جاء منه، يخاطر بالتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويجب دائمًا تقييم الخطر الفردي المستقبلي. وإذا كان الشخص قد تعرض بالفعل لانتهاكات جسيمة، مثل التعذيب، فهناك افتراض بأنه قد يتعرض للتعذيب مرة أخرى في المستقبل. لكن يمكن دحض هذا الافتراض أثناء التحقيق.

[صفحة أصلية 86]

ولا تعمل عملية اللجوء الخاصة بالأطفال دائماً كما ينبغي. فثمة نقص في الإجراءات المتطورة التي تتيح للأطفال عملية لجوء فردية؛ والأطفال الموجودون مع أسرهم هم الأكثر تضرراً، وينطبق ذلك على العملية برمتها. ولا يُنظر إلى الأطفال، حتى في البداية، بوصفهم أفراداً مستقلين بالطريقة نفسها التي يُنظر بها إلى البالغين.

وعندما يوجد ممثل قانوني عام، تقع عليه مسؤولية حماية مصالح موكله وتمثيل كل واحد منهم بطريقة تضمن سلامة الإجراءات. ويعني ذلك النظر إلى الأطفال، لا إلى البالغين فقط، بوصفهم أفراداً مستقلين، والتصرف باحترام عمر الأطفال ونموهم ونضجهم. وينبغي للممثل أن يلتقي موكله قبل تحقيق اللجوء الذي تجرّبه مصلحة الهجرة وأن يهيئهم له. كما يجب أن يجري محادثات فردية مع جميع موكله، وبالتالي مع الأطفال أيضاً. وأثناء تحقيق اللجوء، تقع على الممثل مسؤولية ضمان إجراء التحقيق ومشاركته فيه بطريقة آمنة ومحترمة للطفل، تتيح له فرصة الكلام.

[صفحة أصلية 96]

وإذا لم يُسأل الطفل، وهو ما يحدث كثيرًا، عما عايشه وما يخشاه إذا اضطر إلى العودة، مع طرح أسئلة متابعة ذات صلة، فمن الواضح أن الطفل لا يحصل على فحص لجوء فردي. ويعني ذلك بدوره أنه لا يمكن تقييم الخطر المستقبلي للاضطهاد، وهو الغرض من فحص اللجوء. كما يجب مراعاة أن قدرة الأطفال على تجنب المخاطر تكون عمومًا أضعف من قدرة البالغين.

ولا يمكن أيضًا تقييم أو معرفة ما إذا كان الطفل قد تعرض للتعذيب أو لانتهاكات أخرى، أو ما إذا كان مصابًا بصدمة ويحتاج إلى علاج، إلا إذا ظهرت بطريقة أخرى علامات تدل على أن الطفل ليس بخير. وهناك توافق واسع بين محامي قانون اللجوء على أن التحقيق مع الأطفال، ولا سيما الأطفال الموجودين مع أسرهم، لا يعمل. وليست المشكلة جديدة، وقد أثارها، من بين آخرين، مركز قانون اللجوء مع مصلحة الهجرة.

وبالإضافة إلى قواعد قانون اللجوء، يخاطر القصور في التحقيق بالتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك مع الحق في جبر الضرر وواجب الدولة في التحقيق مع الجناة ومقاضاتهم. وتقع المسؤولية على السلطات، وكذلك على الممثل القانوني العام.

عملية اللجوء بعد عام 6202 مع دخول ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي حيز التنفيذ

[صفحة أصلية 07]

مع دخول قواعد ميثاق الهجرة واللجوء حيز التنفيذ خلال صيف عام 2026، تحدث تغييرات كبيرة قبل عملية اللجوء وأثناءها. ويتكون الميثاق من عشرة صكوك قانونية. وهو في معظمه تشريع موحد ملزم لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد قُدِّمَ الميثاق بوصفه خطة مشتركة، وتقاسماً أقوى للمسؤولية، وإجراءات فعالة، وحماية لحق اللجوء.

قد تَقَوَّت إجراءات الفحص الأشخاص المستضعفين

النظام معقد. ويبدأ إلزامياً بما يسمى الفحص الأولي، بهدف تحديد الهوية وإجراء فحص صحي وتقييم لقابلية التعرض للأذى، فضلاً عن فحص أمني. وخلال هذه المرحلة الأولى، ستُفرض على الأشخاص بعض القيود على الحركة، مما قد يأخذ فعلياً شكل الحرمان من الحرية. وتتطوي تلك الفترة على جميع المخاطر المذكورة أعلاه المرتبطة بإبقاء الأطفال في بيئات مغلقة. وتوجد قواعد لآلية ترأب عدم انتهاك حقوق الإنسان للأشخاص المعنيين، لكن كيفية عملها لا تزال غير واضحة، وكذلك فرص الممثلين ومنظمات المجتمع المدني في لقاء طالبي اللجوء ودعهم.

وتوجد صورتان مختلفتان لإجراءات فحص الحاجة إلى الحماية. الأولى هي إجراء لجوء يشبه النظام الحالي، وينبغي اتخاذ القرار فيه خلال ستة أشهر. والثانية ما يسمى إجراء الحدود الخاص باللجوء للأشخاص الذين يُقدَّر أنهم لن يحصلوا على الحماية على الأرجح. وسيحتجز هؤلاء الأشخاص في مساكن خاصة تسمى مساكن قريبة من الحدود، وينبغي اتخاذ القرار خلال ثلاثة أشهر، بما في ذلك الاستئناف.

وهناك مخاطر كبيرة من تضرر الأطفال، سواء بسبب أوجه القصور في ضمانات الإجراءات القانونية والرعاية أثناء الإجراء نفسه، أو بسبب عدم حصولهم في بعض الحالات على الحماية رغم حاجتهم إليها نتيجة أوجه القصور في الإجراء.

كما ستتسع إمكانية استخدام ما يسمى البلدان الثالثة الآمنة، وكذلك ما يسمى الأجزاء الآمنة من بلدان لا تُعد آمنة في مجملها، وإرسال الأشخاص الذين يقصدون طلب اللجوء في السويد إلى مثل هذه البلدان. ومع ذلك، لا ينبغي للأطفال غير المصحوبين المرور بإجراء الفحص الأولي.

[صفحة أصلية 17]

وقد أعدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إرشادات بشأن الأطفال اللاجئين (11) والأطفال اللاجئين غير المصحوبين (21). وتشير المفوضية، من بين أمور أخرى، إلى ضرورة مراعاة عوامل موضوعية إضافية في بلد الأصل وفي الأسرة عندما يتعلق الأمر بطفل يطلب اللجوء. وينبغي تطبيق قاعدة الاستفادة من الشك بدرجة واسعة. كما تشدد المفوضية على أن خوف الأطفال قد يتخذ أشكالاً مختلفة عن خوف البالغين، وتشير إلى اتفاقية حقوق الطفل وحقوق الأطفال الخاصة. وقد تكون انتهاكات هذه الحقوق مختلفة عن انتهاكات حقوق البالغين وتتخذ أشكالاً أخرى.

فحوص إصابات التعذيب وحكم المحكمة الأوروبية في قضية CR ضد السويد

يشكل حكم للمحكمة الأوروبية (31) خلفية الموقف القانوني لمصلحة الهجرة بشأن الفحوص الطبية للإصابات المدعى بها (41). وخلاصة الأمر أن الحكم يتعلق بعدم تحقيق السلطات بما يكفي في المعلومات التي قدمها طالب اللجوء بشأن إصابات أعقبت التعذيب.

وأكدت المحكمة العليا للهجرة أيضاً، في تلك القضية، مسؤولية محكمة الهجرة عن التحقيق عندما قدم طالب اللجوء شهادة طبية تشير إلى أنه ربما تعرض للتعذيب في بلده الأصلي (GIM 2:2102).

وينص الموقف القانوني لمصلحة الهجرة على ما يلي:

«ينبغي منح الشخص الذي يحتج بإصابات لاحقة للتعذيب أو لمعاملة أخرى تؤسس للحماية، ويقدم شهادة تشير إلى أنه ربما تعرض لمعاملة كهذه، فرصة إجراء فحص إضافي للإصابات على نفقة الدولة».

وبعبارة أخرى، توصي مصلحة الهجرة في موقفها القانوني بأن يخضع مقدم الطلب لفحص لإصابات التعذيب.

[صفحة أصلية 27]

وبطبيعة الحال، يمكن لمصلحة الهجرة أيضاً أن تبدأ هذا الفحص مباشرة، ومن دون شهادة طبية، في الحالات التي ترى فيها أن ذلك مهم لتقييم احتياجات الحماية في القضية.

ومن المرجح وجود عدد كبير غير معروف من الأطفال الذين تعرضوا للعنف والتهديد، ولأوضاع يمكن أن تنطوي على تعذيب، ولم يخضعوا لفحص طبي لإصابات التعذيب. وعندما يوجد ممثل قانوني عام، لا يمتلك الممثل دائماً المعرفة ذات الصلة بأهمية طلب أن تبدأ مصلحة الهجرة فحصاً لإصابات التعذيب.

ومع قواعد ميثاق الهجرة واللجوء التي تعني إجراء أسرع، ووصولاً أضعف إلى الممثلين والممثل القانوني العام، ونظام البلدان المسماة آمنة، يوجد خطر واضح من تضرر الأطفال أيضاً في هذا الجانب، وحصولهم بدرجة أقل على الخبرة الطبية.

احتياجات الرعاية: أسباب إنسانية أم أسباب حماية؟

عندما يطلب شخص اللجوء، يجب مراعاة جميع الأسباب التي قد تمنحه الحق في الحصول على تصريح إقامة في السويد. وعلى مصلحة الهجرة ومحاكم الهجرة أن تراجعاً من تلقاء نفسيهما أسس الإقامة المحتملة، حتى إن لم يُحتج بسبب معين.

وتُعد الأمراض واحتياجات الرعاية عمومًا أسبابًا إنسانية. لكنها قد تشكل في بعض الحالات أساساً للحق في الحماية، وعندها تتدخل القواعد الملزمة في القانون الدولي بشأن حظر التعذيب ومبدأ عدم الإعادة القسرية في الصورة. ومن المهم هنا أيضاً إيلاء اهتمام خاص لاتفاقية حقوق الطفل، ومبدأ مصلحة الطفل الفضلى، وقابلية الطفل الخاصة للتعرض للأذى.

ومن ثم قد يكون فحص حظر التعذيب ذا صلة بالمسائل المتعلقة بالصحة والوصول إلى الرعاية. وقد يشكل، في بعض الحالات، معاملة قاسية أو لاإنسانية أن يُعاد الشخص إلى بلد لا يحصل فيه فعلياً على الرعاية ذات الأهمية الحاسمة لبقائه أو لقدرته على الحفاظ على حياة طبيعية إلى حد معقول.

[صفحة أصلية 37]

وقد يكون مفهوم التعذيب ذا صلة بشخص يعاني من صدمة مرتبطة بتعذيب سابق في البلد الذي يطلب الحماية منه. وقد شددت المحكمة الأوروبية، في قضية بابوشفيلي ضد بلجيكا (51)، ولاحقاً في قضية سافران ضد الدنمارك (61)، على أهمية ألا يكون الوصول إلى الرعاية بالنسبة إلى الفرد وهمياً، بل حقيقياً.

وفي الحكم الذي فُحص فيه حظر التعذيب الوارد في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية، قالت المحكمة إنه إذا وجدت أسباب وجيهة للاعتقاد بأن شخصاً سيتعرض لمعاملة مخالفة للمادة 3، فلا يجوز ترحيله، وبالتالي يجب منحه تصريح إقامة في البلد. ومن المهم إدراك أن العتبة هنا مرتفعة.

وتقرر المحكمة أنه يجب مراعاة الوضع العام والوضع الفردي على السواء. فلا يكفي أن يكون دواء أو عملية أو رعاية معينة متاحة في البلد، بل يجب أن تكون متاحة فعلياً للفرد المعني. ويجب إجراء هذا الفحص في كل حالة فردية. وتوضح وثيقة الموقف القانوني لمصلحة الهجرة، «تطبيق المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية عندما يُحتج بالمرض» (71)، كيفية إجراء الفحص وفقاً لمصلحة الهجرة.

مخاطر الرعاية القسرية، ورعاية الأحداث المغلقة، ومراكز التوقيف

من أمثلة السياقات التي يرتفع فيها خطر تعرض الأطفال للتعذيب المؤسسات المغلقة. ويصف مجلس المؤسسات الحكومي (SiS) نفسه على موقعه على النحو التالي (81):

«يدير مجلس المؤسسات الحكومي، SiS، رعاية قسرية مكيفة فردياً وينفذ رعاية الأحداث المغلقة. وبالتعاون مع الخدمات الاجتماعية، نمنح الشباب والعملاء ذوي المشكلات النفسية الاجتماعية الخطيرة والواسعة شروطاً أفضل لحياة اجتماعية فعالة من دون إساءة استعمال المواد المخدرة أو الجريمة».

[صفحة أصلية 47]

وتوجد تقارير كثيرة عن أوجه القصور في طريقة عمل مؤسسات Sis. وللاطلاع، يُحال القارئ إلى تقارير مكتب حقوق الطفل وتحقيقات أمين المظالم البرلماني (91-62)، وكذلك تقرير معهد حقوق الإنسان «مؤسسات الشباب الحكومية المغلقة، مؤسسات عصرنا للأطفال والشباب ذوي الإعاقة» (72). والوضع خطير جدًا.

ومن الأمور التي شهد بها الأطفال ووثقت: التتمر، والشعور بعدم الأمان مع العاملين والنزلاء الآخرين، واستخدام العاملين العنف بلا مبرر، والتهديد، والتهديد بالعنف، والعقوبات، والمعاملة السيئة والتهديدية، والتحرش الجنسي من العاملين، وإجبار الأطفال على مشاهدة تعرض آخرين للعنف، وفي بعض الحالات تقييدهم وعزلهم بطرق تتعارض مع القواعد.

ومن الواضح أن معاملة بعض الأطفال تبلغ حد الحظر الوارد في القانون الدولي في اتفاقية مناهضة التعذيب، أو تشكل، في أقل تقدير، إساءة معاملة. لكن هذا الأمر لم يُفحص قط، لا في السويد ولا في المحافل الدولية. ولا يمكن، فضلاً عن ذلك، فحص المسألة في السويد لأن التعذيب ليس جريمة معاقباً عليها.

وقد أصدر أمين المظالم البرلماني، في إطار نشاطه بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وهو جهاز الزيارات الوطني الذي يزور بانتظام الأماكن التي يُحتجز فيها الأشخاص وفقاً للبروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، عدة تقارير عن نشاط Sis تحديداً.

وقال أمين المظالم توماس نورلينغ، بعد تفتيش دار الأحداث سونديو في 7 و8 نوفمبر 8102 (52)، ما يلي، مع وجود تحقيقات وتحديثات لاحقة عدة:

«الغرض من النشاط هو، في المقام الأول، أن يكون وقائياً، ومن ثم تحديد عوامل، منها تلك التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تعرض الناس لمعاملة قاصرة. ويشكل الأطفال والشباب فئة ضعيفة، وبالتالي جديرة بحماية خاصة في المجتمع. ولذلك يكون من الخطير جداً دائماً ظهور معلومات عن تعرض هذه الفئة لمعاملة قاصرة. ويكون الأمر أخطر بوجه خاص عندما تتعلق الادعاءات بأطفال وشباب محرومين من حريتهم، لا يحظون، نتيجة ذلك، بالدعم الذي يمكن توقعه عادة من البالغين المحيطين بهم، ويجدون صعوبة خاصة في إيصال أصواتهم.

[صفحة أصلية 57]

إن الوضع الخاص شديد التعرض للأذى الذي يوجد فيه المحرومون من الحرية يجعل على السلطات المعنية دائماً أن تأخذ المعلومات عن العنف وأوجه القصور الأخرى على محمل الجد. ويشمل ذلك التحقيق الفوري في هذه الادعاءات، ثم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أوجه القصور المحتملة. ومن طبيعة الأمر، ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال والشباب، أن يكون من الضروري أيضاً اتخاذ تدابير عاجلة ريثما تكتمل التحقيقات المحتملة.

وخلال إشراف هيئة التفتيش على الرعاية والصحة على دار الأحداث سونديو عام 7102، ظهرت معلومات من عدة شباب عن أوجه قصور خطيرة في طريقة معاملة العاملين لهم في جناح أسبن. وذكر الشباب، من بين أمور أخرى، أن العاملين استخدموا ضدهم عنفاً متعمداً، أي اعتداءً. ورأت الهيئة أن المعلومات من طبيعة تستلزم اتخاذ الدار تدابير. وهذا يعني أن إدارة دار سونديو كانت، منذ ذلك الوقت على الأقل، مدركة تماماً أن الأمور لم تكن تسير على ما يرام في الجناح.

ومن خلال بلاغات «ليكس سارة» الخاصة بمجلس المؤسسات الحكومي، وعددها خمسة خلال أقل من عامين، يتضح وقوع عدد من الأحداث الخطيرة جداً التي تتفق مع روايات الشباب. وأثناء تفتيش البروتوكول الاختياري، تحدث موظفونا مع عدد كبير من الشباب الموجودين في جميع الأجنحة المغلقة في دار الأحداث. وقدم نحو نصف هؤلاء الشباب روايات مماثلة عموماً لما ورد في قرار الهيئة الصادر في يناير من ذلك العام. كما تحدث موظفو الهيئة مع شباب في جميع الأجنحة المغلقة، ووصف عدة شباب تجارب عنف و/أو تهديد بالعنف.

[صفحة أصلية 67]

ويمكنني، بناءً على ذلك، أن أقرر أنه بعد مرور عام على تفتيش الهيئة، لا تزال معلومات مماثلة تظهر في المحادثات مع الشباب. وتختلف إفادات الشباب في مقدار التفاصيل. فبعضهم يصف الأوضاع بعبارات عامة، بينما يقدم آخرون أوصافاً أكثر تفصيلاً لما يدّعى أنه حدث. وينبغي ذكر أن أجزاء من إفادتين تتوافق مع ما رواه الشباب لموظفي الهيئة. ويُفترض أن الأحداث وقعت خلال العام، أي بعد إجراء موظفي الهيئة محادثاتهم.

وفي المحادثات مع موظفينا، ذكر شباب أن العاملين إما أدخلوا الشباب إلى أماكن لا توجد فيها مراقبة بالكاميرات أو تبعوهم إليها، وأن أحداثاً وقعت هناك أدت إلى إصابة الشباب بأضرار جسدية. وفي بعض المحادثات، قدم شباب لم يتعرضوا هم أنفسهم للعنف معلومات عن رؤيتهم شباباً آخرين يتعرضون له. ومع ذلك، فمن الخطير أن يكون هناك اعتقاد منتشر نسبياً بين الشباب في الدار بأن العاملين في جناح أسبن يعرضون الشباب للعنف.

وتقول هيئة التدقيق الوطنية، في تقرير المراجعة «دور الشباب الخاصة التابعة لمجلس المؤسسات الحكومي: أوجه القصور في رعاية الدولة القسرية للأطفال والشباب»، من بين أمور أخرى، إن الأطفال والشباب الذين يوضعون في مؤسسات SiS لا يحصلون دائماً على رعاية وعلاج فعالين (82). ولتحقيق التحسينات، يلزم إجراء تغييرات داخل SiS وخارجها.

[صفحة أصلية 77]

وقد يؤدي عدم حصول الأطفال والشباب على الرعاية والعلاج المقصودين من الإبداع إلى زيادة احتمال عودتهم إلى الجريمة أو إساءة استعمال المواد المخدرة أو غير ذلك من السلوكيات الهدامة. وهذا قد يؤدي بدوره إلى تكاليف كبيرة على المجتمع والفرد، مالية وإنسانية.

وقد نشرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب على موقعها دليلًا جيدًا جدًا بشأن الأطفال المحرومين من حريتهم وكيفية حمايتهم على أفضل وجه من الانتهاكات في البيئة المغلقة، بعنوان «أفضل الممارسات لحماية الأطفال في الاحتجاز» (92).

ومن التوصيات التي يمكن الاسترشاد بها: 1. مراقبة البيانات المغلقة الخاصة بالأطفال وتفتيشها. 2. نشر المعلومات وإتاحتها للجمهور. 3. استخدام أنشطة المناصرة لتحقيق التغييرات اللازمة في القوانين والتعليمات. 4. العمل على مكافحة الإفلات من العقاب واستخدام التقاضي الاستراتيجي، مع توفير تدريب موجه. 5. تقديم دعم مباشر للأطفال المحرومين من حريتهم أو الموضوعين تحت الرعاية. 6. الجمع بين أنشطة مختلفة. 7. الاستماع إلى الأطفال. 8. إنشاء شبكات وشراكات. 9. متابعة الأطفال مع مرور الوقت.

ازدياد وضع الأطفال في مراكز التوقيف ورعاية الأحداث المغلقة، أي سجون الأحداث

يوضع عدد متزايد من الأطفال المشتبه في ارتكابهم جرائم في مراكز التوقيف، مع فرض قيود عليهم. وتوجد قواعد خاصة بشأن معاملة الأطفال في مراكز التوقيف، لكنها لا تُتبع دائمًا. وكثيرًا ما يُذكر ارتفاع الإشغال، وأحيانًا الاكتظاظ، مقترنًا بنقص الموارد البشرية سببًا لذلك.

وبموجب قانون مراكز التوقيف، يحق للأطفال المحتجزين أربع ساعات يوميًا تكسر عزلتهم، أي فرصة الاختلاط بالعاملين أو بغيرهم (الفصل 2، المادة 5 أ من قانون مراكز التوقيف). وقد لفت المحامون ووحدة البروتوكول الاختياري التابعة لأمين المظالم البرلماني، وكذلك لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، الانتباه إلى أن هذا الأمر لا يعمل في أماكن كثيرة.

[صفحة أصلية 87]

وقد أدرجت وحدة البروتوكول الاختياري التابعة لأمين المظالم، التي تعمل تحديداً في موضوع الحرمان من الحرية، في تقرير عام 2020 الآثار الصحية السلبية التي أظهرتها الأبحاث للعزل المطول. وتشمل القائمة، من بين أمور أخرى، الأرق والارتباك والهلوسة والذهان ونوبات الهلع والاكتئاب وخطر السلوكيات المؤذية للذات، فضلاً عن الأعراض الجسدية مثل مشكلات المعدة والأمعاء والصداع النصفي والإرهاق المزمن. ووفقاً للأبحاث، تكون الآثار السلبية للعزل أوضح لدى الأطفال. ويكون خطر السلوك المؤذي للذات أكبر بكثير لدى الأطفال منه لدى البالغين (03).

ووجهت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في أحدث مراجعة لها، انتقادات جديدة إلى السويد بسبب الأطفال المحتجزين مع فرض قيود عليهم (13).

وأخيراً، ينبغي ذكر اتفاقية مجلس أوروبا لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، التي اعتُمدت عام 1987. وقد أنشأت الاتفاقية لجنة مجلس أوروبا لمنع التعذيب (TPC). وتتمثل مهمة اللجنة في فحص معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، كإجراء وقائي لحماية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. وتفحص اللجنة الدول الأعضاء في مجلس أوروبا بطريقة تشبه الفحص في منظومة الأمم المتحدة. وقد فُحصت السويد آخر مرة عام 2012، ووجهت إليها، من بين أمور أخرى، انتقادات جديدة بسبب الاستخدام الواسع للقيود في مراكز التوقيف، دون ذكر خاص للأطفال في مراكز التوقيف (23).

ما ينبغي أن نفعله

تقول لجنة مناهضة التعذيب (TAC) في تعليقها العام رقم 2 ما يلي:

11. «تري اللجنة أن تعريف جريمة التعذيب بوصفها منفصلة عن الاعتداء العادي أو الجرائم الأخرى سيعزز مباشرة لدى الدول الأطراف الغرض العام للاتفاقية، وهو منع التعذيب وغيره من إساءة المعاملة. وإن تسمية هذه الجريمة وتعريفها سيعززان غرض الاتفاقية، من خلال لفت انتباه الجميع، بمن فيهم الجناة والضحايا والجمهور، إلى الخطورة الخاصة لجريمة التعذيب. كما أن تدوين هذه الجريمة سيؤدي إلى: (أ) التأكيد على الحاجة إلى عقوبة مناسبة تراعي خطورة الجريمة؛ (ب) تعزيز الأثر الرادع للحظر نفسه؛ (ج) تحسين قدرة الموظفين المسؤولين على اكتشاف جريمة التعذيب المحددة؛ و(د) تمكين الجمهور ومنحه السلطة لمراقبة تصرف الدولة، وكذلك تقاعسها، فيما يتعلق بالاتفاقية، والطعن فيه عند الحاجة».

عُذِّبَ فِي طِفْلَتِهِ

[صفحة أصلية 97]

توصيات ومطالب

• ينبغي للسويد أن تدرج التعذيب بوصفه جريمة معاقبًا عليها في تشريعاتها. • ينبغي للسويد أن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الذي يمنح حق تقديم شكوى فردية. • ينبغي لجميع السلطات، بما فيها سلطات إنفاذ القانون، وجميع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، ونقابة المحامين، تنفيذ تدابير لرفع المعرفة بشأن الأطفال والتعذيب. وينبغي أن يشمل العمل خفض سن المسؤولية الجنائية وغيرها من المقترحات والتدابير التشريعية ذات الصلة. • ينبغي لمصلحة الهجرة، بالتعاون مع منظمات حقوق الطفل وحقوق الإنسان ذات الصلة، وبمشاركة ممثلين عن الممثلين القانونيين العامين، مراجعة إجراءات العمل عند فحص طلبات لجوء الأطفال، بهدف منح الأطفال عملية لجوء فردية، والتمكن من اكتشاف الأطفال الذين نجوا من التعذيب. • ينبغي للسلطات، ومنها أمين المظالم البرلماني وأمين مظالم الأطفال ومعهد حقوق الإنسان ومصلحة الهجرة، أن تستخدم، في الحالات ذات الصلة، مفهوم التعذيب أو إساءة المعاملة الأخرى، بهدف تحقيق أغراض اتفاقية مناهضة التعذيب، ومنع إخفاء المشكلة، وإتاحة حصول الأطفال على جبر الضرر. وينطبق الأمر نفسه على منظمات المجتمع المدني. • ينبغي لباحثي قانون الهجرة أن يجرؤوا أبحاثًا بشأن الأطفال والتعذيب. • ينبغي للمحامين المتخصصين استخدام التقاضي الاستراتيجي بهدف عرض القضايا المتعلقة بالأطفال الناجين من التعذيب على لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيرها من المحافل ذات الصلة. • ينبغي إشراك الأطفال والاستماع إليهم واستشارتهم في جميع السياقات ذات الصلة.

المراجع

1. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (TCMO). ما التعذيب؟ متاح من: erutrot-si-tahw/era-ew-ohw/ne/gro.tcmo.4c//:sptth [تم الاطلاع في 62 سبتمبر 2025].
2. G iloM eL. التعذيب على يد فاعلين غير حكوميين: أربعة استفسارات. retnl fo lanruoJ. ecitsuj lanimirC lanoitan lanimirC lanoitanretnl fo lanruoJ؛ 1202؛ 91(2):363-193. 920baqm/jcij/3901.01:iod.
3. M kawoN. هل يمكن للفاعلين الخاصين ارتكاب التعذيب؟ ecitsuj؛ 1202؛ 91(2):514-324. 130baqm/jcij/3901.01:iod. 4. وزارة العدل. جريمة تعذيب خاصة؟ 24:5102 sD. ستوكهولم: مكتب الحكومة؛ 5102. 5. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. آدين ضد تركيا، حكم 52 سبتمبر 7991. 6. الحكومة. المقترح 32/2202: تشديد العقوبات على الجرائم العنيفة الخطيرة، وغير ذلك. ستوكهولم: مكتب الحكومة؛ 3202. 7. محكمة استئناف سفيا. الحكم في القضية B 42-566، 02 أبريل 4202. 8. الأمم المتحدة. تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خوان إي. مينديز. 86/82/CRH/A. جنيف: الأمم المتحدة؛ 5102. 9. مصلحة الهجرة. لك، بصفتك طفلاً، وقد تقدمت بطلب لجوء. متاح من: www.//:sptth. mos-gid-rof/tellahmas-aksnevs-ted-mo/es.tekrevsnaitargim.
10. مصلحة الهجرة. الموقف القانوني 0202/010/SR: الاستماع إلى الأطفال. 0202. 11. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. الأطفال اللاجئين: إرشادات بشأن الحماية والرعاية. جنيف: المفوضية؛ 4991. متاح من: fdp.76c6c48b3/fdp-ycagel/selif/tluafed/setis/gro.rchnu.www.//:sptth [تم الاطلاع في 62 سبتمبر 2025].
21. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. إرشادات بشأن السياسات والإجراءات المتعلقة بالأطفال غير المصحوبين طالبي اللجوء. جنيف: المفوضية؛ 7991. 31. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. CR ضد السويد، حكم 9 مارس 0102. 41. مصلحة الهجرة. الموقف القانوني 1202/220/SR: الفحوص الطبية للإصابات المدعى بها. 1202. 51. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. بابوشفيلي ضد بلجيكا، حكم 31 ديسمبر 6102. 61. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. سافران ضد الدنمارك، حكم 7 ديسمبر 1202. 71. مصلحة الهجرة. الموقف القانوني 0202/800/SR: تطبيق المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية عندما يُحتج بالمرض. 0202. 81. مجلس المؤسسات الحكومي (SiS). عن SiS. متاح من: sis-mo/es.eslerytssnaitutitsnisnetats//:sptth [تم الاطلاع في 62 سبتمبر 2025].
91. مكتب حقوق الطفل. «... ولم أستطع التنفس»: تحقيق في العنف ضد الأطفال في دور الشباب الحكومية. ستوكهولم: مكتب حقوق الطفل؛ 1202. 02. مكتب حقوق الطفل. «من سيصدقني؟»: تحقيق في الاعتداءات الجنسية في دور الشباب الحكومية. ستوكهولم: مكتب حقوق الطفل؛ 3202. 12. مكتب حقوق الطفل. العزل والعنف وأوجه القصور في رعاية الشباب التابعة لمجلس المؤسسات الحكومي. ستوكهولم: مكتب حقوق الطفل؛ 4202. 22. أمين المظالم البرلماني. تفتيش البروتوكول الاختياري لمجلس المؤسسات الحكومي، دار الشباب في فيميرا، 21-31 أبريل 2202.

32. أمين المظالم البرلماني. تفتيش البروتوكول الاختياري لمجلس المؤسسات الحكومي، دار الشباب في براته غوردن، 3-5 يوليو 3202. 42. أمين المظالم البرلماني. تفتيش البروتوكول الاختياري لمجلس المؤسسات الحكومي، دار الشباب في سونديو، 51 مارس 1202. 52. أمين المظالم البرلماني. تفتيش البروتوكول الاختياري لمجلس المؤسسات الحكومي، دار الشباب في سونديو، 6-7 نوفمبر 8102. 62. أمين المظالم البرلماني. تفتيش البروتوكول الاختياري لمجلس المؤسسات الحكومي، دار الشباب في لونغانيس، 22-42 أكتوبر 9102. 72. معهد حقوق الإنسان. دور الشباب الحكومية المغلقة: مؤسسات عصرنا للأطفال والشباب ذوي الإعاقة. لوند: معهد حقوق الإنسان؛ 5202. 82. هيئة التدقيق الوطنية. دور الشباب الخاصة التابعة لمجلس المؤسسات الحكومي: أوجه القصور في رعاية الدولة القسرية للأطفال والشباب. 7:4202 RiR. ستوكهولم: هيئة التدقيق الوطنية؛ 4202. 92. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (TCMO). أفضل الممارسات لحماية الأطفال من التعذيب أثناء الاحتجاز. متاح من: er/secruuser/ne/gro.tcmo.www//:sptth [تم الاطلاع في 62 سبتمبر 5202]. 03. U retsÖ، T nostunk. الأطفال المحبوسون. netakovda.netakovda.www//:sptth (3)19؛ 5202. متاح من: rn/5202/remmun-eragidit/es.netakovda.www//:sptth. 13. لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثامن للسويد. 8/OC/EWS/C/TAC. 02 ديسمبر 1202. متاح من: ctac/snoitavresbo-gnidulcnoc/stnemucod/ne/gro.rhcho.www//:sptth nedews-troper-cidoirep-hthgie-snoitavresbo-gnidulcnoc-8ocews 02 أكتوبر 5202. 23. لجنة مجلس أوروبا لمنع التعذيب (TPC). تقرير عن الزيارة الدورية إلى السويد. fnl/TPC (1202) 02. ستراسبورغ: مجلس أوروبا؛ 1202. متاح من: nedews/tpc/bew/ne/tni.eoc.www//:sptth [تم الاطلاع في 02 أكتوبر 5202].

عُذِّبَ فِي طِفْلَتِهِ

[صفحة أصلية 38]

عُذِّبَ فِي طِفْلَتِهِ

[صفحة أصلية 48]

الجزء الثاني التعرّف والتوثيق

عُذِّبَ فِي طِفُولَتِهِ

عُذِّبَ فِي طِفُولَتِهِ

[صفحة أصلية 58]

عُذِّبَ فِي طِفُولَتِهِ

[صفحة أصلية 68]

جوليا ينشتول هي أخصائية نفسية مرخصة وأستاذة مشاركة في العلوم السياسية. عملت سريريًا في مركز الصليب الأحمر السويدي لعلاج المتضررين من الحرب والناجين من التعذيب في أوبسالا. وتشمل أبحاثها مجالات مختلفة، منها عمليات النفوذ والتأثير، والقيم الديمقراطية، والعلاج المكثف لاضطراب الكرب التالي للصدمة.

الفصل الثالث سؤال الأطفال عن التعذيب

يلزم اتخاذ تدابير لاكتشاف الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان حصولهم على الدعم والعلاج وجبر الضرر، وتمكينهم من التمتع بحقوقهم القانونية. ويسلط هذا الفصل الضوء على الحاجة إلى نهج واعٍ بالتعذيب في محادثات المهنيين مع الأطفال، بهدف تحسين فرص اكتشاف الناجين من التعذيب.

[صفحة أصلية 78]

تفتقر معظم السلطات والمؤسسات ومقدمي الرعاية الصحية في الوقت الحاضر إلى المعرفة والإجراءات اللازمة للسؤال عن التعذيب عند لقاء الأطفال (1). وفي الوقت نفسه، يوجد عدد كبير غير معروف من الأطفال الناجين من التعذيب (2-4). وعندما لا يسأل أحد عن التعذيب، لا تحصل هذه الفئة من الأطفال المتضررين من العنف على الدعم والرعاية والعلاج وجبر الضرر الذي يحق لهم بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (7911:8102 SFS) واتفاقية مناهضة التعذيب (1:6891 ÖS).

وفي تحقيق الحكومة السويدية «نشأة خالية من العنف» (07:2202 UOS)، أثرت مسألة التعذيب بوصفها جزءًا من النقاش حول الفئات المعرضة للأذى بوجه خاص. ويؤكد التحقيق أن الأشخاص الذين تعرضوا لعنف جسيم، بما في ذلك التعذيب، لديهم احتياجات واسعة إلى الدعم والعلاج. ويوصف الناجون من التعذيب بأنهم فئة يصعب اكتشافها بوجه خاص، بسبب الثغرات المعرفية لدى المهنيين وغياب الإجراءات التي تسأل عن التعرض للعنف في أوضاع الحياة السابقة (5).

وفي حين يسلط التحقيق الضوء على التعذيب، فإنه لا يتحدث عن الأطفال الناجين من التعذيب. وينصب التركيز أساسًا على البالغين والعواقب غير المباشرة على الأطفال الذين يعيشون مع مقدمي رعاية مصابين بالصدمة، بينما تُحجب تجارب الأطفال أنفسهم مع التعذيب عن الأنظار.

وعواقب الأطفال الذين لا يُكتشفون خطيرة وتستمر مدى الحياة. ويصعب عليهم عيش حياة طبيعية، لأنهم غالبًا ما يوجدون في أوضاع حياتية معرضة للأذى، مع خطر متزايد للتعرض للعنف مرة أخرى، أي إعادة الوقوع ضحية، ولأشكال مختلفة من الانتهاكات، وهو ما يسمى في سياق البحث التعرض المتعدد للأذى.

ويُعد التعرض المتعدد للأذى أحد أكبر عوامل الخطر للمشكلات النفسية والجسدية طويلة الأمد، ويرتبط بأعراض معقدة مثل صعوبة إقامة علاقات مع الآخرين، وضعف النتائج الدراسية، وارتفاع خطر السلوك المؤذي للذات والتعرض للعنف مستقبلاً (6-11).

[صفحة أصلية 88]

ويُعد الاكتشاف المبكر للناجين من التعذيب وللأطفال المتعرضين لأذى متعدد أمراً حاسماً لكسر دوائر العنف والاعتلال الصحي. وينبغي في قطاع الرعاية الصحية إعطاء الأولوية لمن لديهم أكبر الاحتياجات، وإيلاء اهتمام خاص للفئات التي نادراً ما يُسمع صوتها. ووفق مبدأي الحاجة والتضامن، ينبغي منح الأطفال الناجين من التعذيب أولوية أوضح في الرعاية: موارد أكثر، ومساحة أكبر، وحماية أقوى.

وبالإضافة إلى حاجة الناجين من التعذيب إلى الرعاية وحققهم فيها، توجد أسباب قانونية أيضاً لإعطاء الأولوية لاكتشافهم. فاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تمنح الأشخاص المتضررين من التعذيب حقوقاً محددة، ولا يمكن إعمال هذه الحقوق من دون اكتشافهم (21).

وقد يؤدي تحديد الأطفال المعرضين للأذى إلى آثار إيجابية لا على مستوى الفرد فحسب، بل على مستوى الفئة والمجتمع أيضاً. فالإكتشاف المبكر للأطفال المتضررين من العنف إجراء وقائي لمواجهة تجنيد الأطفال والشباب في الشبكات الإجرامية.

وتُظهر دراسة عُرضت مؤخراً عن الأطفال والشباب الذين انخرطوا في الجريمة واستغلوا فيها أن معظم هؤلاء الشباب يحملون تجارب مبكرة مع العنف، لكن عدداً قليلاً جداً منهم سُئل أثناء نشأته عن تعرضه هو للعنف. وتُعد أساليب الاكتشاف المبكر للتعرض للعنف حجر الأساس في العمل الوقائي الرامي إلى منع انجراف الشباب إلى الجريمة (31).

وهناك، علاوة على ذلك، افتراض مفاده أنه عندما يصبح العنف قابلاً للكلام، وعندما توضع التجارب في كلمات ويصبح من الممكن مشاركتها مع الآخرين، يصبح جبر الضرر ممكناً. وقد تؤدي مشاركة التجارب إلى الشعور بالترابط وبنوع من المعنى للمعاناة. وتُعد روايات التعذيب شهادات يمكن استخدامها في أعمال التأثير والمناصرة. وعلى مستوى المجتمع، يمكن جمع هذه الروايات والمساهمة في تعبئة الموارد لمواجهة استمرار الانتهاكات والتعذيب.

[صفحة أصلية 98]

لكن اكتشاف الأطفال المتضررين من العنف صعب. ومن أكبر التحديات أن العنف يجعل الناس يصمتون. فالعنف الجسيم والمهين، ولا سيما التعذيب، من المحرمات بالنسبة إلى كثيرين، ويثير بسهولة مشاعر العار والذنب. ويجد الأطفال بوجه خاص صعوبة في وضع تجارب العنف في كلمات وجعلها قابلة للحديث.

ولكي يكتشف البالغون التعرض للعنف، عليهم أن يمنحوا الأطفال أدوات للحديث عن العنف، وأن يساعدوهم على تسمية المخيف والمحرم وتقليل الوصمة. ويُجز المهنيون هذا العمل كل يوم عندما يسألون الأطفال، في لقاءاتهم معهم، عن العنف وإساءة المعاملة. وتساعدهم في ذلك إجراءات واستمارات مجربة ومفيدة للسؤال عن التعرض للعنف، لكن لا توجد أداة تتناول التعذيب بصورة شاملة.

يتناول هذا الفصل المشكلات المركزية ومجالات التطوير في العمل على اكتشاف الأطفال الناجين من التعذيب. وتناقش أوجه القصور والتحديات العامة في الإجراءات، ثم يُعرض نموذج أولي لأداة دعم جديدة شاملة وحساسة للتعذيب، لاستخدامها في المحادثات مع الأطفال عن العنف.

ويركز هذا الفصل على اكتشاف التعذيب، أما مسائل التحقيق في إصابات التعذيب وتوثيقها فتُعالج في الفصل الرابع.

لماذا يسود هذا الصمت بشأن الأطفال الناجين من التعذيب؟

توجد تفسيرات كثيرة لعدم ظهور الناجين من التعذيب على رادار الجهات المعنية. ونستعرض هنا مزيجاً من العوامل القانونية والتعليمية والنفسية التي يُفترض أنها تؤثر في ندرة الانتباه إلى التعذيب.

الصمت القانوني

من الأمور الأساسية لفهم محدودية الاهتمام بمسألة التعذيب أن التعذيب ليس جريمة في السويد، كما ذُكر في الفصل السابق. وهذا يعني أن السلطات والمؤسسات لا تملك الإمكانات نفسها للتصرف بحزم كما لو كان التعذيب مجرماً.

[صفحة أصلية 09]

ويسهم عدم تنظيم التعذيب في التشريع السويدي في الغموض والالتباس المحيطين بالمفهوم. ومن التصورات الشائعة أن التعذيب يحدث في مناطق الحرب والنزاع، وهي سياقات تقع خارج الحياة اليومية لكثير من السلطات السويدية. ولا يدرك كثيرون أن التعذيب ليس شأنًا يخص الحروب والديكتاتوريات وحدها.

ووفق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، يمكن أن يحدث التعذيب في جميع الأماكن وعلى يد جميع الأشخاص الذين يمثلون السلطة العامة، مثل شرطي أو مقدم رعاية، أو في انتهاكات تقع في دار للرعاية أو السكن (BVH) أو داخل مجلس المؤسسات الحكومي (SiS).

وإضافة إلى الفروق بين استخدام التعذيب في الكلام اليومي وتعريفه في الاتفاقيات، توجد أيضًا اختلافات بين نصوص الاتفاقيات والسياقات القانونية. ويعني ذلك وجود منطقة رمادية واسعة من الأحداث التي قد تُعد تعذيبًا أو لا تُعد كذلك، بحسب الخطاب الذي ننطلق منه. فعلى سبيل المثال، يجادل بعض الباحثين بأن بعض أشكال إساءة معاملة الأطفال الجسيمة والمتكررة يمكن تصنيفها تعذيبًا (41)، بينما يرى آخرون أن بعض أشكال العنف المرتبط بالشرف تعذيب (51).

ويفترض أن عدم تجريم التعذيب، إلى جانب تعدد معاني المفهوم، من الأسباب التي تسهم في الصمت المحيط بالتعذيب. ولم يتعرف إلا عدد قليل جدًا من المهنيين إلى هذا الموضوع أثناء تعليمهم، أو حتى في حياتهم المهنية. ومن غير المعتاد وجود تدريبات أو دورات أو محاضرات يسلط فيها الضوء على التعذيب. كما لا يحظى التعذيب باهتمام يذكر في المبادئ التوجيهية الوطنية ووثائق الإدارة لدى السلطات.

ولو كان التعذيب جريمة في التشريع السويدي تترتب عليها عقوبات قانونية، لكان ذلك سيحفز مبادرات تعليمية، ويخلق حاجة إلى توضيح مسؤولية السلطات. ولنأخذ مثالًا واحدًا: كان ذلك سيؤثر في مهمة «بيوت الأطفال» (suhanaB)، إذ كانت ستحتاج إلى الاستعداد لتحديد جرائم التعذيب المرتكبة ضد الأطفال والتحقيق فيها.

[صفحة أصلية 19]

إن عدم تجريم التعذيب، مقترناً بتعدد معاني المفهوم، يُفترض أنه من الأسباب التي تسهم في الصمت المحيط بالتعذيب.

[صفحة أصلية 29]

البالغون الصامتون

التشريع مهم، لكن توجد تحديات أخرى أيضًا فيما يتعلق باكتشاف التعذيب. ومن التحديات التي ظهرت في الدراسات البحثية الضغط العاطفي والأخلاقي الذي يعيشه المهنيون عند لقاء الأطفال الذين يتحدثون عن العنف (61، 71).

ويخشى المهنيون أن تؤدي الأسئلة عن التجارب الصعبة إلى إحياء ذكريات مؤلمة، وتفاقم المعاناة، بل وإلحاق الضرر بالطفل. ويتعلق الضغط أيضًا بمشاعر العجز عن تقديم المساعدة للطفل.

ويصف grebleumaS وآخرون (8102) كيف يلخص التعبير «لا توقظ الدب النائم» خوفًا واسع الانتشار من أن تؤدي الأسئلة عن الأحداث الصادمة إلى تفاقم حالة الطفل، مما يجعل تجنب الموضوعات الصعبة أسهل من التعامل معها (81). وقد لوحظت أنماط مشابهة بين الناجين من المحرقة، حيث نشأت «مؤامرة صمت» بوصفها وسيلة لحماية أنفسهم وأطفالهم من التذكير بالمعاناة والألم (91).

ولا يعني التعذيب روايات عن العنف الشديد فحسب، بل يعني أيضًا عواقب معقدة على الطفل عندما يصبح تعرضه للأذى معروفًا، مثل الإجراءات القانونية أو قضايا الهجرة أو إعادة ترتيب الأسرة. وهذا يسبب ضغطًا أخلاقيًا لدى كثير من المهنيين عندما تؤدي إفصاحات العنف، مثلًا، إلى نزاعات أسرية أو تدخلات قسرية (61).

ويعبر المهنيون عن عدم يقين بشأن كيفية التصرف إذا أخبر الطفل عن أحداث خطيرة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالتعذيب، حيث قد يبدو الدعم القانوني والعلاجي غير واضح. ولا توجد إرشادات واضحة لكيفية تعامل المهنيين مع هذه الإفصاحات (02).

الأطفال الذين أُسكتوا

بالتوازي مع صمت كثير من البالغين، يوجد لدى الأطفال تجنب قوي للحديث عن التجارب الصعبة. وتوجد تفسيرات بيولوجية لصمت الأطفال.

فالخوف استجابة أساسية من منظور تطوري، وينشط الجهاز العصبي اللاإرادي في الجسم. وفي الوضع التهديدي، تنشط اللوزة الدماغية، مما يؤدي إلى إفراز هرمونات الضغط مثل الكورتيزول والأدرينالين. ويطلق ذلك استجابات القتال أو الفرار أو التجمد المعروفة. وقد تكون استجابة التجمد لدى الأطفال، كأن يصبح الطفل سلبيًا أو ساكنًا، بارزة بوجه خاص، وقد تُفسر على أنها تجنب أو انفصال أو تفارق (12، 22).

ومن الناحية النفسية، يؤدي الخوف الشديد غالبًا إلى تجارب العجز وفقدان السيطرة. وقد تكون لذلك آثار طويلة الأمد في نمو الدماغ، ولا سيما في المناطق التي تنظم العواطف والذاكرة والتفاعل الاجتماعي (32).

الأطفال الذين يتعرضون للعنف أو يعيشون في خوف يتأثرون ليس عصبياً وبيولوجياً فحسب، بل عاطفياً وعلاقاتياً أيضاً. ويخاطر الأطفال الذين تعرضوا لأذى متعدد و/أو عاشوا عنفاً متكرراً بالإصابة بصدمة معقدة.

وفي الصدمة المعقدة تكون الأحداث الصادمة قد أثرت تأثيراً عميقاً في نمو الطفل. ويميل اكتشاف هؤلاء الأطفال إلى أن يكون صعباً بوجه خاص، لأن صورة الأعراض قد تختلف اختلافاً كبيراً، ولأن رواية الطفل عن تعرضه للأذى قد يصعب فهمها (8، 42).

[صفحة أصلية 49]

وعندما يتعرض الطفل للعنف على يد مقدم رعاية، يتأثر نظام التعلق لديه. وعندما يكون الجاني هو الشخص الذي يلجأ إليه الطفل عادة طلباً للأمان، تنشأ مفارقة: فالطفل يعتمد على الشخص نفسه الذي يهدده. وقد يؤدي ذلك إلى مشاعر قوية من العار والذنب، وإلى صمت الطفل خوفاً من العواقب أو حماية للعلاقات داخل الأسرة.

ويمكن فهم عدم الرغبة في الحديث عن العنف الجسيم أيضاً من خلال الطريقة التي يتحدث ويفكر بها كثير منا عن الأشخاص الذين تعرضوا لعنف جسيم كالتعذيب. فكثيراً ما يوصف الناجون من التعذيب بأنهم ضحايا ومحطمون وعاجزون، وهي أوصاف لا يرغب معظم الناس في رؤية أنفسهم فيها. ولتجنب النظر إلى أنفسهم بوصفهم ضحايا وتجنب الحديث عن عجزهم، يختار كثيرون، أطفالاً وبالغين على السواء، عدم الإفصاح.

وهكذا يمكن العثور على أسباب كثيرة تسهم في الصمت السائد بشأن الأطفال الناجين من التعذيب. ونعلم أن الأطفال نادراً ما يتحدثون من تلقاء أنفسهم عن العنف. ونعلم أيضاً أن الأطفال المتضررين من العنف يفتقرون غالباً إلى الثقة بالبالغين، لأن البالغين هم الذين مارسوا العنف في معظم الحالات. وقد يخافون من الانتقام أو يعيشون مشاعر الذنب والعار. وبعد التعذيب، من الشائع أيضاً حدوث تجارب شديدة من العجز وفقدان السيطرة وصعوبات معرفية، مما قد يعزز تجنب الطفل ويجعل وضع التجارب في كلمات، أي جعلها قابلة للحديث، أكثر صعوبة.

ويصيب الصمت الأطفال المتضررين من العنف الذين لا يُكتشفون، والذين يعانون عواقب العنف طوال حياتهم. وتعلق أكثر الأساليب شيوعاً المستخدمة لمواجهة «الصمت المزدوج» لدى الأطفال والبالغين بوضع إرشادات وإجراءات وفحوص لتعزيز العمل على اكتشاف هؤلاء الأطفال.

هل يمكن اكتشاف الناجين من التعذيب باستخدام الإجراءات والاستمارات؟

تتمتع الإجراءات الروتينية والاستمارات المنظمة القائمة على الأدلة بنقاط قوة كثيرة. فإلى جانب المساهمة في اكتشاف الأطفال الذين يعانون، يمكن للإجراءات أن تحسن جودة الرعاية، وتخلق قدرة أكبر على التنبؤ، وتساهم في الأمان والكفاءة لدى المهنيين والأطفال والشباب الذين يطلبون المساعدة (انظر مثلاً 52، 62).

[صفحة أصلية 59]

وقد تكون الإجراءات الروتينية وسيلة أيضًا لإبلاغ الأطفال والشباب بأن الموضوعات الصعبة ليست من المحرمات، وأنه يمكن الحديث عنها. وبذلك يمكن أن تؤدي الإجراءات وظيفية تعليمية، من خلال منح الطفل إطارًا لفهم الأحداث التي لا يجوز لأحد أن يعرضه لها، ومعرفة حقوقه، وعدد كاف من الكلمات للحديث عن الأحداث المخيفة.

ومع أن الإجراءات الروتينية والفحص يعودان بفوائد كبيرة، فإن لهما أيضًا عددًا من المزالق.

الموارد المحدودة والأولويات

تؤكد هيئة الصحة والرعاية الاجتماعية أن جميع المهنيين الذين يلتقون الأطفال ينبغي أن يطرحوا أسئلة عن العنف. وينبغي طرح الأسئلة بصورة روتينية، بصرف النظر عن سبب طلب الطفل للمساعدة. كما ينبغي تكرار الأسئلة، لأن المعلومات المتعلقة بالتعرض للعنف سريعة التغير وتحتاج إلى متابعة منتظمة (72).

والفكرة من الإجراءات أن تُنفذ بصورة روتينية. لكن مدى اتباع إجراء ما في العمل اليومي مسألة تجريبية. فمجرد أن تكون المؤسسة قد اعتمدت إجراءً لا يعني إطلاقاً أن المهنيين يملكون القدرة أو يختارون تنفيذ الإجراءات بالطريقة المقررة، مما قد يمنح الإجراءات شعورًا زائفًا بالأمان (82).

ومن أسباب تخلي المهنيين عن الإجراءات أن المحادثات عن العنف تحتاج إلى وقت أطول مما يسمح به الإجراء الروتيني. ففهم الطفل للسؤال يتأثر، مثلاً، بمستواه التعليمي وخلفيته الثقافية ونضجه وصحته النفسية. وقد تكون المحادثة المفتوحة الاستكشافية ضرورية حتى يتمكن البالغ من تفسير تعبير الطفل تفسيرًا صحيحًا، وضمان فهم الطفل لماهية العنف وكيف يمكن ممارسته.

وكثيرًا ما تكون هناك حاجة إلى أوصاف وتوضيحات مفصلة ومناسبة للعمر، وهو ما قد يصعب التعامل معه في إطار إجراء روتيني تكون فيه البساطة والكفاءة غالبًا موضع الأولوية (92).

[صفحة أصلية 69]

فالسؤال، مثلاً، عما إذا كان الطفل قد تعرض لأفعال جنسية يفترض أن لديه فهمًا مفاهيميًا لمعنى هذه الأفعال في السياق الذي يُطرح فيه السؤال. ومن دون أسئلة متابعة وتوضيحات، يوجد خطر الوقوع في أخطاء التفسير أو الإفراط فيه أو سوء الفهم، مما قد يؤثر في النتيجة.

وفي الوقت نفسه، توجد دراسات تظهر أن المهنيين يميلون إلى طلب الإجراءات والإرشادات للحصول على قدر أكبر من السيطرة، وقد فُسر ذلك بأنه وسيلة لإخراج عدم يقينهم وضغطهم إلى خارج الذات عند طرح موضوعات حساسة ومزعجة مع الأطفال (61). وإذا كان الأمر كذلك، فإن الإجراء يخاطر بأن يُستخدم بجمود وتصلب، في محاولة للسيطرة على العملية، مع خطر فقدان التواصل مع الطفل.

وعندما يكون الهدف هو اكتشاف التعرض للعنف، فإن كون السلطات، مثل الخدمات الاجتماعية، مكلفة بالتحقيق في احتياجات الأطفال الحالية هنا والآن يمثل عاملاً مقيداً. فلا ينبغي لها أن تحقق أكثر مما هو ضروري، وقد يؤدي ذلك إلى عدم استكشاف تجارب العنف السابقة التي لا تبدو للوهلة الأولى مرتبطة بصورة الطفل الحالية من المشكلات. لكن الصدمة ظاهرة معقدة، ولا سيما لدى الأطفال، وقد تظهر بأشكال كثيرة، مما يجعل معرفة أثر حدث ما في الطفل مستحيلة تقريباً قبل إجراء مسح أوسع.

إجراءات محددة وخطابات صامتة

يقوم المنطق الكامن وراء معظم الإجراءات والاستمارات على تعريف إساءة المعاملة والعنف الوارد في اتفاقية حقوق الطفل، وعلى الأحداث التي أظهرت الأبحاث أنها قد تسبب الصدمة، مثل الانفصال والكوارث الطبيعية، وعلى الأحداث الصعبة أثناء الطفولة، المسماة تجارب الطفولة السلبية، مثل الإهمال ومشكلات الإدمان في الأسرة.

ويؤثر التكاليف المحدد للمؤسسة بدرجة كبيرة في كيفية تصميم الإجراءات.

[صفحة أصلية 79]

فقد يحصل طفل يراجع قسم الطوارئ بسبب التهاب في المسالك البولية على سؤال عام عن التعرض المستمر للعنف، بينما يُطرح على طفل أُحيل إلى مركز الصليب الأحمر السويدي أسئلة عن الأحداث التي قد تسبب الصدمة. وتستخدم بعض المؤسسات فحصاً واسعاً لأشكال مختلفة من التعرض للأذى، بينما تركز إجراءات مؤسسات أخرى تحديداً على شكل معين من العنف.

والطموح هو طرح أسئلة عن العنف في جميع الأماكن والمؤسسات التي يتحرك فيها الأطفال، بحيث تتشكل شبكة من الأسئلة تلتقط حالات التعرض للأذى. وبينما تكمن قوة في تعدد الإجراءات، يوجد خطر أيضاً من سقوط الأطفال بين الفجوات. فقد لا يُنْتَبَه، مثلاً، إلى طفل يحمل تجارب صدمة صعبة لكنه لا يتصل بمؤسسات تسأل بصورة روتينية عن الأحداث الصادمة.

وتخاطر الإجراءات التي تسأل عن أحداث وأشكال عنف محددة بإغلاق أبواب عالم الطفل إذا كان قد عاش عنفاً لم يُسأل عنه. وبهذه الطريقة قد يمنح الإجراء شعوراً زائفاً بالأمان، أي الاعتقاد بأننا سألنا عن تعرض الطفل للأذى، في حين أن أسئلة كثيرة لم تُطرح قط.

وقد يفسر الأطفال أثر غياب الأسئلة، أو ما يمكن تسميته الخطاب الصامتة، على أن العنف الذي يعيشونه مقبول أو مخجل، ولذلك لا ينبغي ذكره. ومن الأمثلة أن تُطرح أسئلة روتينية عن العنف في العلاقات القريبة، من دون السؤال عن العنف الذي يمارسه الأشقاء. وفي الأسر التي يقع فيها عنف من البالغين، من الشائع بوجه خاص أن يتعرض الأطفال أيضاً لعنف الأشقاء، مما يعني أن الطفل قد يكون متعرضاً لأذى متعدد على يد البالغين والأطفال الآخرين في المنزل. وتظهر الأبحاث أن عنف الأشقاء قد يسبب الصدمة ويؤدي إلى عواقب طويلة الأمد على الصحة والنمو النفسي (23-03).

[صفحة أصلية 89]

ومن ثم يوجد خطر الضياع في الإجراءات، وعدم استكشاف أحداث العنف التي لا يُسأل عنها بنشاط. وفيما يتعلق بالتعذيب، يكاد الصمت يكون مطبقاً (02). وتُظهر بوابة المعرفة «بارنافريد» أن أدوات الفحص المستخدمة في الممارسة السويدية تركز على الأحداث الصادمة العامة والتعرض للعنف، من دون ذكر التعذيب بوصفه فئة مستقلة (52).

ويُستخدم في الطب النفسي للأطفال والشباب غالباً عدد من استمارات الفحص، مثل STAC، وهو فحص الصدمة للأطفال والشباب، وSTC، وهو فحص صدمة الطفل، وSELYL، وهو مقياس أحداث الحياة للشباب في لينشوبينغ. وقد صُممت هذه الأدوات لتحديد الأحداث التي قد تسبب الصدمة وأعراض الصدمة. وتتضمن أسئلة عن العنف والانتهاكات وغيرها من أحداث الحياة الصعبة، لكنها تفتقر إلى أسئلة صريحة تلتقط التعذيب (33-53).

وعلى المستوى الإقليمي، يجري التشديد على أهمية طرح الأسئلة والتحقيق في تعذيب الأطفال وتوثيقه (63). ولإتاحة ذلك، يُحال إلى المنهج الوطني لهيئة الصحة والرعاية الاجتماعية لرسم خريطة أوضاع الأطفال والتحقيق فيها ضمن الرعاية الاجتماعية للأطفال والشباب، «احتياجات الطفل في المركز» (CIBB). وينبغي أن يعمل CIBB دعماً وإرشاداً للمهنيين، لكنه لا يتناول مسألة التعذيب (73).

وقد يؤدي غياب الأسئلة التي تلتقط التعذيب في هذه الاستمارات إلى التغاضي عن تجارب التعذيب، وهو أمر مهم للتشخيص والعلاج معاً. وهذا يعني أن إجراءات مؤسسات كثيرة تخاطر بعدم اكتشاف الأطفال والشباب الذين تعرضوا للتعذيب، ولا سيما إذا لم تُرو تجربة التعذيب تلقائياً أو لم تنسجم مع الفئات المحددة. ولذلك توجد حاجة إلى استكمال أدوات الفحص القائمة بأسئلة تلتقط تجارب التعذيب تحديداً.

هل يكفي سؤال بسيط عن التعذيب؟

من الناحية النظرية، يمكن بوسائل محدودة نسبياً إضافة سؤال عن التعذيب إلى استمارات الفحص والإجراءات الروتينية القائمة، لكن الأمر أكثر تعقيداً في الممارسة. فالصعوبة تكمن في أن التعذيب شكل محدد من أشكال ممارسة العنف، يصعب السؤال عنه بسؤال واحد.

[صفحة أصلية 99]

وسيكون السؤال المباشر عن تجارب التعذيب إشكاليًا جدًا، لأن التعذيب مفهوم مستخدم في الكلام اليومي، لكن ليس دائمًا بالطريقة التي تتوافق مع معناه القانوني. وسيُطلب الأمر وصفًا مفصلاً لما يُقصد بالتعذيب، مع أمثلة واسعة، قبل أن يتمكن الطفل من تحديد ما إذا كان قد تعرض للتعذيب أم لا.

ويتمثل التحدي في تحديد أسئلة مناسبة عن التعذيب، تكون ملائمة وسهلة الطرح على الأطفال. وينبغي أن تكون الأسئلة كثيرة ومفصلة بما يكفي لالتقاط الأطفال الذين يحملون تجارب تعذيب، لكنها في الوقت نفسه لا تشغل مساحة غير متناسبة في الفحص، لأن التعذيب شكل نادر، وإن كان شديد الخطورة، من أشكال التعرض للأذى.

وقد يتمثل أحد سبل التقدم في تطوير استمارة محددة عن التعذيب، تُستخدم في المحادثات مع الأطفال المنتمين إلى فئة معرضة للخطر. لكن المشكلة أن استمارة موجهة كهذه لن تُستخرج على الأرجح إلا في عيادات الطب النفسي المتخصصة للأطفال، وفي أوضاع يكون فيها المهني قد حصل أصلاً على معلومات كافية عن التعذيب. وفي تلك الحالة ستبدو استمارة التعذيب زائدة وغير ضرورية.

أثر الإجراءات في بناء العلاقة

من الاعتراضات على الإجراءات أن الأطفال نادرًا ما يتحدثون عن العنف والأحداث الصادمة في الإجراءات الروتينية. وحتى عندما تكون الأسئلة واضحة ومنظمة، يتجنب الأطفال تقديم المعلومات، ولا سيما إذا كانوا يفتقرون إلى الشعور بالأمان في الوضع أو لا يفهمون معنى الأسئلة (83).

ويؤكد الدعم المعرفي الصادر عن هيئة الصحة والرعاية الاجتماعية أن الأطفال المتضررين من العنف يجدون غالبًا صعوبة في الحديث عن تجاربهم. وعندما تُطرح الأسئلة بطريقة آلية أو من دون عناصر بناء العلاقة، يخاطر الطفل بعدم الشعور بالثقة، مما يقلل استعداده للكلام (93).

[صفحة أصلية 001]

وبالمثل، يُظهر المسح الوطني الذي أجرته مؤسسة «دار الأطفال العامة» أن طريقة التعامل حاسمة؛ فإذا بدت المحادثات روتينية أو بعيدة، انخفض دافع الطفل إلى الانخراط في العملية الصعبة المتمثلة في الحديث عن العنف (04).

وقد يؤدي إدخال الإجراءات إلى تقليص المساحة المتاحة للعمل العفوي والمرن الذي يبني العلاقة. وإذا أصبح الإجراء موجهًا أكثر من اللازم، يوجد خطر تقويض الثقة الضرورية حتى يجرؤ الطفل على الانفتاح. ومن دون محادثة داعمة يساعد فيها الطفل على تفسير تجاربه ووضعها في كلمات، تخاطر معلومات مهمة بأن تُحذف.

ولا يتأثر الأطفال وحدهم بالإجراءات الصارمة، بل المهنيون أيضًا. وتصف بعض الدراسات كيف يتجنب المهنيون استخدام الإجراءات والاستمارات الرسمية تحديدًا لأنها تبدو معيقة لبناء العلاقة. والنتيجة أن كثيرًا من المحادثات مع الأطفال تجري من دون بنية أو جمع منهجي للمعلومات.

التوجيه السياسي

في نهاية المطاف، تشكل القرارات السياسية شروط العمل مع الأطفال المعرضين للأذى. ويصف snevetsH و tessaH (7002) تطورًا تميل فيه الأحداث المأساوية الفردية إلى إحداث صدى كبير في النقاش المجتمعي. ويشعر صانعو القرار نتيجة ذلك بضغط للتصرف بحزم من خلال قرارات سريعة يسهل تنفيذها من أعلى إلى أسفل. وتكون النتيجة بيروقراطية والبحث عن حلول بسيطة، مثل قائمة تحقق، مما يخاطر بتبسيط واقع معقد (14).

[صفحة أصلية 101]

وتعمل القرارات السياسية بوصفها قيودًا وعوامل تمكين في عمل المهنيين على السواء. فهي تؤثر في الأطر القانونية وأساليب العمل وتوزيع الموارد، مما يجعلها عاملاً أساسياً في مدى فعالية المجتمع في اكتشاف الأطفال المتضررين ودعمهم. كما تؤثر المطالب السياسية بأن تكون التدخلات قابلة للقياس وأن تؤدي إلى زيادة الكفاءة في التدخلات التي تُعطى الأولوية على مستوى السلطات.

وعندما تضطر المؤسسات إلى إظهار نتائج واضحة وقابلة للقياس الكمي، يخاطر التركيز بالانتقال من الجوانب المعقدة والعلاقاتية إلى العمليات الخاضعة للقواعد والأساليب الموحدة. ويعني ذلك أن الوقت المخصص لتنمية الكفاءات التي تعزز قدرة المهنيين على بناء العلاقات والمرونة غالباً ما يُهمل، لأن هذه التدخلات تُعد مستهلكة للوقت وصعبة القياس.

وتظهر الأبحاث أن منطق القياس هذا يخاطر بإزاحة الأبعاد النوعية للعمل الاجتماعي، وخلق ثقافة تُعطى فيها الأولوية لجمود الإجراءات والتوثيق والإحصاءات بدلاً من العمل القريب من المستفيدين (24).

الحاجة إلى إجراء علاقتي ومنظور شامل للعنف

يُخصص الجزء المتبقي من هذا الفصل لوصف نموذج أولي لأداة دعم حساسة للتعذيب، تُستخدم في المحادثات مع الأطفال عن العنف. والأداة قيد التطوير، لكننا نقدم هنا خلفية وتبريراً لفائدة الأداة المحتملة، يليه وصف لبنيتها.

إجراء علاقتي

وكما يحتاج المهنيون الذين يعملون مع الأطفال المصابين بالصدمة إلى تقديم رعاية واعية بالصدمة، يجب أن يتسم العمل على اكتشاف التعرض للعنف بنهج واعٍ بالعنف. ويعني ذلك الوعي بحاجة الأطفال إلى الشعور بالأمان والثقة قبل أن يتمكنوا من الإجابة بصراحة عن الأسئلة المتعلقة بالعنف. ولإتاحة ذلك، يحتاج المهنيون إلى إجراء روتيني لبناء علاقة مع الأطفال، أي إجراء علاقتي.

[صفحة أصلية 201]

ويبني المهنيون علاقات قائمة على الثقة من خلال منح الطفل شعورًا بالسيطرة على الوضع، وتجنب الضغط لاستخراج الإجابات، وإظهار أن رواية الطفل تُستقبل بالقبول والاهتمام. ويمكن تعزيز الأمان أيضًا إذا وضع البالغ الأسئلة المتعلقة بالعنف في سياق يصبح مفهومًا للطفل (52).

ويزيد الشعور بالأمان في وضع المقابلة احتمال أن يختار الطفل الكلام. وعندما يبدأ الأطفال في الحديث، نادرًا ما يحدث ذلك في محادثة واحدة، بل يحدث غالبًا بوصفه عملية تدريجية يختبر فيها الطفل ردود فعل البالغ قبل مشاركة معلومات أكثر تفصيلًا (83).

[صفحة أصلية 301]

والأطفال الذين يشعرون بأن البالغين يخصصون لهم وقتًا، ويظهرون التعاطف، ويبقون إلى جانبهم حتى في المشاعر الصعبة، يجرؤون بدرجة أكبر على الحديث عن التجارب الصعبة. وتظهر الأبحاث أن الأطفال الذين يتحدثون عن العنف والانتهاكات يفعلون ذلك غالبًا مع بالغين في حياتهم اليومية، مثل العاملين في المدرسة، بدلاً من الحديث مع السلطات (23). وعندما تُبنى الثقة، قد تكون للعلاقة نفسها آثار علاجية من خلال تقليل مشاعر العار والوحدة والعزلة (34).

وتظهر التحليلات التلوية أن المهنيين نادرًا ما يرون المشكلة في نقص الإجراءات، بل يطلبون بدلاً من ذلك دعمًا تنظيميًا يساعدهم على بدء محادثات العنف وتحملها. وأكبر عائق أمام المهنيين هو الضغط العاطفي والضغط الأخلاقي اللذان قد تصاحبهما محادثات العنف مع الأطفال (71).

ولو أضيفت أسئلة عن التعذيب إلى الإجراءات الروتينية، فمن السهل تصور ازدياد الضغط العاطفي. وتقترح دراسة keabla وآخرين (9102) أن أحد الحلول هو العمل على تنظيم مشاعر المهنيين ووعيهم بذواتهم وقدرتهم على بناء العلاقات وتطويرها. كما اقترحت مجموعات الدعم بين الزملاء وسيلة لمعالجة ردود الفعل العاطفية (61). ومن خلال هذه التدخلات، تتوافر للمهنيين شروط الاستمرار في الحضور العاطفي مع الأطفال المعرضين للأذى مدة أطول.

ويتعلق النهج الواعي بالعنف، من جهة، بتطوير إجراء علاقاتي، ومن جهة أخرى بفهم تعقيد العنف ودينامياته. منظور شامل للعنف

تظهر الأبحاث أن العنف ضد الأطفال ظاهرة معقدة لا تناسبها التبسيطات والافتراضات السهلة عن السبب والنتيجة. ورغم أن التبسيط مرغوب، فمن غير الممكن التقاط ظاهرة متعددة الأبعاد بالاعتماد على الإجراءات الموحدة والفحوص الروتينية وحدها، بل يتطلب الأمر نهجًا مرئيًا قائمًا على حل المشكلات. وهذا يفرض مطالب كبيرة على قدرة المهنيين وإمكانيتهم في الحضور أثناء اللقاء والاستثمار في العلاقة مع الطفل.

[صفحة أصلية 401]

ويتعارض هذا جزئيًا مع الافتراض الوضعي والخطي السائد في خطاب العنف ضد الأطفال. وبدلاً من البحث عن علاقات خطية، ينبغي تحليل العنف وفهمه في سياق أوسع تتفاعل فيه عمليات وأحداث كثيرة.

وكما ذكر، تركز معظم الاستثمارات والأدوات الرامية إلى استكشاف تعرض الأطفال للأذى تحديدًا على نوع واحد من العنف أو التعرض للأذى، مثل العنف المرتبط بالشرف أو العنف الجنسي. وفي الوقت نفسه، يصف الباحثون والأطباء حاجة إلى أدوات تلتقط أشكالًا مختلفة من التعرض للأذى، أي لا تقتصر على أحداث عنف منفردة أو محددة، أو أنواع علاقات أو سياقات بعينها.

ومن الأمثلة أداة «استبيان فحص إساءة معاملة الأطفال» (TSACI)، التي صممها خبراء دوليون، وتتضمن أسئلة عن العنف الجسدي والنفسي والجنسي، وعن عوامل السياق مثل الجاني والتوقيت والبيئة (44). ورغم أن TSACI شاملة، فإنها موجهة أساسًا إلى البحث، وليست مناسبة للاستخدام في الرعاية والخدمات الاجتماعية بسبب اتساعها.

وتظهر في الشكل 1 طريقة مبسطة جدًا لتوضيح إطار الفهم. ففي محادثة عن العنف والتعرض للأذى، ينبغي استكشاف جميع الدوائر، وكذلك كيفية تفاعلها بعضها مع بعض، في تحليل «طبقة فوق طبقة».

الشكل 1

[صفحة أصلية 501]

نبدأ بالنظر عن كثب إلى الدائرة الداخلية السوداء. وتظهر أبحاث الأحداث الصعبة أثناء الطفولة، أي دراسات تجارب الطفولة السلبية المذكورة، ديناميات العنف الكامنة. ويتضح هنا فرق مهم بين الأطفال الذين عاشوا أحداثاً صادمة منفردة والأطفال الذين مروا بتجارب صعبة متعددة.

فالأحداث المنفردة، مثل حادث أو كارثة طبيعية، قد تؤدي إلى استجابات ضغط حادة، لكن التعافي التلقائي يكون ممكناً في الغالب، ولا سيما إذا كان الطفل يتلقى الدعم من بالغ آمن.

وتسلط الدائرة الحمراء الثانية الضوء على أهمية الموارد والقدرات الداخلية للطفل في التعامل مع التجارب الصعبة. وقد تكون الموارد الداخلية قدرات معرفية واجتماعية تؤثر في فهم الطفل لما حدث وطريقة تعامله معه ومع الاستجابات العاطفية التي يثيرها. وبعض الأطفال أكثر قدرة على الصمود، فيطورون استراتيجيات مفيدة للتعامل مع التجارب الصعبة، بينما يخاطر الأطفال الأكثر هشاشة بالوقوع، مثلاً، في لوم الذات، مما يزيد خطر الاعتلال النفسي (54).

وتلفت الدائرة الوردية الانتباه إلى علاقات الطفل وبيئة الرعاية. فالأطفال الذين ينشأون في الفقر، أو في أسر تعاني من اعتلال نفسي، أو توجد فيها مشكلات إدمان، أو ينتمون إلى جماعات تتعرض للتمييز، يكونون أكثر عرضة للعنف وللمعاناة الأشد من عواقبه (64).

[صفحة أصلية 601]

ويكون الأطفال الذين يتعرضون للعنف في المنزل على يد أشخاص قريبين منهم معرضين بوجه خاص لخطر الاعتلال النفسي طويل الأمد والعميق. فالعنف الصادر عن مقدم الرعاية يمثل خيانة مزدوجة وأزمة عميقة في نظام التعلق. ولذلك يكون الأطفال الذين يفتقرون إلى قاعدة مستقرة لتنظيم مشاعرهم وطلب الدعم أكثر عرضة للصعوبات طويلة الأمد (74). وقد يؤدي ذلك إلى تعلق غير منظم يصبح فيه سلوك الطفل صعب الفهم ومجزأ (84).

وتُظهر دراسة طولية أن الشباب البالغين الذين تعرضوا لأذى متعدد أثناء طفولتهم يظهرون درجة أعلى بكثير من الأعراض المرضية النفسية. وفي الوقت نفسه، قد يكون وجود بالغ واحد داعم أثناء النشأة قد أدى إلى أثر وقائي، ومن ثم أثر في العلاقة بين التعرض المتعدد للأذى والاعتلال النفسي (94).

ويُعد التعلق الآمن بأحد مقدمي الرعاية من أهم عوامل الحماية للأطفال الذين يعيشون أحداثاً صادمة. ويمكن لمقدمي الرعاية الحاضرين والمتنبهين أن يعملوا حاجزاً واقئاً، ويسهلوا معالجة التجارب، ويتيحوا التعافي.

وتُدخل الدائرة الخارجية الرمادية أداء المجتمع المحيط وتفاعله مع الدوائر الأخرى. فالنشأة في ظروف حياتية صعبة تزيد خطر التعرض لأنواع مختلفة من العنف، وغالباً ما تعني محدودية الوصول إلى عوامل الحماية المهمة في حياة الأطفال، مثل الرعاية الصحية والتعليم والأنشطة الترفيهية (05).

[صفحة أصلية 701]

وقد ذُكر سابقًا أن الأطفال المتضررين من العنف يكونون أكثر عرضة للتعرض له مرة أخرى أثناء الطفولة والبلوغ على السواء (01). فعلى سبيل المثال، يكون الأطفال المحرومون من الحرية أكثر عرضة للتعرض المتعدد للأذى والاعتلال النفسي. وبالمثل، يحمل الأطفال الفارون أو الموجودون في بيئات الحرب غالبًا طبقات متعددة من التجارب الصادمة، تبدأ بالانفصال وتمتد إلى التمييز في بلدان الاستقبال.

وهذا يؤكد أهمية رسم خريطة لجميع تجارب العنف التي يحملها الطفل وفهمها في ضوء وضعه الحياتي الكامل، بما في ذلك عوامل الحماية التي كانت حاضرة في حياته، حتى يمكن التخطيط للتدخلات المناسبة.

وخلاصة القول، قد يتفاعل طفلان بطريقة مختلفة تمامًا مع الحدث نفسه، تبعًا لنظام الرعاية وظروف الحياة والموارد الفردية. وتجربة الطفل الذاتية نتيجة تفاعل معقد بين طبيعة الحدث، والعلاقة بالجاني، والتعلق، وظروف الحياة، والموارد الخاصة. وتخطر أدوات الفحص التي تركز على أحداث معينة وحدها بفقدان المعلومات وسوء تفسيرها، لأن آثار العنف معقدة ومتعددة الأبعاد.

وعلى خلفية ذلك، من المهم ألا يختزل العمل على تحسين اكتشاف الأطفال الناجين من التعذيب في مسألة روتينية، بل أن يطور منهجًا قادرًا على التعامل مع العواقب المعقدة للعنف.

خريطة التعرض للأذى: إجراء علاقتي لاكتشاف العنف

طور الأطباء في مركز الصليب الأحمر السويدي للعلاج في أوبسالا، بالتعاون مع باحثين، نموذجًا أوليًا لأداة دعم تحمل اسم العمل «خريطة التعرض للأذى». وكان أحد الأهداف الفرعية تطوير أداة تستجيب للتحديات التي تبرزها الاستراتيجية الوطنية لهيئة الصحة والرعاية الاجتماعية «نشأة خالية من العنف» (5).

وخريطة التعرض للأذى اقترح لأداة دعم حساسة للتعذيب، تُستخدم في المحادثات مع الأطفال وأولياء أمورهم عن العنف وإساءة المعاملة، من سن 0 إلى 71 عامًا. وكان المبدأ الموجه في تصميمها هو ضمان الاكتشاف المبكر للأطفال الأشد تعرضًا للأذى المتعدد، من خلال توفير بنية ومنهجية لجمع المعلومات عن تجارب الأطفال الحالية والسابقة.

وكان الطموح تطوير أداة يمكن استخدامها في مؤسسات مختلفة، وتكون شاملة لجميع أشكال إساءة المعاملة والعنف وأعراض الصدمة، مع إعطاء الأولوية في الوقت نفسه لبناء العلاقة. ويستند العمل إلى أبحاث ومواد دعم سابقة حول إنشاء محادثة آمنة، بما في ذلك أداة «أسئلة عن العنف» التي أعدتها منطقة فيسترا يوتالاند.

[صفحة أصلية 801]

وتتكون «خريطة التعرض للأذى» من ثلاث وحدات موضحة في الشكل 2. ويُخصص الجزء المتبقي من الفصل لوصف كل وحدة بمزيد من التفصيل.

الشكل 2

الوحدة الأولى: العلاقة

يركز هذا المكون على بناء العلاقة والوصول إلى محادثة بناءة قائمة على الثقة مع الطفل. وبناءً على الأبحاث والخبرات السابقة المتعلقة بإجراء محادثات مع الأطفال عن تعرضهم للأذى، تتكرر أربعة جوانب بوصفها مهمة بوجه خاص لإقامة علاقة قائمة على الثقة (25).

الوضوح يعني شرح سبب الرغبة في الحديث مع الطفل وكيف ستجري المحادثة. ويتعلق الوضوح بإبلاغ الطفل بحقوقه، مثل حقه في الحماية، وكذلك في الرعاية والعلاج وإعادة التأهيل عند الحاجة. وأخيرًا، يحتاج البالغ إلى تناول العواقب المحتملة التي قد تؤدي إليها المحادثة. ويتمثل التحدي الكبير في معيار الوضوح في نقل المعلومات بطريقة يستطيع الطفل استيعابها وفهمها.

[صفحة أصلية 901]

التحقق من مشاعر الطفل يعني أن يعبر البالغ عن حضوره واهتمامه وقبوله في التفاعل مع الطفل. ومن طرق التحقق من المشاعر إظهار الفضول تجاه حال الطفل النفسية والجسدية الحالية، ورغباته واهتماماته.

والتنبيه يعني محاولة فهم احتياجات الطفل وقدراته وتجارب حياته. ويتطلب ذلك وقتًا ومساحة للتعرف إلى الطفل وفهم نقاط قوته ومواطن هشاشته. وقد يتعلق الأمر ببناء فهم للغة الطفل العاطفية، مثل الإشارات التي تدل على القلق أو مشكلات التركيز أو التعب أو الفرح. كما قد يعني التنبيه فهم تعبيرات الطفل والاستماع إلى ما هو مهم من منظوره.

التكليف. يعني التكليف إيجاد شكل وبنية للمحادثة ينطلقان من احتياجات الطفل وقدراته، مثل المدة التي يستطيع الطفل خلالها الحفاظ على تركيزه، أو ما إذا كان من المفيد استخدام وسائل بصرية.

وقد تستغرق عملية إقامة علاقة آمنة وقتًا، لكن من دون استثمار هذا الوقت يكون خطر عدم تحمس الطفل للكلام كبيرًا.

وتوجد طرق كثيرة للتعرف إلى بعضنا وإقامة علاقة. ويُقترح هنا مدخل يركز على الجسد والتجارب الجسدية. وقد يكون هذا مناسبًا في سياقات كثيرة، ولا سيما عندما يعاني الطفل نوعًا من المشكلات الجسدية، مثل اضطرابات النوم أو الصداع أو ألم المعدة أو إصابة جسدية من أي نوع.

والحديث عن الجسد أكثر تحديدًا من الحديث عن المشاعر والأفكار. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يكون وسيلة لمساعدة الطفل على رؤية الصلة بين الجسد والحالة النفسية.

[صفحة أصلية 011]

وينبغي أن يستغرق العمل المتعلق بالجسد وقتًا. ويمكن لمحادثة تنطلق من الجسد أن تعطي فهمًا جيدًا لأداء الطفل وحاله، مثل نضجه وتطوره اللغوي وعلاقته بنفسه وجسده.

وفي المحادثة يمكن إظهار الفضول تجاه التجارب الجسدية المختلفة: الألم أو عدم الراحة أو ربما الإحساس اللطيف في الجسد. كيف يشعر الطفل في هذه اللحظة؟ وكيف يشعر عادة في الحياة اليومية؟ وماذا يفعل عادة عندما يؤلمه جزء من جسده أو عندما يمر بإحساس صعب في جسده؟

وإذا دُعي الطفل إلى الرسم على خريطة للجسد، وإلى الحديث في الوقت نفسه عن أجزاء الجسد المختلفة، فقد نصل إلى روايات عن التعرض للأذى والعنف و/أو عواقبهما.

كيفية وصف الوحدة الأولى للطفل

«يمر جميع الناس أحيانًا بأمور صعبة، أمور تجعلنا نشعر بالسوء من الداخل أو تجعل أجسادنا تؤلمنا. وقد يؤلم الجسد لأن شيئًا أصابنا، لكنه قد يؤلمنا أيضًا عندما نمر بشيء مخيف. وأحيانًا يؤلمنا فقط في اللحظة التي يحدث فيها الشيء المخيف، وأحيانًا يستمر الألم فترة طويلة بعد ذلك».

وقد تساعد الرموز التعبيرية الطفل على التعبير عن شعور موجود في جسده؛ فقد يكون الحزن، مثلًا، في المعدة أو ربما في القلب. كما أن ما يفعله الطفل عندما يشعر بمشاعر مختلفة قد يعطي نظرة مفيدة إلى أدائه وحاله.

[صفحة أصلية 111]

وتوجد في الصفحة التالية صورة، الشكل 3، يمكن للبالغ والطفل الانطلاق منها في الوحدة الأولى.

الشكل 3

[صفحة أصلية 211]

الوحدة الثانية: المعرفة

يركز الجزء الثاني على تطوير إطار معرفي مشترك، وفهم مشترك، ولغة مشتركة عن العنف والتعرض للأذى. وهو يغطي الطيف الكامل للتعرض للعنف، من نقص الرعاية إلى أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، مثل التعذيب.

كيفية وصف الوحدة الثانية للطفل

«يحتاج البالغون أحيانًا إلى سؤال الأطفال عن أمور صعبة ربما مروا بها. وإذا مر الإنسان بأمور مخيفة، فقد يحتاج أحيانًا إلى المساعدة. ويجب أن يعرف الأطفال أن هناك أشياء يحظر فعلها ضد الأطفال، وأن لهم الحق في الحصول على المساعدة. وليس ذنب الطفل أبدًا أن يمر بأمور مخيفة. وأود أن أتحدث معك عن الأمور التي مررت بها. ولست مجبرًا أبدًا على الكلام. ولا توجد أيضًا أمور صحيحة أو خاطئة يمكن الحديث عنها. ما رأيك في أن نتحدث قليلًا عنك وعن الأمور التي مررت بها؟».

ويتضمن هذا الجزء إخبار الطفل بماهية العنف وكيف يمكن أن يتفاعل الإنسان ويشعر بعده، أي أعراض الصدمة، مع الاستماع في الوقت نفسه إلى تعبير الطفل وروايته. ويتطلب ذلك تنبُّهاً إلى ردود فعل الطفل العفوية وإفصاحاته.

والأسهل هو البدء بالحديث عن أمور ترتبط بتجارب الطفل، إذا كانت هناك معلومات متاحة، ثم انتظار ردود فعل الطفل نفسه.

والهدف استكشاف تعرض الطفل الحالي والسابق للعنف، وإعداد ملخص عام لتجارب حياته في جدول متقاطع، انظر الشكل 4. ويتضمن الجدول المتقاطع متغيرين: نوع العنف والبيئة. ويُلوّن الجدول بالاشتراك مع الطفل، وفقًا لما إذا كانت أحداث عنف قد ظهرت، باللون الأحمر، أو كانت هناك مؤشرات على العنف، باللون الأصفر، أو لم توجد مؤشرات على العنف، باللون الأخضر.

عُذِّبَ فِي طِفْلَتِهِ

[صفحة أصلية 311]

الشكل 4

[صفحة أصلية 411]

يمثل كل مربع في الجدول نوعًا معينًا من ممارسة العنف في بيئة معينة. وستتوافر أسئلة نموذجية لكل مربع بوصفها دعمًا، لكن من المهم تكييف الأسئلة مع نمو الطفل ومستوى نضجه. وينبغي أن يكون هناك تنوع كبير وتكيفات في صياغة الأسئلة.

ولإتاحة المجال لدافع الطفل ورغبته وقدرته على الكلام، من المهم متابعة رواية الطفل. ويمكن للمحادثة أن تتحرك بحرية بين الصفوف والأعمدة، بحسب ما يظهر فيها. وعند طرح الأسئلة الروتينية، يمكن البدء بمعلومة محايدة نعرفها عن الطفل، ثم رؤية الاتجاه الذي تتخذه المحادثة. وعندما تبدأ المحادثة بسبب مؤشر على التعرض للعنف، قد يكون من المناسب البدء بالمربع الأكثر صلة، بناءً على المعرفة المتاحة عن تجارب الطفل. فإذا كان معروفًا، مثلاً، أن الطفل عاش الحرب، يمكن أن تبدأ المحادثة في ذلك الصف، كما يوضح الشكل 5. ويعرض البالغ الموضوع، ثم يطلب معلومات عما إذا كان الطفل قد عاش أشكالاً مختلفة من العنف في بيئة الحرب. وإذا عبر الطفل عن تجارب صعبة، توضع علامة حمراء في المربع. فإذا أجاب الطفل، مثلاً، بأنه سمع القصف واختبأ تحت الطاولة، توضع علامة حمراء في مربع «الحرب/العنف النفسي».

الشكل 5

[صفحة أصلية 511]

وفي الوضع الذي يعبر فيه الطفل، أو يظهر بطريقة أخرى، عن عدم رغبته في الحديث أكثر عن موضوع معين، مثل الحرب، بينما يقدّر المهني أن هناك على الأرجح تجارب صعبة أخرى غير القصف، تُعلم المربعات باللون الأصفر، كما يوضح الشكل 6. ويشير اللون الأصفر إلى وجود تجارب يحتمل أن تكون مسببة للصدمة وتحتاج إلى مزيد من التحقيق.

الشكل 6

وعندما تنتهي المحادثة، يمكن أن يكون الجدول المتقاطع ملونًا كله أو بعضه بالأحمر والأصفر والأخضر، مما يعطي نظرة عامة على تعرض الطفل السابق والحالي للآذى، وإرشادًا واضحًا لمقدمي الرعاية وغيرهم من مقدمي الخدمات الصحية الموجودين في شبكة الطفل بشأن ما يحتاج إلى مزيد من التحقيق، كما يوضح الشكل 7.

الشكل 7

الوحدة الثالثة: رواية أو روايات العنف

في الحالات التي يتحدث فيها الطفل عن العنف، يجب الاستعداد لتلقي الرواية كاملة. وليس الهدف بالضرورة الحصول على رواية كاملة، لكن احترامًا للطفل ينبغي إتاحة الوقت والمساحة العاطفية لتلقي جميع المعلومات المهمة التي يشاركها.

[صفحة أصلية 611]

ويكتب البالغ والطفل معًا كلمات الطفل نفسه عن الحدث في ورقة منفصلة، انظر الشكل 8. وقد يصعب معرفة ما حدث فعلاً، أي الحصول على رواية مترابطة. وقد تكون الروايات مجزأة، فيستطيع الطفل وصف بعض الأجزاء بوضوح، بينما يصعب عليه الحديث عن أجزاء أخرى.

الشكل 8

وتشير الأسئلة الموجودة في المربعات الوردية إلى معلومات ذات صلة خاصة ينبغي الانتباه إليها أثناء المحادثة، أي لا ينبغي طرح الأسئلة صراحة على الطفل. وقد ظهرت هذه العوامل في الدراسات البحثية بوصفها مهمة بوجه خاص لفهم أثر الحدث في صحة الطفل. وقد تكون هذه الجوانب مهمة أيضاً لتقييم التدخلات الصحية المناسبة، وكذلك في القضايا القانونية مثل إجراءات اللجوء.

ماذا؟ أولاً، من المهم ملاحظة ما مر به الطفل: ما نوع العنف الذي تعرض له؟ وقد تتضمن الرواية أيضاً أشكالاً مختلفة من التعرض للعنف. فقد تظهر، مثلاً، أشكال جديدة من العنف مع تطور الرواية، كأن يخبر الطفل عن القصف واختبائه تحت الطاولة، أي العنف النفسي، ثم يتابع روايته بأنه وجد جدته مصابة بشظايا في ساقها، أي العنف الجسدي.

ومن الجوانب المركزية فهم كيفية تعرض الطفل للعنف: هل شهد الطفل العنف أم تعرض له بنفسه؟ ويترك العنف آثاراً مختلفة تبعاً لما إذا كان الشخص قد تعرض له بنفسه أو شاهده أو سمع عنه.

[صفحة أصلية 711]

ويزداد خطر الصدمة إذا تعرض الشخص لعنف موجه إليه، مقارنةً بمشاهدة حدث مخيف على الإنترنت أو السماع عنه. وفيما يتعلق بالعنف المشاهد، يكون من الحاسم غالبًا معرفة من وُجه إليه العنف. فمشاهدة الطفل للعنف الموجه ضد مقدمي رعايته، مثل التعذيب، تنطوي غالبًا على مخاطر خطيرة على الطفل.

متى؟ من المهم معرفة وقت وقوع الحدث لتكوين فكرة عن نطاقه وطبيعته التجربة، وهو ما يؤثر غالبًا في صورة الأعراض عند حدوث الصدمة. ويزيد حدث عنف منفرد ومحدد، ذو طبيعة خطيرة، خطر التأثير سلبيًا في صحة الطفل النفسية والجسدية. وفي الوقت نفسه، قد تزيد الأحداث الأقل خطورة، إذا كانت متكررة وكثيرة، خطر الصدمة أيضًا. وعند التعرض المتكرر للعنف، ولا سيما عندما يكون العنف خطيرًا، يوجد خطر خاص من أن يطور الطفل أشكالًا أكثر تعقيدًا وارتباطًا بالنمو من الصدمة.

الشعور آنذاك/الآن؟ يمكن لمشاعر الطفل التي يصفها أثناء وقوع الحدث وأثناء روايته أن تقدم مؤشرًا إلى كيفية تأثير العنف في الطفل مع مرور الوقت، وإلى موارده الداخلية والخارجية التي ربما أتاحت التعافي أو أعاقته، وإلى الصدمة الحالية. كما يمكن للألم الجسدي، وقت وقوع العنف وفي الوقت الحاضر، أن يقدم معلومات كثيرة عن الصحة الجسدية والنفسية وعن المشكلات الجسدية المرتبطة بالصدمة.

من/من؟ للمعلومات المتعلقة بالمسؤول عن العنف أهمية كبيرة. فعلاقة الطفل بالجاني أو الجناة، وموقع السلطة الذي يحتله هؤلاء الأفراد في علاقتهم بالطفل، أمران حاسمان لفهم عواقب العنف، وتعقيد صورة الأعراض، واحتياجات الطفل الحالية إلى الحماية، والتقييمات في الإجراءات القانونية.

[صفحة أصلية 811]

لماذا، وما الغرض؟ قد يكون وصف الطفل لسبب وقوع الحدث، أي ما تسبب في حدوثه، مفيدًا لفهم عالم الطفل التجريبي. ويمكن لفهم الطفل أن يعطي صورة عن عالمه الفكري واستراتيجيات تعامله ونضجه العاطفي.

وإذا ظهرت أثناء المحادثة بأي طريقة دوافع الجناة للعنف، فقد تقدم معلومات ذات قيمة في الإجراءات القانونية، مثل تقييم ما إذا كان العنف جريمة كراهية أو تعذيبًا أو مرتبطًا بالشرف.

المساعدة والدعم آنذاك/لاحقًا/الآن؟ تمثل تجربة الطفل للدعم والمساعدة أثناء الحدث وبعده قطعة مهمة من الأحجية لفهم ما إذا كانت هناك شروط لعملية شفاء تلقائية بعد الصدمة. ويُعد غياب الدعم والرعاية أثناء التجارب الصادمة أو بعدها عاملاً يزيد الصعوبة، وقد يؤثر في صورة الأعراض.

وعندما نلاحظ أن الطفل شارك القدر الذي يشعر معه بالارتياح أو يستطيع تحمله، نغادر الحدث ونعود إلى الجدول المتقاطع.

خريطة التعرض للأذى: خط ناظم عبر نظام الرعاية والخدمات الاجتماعية

إلى جانب المساهمة في اكتشاف العنف وإعطاء صوت لرواية حياة الطفل، يمكن لخريطة التعرض للأذى أن تسهل تجميع المعلومات المعقدة ونقلها بين المهنيين والسلطات ومقدمي الرعاية الصحية المختلفين.

[صفحة أصلية 911]

ويُعد نقل المعلومات حاسماً حتى لا تبقى رواية الطفل لدى فاعل واحد. وقد أُشير إلى نقل المعلومات بوصفه تحدياً، ولا سيما بين الوحدات المختلفة للخدمات الاجتماعية (35).

وتسلط دراسة جديدة الضوء على مشكلة بقاء رواية الطفل عالقة في النظام، وعلى أن الرواية نادراً ما تكون موجهة لتصميم تدخلات الرعاية المفتوحة التي يجري تنفيذها. وحتى في الحالات التي تحدث فيها الطفل عن تعرضه للأذى، لا تُشارك المعلومات دائماً مع الجهات ذات الصلة، وفي كثير من الحالات لا يصبح وصف الطفل وصورة مشكلته عاملين موجهين للعملية اللاحقة.

ويدعو الباحثون إلى أن تستند جميع تدخلات الرعاية المفتوحة إلى «رواية الطفل بوصفها خيطاً ناظماً» من التحقيق إلى الإنهاء (45). ويمكن أن تكون خريطة التعرض للأذى هي الخيط الناظم في هذا العمل.

الطريق إلى الأمام

لكي يصبح الناجون من التعذيب وحقوقهم واحتياجاتهم مرئيين، يتمثل الطريق إلى الأمام في الجمع بين التدخلات البنوية، أي رفع المعرفة والبحث، والتدخلات العلاقية، أي بناء الأمان والثقة.

وكان الطموح في هذا الفصل المساهمة في العمل الجاري لتحسين اكتشاف الناجين من التعذيب، من خلال إعداد نموذج أولي لأداة دعم تُستخدم في المحادثات مع الأطفال عن العنف. وأداة الدعم «خريطة التعرض للأذى» حساسة للتعذيب، ما يعني أنها تستطيع النقاط التعذيب بوصفه ظاهرة من دون طرح أسئلة مباشرة عن التعذيب. ويتركز التشديد على التدخلات التي تبني العلاقة، لأن العلاقة الآمنة شرط حتى يتحدث الأطفال عن التجارب الصعبة.

[صفحة أصلية 021]

وقد تساهم خريطة التعرض للأذى في تقديم صورة شاملة عن عالم تجارب الطفل. كما قد تساعد في تبسيط نقل المعلومات بين السلطات ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال تقديم نظرة عامة على تعرض الطفل الحالي والسابق للأذى، إلى جانب فهم أعمق للأحداث الفردية وتأثيرها في الطفل.

والعمل على خريطة التعرض للأذى مستمر. ومن الأسئلة البحثية المهمة مستقبلاً تقييم نقاط قوة الخريطة ونقاط ضعفها. وتجري حالياً محادثات مع المهنيين بهدف مواصلة تطوير الخريطة وتعزيز سهولة استخدامها، وضمان استجابتها للاحتياجات والتحديات التي يواجهها المهنيون في حياتهم اليومية.

[صفحة أصلية 121]

والخطوة التالية هي دراسة تجارب الأطفال والشباب مع المحادثات التي تستخدم خريطة التعرض للأذى. وتتمثل الخطة طويلة الأمد في تطبيق الخريطة وتقييمها في مؤسسات مختلفة. ومن الأسئلة المهمة عندئذ دراسة التغييرات التنظيمية التي تجعل العمل العلاقتي أولوية عملية في المؤسسات المختلفة، أي بحث التطبيق. لكن إذا أصبحنا، كمجتمع، أفضل في تحديد الأطفال الناجين من التعذيب، فعلينا أيضًا أن نقدم للمهنيين إرشادات بشأن ما ينبغي فعله عند اكتشاف التعذيب: كيف نخبر الطفل بما سيحدث بعد اكتشاف التعذيب؟ وإلى أين نحيله بسبب المشكلات المرتبطة بالتعذيب؟

وتوجد حاجة إلى رفع عام لمستوى المعرفة في المجتمع بشأن التعذيب وعواقبه واختلافه عن أشكال العنف الأخرى. وهناك حاجة إلى مواد تعليمية عن الأطفال الناجين من التعذيب. وينبغي للمؤسسات التعليمية أن تقدم دورات عن التعذيب، ولا سيما في برامج تعليم الرعاية والخدمات الاجتماعية. كما يمكن للسلطات والمؤسسات ومقدمي الرعاية الصحية المساهمة من خلال توفير أنشطة لرفع كفاءة العاملين.

وقد يترك رفع الوعي العام بالتعذيب أثرًا في إجراءات عمل المهنيين. ففي الرعاية الصحية الأولية، قد تكون زيارات المتابعة الإضافية لدى الطبيب أو الممرض عند وجود مؤشر على العنف وسيلة بسيطة لبناء العلاقة، ومن ثم زيادة احتمال حديث الأطفال عن العنف الجسيم. وفي مجال المدرسة، توجد إمكانية تطوير علاقات آمنة على مدى فترة طويلة. وتمثل المحادثات الصحية التي تجريها ممرضات المدارس مع التلاميذ فرصة متكررة ومنظمة لفتح الحديث عن العنف الجسيم.

[صفحة أصلية 221]

كما تستطيع مراكز رعاية الأطفال استكشاف التعرض للعنف بمرور الوقت، إلى جانب الانتباه إلى عوامل الخطر النفسية الاجتماعية، وهو ما يجري في أماكن كثيرة حاليًا من خلال إجراء «طفل آمن» ونموذج KEES. ويكتسي زيادة الوعي بالتعذيب في الخدمات الاجتماعية أهمية خاصة، لأنها تلنقي بدرجة كبيرة بالأطفال المعرضين لخطر التعرض المتعدد للأذى وإعادة الوقوع ضحايا.

ومن منظور عالمي، يكتسي التوثيق والتسجيل المنهجي لحالات التعذيب المكتشفة أهمية حاسمة للعمل بفعالية على مواجهة التعذيب ومنعه، انظر مثلاً المؤشر العالمي للتعذيب والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. وسيكون إنشاء سجل وطني موردًا مهمًا في هذا العمل. ويتطلب ذلك خطة وطنية لرفع الكفاءة بشأن الأطفال الناجين من التعذيب.

وأخيرًا، إلى جانب الناجين من التعذيب، يوجد كثير من الأطفال المتعرضين لأذى متعدد الذين لا يحصلون قط على الدعم والعلاج اللذين يحق لهم. وهؤلاء الأطفال معرضون بوجه خاص للتجنيد في الشبكات الإجرامية. ولوقف تجنيد الشباب، تتعالى حاليًا أصوات كثيرة مطالبة بعقوبات أشد بهدف الردع. لكن العقاب لا يعني بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال تعلمًا جديدًا أو إعادة تعلم، بل يعني استمرار التعرض للأذى الذي عاشوه طوال حياتهم. ويلزم اتخاذ تدابير أخرى، وقبل كل شيء توفير موارد أكثر لتحديد هؤلاء الأطفال في وقت أبكر بكثير من حياتهم. ويُعد الاكتشاف المبكر، مع الدعم والعلاج والرعاية، تدبيرًا وقائيًا لمواجهة المعاناة النفسية طويلة الأمد وخطر الوقوع في بيئات مدمرة وإجرامية.

وفي المستقبل، يلزم اتخاذ تدابير قوية لتعزيز إمكانات المهنيين في تحديد الأطفال المعرضين للأذى، وكسر دوائر العنف، وتهيئة الظروف للطفل لبناء علاقات آمنة والشعور بالثقة في المجتمع المحيط.

المراجع

1. C esoB nélhaN ,R idijdMaT .الأطفال الذين نجوا من التعذيب: مراجعة منهجية للأدبيات حول
الفحص والتوثيق وعلاج إصابات التعذيب لدى الأطفال. ستوكهولم: مركز الصليب الأحمر للخبرة في إعادة تأهيل
المصابين بالتعذيب والحرب؛ 3202. 2. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (TCMO). تعذيب الأطفال:
التقرير العالمي 1202. جنيف: TCMO؛ 1202. متاح من: er/nel/gro.tcmo.www//:spthth 3. 1202-troper-labolg-nerdlihC-fo-erutrot/stroper/secruos
الأطفال. erutroT. 9002 (2):66-78. 4. E rettodsdravgiS وآخرون. انتشار التعذيب
وغيره من الأحداث الصادمة المرتبطة بالحرب لدى المهاجرين قسراً: مراجعة منهجية. lanruoJ erutroT.
6102؛ 62(2):14-37. 5. هيئة الصحة والرعاية الاجتماعية. نشأة خالية من العنف: استراتيجية وطنية
لمنع العنف ضد الأطفال ومكافحته. ستوكهولم: مكتب الحكومة؛ 2202. متاح من: os.www//:spthth.
6. es.neslerytslaic .B kloK red nav .الجسد يحتفظ بالأثر. نيويورك: gnikiV؛ 4102. 7.
I nesredeP-rhaaH وآخرون. التعرض المتعدد للأذى والاعتقال النفسي لدى الأطفال والمراهقين:
مراجعة منهجية للدراسات التي تستخدم استبيان إيزاء الأحداث. 0202.tcelgeN dna esubA dliiH.
701. 8. JV ittileF وآخرون. علاقة إساءة معاملة الطفولة واختلال الأسرة بأسباب الوفاة الرئيسية لدى
البالغين. deM verP J ma. 8991؛ 41(4):542-852. 9. L gnahZ وآخرون. أنماط تجارب
الطفولة السلبية لدى الأطفال الصينيين: روابط طويلة على مدى أربع سنوات مع الأعراض المرضية النفسية.
J fo J eserR taihcysP 9102؛ 221(6). 01. AH renruT وآخرون. التعرض المتعدد للأذى
والعنف لدى الشباب عبر السياقات. J htlaeH cselodA 7102؛ 06(6):167-967. 11. retaC.
آخرون. تعرض الشباب للإيذاء في السويد: الانتشار والخصائص والعلاقة بالصحة النفسية والمشكلات
السلوكية في بداية البلوغ. IgeN dna esubA dliiH 4102؛ 83(8):0921-2031. 21. srewoT.
آخرون. التعرف إلى ضحايا التعذيب في إجراءات اللجوء الوطنية: عرض مقارن لتحديد المبكر ووصول
الضحايا إلى التقارير الطبية القانونية في بلدان استقبال طالبي اللجوء. كوبنهاغن: المجلس الدولي لإعادة تأهيل
ضحايا التعذيب؛ 3102. 31. أمين مظالم الأطفال. لطالما وجد العنف، أي منذ وجود المشكلات: تقرير إلى
الحكومة. ستوكهولم؛ 5202. متاح من: es.nennamsdubmonrab.www//:spthth

41. J nnyL وآخرون. تعذيب الأطفال بوصفه شكلاً من أشكال إساءة معاملة الأطفال: دراسة استكشافية لجوانب التحقيق لدى 24 جانباً. *tcelgeN dna esubA dliHC*. 51. 851. 4202. *L. snarG*. التزام الدولة بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: قضية العنف المرتبط بالشرع. *ver L stR muH*. 5102. 51(4):596. 61. *UA keabIA* وآخرون. السير بالأطفال عبر حقن ألغام: كيف يختبر المهنيون استكشاف تجارب الطفولة السلبية. *htlaeH lauQ*. 8102. 82(2):132-442. 71. *UA keabIA* وآخرون. الغوص في بحر مظلم من المشاعر: التجارب العاطفية للمهنيين عند تناول إساءة معاملة الأطفال في المقابلات. *seR htlaeH lauQ*. 0202. 03(8):6121-9221. 81. *S ödiB* وآخرون. الصدمة لدى الأطفال: دليل. ستوكهولم: *rutaN Y ileinaD*. 91. 8102. مشاركة المعالجين النفسيين في مؤامرة الصمت حول المحرقة. *lohcySP lanaohcySP*. 4891. 1(1):32-24. 02. *C esoB nélhaN*. 02. *R idijdmaT*. الأطفال الذين نجوا من التعذيب: مراجعة منهجية للفحص والتوثيق وعلاج إصابات التعذيب لدى الأطفال. *erutroT lanruoJ*. 4202. 43(3):51-04. 12. *J xuoDeL*. الدماغ العاطفي. نيويورك: *nomiS*. 6991. 22. *K iohC* وآخرون. العلاقات بين سوء المعاملة والأعراض التالية للصدمة والنمط التفارقي من اضطراب الكرب التالي للصدمة لدى المراهقين. *J ssiD dna amuarT*. 9102. 02(2):212-722. 32. *HM rehcieT AJ nosmaS*. الآثار العصبية البيولوجية المستمرة لإساءة معاملة الطفولة وإهمالها. *yrtaihcySP lohcySP dliHC*. 6102. 75(3):142-662. 42. *K sehguH* وآخرون. أثر تجارب الطفولة السلبية المتعددة في الصحة: مراجعة منهجية وتحليل تلوي. *htlaeH cilbuP tecnaL*. 7102. 2(8):653e-663. 52. *dirfanraB*. صندوق أدوات لفحص الصدمة في الخدمات الاجتماعية. لينشوبينغ: جامعة لينشوبينغ؛ 4202. متاح من: *pw/latrospaksnuk/es.dirfanrab//:spth*. لينشوبينغ: *fdp.dotssirk-rof-xobloot/50/4202/sdaolpu/tnetnoc*. هيئة الصحة والرعاية الاجتماعية. المبادئ التوجيهية الوطنية: العنف في العلاقات القريبة. ستوكهولم؛ 2202. متاح من: *os.www//:spth*. هيئة الصحة والرعاية الاجتماعية. العنف ضد الأطفال: الدعم المعرفي والقواعد. ستوكهولم؛ 3202. متاح من: *es.neslerytslaicos.www//:spth*. 82. *AA kjidnenjinoK* وآخرون. ما العوامل التي تزيد التزام مهنيي صحة الطفل الهولنديين بمبدأ وطني لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم؟ *tcelgeN dna esubA dliHC*. 6102. 35:811-721.

92. EA nitsuA وآخرون. فحص تجارب الطفولة السلبية: تقييم نقدي. scirtaideP. 4202؛ 451(6):3843603202e.03 JC rekcU وآخرون. أنماط عدوان الأشقاء والصحة النفسية في الطفولة والمراهقة. amuarT ylimaF fo lanruoJ, dna ydotsuC dliHC -poleveD tneM. 4202؛ 12(1):2-12. 13. D rohlekniF وآخرون. عنف الأقران والأشقاء وتأثيره في الأطفال الأصغر والأكبر. C orbnreJ dna esubA dliHC. 1241-1041:03؛ 6002. 23. C orbnreJ. S nosnaJ. العنف ضد الأطفال 6102: مسح وطني. كارلستاد: مؤسسة دار الأطفال العامة؛ 7102. متاح من: MC llennoC, MJ gnaL. 33 es.tesuhn rabannamlla//:sptth. تطوير والتحقق من مقياس موجز لفحص الصدمة لدى الأطفال: فحص صدمة الطفل. amuarT lohcySP. 7102؛ 9(3):093-893. 43. C reshcaS وآخرون. التطوير الدولي والخصائص السيكمترية لفحص الصدمة للأطفال والمراهقين (STAC). drosiD tceffa J. 7102؛ 012:981-591. 53. D nossliN وآخرون. تقييم مقياس أحداث الحياة للشباب في لينشوبينغ (SELYL). siD tneM vreN J. 0102؛ 891(01):867-477. 63. المركز العابر للثقافات. إصابات التعذيب. متاح من: nart.www//:sptth. هيئة الصحة والرعاية الاجتماعية. الكتاب الأساسي لـ CIBB: احتياجات الطفل في المركز. ستوكهولم؛ 3202. 83. amestieR, MA sneteirG. هل من أحد يستمع؟ مراجعة الأدبيات حول العملية الحوارية لإفصاح الطفل عن الاعتداء الجنسي. amuarT dna ecneloiV. 6102؛ 71(3):043-033. 93. هيئة الصحة والرعاية الاجتماعية. العنف في العلاقات القريبة: دليل للخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية ورعاية الأسنان. ستوكهولم؛ 3202. 04. C orbnreJ وآخرون. العنف ضد الأطفال 2202: مسح وطني. تقرير بتكليف من مؤسسة دار الأطفال العامة؛ 3202. 14. P tessaH, I snevetS. تطبيق نظرية التعقيد على المخاطر في ممارسة حماية الطفل. doohdliHC. 7002؛ 41:821-441. 24. T epräjH. القياس والمقاومة: التوجيه بالأرقام في الحياة اليومية للخدمات الاجتماعية. أطروحة دكتوراه. لوند: جامعة لوند؛ 0202. 34. منظمة إنقاذ الأطفال. رعاية واعية بالصدمة. ستوكهولم؛ 8102. 44. ennuD PM وآخرون. أدوات الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم لفحص إساءة معاملة الأطفال، النسخة الاستيعادية: دراسة دلفي واختبار ميداني في سبعة بلدان. C orbnreJ dna esubA dliHC. 9002؛ 33(11):518-528. 54. H nnamreH وآخرون. ما الصمود؟ yrtaihcysP J naidanaC. 1102؛ 65(5):852-562. 64. M mörtsgnE وآخرون. خبرات ممرضات صحة الطفل في استخدام نموذج البيئة الآمنة لكل طفل أو الممارسة المعيارية الحالية لمعالجة عوامل الخطر النفسي الاجتماعي في الأسر التي لديها أطفال صغار في خدمات صحة الطفل السويدية. C orbnreJ dna esubA dliHC. 2202؛ 231:028501. 74. K tsivqmIA وآخرون. الأطفال والشباب والصدمة: الانتباه والفهم والمساعدة. ستوكهولم: rutluK hco rutaN؛ 9102. 84. D ztivbocaJ, K htur-snoyL. اضطراب التعلق: العوامل الجينية وسياقات التربية والتحول النمائي من الطفولة إلى البلوغ. في: ydisaC, RP revahS, محرران. دليل التعلق. الطبعة الثالثة. نيويورك: sserP drofliuG؛ 6102. 94. F signalB وآخرون. اختبار ما إذا كانت العوامل متعددة المستويات تحمي الأطفال المعرضين لإيذاء متعدد من الاعتلال النفسي في بداية البلوغ: دراسة جماعية طويلة. icS rtaihcysP loimedipE. 4202؛ 33:1-85e. 11. 05. اليونيسف. منع العنف ضد الأطفال والاستجابة له: التقرير العالمي عن الوضع 3202. نيويورك: صندوق الأمم المتحدة للطفولة؛ 3202. 15. K nomrÖ, J kröjB. التحقق من استبيان VOF، أي أسئلة عن العنف للبالغين؛ 1202. 25. O nnamtluH وآخرون. kSiRi: تطوير أداة تقييم وتدخلات دعم للأطفال

المتضررين من العنف. غوتنبرغ: جامعة غوتنبرغ؛ 5102. 35. etroF. بعد العنف: من التدخلات المجزأة إلى الدعم المنسق. ستوكهولم؛ 5202. 45. M remieH، N nergsroF. الأطفال بوصفهم أصحاب حقوق في تدخلات الرعاية المفتوحة. مؤسسة دار الأطفال العامة؛ 5202.

عُدِّبَ فِي طِفْلَتِهِ

[صفحة أصلية 621]

عُدِّبَ فِي طِفْلَتِهِ

[صفحة أصلية 721]

عُدِّبَ فِي طِفْلَتِهِ

[صفحة أصلية 821]

هنري آشِر هو طبيب أطفال ومراهقين وأستاذ في علوم الصحة العامة. عمل وبحث ودّرس في مجالات الهجرة والصحة وحقوق الإنسان، من بين أماكن أخرى في عيادة أطفال اللاجئين في يوتيبيوري، وضمن عمل مؤسسة روزنغرينسكا في تقديم الرعاية للأشخاص الذين لا يحملون أوراقاً، وفي مستشفى أنغريد المحلي وأكاديمية سالغرينسكا.

فيكتور موريبيتس هو أخصائي نفسي مرخّص في مركز الصليب الأحمر السويدي لعلاج المتضررين من الحرب والناجين من التعذيب في أوبسالا، حيث يعمل في العلاج النفسي للأطفال والبالغين وفي فحوص إصابات التعذيب.

الفصل الرابع توثيق إصابات التعذيب الملائم للأطفال

يُعد توثيق إصابات التعذيب أمراً حاسماً لحق الأطفال في إعادة التأهيل وجبر الضرر بعد الانتهاكات الخطيرة. ومع ذلك، ظل الشباب غير مرنيين مدة طويلة في الإرشادات الدولية وفي أعمال التوثيق العملية على السواء. فكيف يمكن التحقيق في إصابات التعذيب لدى الأطفال وتوثيقها بطريقة تراعي قابلية الأطفال الخاصة للتعرض للأذى واحتياجاتهم؟

[صفحة أصلية 921]

في عام 1984 اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وكان الهدف منع التعذيب وإنشاء نظام من الضمانات لمعاقبة من يرتكب التعذيب. ومنذ ذلك الحين تطورت المعرفة، سواء بشأن كيفية توثيق التعذيب المشتبه فيه أو بشأن أساليب إعادة تأهيل ضحايا هذا النوع من الانتهاكات. وأنشئت بروتوكولات للتحقيق، وكذلك مراكز دولية ومنظمات علمية للبحث في أساليب العلاج المختلفة وتقييمها.

وكل ذلك ذو قيمة كبيرة بطبيعة الحال. لكن العمل حتى الآن ركز على البالغين، مع استثناءات قليلة. وللأسف، يتعرض الأطفال أيضًا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وهناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن عدد هؤلاء الأطفال كبير. ومع ذلك، لا تذكر اتفاقية مناهضة التعذيب الأطفال، ولا تتوافر إلا أبحاث قليلة جدًا عنهم وعن احتياجاتهم. ولم يدخل منظور الطفل في المعيار الدولي للأمم المتحدة لتوثيق إصابات التعذيب، أي بروتوكول إسطنبول، إلا عام 2002.

ونتيجة لهذا التمييز، حُرِمَ عدد كبير جدًا من الأطفال من حق توثيق الانتهاكات التي تعرضوا لها. ولم تتح لهم فرص إعادة التأهيل والعلاج واستعادة كرامتهم، رغم أن المادة 93 من اتفاقية حقوق الطفل تضمن ذلك. وهذا غير مقبول. ولتحسين الوضع، نحتاج من جهة إلى الانتباه إلى أن الأطفال قد يكونون أيضًا ضحايا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. ونحتاج من جهة أخرى إلى تزويد المهنيين الذين يعملون مع الأطفال بالأدوات اللازمة لتحديدهم، وعرض التحقيق والتوثيق والعلاج وإعادة التأهيل عليهم.

وقد بادر مركز الصليب الأحمر السويدي لعلاج المتضررين من الحرب والناجين من التعذيب في أوبسالا، لهذا الغرض، إلى مشروع «الأطفال الذين نجوا من التعذيب» في إطار مركز الصليب الأحمر للخبرة في إعادة تأهيل المصابين بالتعذيب والحرب. وكجزء من هذا العمل، أجريت دراسة مقابلات مع عاملين في الرعاية الصحية لديهم خبرة في توثيق إصابات التعذيب لدى الأطفال في مناطق مختلفة من العالم. ونقدم في هذا الفصل نتائج الدراسة، إلى جانب نتائج العمل على إعداد نماذج تقارير ملائمة للأطفال ومواد دعم منهجية لفحوص إصابات التعذيب وفق بروتوكول إسطنبول. ونأمل أن يمثل ذلك خطوة صغيرة إلى الأمام.

الخلفية توثيق إصابات التعذيب

يعني توثيق إصابات التعذيب عملاً طبياً قانونياً منهجياً للتحقيق في تعرض الأشخاص للتعذيب وتوثيقه. ويتم ذلك من خلال ربط أوصافهم للعنف الذي تعرضوا له بالإصابات الجسدية والنفسية التي تُلاحظ أثناء الفحوص. وقد يكون لتوثيق إصابات التعذيب أغراض كثيرة، مثل جبر ضرر الأشخاص المتعرضين له، وتوفير أساس لفرض عقوبات على البلدان والجناة، وإثبات وجود التعذيب ومكافحته، أو لفت الانتباه إلى احتياجات الحماية لدى طالبي اللجوء الذين يخاطرون بالتعرض للتعذيب مرة أخرى إذا عادوا إلى بلد فرارهم. وكما ذُكر أعلاه، يوجد منذ عام 9991 معيار دولي لتوثيق إصابات التعذيب، هو بروتوكول إسطنبول، وقد نُقح عامي 4002 و2202 (1).

بروتوكول إسطنبول

يقوم بروتوكول إسطنبول على الجمع بين الفحص والتقييم الطبي والنفسي، ومقابلة تتعلق بالتاريخ والحالة النفسية الاجتماعية، ووصف مفصل للعنف الذي يقول الشخص إنه تعرض له. ووفقاً للبروتوكول، ينبغي للمحققين بعد ذلك أن يوازنوا بين هذه الأجزاء ويقدموا رأياً بشأن مدى توافق نتائج التحقيق مع العنف المدعى به. وبعبارة أخرى، ينبغي للتحقيق وفق بروتوكول إسطنبول أن يستوفي متطلبات عالية من حيث دقة التحقيق ونطاقه، ومن حيث معرفة المحققين بآثار الأشكال المختلفة للعنف الجسدي والنفسي.

تعرض الأطفال للتعذيب: مجال مهم

ينبغي، من الناحية النظرية، توثيق إصابات التعذيب لدى الأطفال للأسباب نفسها التي تُوثق بها لدى البالغين. لكن توثيق إصابات التعذيب لدى الأطفال ظل عملياً مجالاً مهماً من نواحٍ كثيرة، شأنه شأن التعريفات والعلاج والوقاية الملائمة للأطفال (2).

[صفحة أصلية 131]

كما غابت إرشادات محددة لتوثيق إصابات التعذيب لدى الأطفال (3). وكما ذكرنا في المقدمة، فإن آخر مراجعة لبروتوكول إسطنبول، عام 2202، هي التي أدخلت أوصافاً للتحقيق والتوثيق الملائمين للأطفال. لكن هذه الإضافات لا تزال بدائية نسبياً إلى جانب التعليمات الخاصة بتوثيق إصابات التعذيب لدى البالغين، ولا يمكن اعتبارها شاملة تماماً. ولا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله في مجال البحث أيضاً. فقد عثرت أول دراسة منهجية للأدبيات في مشروع «الأطفال الذين نجوا من التعذيب» على 41 دراسة منهجية فقط بشأن توثيق إصابات التعذيب لدى الأطفال، لم تتضمن سوى ست منها نوعاً من التقييم النفسي (4).

وقد تكون أسباب ذلك متعددة. فالأطفال يجدون صعوبة في إيصال أصواتهم وجعل أوضاع حياتهم مرئية في عالم البالغين. وينطبق ذلك بدرجة أكبر على الأطفال ضحايا العنف. وغالباً ما يكون العار أثراً مستمراً وطويل الأمد يصيب الضحايا ويسهم في الصمت حول تجاربهم. كما تراجعت أوضاع الأطفال تاريخياً أمام أشكال المعاناة الأخرى المرتبطة بالنزاعات المسلحة. وقد يظل تعرض الأطفال للأذى في هذه النزاعات غير مرئي أيضاً لأن استيعاب عالم البالغين له قد يكون مؤلماً جداً.

وتحيط بمسألة تعذيب الأطفال أوجه غموض تتعلق بالأوضاع والبيئات والأفعال التي يمكن أن يشملها مفهوم التعذيب وينبغي أن يشملها. كما يوجد خطر أن يثير مفهوم «التعذيب» ارتباطات بأفكار نمطية عن أساليب محددة للعنف الجسدي، مما قد يجعل الأوضاع التي تكون، عملياً، مساوية للتعذيب أو أشد منه من منظور الطفل، تقع في الظل. وللاطلاع على مناقشة أعمق لهذه المسائل، انظر الفصلين الأول والثاني.

الخبرات السويدية

في عام 7102 استقبلت عيادة أطفال اللاجئين في يوتيبوري، حيث عمل هنري أشر بين عامي 8002 و1202، عددًا من الأطفال الذين لم يكونوا مصابين بصدمة نفسية فحسب، بل كانت لديهم أيضًا ندوب جسدية نتيجة التعذيب. وعندما أراد العاملون توثيق هذه الإصابات لإصدار شهادات في قضايا لجوء الأطفال، لم يكن الأمر سهلاً. فلم يرغب الأطفال في خلع ملابسهم وإظهار الندوب. ورغم العمل المكثف من أطباء العيادة النفسيين، تعرض عدة أطفال لاسترجاعات مؤلمة أثناء الفحص، وكانت شديدة في إحدى الحالات إلى درجة اضطرارهم إلى إيقافه. وكان أحد الأطفال قد فقد سناً أمامية أثناء التعذيب، ورفض الذهاب إلى المدرسة قبل تركيب سن مثبتة له. وكانت أسئلة المدرسة عن سبب فقدانه السن تجعله يعيش التعذيب مرة أخرى.

ودفعت هذه الخبرة العاملين في عيادة أطفال اللاجئين إلى التفكير في احتمال عدم اكتشاف الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. ولذلك أجريت مراجعة للأطفال الـ 311 الذين كانوا يتلقون العلاج في العيادة. وكان 89 منهم قد تعرضوا للعنف. وبالنسبة إلى 44 طفلاً، تعلق الأمر بالتعذيب أو العنف البدني أو السجن أو التهديد بالقتل أو الاختطاف. وقد يكون الغرض الحصول على معلومات أو فدية أو التجنيد القسري في جماعات مسلحة أو الاتجار الجنسي. أما الأطفال الـ 45 الآخرون فقد تعرضوا لعنف آخر داخل الأسرة أو خارجها.

وكثيراً ما كان التعرض للعنف صعب الاكتشاف، وغُفِلَ عن حق الأطفال في الحماية، ولا سيما في عملية اللجوء. وفي حالات كثيرة، كان العلاج في العيادة قد استمر مدة طويلة قبل اكتشاف التعرض للعنف. ووجد كثير من الأطفال صعوبة في الحديث عما مروا به. وكانت الثقة والأمان والوقت شروطاً مهمة.

آثار العنف ضد الأطفال الأطفال ليسوا بالغين صغاراً

يختلف الأطفال عن البالغين في نواح عدة. ويعني ذلك أن ما يمكن أن يشكل معاملة قاسية ولاإنسانية لطفل أصغر سناً لا يلزم أن يكون بالخطورة نفسها بالنسبة إلى البالغين أو الأطفال الأكبر سناً. ولذلك يحتاج من سيحقق في الانتهاكات ضد الأطفال إلى معرفة عامة راسخة بالنمو الطبيعي للأطفال حتى يتمكن من تقييم نتائج الفحص المحتملة. وفي الوقت نفسه، يحتاج أيضاً إلى معرفة احتياجات الطفل الفردية وظروفه.

[صفحة أصلية 331]

ومن العوامل التي تختلف لدى الأطفال مقارنة بالبالغين الذاكرة، والإحساس بالزمن، والنضج المعرفي والنفسي الاجتماعي، فضلاً عن كون الطفل شخصاً في طور النمو والنضج البيولوجي. ويعيش الأطفال بدرجة كبيرة في الحاضر، كما أن خبراتهم التي يمكنهم ربط تجاربهم بها محدودة. وقد يؤثر ذلك في كيفية تخزين الذكريات واستعادتها والتعبير عنها. ومن نتائج ذلك أن إحساس الأطفال بالزمن مختلف. فأسئلة مثل «متى حدث ذلك؟» و«كم استمر؟» و«ماذا حدث بعد ذلك؟» يصعب غالباً على الأشخاص الذين تعرضوا لعنف صادم الإجابة عنها. وبالنسبة إلى الأطفال في جميع الأعمار، تكون الإجابة أصعب أو مستحيلة. ولذلك يعتمد الموثق غالباً على وثائق أو معلومات من البالغين آخرين.

وقد تكون للأطفال ذوي الصعوبات المعرفية أو المشكلات السلوكية أو الأمراض والإعاقات المزمنة احتياجات فردية ينبغي مراعاتها، في حين يكونون معرضين بوجه خاص للعنف والانتهاكات. ويجعل ذلك العنف يؤدي إلى آثار مختلفة وأشدّ جزئياً بسبب زيادة صعوبة التعامل مع الضغوط. وقد يجد هؤلاء الأطفال أيضاً صعوبات خاصة في وصف ما تعرضوا له وتجاربهم المتعلقة به.

[صفحة أصلية 431]

كلما كان الطفل أصغر سنًا، زاد اعتماده جسديًا ونفسيًا على البالغين أمنين يتعلق بهم. ويحتاج الأطفال إلى الحماية من أجل بقائهم، وهم غالبًا واعون بذلك. ويستمر احتياجهم إلى حماية البالغين خلال معظم فترة النشأة. ويُعاش سلب هذا الأمان، أو التهديد بسلبه، بوصفه تهديدًا وجوديًا لكيان الطفل كله. وهذا أحد أسباب تأثر الأطفال بشدة عندما يشهدون تهديدات أو عنفًا أو انتهاكات ضد والديهم، حتى لو لم يتعرضوا هم مباشرة لذلك. وكثيرًا ما يصف الأطفال أنهم يخافون من أن يحدث شيء لوالديهم أكثر من خوفهم من تعرضهم هم للأذى.

كما أن فصل الطفل عن والديه خلافًا لإرادته وإرادة الطفل، مثل اختطافه، يكون في العادة تجربة مخيفة ومسببة للصدمة جدًا. وينطبق الأمر نفسه عندما يُهدد الطفل بوقوع أمور فظيعة لوالديه إذا لم يفعل ما يريده الجناة. ويصبح وضع التعذيب، سواء وُجه أساسًا إلى الوالدين أو إلى الطفل نفسه، انهيارًا وجوديًا يحطم إحساس الطفل بأن والديه قادران على حمايته. ويرى الطفل كيف تتحطم صورته السابقة عن والديه، ربما بوصفهما قويين وأمنين، وكيف يتحولان أمام عينيه إلى عاجزين مثله.

سلوك الأطفال واحتياجاتهم بعد التجارب العنيفة

تتأثر قدرة الأطفال على التعامل مع ما مروا به وفهمه بقدراتهم المعرفية. وتختلف هذه القدرات بين الأطفال، لكنها تعتمد أيضًا على نمو الطفل النفسي والاجتماعي والجسدي. ويفسر الطفل الصغير الأحداث الصعبة ويعالجها وفق القدرات التي يمتلكها. ومع نمو الطفل وتطوره، يطور قدرات جديدة. ومن الشائع عندئذ أن يعيد الطفل تفسير الحدث نفسه بطرق مختلفة.

[صفحة أصلية 531]

وقد يحاول الأطفال الذين عاشوا أحداثاً صعبة ومؤلمة تتجاوز تجاربهم السابقة إغلاق ذاكرتهم عن الحدث ودفعها بعيداً إذا شعروا بأنها مؤلمة جداً وأنهم يفتقرون إلى وسائل التعامل معها ومعالجتها. لكن الطفل قد يحاول أيضاً معالجة التجربة وفق قدراته. ويكون اللعب الوسيلة الأكثر شيوعاً لدى الأطفال. وقد يتفاعل البالغون أحياناً بقوة عندما يلعب الأطفال لعبة الحرب أو العنف، لكن بالنسبة إلى طفل لديه تجارب عنيفة خاصة به، قد يكون هذا اللعب وسيلة للتعبير عنها ومعالجتها.

ومع ذلك، قد يعلق الأطفال المصابون بالصدمة في اللعب، ويكررون العنف والانتهاكات بطريقة آلية. وقد يحتاجون عندئذ إلى المساعدة في العثور على طريق للخروج من التكرار الصادم.

وغالباً ما يحتاج الأطفال الأكبر سناً إلى التعبير عن تجاربهم بالكلمات. وقد يحتاجون عندئذ إلى دعم مستمع بالغ. ويصعب على كثير من الأطفال وضع تجاربهم في كلمات، ولا سيما بلغة ليست لغتهم الأم. ولذلك من المفيد عرض بدائل مختلفة على الأطفال، مثل الرسم وكتابة اليوميات والشعر وكلمات أغاني الراب والتصوير الفوتوغرافي أو التصوير بالفيديو.

وغالباً ما ينتبه الطفل الذي يروي حدثاً صادمًا إلى المستمع، ويكيف روايته وفق ما يعتقد أن المستمع يستطيع تحمله. وقد يحد الطفل من قصته ويقلل من شأنها إذا شعر أن المستمع غارق في التأثر أو حزين بسببها. وغالباً ما تكون رواية الطفل محاولة لتحديد ما مر به. وكثيراً ما توجد فجوات وتناقضات وأمور غير مترابطة. وقد يرغب البالغ بسهولة في تصحيحها، لكن الخطر عندئذ أن يركز الطفل أكثر على إرضاء المستمع.

الآثار الجسدية للعنف

تتشابه الآثار الجسدية لدى الأطفال الذين يتعرضون للعنف الجسدي مع آثارها لدى البالغين وتختلف عنها. وقد تكون الآثار فورية، مثل الجروح والكسور، أو تظهر لاحقاً، مثل الآثار الناتجة عن العنف الذي يصيب الدماغ والجهاز العصبي. وتلتئم البشرة والأغشية المخاطية والأنسجة الرخوة والهيكل العظمي عادة لدى الأطفال بصورة أفضل وأسرع من البالغين، وكلما كان الطفل أصغر سناً زاد ذلك. ويعني هذا أن الإصابات قد تلتئم بسرعة نسبياً ولا يلزم أن تترك ندوباً ظاهرة.

لكن لدى بعض الأشخاص قابلية فطرية للشفاء مع ندوب كبيرة ومتضخمة قد تكون مؤلمة، وتحد الحركة، وتسبب مشكلات من الناحية الشكلية. ويشيع ذلك أكثر لدى بعض الفئات ذات البشرة الغنية بالصبغة.

وقد تؤدي الإصابات التي عولجت أو عولجت بطريقة خاطئة، مثل الكسور والتهابات الأنسجة الرخوة، إلى مشكلات مستمرة، مثل التشوهات وإصابات الأنسجة الرخوة أو عيوبها، وضعف الحركة والوظيفة، والألم. وقد يعوض الطفل النامي أحياناً عن هذه الإصابات من خلال تطور وظائف وقدرات جديدة تقلل آثار الفقد. لكن العواقب تستمر غالباً، أو قد تظهر وتصبح أوضح.

وفيما يتعلق بآثار الإصابات العصبية، أي الإصابات التي تصيب الدماغ والجهاز العصبي، يصاب البالغون عادة بإصابات بؤرية. ويعني ذلك تضرر وظائف محددة، مثل شلل نصف الجسم أو تضرر القدرة على الكلام. أما لدى الأطفال، فيكون الدماغ والجهاز العصبي في طور النمو، ولذلك تكون للإصابات غالباً آثار أكثر عمومية.

[صفحة أصلية 731]

وقد يتأثر استمرار نمو الدماغ بطرق مختلفة، لكنه لا يكون في كثير من الأحيان واضحًا بالقدر نفسه الذي يكون عليه لدى البالغين. وقد تكون المنعكسات العصبية طبيعية، لكن الإصابات قد تظهر عند ركض الطفل بسرعة في صورة حركات مصاحبة مرضية، مثل تشنج الذراع أو ركض الطفل بطريقة غير طبيعية. وقد تشمل الآثار الأخرى تغيرات سلوكية يمكن أن تكون استجابة نفسية. كما أن المشكلات المعرفية وصعوبات التعلم والصعوبات الأكثر دقة وانتشارًا من الآثار الشائعة لإصابات الدماغ، وقد تظهر في سن أكبر عندما تزداد المطالب. وقد يظهر الصرع أيضًا بوصفه أثرًا متأخرًا للعنف الذي يصيب الرأس.

عمل الصليب الأحمر السويدي في توثيق إصابات التعذيب والأطفال

يدير الصليب الأحمر السويدي، وقت كتابة هذا النص في ربيع 6202، خمسة مراكز لعلاج المتضررين من الحرب والناجين من التعذيب في أنحاء السويد. وإلى جانب التقييمات والعلاجات، تقدم هذه العيادات أيضًا خدمة توثيق إصابات التعذيب. ويتم ذلك من خلال تحقيقات يجريها العاملون في مراكز العلاج، بدعم من شبكة من الأطباء المتطوعين الذين يساعدون في التحقيقات. ويتلقى جميع المحققين تدريبًا على بروتوكول إسطنبول، ويعملون بدعم من زملاء ومحامي قانون اللجوء ذوي الخبرة، انطلاقًا من إجراءات مكتوبة ونموذج موحد لتقارير توثيق إصابات التعذيب.

لكن المنظمة تلقت، خلال السنوات التي أجرت فيها فحوص إصابات التعذيب، عددًا قليلًا جدًا من الطلبات المتعلقة بالأطفال، وتفتقر عمومًا إلى الخبرة في التحقيق معهم. ومع ذلك، يوجد عمل مستمر في مجال التقييم والعلاج النفسي للأطفال الذين أصيبوا بصدمة نتيجة الحرب أو التعذيب في مركز العلاج في أوبسالا، وهو مركز العلاج الذي يستقبل الأطفال مرضى. أما مراكز العلاج الأخرى فتقدم نشاطًا نفسيًا اجتماعيًا للأطفال الذين تربطهم صلة قرابة بالمرضى البالغين.

أجزاء المشروع الفرعي

تكون المشروع الفرعي الخاص بتوثيق إصابات التعذيب من جزأين. كان الجزء الأول دراسة مقابلات صغيرة، هدفها تحسين فهم تعقيد التقييمات النفسية للأطفال في توثيق التعذيب وإساءة المعاملة. وُفُذَت الدراسة بجمع آراء خبراء سريريين لديهم خبرة ذات صلة وتركيبها. أما المكون الثاني للمشروع الفرعي فتألف من إعداد مادة دعم منهجية مكتوبة لفحوص إصابات التعذيب لدى الأطفال، إلى جانب نموذج تقرير جديد للأطفال.

نصف أدناه أولاً منهج دراسة المقابلات ونتائجها واستنتاجاتها. ثم نعرض العمل المتعلق بمادة الدعم المنهجية ونموذج التقرير، إلى جانب استنتاجات المؤلفين وتوصياتهم الموجزة.

دراسة المقابلات المنهج

المشاركون

سُعى إلى العثور على المشاركين في المقابلات أولاً من خلال الشبكة المهنية لتوثيق إصابات التعذيب وإعادة تأهيلها التابعة للمجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب (TCRI)، حيث إن جميع مراكز الصليب الأحمر السويدي للعلاج أعضاء. وبعد ذلك استمر استقطاب المشاركين بطريقة كرة الثلج، من خلال الشبكات والمنظمات التي أُقيم اتصال بها أثناء العملية. وأبلغ المشاركون المحتملون شفهيًا وكتابيًا بهدف المشروع ومضمونه، وبطوعية المشاركة وسريتها. ولم يُقدم أي تعويض. وبناءً على ذلك، وافق جميع المشاركون على مساهمتهم.

ومن الجدير بالملاحظة، فيما يتعلق بعملية الاستقطاب، صعوبة العثور على أخصائيين نفسيين أو عاملين اجتماعيين أو أطباء نفسيين للأطفال لديهم خبرة ذات صلة بتوثيق إصابات التعذيب لدى الأطفال والشباب، حتى عند الاتصال بمنظمات يتمحور عملها الأساسي حول توثيق إصابات التعذيب وإعادة تأهيلها.

[صفحة أصلية 931]

أُجريت مقابلات مع سبعة أشخاص أثناء المشروع. وشمل هذا الاختيار أربعة أشخاص يعملون في شمال أوروبا، وشخصًا في غرب آسيا، وشخصًا في شرق أفريقيا، وشخصًا في أمريكا الوسطى. وكان اثنان من المشاركين طبيبين متخصصين في الطب النفسي للأطفال والعلاج النفسي للأطفال، وثلاثة أخصائيين نفسيين، ومعالجًا نفسيًا واحدًا، وأخصائيًا اجتماعيًا واحدًا. وكان لجميع المشاركين سنوات عدة من الخبرة في العمل على توثيق التعذيب وغيره من أشكال العنف الذي يتعرض له الأطفال.

المقابلات

أُجريت المقابلات بصورة شبه منظمة، انطلاقًا من ستة مجالات حُددت مسبقًا. وطُرحت أسئلة متتابعة أثناء المقابلات استنادًا إلى إجابات المشاركين، بهدف السماح لخبراتهم بتوجيه المحادثة إلى ما يتجاوز تصورات المحاور القائمة. وأُجريت المقابلات وسُجلت عبر منصات رقمية لمحادثات الفيديو، وتراوحت مدة التسجيلات بين 25 و57 دقيقة. واستخدم مترجم شفوي في إحدى المقابلات، بينما أُجريت المقابلات الأخرى بالسويدية أو الإنجليزية أو الإسبانية.

واختبرت المجالات الستة التي غطتها كل مقابلة انطلاقًا من الأبحاث السابقة والأدلة والإرشادات القائمة، ولا سيما بروتوكول إسطنبول. وشملت الشخص الذي أُجريت معه المقابلة وخبراته المهنية، والسياق والأغراض والأماكن والفئات العمرية واللغات والسياق القانوني، والتقييم في الأعمار المختلفة، والأسرة، ومصلحة الطفل الفضلى وحقوقه، والثقافة والإثنية.

[صفحة أصلية 041]

وتتناول مجال الأسرة إجراء فحوص إصابات التعذيب مع الأطفال الذين يعيشون مع أسرهم الأصلية أو المنفصلين عنها، والحصول على الموافقة، ودور مقدمي الرعاية، والتحديات مثل مشاعر الذنب أو التهديد داخل الأسرة. وتتناول مجال مصلحة الطفل الفضلى الأوضاع التي يكون فيها التحقيق مناسباً أو غير مناسب، والاعتبارات والاستثناءات والتعديلات اللازمة لرعاية مصلحة الطفل. أما مجال الثقافة والإثنية فتتناول ما إذا كانت هذه العوامل تسهل التحقيقات والتوثيق أو تعيقهما، وما إذا كانت ذات صلة في السياقات المختلفة.

التحليل

فُرِغَت التسجيلات كتابيًا بواسطة خدمة تفرغ متخصصة، وُحِلَّت موضوعيًا (5).

النتائج السياقات

تحدث المشاركون عن العمل في توثيق إصابات التعذيب ضمن مجموعة متنوعة من السياقات الجغرافية. وفي سياق غرب آسيا، أُجريت الفحوص أساسًا بهدف إظهار التعذيب ومكافحته على المستوى السياسي. وُصِف استهداف الأطفال بالتعذيب، أساسًا، بغرض مهاجمة الجماعة الإثنية التي ينتمون إليها. وكانت المنظمة تعمل من خلال عيادات ومن خلال نشاط ميداني، حيث كانت الأسر المحتاجة إلى خدماتها تُحدد أثناء العمل الميداني.

[صفحة أصلية 141]

وفي سياق آخر، استُخدم توثيق إصابات التعذيب لمكافحة التعذيب، ولا سيما فيما يتعلق بالسجناء السياسيين، وكان من الممكن استخدامه أيضًا بوصفه دليلاً في إجراءات جبر الضرر القانونية للمعتقلين. ووصف أن الأطفال كانوا يتعرضون للتعذيب بوصفه وسيلة لمهاجمة والديهم الناشطين سياسيًا. وكانت المنظمة تعمل بدرجة كبيرة من خلال نشاط ميداني، كما كانت تتلقى قضايا عبر التوصيات الشفهية.

وفي سياق أمريكا الوسطى، عمل أحد المشاركين في منظمة تدبر مشاريع نفسية اجتماعية داخل مؤسسات احتجاج الأحداث، وكانت تجري فيها أيضًا فحوص إصابات التعذيب. وكان الأطفال في هذا السياق يتعرضون للتعذيب، قبل كل شيء، داخل نظام العدالة.

وأجريت أربع مقابلات مع أشخاص يعملون في ثلاثة بلدان مختلفة في سياق شمال أوروبي، حيث كان توثيق إصابات التعذيب يُجرى، دون استثناء تقريبًا، في إطار إجراءات اللجوء، إما للاحتجاج بخطر التعرض للتعذيب مرة أخرى عند العودة إلى بلد الأصل، أو للاحتجاج بالعواقب الصحية للتعذيب بوصفها سببًا لمنح تصريح الإقامة. وكانت المنظمات التي عمل فيها المشاركون تدبر خدمات استقبال في الرعاية الصحية أو أشكالًا أخرى من الدعم للأشخاص الفارين.

[صفحة أصلية 241]

التحديات والاستراتيجيات

وصفت المقابلات تحديات في الفحوص النفسية لإصابات التعذيب لدى الأطفال، تختلف في بعض الحالات بين السياقات المختلفة، لكنها تتشابه في حالات كثيرة.

وكانت إحدى التحديات التي حددها جميع المشاركون الحاجة إلى إقامة اتصال جيد بالطفل وكسب ثقته. ووفقًا للمشاركين، قد يحتاج الأطفال المصابون بالصدمة غالبًا إلى وقت أطول من البالغين حتى يشعروا بالأمان، وقد أُشير في جميع المقابلات إلى الحاجة إلى وقت كاف لذلك. ووصف أحد المشاركين الأمر قائلاً:

«عليّ أن أبذل جهدًا كبيرًا لخلق جو جيد يمكن لطفل أصغر أن يشعر فيه بالأمان. وأعتقد أن الأمر كذلك مع المراهقين أيضًا، لكنه أكبر بكثير... نعم، أحتاج إلى بذل جهد أكبر بكثير مع الطفل الأصغر لخلق ذلك الجو».

وذكر عدة مشاركون أيضًا مشاركة البالغين من مقدمي الرعاية أثناء التحقيق بوصفها استراتيجية لزيادة ثقة الأطفال وشعورهم بالأمان. وذكر بعض المشاركون الزيارات المنزلية للأطفال وأسرهـم استراتيجية لزيادة الثقة في العلاقة مع الأطفال ومقدمي الرعاية على السواء. كما تناول عدة مشاركون حاجة الأطفال إلى الدعم والتشجيع والمدح أثناء التحقيقات.

ومن التحديات الأخرى التي أبرزها عدة مشاركين تفاوت قدرة الأطفال، ولا سيما الأصغر سنًا، على التعبير بالكلمات عن تجاربهم وحالتهم النفسية الحالية. وذكر بعض المشاركون أن الاستراتيجية الأساسية للتعامل مع ذلك هي إتاحة أساليب تعبير ملائمة للعمر، مثل اللعب أو الفن.

[صفحة أصلية 341]

ووصف أحد المشاركين الأمر قائلاً: «الأمر أكثر عدماً للتحديد، وأعتقد أنني في التقييم أحتاج إلى... يجب أن أكون مرئاً جداً. يمكنني استخدام استمارات التقييم، لكن يمكنني أيضاً محاولة الحصول على المعلومات من خلال اللعب مع الطفل أو النظر في كتاب معه».

وكانت الاستراتيجية الأخرى استخدام معلومات الوالدين أو مقدمي الرعاية الآخرين تكملته لفهم تواصل الطفل بصورة أفضل. وذكر أحد المشاركين الحاجة إلى وقت كافٍ لتقييم تواصل الطفل الفردي. كما ذكر عدة مشاركين اعتمادهم على الخبرات السابقة والتعليم عند إقامة التواصل مع الأطفال الذين يفحصونهم وتفسيره.

ووصف أحد المشاركين ذلك قائلاً: «نحاول أن يكون لدينا وقت كافٍ للقيام بأشياء مختلفة مع الأطفال. ونبدأ بإجراء يتيح لنا التعرف إلى بعضنا، ويتيح للوالدين أيضاً التعرف إلى المحقق. ويمكن للأطفال أن يروا أنهما، حسناً، ودودان تجاه بعضهما وأن الجو مريح. هذه خطوة أولى. ثم نحاول التفاعل مع الأطفال وفق أعمارهم. فكلما كانوا أصغر، لعبنا أكثر ربما بأشكال صغيرة ودمى صغيرة، مثل بلاي موبيل. وننشئ بعض الأوضاع المختلفة ثم نراقب».

وأضاف مشارك آخر: «لدي، من جانبي، تدريب مهني على التعامل مع مسائل الأطفال والعنف. وقبل أن أعمل لدى [صاحب العمل السابق]، دربني [صاحب عمل سابق آخر] على العمل مع الأطفال. وتعلمت مهارات التعامل مع الأطفال والحصول على المعلومات منهم».

[صفحة أصلية 441]

وكان من التحديات القريبة التي حُددت مسبقاً في مادة المقابلة تقييم التناقضات الظاهرة في أوصاف الأطفال لتجاربهم. وعند الحديث عن ذلك، تناول عدة مشاركين الحاجة إلى وقت كافٍ للتعرف إلى الطفل، وفهم ما يتواصل بشأنه بصورة أفضل من خلال التفاعل والملاحظة مع مرور الوقت. وقيل إن ذلك ينطبق بوجه خاص على فحوص الأطفال الأصغر سناً. وكانت استراتيجية أخرى ذكرها المشاركون أن يساعد البالغون من مقدمي الرعاية الأطفال على تنظيم تواصلهم أثناء التحقيق.

ومع ذلك، لم يُطرح الوالدان ومقدمو الرعاية الآخرون بوصفهم دعماً للتحقيقات فحسب، بل عُذوا تحدياً محتملاً أيضاً. وذكر عدة مشاركين أن الوالدين والأطفال قد يميلون إلى حماية مشاعر بعضهم بعضاً، من خلال تجنب موضوعات معينة في حضور الطرف الآخر، وقد لا يكون أحدهما واعياً أحياناً بما يعيشه الآخر.

ووصف أحد المشاركين طفلاً كان يستيقظ كل ليلة ويبكي، لكنه لم يكن يريد إيقاظ أمه. وكانت الأم تتناول مضادات اكتئاب وتنام نوماً عميقاً، ولذلك قالت إن طفلها ينام طوال الليل، من دون أن تعرف أنه يستيقظ كل ليلة في الساعة الواحدة. وذكر المشاركون أن أفراد الأسرة قد يخفون مشكلاتهم ويحاولون أن يكونوا أقوىاء، وربما لا يتقبلون مشكلاتهم الخاصة أو لا يريدون الاعتراف بها، وقد يكون ذلك غريزة بقاء.

وأشار المشاركون أيضاً إلى أن العلاقات في الأسر المصابة بالصدمة تتوتر عادة بسبب العار أو الذنب المرتبطين بتجارب العنف المشتركة، مما قد يسهم في صعوبات التواصل داخل الأسر أثناء التحقيق. ووصف أحد المشاركين مقدار العار والذنب الذي قد ينشأ عندما تغادر الأسرة هرباً لحمايتها ثم تحدث أمور أسوأ أثناء الفرار، أو عندما يشعر الطفل بالذنب تجاه والديه لأنه وضعهما في موقف معين.

[صفحة أصلية 541]

وفي سياق أمريكا الوسطى، وُصف العمل مع شبكة لأولياء أمور الأطفال المعذبين، أنشئت بهدف تقليل الوصمة التي تعاني منها الأسر وتعزيز قدرة الوالدين على دعم أطفالهم. وفي سياق غرب آسيا، وُصف العمل الميداني مع الأسر المعرضة للأذى، من خلال الزيارات المنزلية والاتصالات عبر الإنترنت، بوصفه استراتيجية رئيسية للتغلب على صعوبات العار والوصمة. وقال أحد المشاركين: «أنشأنا فريقًا متنقلًا. يذهبون إلى منازل الأسر، وهذا مرتبط بالثقافة. فالأسر لا تجرؤ على إرسال طفلها لأنها لا تريد أن يُوصم بأنه مجنون أو ليس بخير نفسيًا بسبب هذه الأمور. ولذلك قررنا أن نذهب نحن إليهم ونحاول الوصول إليهم».

وكان من التحديات التي حددها مشاركان تقييم مصلحة الطفل الفضلى فيما يتعلق بإجراء فحوص إصابات التعذيب من عدمه. ومن الأمثلة المراهقون طالبو اللجوء المنفصلون عن أسرهم الأصلية، والمخاطر التي قد تنشأ إذا كُشفت معلومات التحقيق من خلال إجراءات قانونية. وقد يصعب على المراهقين تقييم هذه المخاطر مسبقًا، مما يؤثر أسئلة عن كيفية الحصول على موافقة مستنيرة بطريقة تحمي مصالح الشاب في الوقت نفسه.

ويتعلق مثال آخر بالأطفال الذين لا يزالون يعيشون مع أسرهم ويشاركون معلومات مع المحققين، وقد تؤدي إتاحة هذه المعلومات إلى وصم الأسرة أو إلى خطر تعرض الطفل لعنف قائم على الشرف من أفراد الأسرة أو أقارب آخرين. وتأمل المشاركون في الحاجة إلى حماية الأطفال والموازنة بين مخاطر واحتياجات مختلفة قد تتعارض، مع إتاحة مجال لوكالة الطفل وموافقة المستنيرة.

[صفحة أصلية 641]

وذكر مشاركان أن الخبرة في العمل مع حالات مماثلة حاسمة في إجراء الموازنات الصعبة. ووصف أحد المشاركين الأمر قائلاً: «الأمر ليس أسود وأبيض بسهولة، بل علينا أحياناً إجراء موازنات سيئة جداً: ما الأقل سوءاً؟ وعندما يعمل المرء في هذا المجال كثيراً، أعتقد أنه يدرك ذلك، لكن إذا لم يعمل كثيراً مع الأطفال، ربما طالبي اللجوء، فلا أعتقد أنه يفهم تماماً مدى صعوبة الحصول على اللجوء، وأن هذا جزء من الأسئلة».

وتناول أحد المشاركين جانباً آخر من مصلحة الطفل الفضلى، وهو تضارب المصالح المحتمل في لقاء الأطفال المصابين بالصدمة، بين الأغراض المحدودة لفحص إصابات التعذيب من جهة، وواجب الرعاية العلاجي من جهة أخرى. فهناك حاجة المحقق إلى الحصول على معلومات محددة عن التعذيب المدعى به، مقابل حاجة الطفل إلى معالجة تجارب قد تبدو، من منظوره، مهمة بالقدر نفسه أو أهم.

ورأى المشاركون أن الالتزامات الأخلاقية المتعلقة برعاية مصلحة الطفل الفضلى تعني محاولة تلبية حاجة الطفل إلى جعل تجاربه مترابطة. وفي الوقت نفسه، عُد ذلك مهمة صعبة ومعقدة، ولا سيما مع الأطفال المنفصلين عن والديهم، الذين ربما لم يحصلوا قط على مساعدة من بالغ لمعالجة تجاربهم. وقال أحد المشاركين: «نادرأ ما يطلب الأطفال المساعدة، فلا يمكن للمرء طلب المساعدة في شيء لا يستطيع صياغته... لكن عندما لا يكون هناك والدان، يصبح المرء نوعاً ما والداً أيضاً طوال الوقت في اللقاء معهم، لأنهم يحتاجون إلى والد، فيضطر المرء إلى أن يكون كذلك قليلاً».

[صفحة أصلية 741]

وعند السؤال عن تأثير الثقافة والإثنية في التحقيقات، تفاوتت إجابات المشاركين بين اعتبار هذه الجوانب مهمة جدًا واعتبارها غير مهمة بوجه خاص. وتحدث أحد المشاركين عن عدم وجود صعوبات عادة في لقاء الأطفال والوالدين من ثقافات وإثنيات مختلفة، باستثناء جماعة محددة في سياقها، حيث شكلت الفروق الثقافية والدينية عائقًا كبيرًا أمام إقامة الثقة. وذكر مشارك آخر أن مؤسسته حاولت إنشاء نشاط ميداني ملائم للاحتياجات الخاصة لأقلية إثنية معينة في سياقها.

ورأى مشارك ثالث أن خطر التركيز المفرط على الفروق الثقافية أو الإثنية أكبر من خطر عدم الوعي بها، وشدد على أهمية تجنب الأحكام المسبقة القائمة على افتراضات عن هوية المريض، بقوله: «... ينبغي أن نتذكر أن الإنسان الذي أمامنا إنسان، لا أصلًا أو ما شابه ذلك».

التحليل الموضوعي وآثاره النهج العلاجي والوقت الكافي

كان من الموضوعات التي ظهرت في التحليل الحاجة إلى نهج علاجي تجاه الأطفال والوالدين لإتاحة إجراء تقييمات مناسبة. وقد يعني «النهج العلاجي» أمورًا كثيرة، لكنه يشير هنا إلى أوصاف المشاركين لأمر مثل العمل النشط على إطار التحقيق، والتعاون، والأهداف المشتركة، وشعور الطفل والوالدين بالقدرة على الفعل، والأمان العاطفي، وتحالف العمل المتعلق بالاحتياجات النفسية للطفل المفحوص. وقد ظهرت هذه الجوانب في المقابلات، ولها أوجه تشابه واضحة مع المسائل المنهجية الشائعة في العلاج النفسي للأطفال والأسر. كما أن عدة تدخلات ذُكرت في القسم السابق شائعة في سياقات العلاج.

[صفحة أصلية 841]

وظهر هذا الموضوع بوضوح خاص في التعليقات المتكررة حول الحاجة إلى وقت كاف لتعميق العلاقة مع الطفل المفحوص وتقويتها. ووفقاً للمشاركين، كان أحد أغراض ذلك تمكين الطفل من الشعور بالأمان والارتياح بما يكفي ليتمكن من التواصل بشأن محتوى صعب عاطفياً. وكان غرض آخر، ذُكر أيضاً، هو حاجة المهني إلى تفسير تواصل الطفل وسلوكياته الأخرى ضمن علاقة أخذة في النمو، وفي عملية تعاونية عبر الزمن. وعندما نضع هذين الغرضين جنباً إلى جنب، فإنهما يبرزان الأهمية الحاسمة للعلاقة في إتاحة التقييمات النفسية لآثار التعذيب المدعى به على الأطفال.

وظهر الموضوع أيضاً في التعليقات التي تناولت مساعدة الأطفال والوالدين على التغلب على الخوف أو العار أو الذنب الناجم عن العنف الذي تعرضوا له. ففي هذه الحالة تصبح ردود الفعل العاطفية أثناء التحقيق، من جهة، أعراضاً لضرر نفسي تسببه التجارب المدعى بها التي يجري التحقيق فيها، ومن جهة أخرى عوائق نفسية أمام الحصول على المعلومات أثناء التحقيق، ينبغي التغلب عليها. ولذلك تخدم التدخلات المهنية الرامية إلى مواجهة هذه الاستجابات غرضين مترامين ومتشابهين: فهي تسهل التحقيق مع الطفل، وتساعد في الوقت نفسه على التعافي.

إن موضوع النهج العلاجي الظاهر في المقابلات ليس جديداً، ولا يقتصر على فحوص إصابات التعذيب لدى الأطفال. فبروتوكول إسطنبول، مثلاً، يوصي لجميع الأعمار بأن يتجنب المحققون «الحياذ السريري»، ويقترحون بدلاً من ذلك أن يكونوا «داعمين» و«شفافين» و«غير حُكَميين» (§525)، وأن يستخدموا «الاستماع النشط» و«التواصل الدقيق» و«التعاطف الحقيقي» (§272).

[صفحة أصلية 941]

وكان من الممكن العثور على جميع هذه التوصيات في مواد تعليمية أو أدلة لكثير من العلاجات النفسية أو المعالجات النفسية. لكن يبدو أن هذه الاحتياجات تتركز بدرجة أكبر عند العمل مع الأطفال. فالكثير من التحديات التي حُددت في هذا المشروع يبدو مرتبطاً بصعوبة الأطفال الأكبر في فهم سبب إجراء توثيق إصابات التعذيب، ومن يقابلهم، ولماذا ينبغي لهم وصف تجاربهم، وكذلك ما عاشوه أو يعيشونه فعلاً، ووضع ذلك في كلمات. وقد يكون النهج العلاجي حاسماً لجعل وصف التجارب الصادمة ممكناً حتى لكثير من البالغين، لكن التحديات الخاصة بالأطفال تجعل هذا النهج ضرورياً أثناء هذه التحقيقات.

ويعرّف بروتوكول إسطنبول واجب الرعاية بصورة أوضح للأطفال منه للبالغين، لكنه يقصر واجب المحقق تجاه الأطفال على «حماية الطفل» و«تجنب المخاطر والإبلاغ عنها» (§461). وتشير المقابلات في المشروع إلى أنه، إلى جانب هذه المهمة المحدودة، ينشأ سؤال أخلاقي آخر للمهنيين الذين يعملون مع أطفال قد يكونون متأثرين بالتعذيب، يتمثل في الحاجة إلى مساعدة الطفل نفسياً، مثل مساعدته على ترتيب تجاربه ومنحها معنى. وبذلك تثير قابلية الأطفال الخاصة للتعرض للأذى واحتياجاتهم النمانية أسئلة عن أخلاقيات التحقيق عندما تُلاحظ احتياجات علاجية أثناءه. وفي الوقت نفسه، توضح إفادات المشاركين أن إجراءات التقييم النفسي في توثيق إصابات التعذيب لدى الأطفال والشباب تتداخل مع التدخلات العلاجية.

ولذلك يصعب لدى الأطفال المصابين بالصدمة الفصل الواضح بين التحقيق والعلاج. وهذا يخلق تحديات خاصة لمن يجد نفسه في هذا الدور المزدوج، وهو ما تنعكس عليه الإشارات المتكررة في المقابلات إلى الحاجة إلى الوقت والتعليم والخبرة، حتى يمكن تقييم تواصل الأطفال وسلوكهم، اللذين يصعب تفسيرهما غالباً، بطريقة مقبولة أخلاقياً أثناء التحقيق.

[صفحة أصلية 051]

التعليم والخبرة

كان الموضوع الرئيسي الثاني الذي ظهر في التحليل هو اعتماد الأطباء على التعليم والخبرة عند التعامل مع التحديات التي بدت خاصة بالتحقيق مع الأطفال. وظهر هذا الموضوع في الحديث عن كيفية تقييم المعلومات المجموعة وتفسيرها، وفي الحديث عن الجوانب العملية لتنفيذ إجراءات التحقيق.

وذكر عدة مشاركين اعتمادهم على الخبرة عند الحديث عن إقامة الاتصال والثقة، وفهم تواصل الأطفال وتقييم أعراسهم، والعمل مع أفراد الأسرة، والتعامل مع المخاطر أثناء التحقيقات وضمان مراعاة مصلحة الطفل الفضلى. وظهر ذلك مراراً عندما انتقلت المقابلات إلى مستوى التفاصيل المتعلق بالتفسير واتخاذ القرار والحلول البديلة للتحديات والصعوبات الشائعة، كما ظهر مراراً في الحديث عن التحديات الخاصة بالأطفال الأصغر سناً.

وسلط أحد المشاركين الضوء على الموضوع نفسه من زاوية أخرى، إذ ذكر مراراً، رغم تدريبه وخبرته في العلاج النفسي وفي هذا النوع من التحقيقات، أن نقص التعليم الخاص بالأطفال كان يزيد صعوبة عمله على التحقيق مع الأطفال ويحد منه.

من جهة، قد يبدو بديهياً أن مهمة معقدة وحساسة، مثل التقييم النفسي لتأثير الطفل بالتعذيب المدعى به، تتطلب تعليماً وخبرة مناسبين. ومن جهة أخرى، أثّر هذا الموضوع مراراً وتكراراً في المقابلات المتعلقة بتحديات المهمة. كما أصبح واضحاً مدى ترابط التقييم والحصول على المعلومات، وكيف يحدث كلاهما ضمن علاقة أخذة في التكوين مع الطفل المفحوص.

[صفحة أصلية 151]

ويمكن النظر إلى إقامة هذه العلاقة وتعميقها واستخلاص النتائج منها بوصفها نوعاً من الحرفة التي ليس من السهل تلخيصها في أدلة أو إرشادات.

ومن الجدير بالملاحظة أن موضوع التعليم والخبرة ظهر كثيراً بوجه خاص عند الحديث عن التحديات الخاصة بالأطفال الأصغر سناً. ولعل هذا يدل على نوع التعليم والخبرة المطلوبين عند العمل مع هذه الفئة.

[صفحة أصلية 251]

وتختلف احتياجات الأطفال وسلوكياتهم وتجاربهم للعالم المحيط اختلافاً كبيراً تبعاً للعمر؛ فكلما كان الطفل أصغر، زادت الفروق عن البالغين. وكثيراً ما نرى الأطفال الأكبر سناً شبه البالغين، فنخاطر عندئذ بتجاهل أن لديهم هم أيضاً احتياجات خاصة بالأطفال، وإن كانت ملائمة لعمرهم ونضجهم. وعندما نلتقي الأطفال الأصغر سناً تصبح احتياجاتهم الخاصة أوضح. ويمكن القول إن احتياجات الأطفال الأصغر تُظهر احتياجات جميع الأطفال.

ويصف بروتوكول إسطنبول التعليم اللازم للتحقيق مع الأطفال بأنه «تقنيات وإجراءات مقابلة محددة تضمن رفاه الأطفال وتحميهم من إعادة الصدمة، وتقدم إرشادات عن كيفية الحصول على المعلومات من الأطفال بطريقة موثوقة تبعاً لمستواهم النمائي»، مع الإشارة إلى إرشادات أخرى لاستجواب الأطفال أو مقابلتهم (الملحق الثاني، الفصل II. A). وتبدو هذه الجوانب أساسية، لكنها تقتصر في الوقت نفسه على جمع المعلومات عن تجارب الأطفال. ومن ثم فهي تغفل مسائل الحاجة إلى بناء علاقة آمنة مع الطفل لإتاحة الحصول على المعلومات، كما تغفل التقييم النفسي الذي يشكل، في فحوص إصابات التعذيب، جزءاً مركزياً من الأساس اللازم لتقييم توافق النتائج مع العنف المدعى به.

وبناءً على المقابلات التي أجريت في هذا المشروع، يبدو أن التعليم والخبرة المناسبين في التقييم النفسي وعلاج الأطفال المصابين بالصدمة لا يقلان أهمية.

وخلاصة القول، لا تقدم خبرات المشاركين طرقاً مختصرة وسريعة لتجاوز التحديات التي ينطوي عليها إجراء تقييمات نفسية للأطفال الذين قد يكونون قد تأثروا بالتعذيب. بل تشير إلى الحاجة إلى قدر كاف من التعليم والخبرة والوقت، حتى يمكن لقاء الأطفال والأسر المتضررة بطريقة تنتج إجراء هذه التقييمات، مع تلبية احتياجات الأطفال المفحوصين بطريقة أخلاقية سليمة. كما تشير إلى الحاجة إلى مواصلة تطوير الإرشادات الدولية القائمة.

مواد لتكييف فحوص إصابات التعذيب

أنجز في إطار المشروع عمل لإعداد مواد لتكييف فحوص إصابات التعذيب التي يجريها الصليب الأحمر السويدي، بحيث تصبح المؤسسات أكثر استعداداً لاستقبال الأطفال لهذا الغرض. ومراكز الصليب الأحمر السويدي الخمسة في شيلفتيو وأوبسالا وشوفده ويوتيبوري ومالمو أعضاء جميعاً في المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وقد أجريت فحوص إصابات التعذيب وفق بروتوكول إسطنبول داخل المنظمة منذ عام 8002. كما كان للصليب الأحمر السويدي ممثل في العمل على مراجعة البروتوكول.

[صفحة أصلية 351]

تُجرى التحقيقات في القسم بناءً على طلب المرضى المفحوصين، عادة بناءً على طلب محكمة الهجرة أو الممثل القانوني، بهدف إدراجها ضمن الأدلة المتعلقة بطلبات تصريح الإقامة. وينفذ التحقيقات ويوقعها فريق من شخصين، أحدهما أخصائي نفسي موظف لدى الصليب الأحمر السويدي، والآخر طبيب، إما موظف أو طبيب متطوع، إذ لدى الصليب الأحمر السويدي مجموعة من الأطباء المتطوعين.

وقد نظم القسم خلال السنوات تدريبات داخلية على فحوص إصابات التعذيب، كما يتلقى المحققون إشرافاً جماعياً من محققين آخرين ذوي خبرة. ويعمل لدى الصليب الأحمر السويدي أيضاً محامو قانون الهجرة الذين يساعدون مؤسسات الرعاية في التقييمات القانونية المتعلقة بطلبات فحوص إصابات التعذيب، وفي الاستشارات المتعلقة بالجوانب القانونية للتحقيقات. وتوجد مجموعة عمل خاصة تتخذ القرارات المتعلقة بالعمل على فحوص إصابات التعذيب، كما يسعى إلى توحيد إجراءات التحقيق والتقارير. وقد أعد القسم، من بين أمور أخرى، نماذج تُستخدم في كتابة تقارير التحقيق.

وفي الوقت نفسه، تفتقر مراكز الصليب الأحمر السويدي للعلاج عملياً إلى الخبرة في فحوص إصابات التعذيب لدى الأطفال، ولا سيما الأطفال الأصغر سناً، كما أن الخبرة في فحوص المراهقين محدودة جداً. ولذلك اختار مركز العلاج في أوبسالا، في إطار مشروع «الأطفال الذين نجوا من التعذيب»، إعداد مقترحات لمواد ملائمة للأطفال لفحوص إصابات التعذيب.

[صفحة أصلية 451]

وتم ذلك في صورة نموذج تقرير جديد خاص بالأطفال، وفي صورة مادة دعم منهجية تتضمن توصيات بشأن جوانب مختلفة من فحوص إصابات التعذيب. واستندت مواد هذه الوثائق إلى الإرشادات القائمة والأدبيات العلمية، والمعرفة والخبرة السريرية للمؤلفين، والمعلومات التي جُمعت في دراسة المقابلات الموضحة أعلاه، واستشارات مع أخصائيين نفسيين وأطباء ومحامين لديهم خبرة ومعرفة ذات صلة.

ونموذج التقرير ومادة الدعم المنهجية وثيقتان عمليتان سريريتان يُقصد أن تتم مراجعتهما داخليًا، ولذلك لا توصفان بالتفصيل ولا تُرفقان بهذه الأنطولوجيا. ومع ذلك، نلخص أدناه بعض النقاط المركزية التي ظهرت أثناء العمل عليهما.

الاستنتاجات والتوصيات تكيف فحوص إصابات التعذيب للأطفال

فحص إصابات التعذيب عملية واسعة تتطلب الدقة والوقت. وهي تتناول تجارب كانت مخيفة وقلبت حياة الطفل. ولا مفر من أن يؤثر التحقيق ذكريات مؤلمة. وفي الوقت نفسه، يعني الأساس الأخلاقي الذي تقوم عليه الرعاية الصحية أن الرعاية وموظفيها لا يجوز لهم أبدًا الإضرار أو الإيذاء، بل عليهم تخفيف المعاناة، والشفاء إن أمكن.

وقد تتعارض احتياجات ومصالح مختلفة عند التفكير في إجراء فحص تعذيب لطفل، ومن المهم دراسة هذه الجوانب بعناية قبل اتخاذ قرار بإجراء التحقيق. والمركزي هو تحديد مصلحة الطفل واحتياجاته على المدى القصير، وعلى المدى الأطول قليلًا، أي مصلحة الطفل الفردية الفضلى.

[صفحة أصلية 551]

إذا كان القرار هو إجراء التحقيق، فمن المهم جدًا اتخاذ تدابير لتقليل آثاره الجانبية السلبية على الطفل. ومن المهم، إلى أقصى حد ممكن، خلق وضع آمن ومستقر يشعر فيه الطفل بالأمان. وينبغي تجنب الأوضاع التي يشعر فيها الطفل بالعجز وعدم القدرة، لأنها قد تذكره بأوضاع صادمة. ولذلك فإن التعرف إلى الطفل وبناء علاقة قائمة على الثقة أمران مهمان جدًا وحاسمان مباشرة لإمكان إجراء تحقيق موثوق.

وينبغي توضيح أن الطفل ليس مضطراً إلى الإجابة عن الأسئلة التي يشعر بعدم الارتياح تجاهها، وأن الطفل هو من يقرر ما يريد مشاركته مع الفاحص. وينبغي شرح سبب إجراء الفحص، وتشجيع الطفل وتقديم ملاحظات متكررة له أثناء المحادثة والفحص. ويجب إجراء التحقيق بالسرعة التي يستطيعها الطفل، وإتاحة الوقت الذي يحتاجه، وغالبًا ما يتطلب الأمر أكثر من جلسة. ومن المهم الانتباه إلى الوقت الذي يحتاج فيه الطفل إلى استراحة.

ومن الأجزاء المهمة في إقامة الأمان والحصول على أفضل معلومات ممكنة التعاون مع الوالدين أو البالغين آخرين يشعر الطفل معهم بالأمان ويعرفونه. لكن هذا التعاون ينطوي غالبًا على تحديات، ولا سيما إذا كانت العلاقة بين الطفل والوالدين متوترة نتيجة تجارب صادمة مشتركة. وفي الوقت نفسه، من الجيد عمومًا إتاحة فرصة الحديث للطفل والبالغين بصورة منفردة، وإلا وجد خطر أن يحجب الأطفال والوالدان معلومات لحماية بعضهم بعضًا. ولذلك من المهم إجراء تقييم شامل لكيفية تنفيذ التحقيق بطريقة آمنة ومريحة قدر الإمكان للطفل المفحوص.

[صفحة أصلية 651]

وقد يتضح أحياناً أثناء التحقيق أن الوضع أصبح مرهقاً جداً للطفل، رغم تدابير بناء الأمان التي يمكن تقديمها. وينبغي في مثل هذه الحالات إيقاف التحقيق. وربما يمكن استئنافه في المستقبل القريب أو البعيد عندما تصبح الظروف أفضل. كما أن الحاجة إلى إيقاف التحقيق معلومة مهمة في حد ذاتها عن حالة الطفل.

ومن الأجزاء الأساسية في خلق بيئة آمنة للطفل قبل التحقيق تكيف الأماكن لتناسب الأطفال. فمعظم الأطفال يرون بيئات المستشفيات والمؤسسات الخالية من السمات الشخصية مخيفة. ومن المهم الانتباه إلى اختلاف تجارب الأمان لدى الأطفال في البيئات المختلفة تبعاً للعمر والإعاقات المختلفة أو القدرات المعرفية. وينبغي أن تكون غرف المراهقين مختلفة عن غرف أطفال ما قبل المدرسة.

ومن العوامل المهمة الأخرى لضمان أمان الأطفال في التحقيقات المتعلقة بالتعذيب المشتبه فيه ارتفاع كفاءة المحققين. فوجود خبرة واسعة في الحديث مع الأطفال وفحصهم في الأعمار المختلفة، إلى جانب خبرة راسخة في نمو الأطفال الطبيعي وغير الطبيعي، أمر بالغ الأهمية. وينطبق الأمر نفسه على الخبرة في لقاء الأطفال الذين تعرضوا للعنف والتجارب الصادمة والتعذيب والحديث معهم، وعلى الخبرة في إجراء فحوص إصابات التعذيب.

ومن الاستنتاجات العامة أن فحوص إصابات التعذيب لدى الأطفال لا يمكن أن تُجرى بوصفها تحقيقاً رسمياً فقط، أو استجابةً وفحصاً جسدياً تقليدياً لشخص بالغ. فإذا أردنا الحصول على معلومات مهمة وشاملة قدر الإمكان، يجب خلق أمان حول الطفل يتيح له الاقتراب من الذكريات المؤلمة والموجعة. وهذا ضروري أيضاً احتراماً لحقوق الطفل وفق اتفاقية حقوق الطفل (6)، ولأخلاقيات المهن الطبية والنفسية (7، 8).

[صفحة أصلية 751]

وبيعني ذلك أن الفصل التقليدي بين التحقيق والعلاج غير ممكن بالكامل. فالطفل يحتاج أثناء التحقيق نفسه إلى معلومات مستمرة وملاحظات إيجابية وتشجيع. ومن أغراض التحقيق أن يكون حلقة في شفاء الطفل وإعادة تأهيله، بهدف إعادة بناء الأمل.

جوانب خاصة بالأطفال في العنف الجسدي

فيما يتعلق بالتحقيق الجسدي، توجد، كما سبق وصفه في الفصل، عوامل مهمة تميز بين الأطفال والبالغين. ولعل أهمها أن إصابات الرأس والدماغ والجهاز العصبي تؤدي غالبًا لدى الأطفال إلى إصابات أكثر عمومية وأحيانًا أكثر غموضًا، بينما تؤدي لدى البالغين غالبًا إلى إصابات عصبية بؤرية، مثل الشلل النصفي أو فقدان وظيفة محددة، مثل الحبسة الكلامية.

وتظهر الإصابات الحركية لدى الأطفال غالبًا بوضوح عند الركض أو القفز على ساق واحدة أو الحركة. وتظهر الحركات المصاحبة المرضية والصعوبات أو التشنج غالبًا عندئذ. وهذا يعني أن أماكن الفحص تحتاج إلى التكيف للأطفال، مثل ضمان وجود مساحة يستطيع الطفل فيها الركض والحركة.

وقد تظهر الإصابات الأكثر انتشارًا لاحقًا أثناء نمو الطفل، عندما لا يستطيع الطفل ربما مواجهة مطالب عصبية أو معرفية جديدة وأكبر، انظر مثلاً الفصل السادس. وتشيع صعوبات التعلم المنتشرة، وغالبًا ما تكون صورة النمو غير متساوية، بحيث تعمل بعض الوظائف بصورة أفضل من غيرها.

[صفحة أصلية 851]

وقد تظهر الصعوبات الاجتماعية أيضًا، أي صعوبات التفاعل مع الآخرين، في سن أكبر عندما تزداد المطالب. وفي فحص إصابات التعذيب، يجب التمكن من تحديد ما إذا كانت هذه المشكلات قد نتجت عن العنف الذي تعرض له الطفل. وهنا يكون التاريخ المرضي والتاريخ المبكر مهمين.

فإذا كان الطفل يؤدي وظائفه جيدًا قبل أحداث العنف، بل كان من السهل عليه التعلم في المدرسة، فهذا يشير إلى أن العنف الذي تعرض له أسهم في الصعوبات الحالية. أما إذا كان الحمل والولادة معقدين، أو كان الطفل قد عانى أمراضًا خطيرة، أو تأخر في نموه المبكر، أو وُجد تاريخ عائلي لصعوبات عصبية بيولوجية، فهذا يشير إلى أن الصعوبات المرئية لها، كليًا أو جزئيًا، تفسيرات أخرى غير العنف المذكور، مع أن ذلك لا ينفي احتمال تعرض الطفل للعنف أيضًا.

وأثناء فحص الجسد، من المهم إعداد الطفل لكل خطوة، وشرح ما سيفعل ولماذا. ومن المفيد فحص جزء واحد من الجسد في كل مرة، وخلع الملابس أو رفعها عن ذلك الجزء بدلًا من تجريد الطفل من ملابسه بالكامل. وقد يؤدي فحص أجزاء الجسد التي تعرضت للعنف أو تحمل آثاره إلى استرجاعات مؤلمة. وقد يلزم تذكير الطفل بمكان وجوده وسبب الفحص. ومن المفيد حضور أشخاص يراهم الطفل آمنين.

التقرير

تخدم التقارير المكتوبة لفحوص إصابات التعذيب أغراضًا عدة يجب الموازنة بينها. ففي معظم الحالات، ستُستخدم في سياقات قانونية، وعادة ما يفتقر قراؤها إلى المعرفة المهنية بنمو الأطفال أو بآثار التعرض للعنف. ومن المهم أن تكون أوصاف هذه الجوانب وتأثيرها في التقييم تعليمية وواضحة.

[صفحة أصلية 951]

وفي الوقت نفسه، بظل تقرير التحقيق في نهاية المطاف وثيقة الطفل. ولذلك من المهم بوجه خاص أن يُكتب بطريقة تحمي خصوصية الطفل وكرامته، وأن يكون، قدر الإمكان، مفهوماً للطفل نفسه إلى حد كبير. ومن المفيد جداً أيضاً أن يعرض المحقق نتائج التحقيق واستنتاجاته وأي تدابير لاحقة محتملة، مثل الإحالات، على الطفل، مع تكييفها وفق عمره ومستوى نضجه.

خاتمة

يجب أن يتمتع الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب بالحق نفسه الذي يتمتع به البالغون في التحقيق والتوثيق والعلاج وإعادة التأهيل. ولذلك يجب توضيح إمكانيات إجراء فحوص إصابات التعذيب وتيسيرها. ويعني ذلك بدوره إتاحة فحوص إصابات التعذيب الملائمة لاحتياجات الأطفال الخاصة للأطفال الذين يُشتبه في تعرضهم للتعذيب، مثلاً في سياق إجراءات اللجوء.

وكما ظهر أعلاه، يفرض ذلك أيضاً توفير موارد من المحققين ذوي التعليم والخبرة الكافيين، الذين يحصلون على الوقت والظروف الأخرى اللازمة لإجراء التحقيقات بطريقة سليمة.

ومن المشكلات الأساسية في هذا المجال نقص الإرشادات الدولية. وكانت مراجعة بروتوكول إسطنبول عام 2202 خطوة كبيرة نحو الانتباه إلى احتياجات الأطفال الخاصة عند توثيق إصابات التعذيب، لكن الأجزاء من البروتوكول التي تتعلق بالأطفال بدائية جداً في الوقت الحالي بحيث لا تصلح لتوجيه العمل في جميع الجوانب ذات الصلة.

[صفحة أصلية 061]

وفي الوقت نفسه، يصعب نقص البحث العمل على الإرشادات، ولا سيما فيما يتعلق بالجوانب النفسية لتوثيق إصابات التعذيب، وكذلك المعرفة الطبية. ونخلص إلى أن هذا البحث ينبغي أن يركز مستقبلاً، من بين أمور أخرى، على مسائل النهج أثناء فحص الأطفال عند وجود ادعاء بالتعذيب، والعمل مع الوالدين ومقدمي الرعاية الآخرين، والكفاءة اللازمة لإجراء تحقيقات راسخة، والعلاقات بين المحققين والأطفال، والسياقات المختلفة التي يتعرض فيها الأطفال للتعذيب أو تُوثق فيها إصابات التعذيب.

وخلاصة القول، توجد مؤشرات قوية على أن الأطفال الذين تعرضوا للعنف والتعذيب، في السويد وفي أنحاء العالم، يجدون صعوبة في الحصول على التدخلات والدعم اللذين يحتاجون إليهما. ومن المهم زيادة العمل على تحديد الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب، مثل العمل الموصوف في الفصل الثالث. ومن المشكلات الأساسية أيضاً أن الأطفال لا يحصلون على تحقيق وتوثيق منهجيين وكفؤين لرواياتهم وإصاباتهم.

وقد يسهم ذلك في تغييبهم، مما يحد إمكان إعمال حقوق الطفل، مثل الحق في إعادة التأهيل للأطفال الذين تعرضوا للعنف أو الحرب أو غيره من ضروب المعاملة المهينة، وفق المادة 93 من اتفاقية حقوق الطفل (6). ولا تزال هناك تحديات كبيرة أمام جعل الأطفال ضحايا العنف والتعذيب مرئيين، في السويد وعلى المستوى الدولي، بين المهنيين الذين يلتقون الأطفال والجمهور العام على السواء. وينبغي للدول والجهات الإنسانية أن تتحمل مسؤولية أكبر في ضمان تلبية احتياجات الأطفال المعذبين وحقوقهم.

المراجع

1. مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. بروتوكول إسطنبول: دليل التحقيق والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. الطبعة المنقحة الثامنة. جنيف: الأمم المتحدة؛ 2202. 2. P. selaS-zeréP. توثيق التعذيب لدى الأطفال والشباب: حان وقت التأمل. erutroT. 9102؛ (1)92:41-1. 3. JJ rettO ned وآخرون. توثيق التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأطفال: مراجعة الإرشادات والأدوات القائمة. idijdmaT، C esoB nélhaN. 4. 23-72:(3-1)422؛ 3102. tnl icS cisneroF R. الأطفال الذين نجوا من التعذيب: مراجعة منهجية للفحص والتوثيق وعلاج إصابات التعذيب لدى الأطفال. erutroT. 4202؛ (3)43:04-51. 5. V ekralC، V nuarB. استخدام التحليل الموضوعي في علم النفس. lohcySP seR lauQ. 6002؛ (2)3:101-77. 6. الأمم المتحدة. اتفاقية حقوق الطفل. مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 7751. نيويورك: الأمم المتحدة؛ 9891. 7. اتحاد الأطباء السويدي. القواعد الأخلاقية لاتحاد الأطباء. ستوكهولم؛ 7102. متاح من: relger-aksite-stednubrofrakal/kite/dots-hco-dar/es.fls//:sptth / 8. اتحاد الأخصائيين النفسيين السويدي. المبادئ الأخلاقية المهنية للأخصائيين النفسيين في بلدان الشمال. ستوكهولم؛ 3202. متاح من: i-dots/gninvotusekry-nid/dots-hco-dar/es.tednubrofgolokysp.www//:sptth / nedron-i-regolokysp-rof-repicnirp-aksitesekry/gadravsekry-nid

عُدِّبَ فِي طِفْلَتِهِ

[صفحة أصلية 261]

الجزء الثالث العلاج

عُذِّبَ فِي طِفُولَتِهِ

عُذِّبَ فِي طِفْولَتِهِ

[صفحة أصلية 361]

عُذِّبَ فِي طِفْولَتِهِ

[صفحة أصلية 461]

كاتارينا نالين بوسي هي باحثة في المدرسة العليا للصليب الأحمر ومؤلفة مشاركة في مراجعة الأدبيات «نتائج علاج الصدمة لاضطراب الكرب التالي للصدمة لدى القاصرين اللاجئين وطالبي اللجوء ذوي وضع الإقامة غير المؤكد: مراجعة منهجية» (6202).

الفصل الخامس نتائج العلاج رغم صعوبة الوضع الحياتي

تعني سياسة الهجرة الحالية، التي تجعل تصاريح الإقامة المؤقتة قاعدة، أن الشباب الذين جاؤوا إلى السويد فرارًا يعيشون في حالة من عدم اليقين فترات أطول فأطول. وبما أن علاج الصدمة يُعد غالبًا محتاجًا إلى وضع حياتي مستقر، فإن هذا عدم اليقين قد يحد من وصولهم إلى الرعاية. وتتحدى مراجعة أدبيات جديدة الاعتقاد بأن الاستقرار يجب أن يسبق العلاج.

الأطفال الذين يطلبون اللجوء أو مُنحوا تصاريح إقامة بوصفهم لاجئين أو طالبي حماية معرضون بدرجة أعلى بوضوح للإصابة باضطراب الكرب التالي للصدمة (DSTP)، إذ قد يصل انتشاره إلى ضعف انتشاره لدى الأطفال الآخرين (1، 2). ويحصل معظم الأطفال الفارين على تصاريح إقامة مؤقتة فقط، ويعيشون في خوف من الترحيل وقلق على المستقبل (3). وأظهرت الدراسات أن تصاريح الإقامة غير المؤكدة تسهم في إصابة الشباب طالبي اللجوء والأشخاص الذين لديهم تصاريح إقامة بوصفهم طالبي حماية أو لاجئين باضطراب DSTP (4، 5). وأظهرت دراسة سابقة أن الشباب ذوي تصاريح الإقامة غير المؤكدة كانوا أكثر عرضة بنسبة 67% للحصول على تشخيص DSTP مقارنة بالسكان عمومًا (5).

وكجزء من مشروع «الأطفال الذين نجوا من التعذيب»، بدأت مراجعة للأدبيات لمعرفة ما إذا كان ينبغي تأجيل علاج الصدمة للأطفال الذين يعيشون في ظروف غير مستقرة. وأجرى الباحثان كاتارينا نالين بوسي وميغيل دياز دراسة الأدبيات عام 5202.

الباحثون وراء الدراسة

كاتارينا نالين بوسي ممرضة مرخصة متخصصة في رعاية القلب، وهي حاصلة على دكتوراه في الطب، ونالت الدكتوراه عام 5102 من معهد كارولينسكا. ومنذ ذلك الوقت عملت محاضرة في المدرسة العليا للصليب الأحمر في التدريس والبحث. وشاركت باحثة في المرحلة الأولى من مشروع «الأطفال الذين نجوا من التعذيب»، وأجرت مع رونك تامجيدي مراجعة منهجية للفحص والتوثيق والعلاج لهذه الفئة من المرضى، نتج عنها تقرير ومقال علمي.

وتعاونت كاتارينا في الدراسة مع ميغيل دياز، الحاصل على الدكتوراه والمحاضر في المدرسة العليا للصليب الأحمر. كما شارك ميغيل باحثًا في مشروع سابق عن تأثير التعذيب في الوظائف التنفيذية، نُشر في تقرير ومقال علمي.

هل تُظهر دراستكم أن على العاملين في الرعاية الصحية تأجيل علاج الصدمة للأطفال الموجودين في عملية اللجوء أو ذوي تصاريح الإقامة المؤقتة؟

لا. لم نجد في دراستنا أي دليل يدعم تأجيل العاملين في الرعاية الصحية علاج الصدمة للأطفال الذين يعيشون في نوع عدم الاستقرار الذي تنطوي عليه عملية اللجوء، أو الذين لديهم تصاريح إقامة مؤقتة. بل إن نتائجنا تتحدى الاعتقاد بأن الاستقرار ضروري قبل بدء علاج الصدمة.

[صفحة أصلية 661]

وتوضح الأبحاث أيضًا أهمية علاج الصدمة للأطفال. فقد أظهرت الدراسات أن DSTP لدى الأطفال قد يؤثر في نمو الدماغ، وقد يظهر ذلك لاحقًا في ضعف تنظيم المشاعر وازدياد التفاعل في نظام التهديد الدماغي (6). وأظهر تحليل تلوي سابق أن الأطفال الذين تعرضوا لأحداث صادمة يظهرون، حتى من دون تشخيص DSTP، نشاطًا دماغيًا متغيرًا في المعالجة المعرفية والعاطفية مقارنة بمجموعات الضبط (7). والعواقب طويلة الأمد لـ DSTP خطيرة وقد تهدد الحياة. وأظهرت دراسة جماعية كبيرة أن DSTP يضاعف خطر الانتحار ابتداءً من سن الرابعة عشرة (8). وتشكل الآثار الضارة لـ DSTP لدى الأطفال أسبابًا قوية للفحص والعلاج.

ومن النتائج المهمة لمراجعتنا وجود دليل على أن علاج الصدمة يمكن أن يكون فعالاً رغم عدم استقرار الوضع الحياتي، لأن هؤلاء الأطفال يخاطرون بعدم الحصول على العلاج بحجة ضرورة الاستقرار. إنهم يعيشون وضعًا غير مستقر، وفي الوقت نفسه مروا بأحداث صادمة ويعانون DSTP، أي إنهم معرضون لأذى مزدوج ويحتاجون بشدة إلى العلاج. ويمكن قلب المسألة: قد يكون عدم الاستقرار سببًا أقوى لتقديم علاج الصدمة، لا سببًا لتأجيله.

لقد اخترتم دراسة «الوضع الحياتي غير المستقر» من خلال الوضع القانوني للأطفال والشباب. هل يمكنك شرح هذا الاختيار؟

ناقشنا ما يمكن أن يعنيه وضع حياتي غير مستقر، كما يفعل العاملون في الرعاية الصحية عند التفكير في الأوضاع التي قد تؤثر في علاج الصدمة أو تتأثر به. واحتجنا أيضًا إلى تعريف إجرائي وحدود لإجراء بحث في الأدبيات. وكان يمكن أن تكون أشكال مختلفة من عدم الاستقرار ذات صلة، مثل انتقال الأطفال المتكرر بين مساكن الحماية أو دور الطوارئ والأسر الحاضنة، لكننا اخترنا الأطفال الموجودين في عملية اللجوء أو ذوي تصاريح الإقامة المؤقتة. واتخذنا القرار لأن الدراسة تجرى في إطار مركز الصليب الأحمر لإعادة تأهيل المصابين بالتعذيب والحرب، ولأن كثيرًا من الأطفال يعيشون هذه الأوضاع، ليس في السويد وحدها بل في العالم كله.

هل كانت هناك معرفة كثيرة؟

أجرينا مراجعة منهجية هدفها تركيب البحوث المنشورة عن أثر علاج الصدمة لدى الأطفال الموجودين في عملية اللجوء أو ذوي تصاريح الإقامة المؤقتة. كما بحثنا ما إذا كان الوضع غير المستقر، أي وجود الطفل في عملية لجوء أو امتلاكه تصريح إقامة مؤقتاً، عاملاً يتنبأ بنتيجة العلاج أو بالالتزام به.

بحثنا عن الدراسات في أربع قواعد بيانات، وراجعنا 147 مقالة علمية. ومن بينها درست 32 دراسة أثر علاج الصدمة في أعراض DSTP لدى الأطفال الموجودين في عملية اللجوء أو ذوي تصاريح الإقامة المؤقتة. ولم يكن الهدف الصريح لمعظم الدراسات دراسة الوضع غير المستقر، لكنها شملت أطفالاً لا يملكون تصاريح إقامة دائمة، ولذلك قدمت مع ذلك معرفة عنه.

أجريت الدراسات أساساً في أوروبا، ولا سيما ألمانيا (01 دراسات)، والسويد (3)، والمملكة المتحدة (2)، وهولندا (2)، مع دراسات منفردة من فنلندا والنرويج وبلغاريا بالتعاون مع ألمانيا. وأجريت ثلاث دراسات في الولايات المتحدة وواحدة في أوغندا. وجاء المشاركون أساساً من أفغانستان وسوريا والعراق، ومن بلدان أفريقية مثل إريتريا والصومال. وشملت الدراسات الأمريكية أساساً أطفالاً من أمريكا الوسطى والملايينية.

وشملت معظم الدراسات مراهقين بين 21 و81 عاماً عادة، مع أن النطاق الإجمالي كان 4-12 عاماً. وشملت دراسات قليلة أطفالاً دون السابعة. وكان المشاركون أطفالاً غير مصحوبين وأطفالاً وصلوا مع أولياء أمورهم. وشكل الأولاد أغلبية واضحة في معظم الدراسات، مع أن بعض الدراسات أبلغت عن توزيع أكثر توازناً أو عن أغلبية من الفتيات.

[صفحة أصلية 861]

وتنوعت أنواع علاج الصدمة في الدراسات، وجمعناها في الفئات التالية: • العلاج السلوكي المعرفي (TBC) (01 دراسات). • العلاج بالتعرض السردى (TEN) وTENDIK (3). • إزالة التحسس وإعادة المعالجة بحركة العينين (RDME)، أو أساليب تجمع RDME (4). • تدخلات تتضمن عناصر مختلفة من علاج الصدمة، مثل التنقيف النفسي والفن التعبيري والعلاج متعدد الأسر (5).

ماذا أظهرت المراجعة؟

انخفضت أعراض DSTP انخفاضاً مهماً في 71 من الدراسات الـ32. وأبلغت ست دراسات عن استمرار الآثار في متابعات تراوحت بين 3 و52 شهراً، بينما لم تحافظ دراسة أظهرت تحسناً قصيراً الأمد مهماً على أثرها عند المتابعة. وأبلغت 11 دراسة عن أحجام الأثر، لا عن الدلالة الإحصائية وحدها، بل عن مقدار التغير الذي أحدثه العلاج. وكان الوسيط مرتفعاً، إذ بلغ d لكوهين 79.0، مع نطاق ربعي 32.1–44.0. وتراوح النطاق الإجمالي لأحجام الأثر بين المتوسط والمرتفع، من 33.0 إلى 9.1، مما قد يشير إلى تغير مهم سريرياً.

وكانت العلاجات التي خفضت أعراض DSTP بنجاح، أساساً، علاجات الصدمة التقليدية مثل TBC وTEN وTENDIK، وRDME، أو RDME مقترناً بـ TBC المركز على الصدمة أو TENDIK أو العلاج بالكلام أو العلاج باللعب. وتظهر نتائجنا كذلك أن أشكالاً أخرى، مثل العلاج الجماعي متعدد الأسر والتدخلات بالفن التعبيري، فعالة أيضاً. أي توجد مجموعة متنوعة من العلاجات الفعالة.

[صفحة أصلية 961]

وتنوعت أنواع علاج الصدمة في الدراسات. وجمعنا العلاجات وفق الفئات المذكورة أعلاه.

ما الذي أظهرته المراجعة؟

انخفضت أعراض DSTP بدرجة مهمة في 71 من الدراسات الـ 32 المشمولة. وحافظت ست دراسات على آثارها في المتابعات التي تراوحت بين 3 و 52 شهرًا، في حين لم تحافظ دراسة أظهرت تحسنًا قصير الأمد مهمًا على الأثر عند المتابعة. وبلغ وسيط حجم الأثر في الدراسات التي أبلغت عنه 79.0 وفق d لكوهين، مع نطاق ربعي 44.0-32.1.

[صفحة أصلية 071]

لم تستطع مراجعتنا إثبات أن تصريح الإقامة غير الدائم عامل يتنبأ بنتيجة العلاج. وناقشت بعض الدراسات عدم اليقين المرتبط بانتظار قرار اللجوء والخوف من الرفض بوصفهما عاملين ضاغطين في السياق، لكنها لم تدرس ما إذا كان ذلك يؤثر في نتيجة العلاج. وربطت دراسات قليلة بين تصريح إقامة غير دائم والالتزام بالعلاج، إذ قد يكون الانتقال مثلاً سبباً لانقطاع العلاج. ومع ذلك، بلغ الالتزام بجلسات العلاج في المتوسط 67%، بنطاق 5.34-001%، في الدراسات.

ما توصياتك للعاملين في الرعاية الصحية الذين يلتقون الشباب المصابين بالصدمة في عملية اللجوء أو ذوي تصاريح الإقامة المؤقتة؟

ينبغي للعاملين في الرعاية الصحية الفحص عن أعراض DSTP، وتقديم علاج الصدمة عند الحاجة. ويمكن لعلاج الصدمة تخفيف أعراض DSTP لدى مجموعة من الأطفال والشباب الذين تضرروا من الحرب والاضطهاد والفرار. وينبغي للرعاية أن تفعل ذلك أيضاً لأن اتفاقية حقوق الطفل تؤكد أن للأطفال، بصرف النظر عن وضع الهجرة، الحق في الرعاية الصحية وإعادة التأهيل (المادة 42)، وأن على الدول الأطراف اتخاذ تدابير لتعزيز التعافي الجسدي والنفسي للأطفال الذين تعرضوا لأي شكل من العنف أو النزاعات المسلحة (المادة 93) (9).

ومن المهم التأكيد أن الأطفال الذين مروا بأحداث صادمة ويعيشون بتصاريح إقامة مؤقتة أو في عملية لجوء يمكن أن يستفيدوا من علاج الصدمة.

[صفحة أصلية 171]

ما الدراسات التي تودون رؤيتها الآن؟

مع أن النتائج أظهرت فعالية علاج الصدمة، سيكون من المفيد إجراء دراسات تهدف صراحة إلى بحث أثر الوضع القانوني في نتائج العلاج، ويفضل ضمن دراسات عشوائية مضبوطة أكبر، لتعزيز الدليل. ويمكن للبحث المستقبلي أن يشمل أطفالاً أصغر سناً، وعدداً أكبر من الفتيات، وأن يصنف النتائج وفق العمر النمائي، وأن يتضمن فترات متابعة أطول.

كما ستكون الدراسات النوعية عن تجارب الأطفال والأسر لفائدة العلاج، والعوامل التي تشجع المشاركة في علاج الصدمة أو تعيقها، ذات قيمة.

اقرأ المقال

M zaiD، C esoB nélhan. نتائج علاج الصدمة لاضطراب الكرب التالي للصدمة لدى القاصرين اللاجئين وطالبي اللجوء ذوي وضع الإقامة غير المؤكد: مراجعة منهجية. *yrtaihcyS ni sreitnorF*، المجلد 61، 5202. <https://doi.org/10.5202/tyspf.9833.01>

قراءة ذات صلة من ميغيل دياز

I llednuL nillaW، M zaiD. أثر التعذيب في الوظائف التنفيذية: عواقب DSTP وإصابة الدماغ الرضية في عملية اللجوء والعلاج والاندماج لدى الناجين من التعذيب. مركز الصليب الأحمر السويدي للخبرة في إعادة تأهيل المصابين بالتعذيب والحرب؛ 5202. التقرير رقم 1:5202.

المراجع

1. B. R. eromkcal وآخرون. مراجعة منهجية وتحليل تلوي: انتشار المرض النفسي لدى الأطفال والمراهقين اللاجئين وطالبي اللجوء. J mAc dacA dlihc cselodA yrtaihcysP. 2020؛ 95: 417-507.
2. C. neik وآخرون. انتشار الاضطرابات النفسية لدى اللاجئين الشباب وطالبي اللجوء في البلدان الأوروبية: مراجعة منهجية. yrtaihc -ysP cselodA dlihc ruE. 2020؛ 82: 5921-0131. 11.11.2020. caaj.j/6101.01:iod
3. J. ttoilleL وآخرون. مشكلات الصحة النفسية لدى اللاجئين الشباب غير المصحوبين في حالة تعليق: أسباب الوضع القانوني غير المؤكد وعواقبه. J ttoilleL. 2020؛ 43: 1-03. 11.11.2020. caee/lrji/3901.01:iod
4. F. kcefnroH وآخرون. اضطراب الاكتئاب والقلق. lohcysP tnorF. 2020؛ 41: 4369411. 11.11.2020. caee/lrji/3901.01:iod
5. J. reseeV وآخرون. اضطراب الكرب التالي للصدمة لدى القاصرين اللاجئين في مركز رعاية خارجية: الانتشار والعوامل المرتبطة. ruE. 2020؛ 23: 914-624. 11.11.2020. caee/lrji/3901.01:iod
6. JR. agnirreH وآخرون. تحليل الدماغ النامي. peR yrtaihcysP rruC. 2020؛ 91(01): 96. 11.11.2020. caee/lrji/3901.01:iod
7. R. noterl وآخرون. تلوي للتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لصدمة الطفولة. icsorueN ngoC yrtaihcysP loiB. 2020؛ 9(6): 165-075. 11.11.2020. caee/lrji/3901.01:iod
8. V. xof وآخرون. خطر الانتحار لدى الأشخاص المصابين باضطراب الكرب التالي للصدمة: دراسة جماعية لـ 1.3 مليون شخص في السويد. J tceffA. 2020؛ 972: 906-616. 11.11.2020. caee/lrji/3901.01:iod
9. الجمعية العامة للأمم المتحدة. اتفاقية حقوق الطفل. مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 7751، 02 نوفمبر 1989.

عُدِّبَ فِي طِفْلَتِهِ

[صفحة أصلية 371]

عُدِّبَ فِي طِفْلَتِهِ

[صفحة أصلية 471]

فاني لورين هي أخصائية نفسية مرخصة ومتخصصة في علم النفس السريري مع تركيز على علم النفس العصبي. ولديها خبرة 02 عامًا في العمل مع الأطفال والشباب ذوي الحالات العصبية النفسية، والصدمة، وتجارب الفرار.

الفصل السادس الحالات العصبية النفسية والصدمة

تبين أن الأطفال ذوي الحالات العصبية النفسية معرضون بدرجة أكبر للتجارب التي قد تسبب الصدمة، وأنهم، إذا تعرضوا لهذه الأحداث، يملكون موارد وقدرة أضعف على التعافي التلقائي. ولذلك يكونون أكثر عرضة للإصابة بالصدمة. ويكون ضعف القدرة على الصمود عصبيًا بيولوجيًا ومعرفيًا وعلاقيًا.

اقرأ التقرير

يستند الفصل إلى تقرير فاني لورين «الحالات العصبية النفسية لدى الأطفال المصابين بالصدمة: الأمراض المصاحبة والتشخيص التفريقي والتكيف السريري في العمل مع الأطفال المتضررين من الحرب والتعذيب». مركز الصليب الأحمر للخبرة في إعادة تأهيل المصابين بالتعذيب والحرب، 3:6202.

[صفحة أصلية 571]

يصف هذا الفصل كيفية فهم علم النفس العصبي والصدمة معًا. ول فهم التعقيد، سننطلق من خمسة منظورات عامة. والعناوين تبسيطية، لكننا سنتعمق في كل جزء ونضفي عليه الفروق من خلال ما يلي:

- تزيد الحالات العصبية النفسية خطر التعرض للأذى والصدمة. • تؤدي الصدمة إلى آثار مرتبطة بالحالات العصبية النفسية. • للحالات العصبية النفسية والحالات المرتبطة بالصدمة أعراض متداخلة قد يختلط بعضها ببعض. • تحدث الحالات العصبية النفسية والحالات المرتبطة بالصدمة معًا كثيرًا. • توجد علاقات تفاعلية تعزز فيها الصعوبات بعضها بعضًا.

الحالات العصبية النفسية تزيد خطر التعرض للأذى والصدمة

الأطفال والشباب ذوو الإعاقات العصبية النفسية أكثر عرضة لأشكال مختلفة من التجارب المسببة للصدمة، مثل الإقصاء الاجتماعي والاعتداء الجسدي والإهمال والاعتداءات الجنسية (1). كما أن خطر تعرض الأطفال ذوي هذه الحالات للتعرض المتعدد للأذى، أي التعرض لأنواع عدة من الأحداث الصادمة أثناء النشأة، يزيد مرتين إلى ثلاث مرات (2، 3).

[صفحة أصلية 671]

وتوجد أسباب متعددة لزيادة الخطر: فقد يزيد ضعف التحكم في الاندفاع وفرط النشاط وسوء الفهم الاجتماعي خطر الحوادث والتنمر والتفاعلات السلبية مع البالغين (2، 4). كما قد تجعل القابلية المتزايدة للصعوبات الاجتماعية والقيود في الإدراك الاجتماعي قدرة الطفل على تفسير الإشارات الاجتماعية والتنقل في الأوضاع الاجتماعية المعقدة أصعب، مما يزيد خطر النزاعات والتنمر (5).

[صفحة أصلية 771]

يمكن للأطفال المصابين بالتوحد أيضًا في كثير من الأحيان أن تكون لديهم معالجة مختلفة للمنبهات الحسية، مما قد يعزز الشعور بالتهديد والإجهاد في الحالات الصادمة. وقد يواجهون صعوبة في المرونة، مما قد يؤدي إلى انشغالهم بالحدث الصادم، ويعزز أعراض ما بعد الصدمة المتعلقة بإعادة التجربة. ولذلك قد يؤدي النوع نفسه من الحدث الصعب إلى أعراض أوسع لدى الأطفال ذوي الحالات العصبية النفسية مقارنة بالأطفال الذين لا يملكون هذه القابلية.

الصدمة تؤدي إلى آثار مرتبطة بالحالات العصبية النفسية

يمكن أن تؤدي الصدمة لدى الأطفال إلى آثار ترتبط بالصورة السريرية للحالات العصبية النفسية أو تشبهها. ويتعلق الأمر، باختصار، بكيفية تعرض النمو المستمر للطفل لخطر التأثير العميق بالأحداث المبكرة والصعبة والمتكررة التي قد تسبب الصدمة، بحيث تشبه الصعوبات العصبية النفسية.

وتندرج ضمن هذا المجال التغيرات المستمرة في بنية الدماغ ووظيفته وكيميائه الحيوية، وما يصاحبها من تغيرات معرفية وتأثيرات سلوكية، وكذلك ما يسمى بالصعوبات شبه التوحدية. وقد تكون لهذه التغيرات أهمية أو تختلط بصعوبات مماثلة في الحالات العصبية النفسية. وقد تكون أيضًا من عواقب الصدمة لدى الأطفال، فتسبب أعراضًا شبيهة بأعراض الحالات العصبية النفسية أو تخفض العتبة اللازمة لظهورها.

التغيرات في بنية الدماغ ووظيفته نتيجة الصدمة، والتي تؤدي إلى أعراض شبيهة بأعراض الحالات العصبية النفسية

لا تؤثر الصدمة في الوظائف النفسية والاجتماعية فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى تغيرات عصبية بيولوجية يمكن إثباتها. وقد أظهرت أبحاث العقود الأخيرة أن الإجهاد طويل الأمد وإهمال الرعاية والاعتداء يمكن أن تترك أثرًا في بنية الدماغ ووظيفته وكيميائه الحيوية، وأن تؤدي إلى أعراض تتداخل مع الحالات العصبية النفسية (31، 61، 71).

[صفحة أصلية 871]

أظهرت دراسات تصوير الدماغ أن الأطفال الذين تعرضوا لأحداث صادمة يظهرون غالبًا انخفاضًا في حجم الحصين والقشرة الجبهية الأمامية، وهما منطقتان حاسمتان للذاكرة والتحكم في الاندفاع وتنظيم المشاعر (81)، (91). وفي الوقت نفسه، يُلاحظ فرط النشاط في اللوزة الدماغية، مما يسهم في زيادة حساسية التهديد وعدم الاستقرار العاطفي وصعوبات تنظيم المشاعر (92). كما تتأثر اتصالات الدماغ، أي التفاعل بين الشبكات المختلفة، مما يصعب دمج العمليات المعرفية والعاطفية (31، 12).

وتتمثل آلية مركزية لفهم أثر الصدمة في الدماغ في نظام الإجهاد الجسدي، ولا سيما محور APH، أي محور الوطاء والغدة النخامية والغدة الكظرية. وقد تؤدي تجربة صادمة حادة منفردة، مثل حادث، إلى استجابات قوية لكنها عابرة غالبًا. أما الصدمة المزمنة أو المعقدة، مثل الإهمال طويل الأمد أو الاعتداءات المتكررة، فقد تؤدي إلى تأثير أعمق وأكثر شمولاً (22).

وعند التعرض للإجهاد طويل الأمد، يصبح محور APH غالبًا مفرط النشاط، مع ارتفاع مستويات الكورتيزول التي قد تضر أنسجة الدماغ، وتنبط نمو الخلايا العصبية، وتؤثر في تكوين المشابك العصبية، وتضعف الميالنة، أي تكوين المايلين حول الألياف العصبية، وهي عملية نضج تجعل نقل الإشارات الدماغية أسرع وأكثر استقرارًا (32). وقد يؤدي ذلك إلى صعوبات في الانتباه والذاكرة العاملة والتحكم في الاندفاع والفهم الاجتماعي، وهي وظائف مركزية أيضًا في الحالات العصبية النفسية.

وفي حالات أخرى، يصبح نظام الإجهاد منخفض النشاط، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الكورتيزول ونقص الطاقة وارتفاع خطر الأعراض التفارقية (42). ويمكن أن يظهر سوء التنظيم في صورة فرط نشاط، مع ارتفاع الكورتيزول وصعوبة العودة إلى المستوى الطبيعي، أو في صورة نقص نشاط، مع انخفاض إنتاج الكورتيزول. ويرتبط كلا النمطين بزيادة القابلية للإصابة بالاعتلال النفسي وبمشكلات تنظيم المشاعر والانتباه.

وقد يؤثر الخلل الوظيفي طويل الأمد أيضًا في طريقة نمو الحصين واللوزة الدماغية والقشرة الجبهية الأمامية، مما يعزز الصلة بين تنظيم الإجهاد البيولوجي والصعوبات المعرفية والعاطفية.

[صفحة أصلية 971]

وثبت وجود خلل في محور APH لدى المصابين باضطراب الكرب التالي للصدمة واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، كما لوحظ لدى المصابين باضطراب طيف التوحد. ويشير ذلك إلى نموذج بيولوجي محتمل يفسر سبب تداخل الصدمة والصعوبات العصبية النفسية أحياناً في صورة الأعراض (21، 31).

ويتأثر الجهاز العصبي اللاإرادي أيضاً عند التعرض للأذى والصدمة. وتصف النظرية متعددة المبهمة كيف يمكن أن يختل تنظيم العصب المبهمة، فيعلق الطفل في فرط الاستثارة، أي القتال أو الفرار، أو نقص الاستثارة، أي التجمد، بدلاً من حالة المبهمة البطني التي تتيح الأمان والانخراط الاجتماعي والتعافي.

وغالباً ما يكون لدى الأطفال المصابين بالصدمة نغمة مبهمة أقل، وقد ارتبط ذلك بالاندفاعية وعدم الاستقرار العاطفي وصعوبة تنظيم الاستجابات الجسدية والعاطفية (52، 62). وقد يسهم هذا الخلل اللاإرادي في أعراض تشبه أعراض الحالات العصبية النفسية، مثل مشكلات الانتباه وفرط التفاعل مع الإجهاد وصعوبات العلاقات.

وتظهر الدراسات أيضاً أن أنواعاً مختلفة من الأحداث المسببة للصدمة تميل إلى إحداث أنماط مختلفة من التأثير. فقد ارتبط الاعتداء الجسدي باضطرابات في الأنظمة الحسية الحركية، والإهمال بتأثير في الشبكات الجبهية الأمامية، بينما ارتبط الاعتداء الجنسي بدرجة أكبر بتغيرات في اللوزة الدماغية والجهاز الحوفي، مع عواقب على تنظيم المشاعر والإدراك الاجتماعي (72، 82).

كما سلطت الدراسات الضوء على الفروق بين الجنسين: تميل الفتيات إلى إظهار انخفاض في حجم الحصين، وهو ما يرتبط بخطر أعلى للاكتئاب والقلق، بينما يظهر الأولاد تأثيراً أكبر في المناطق الجبهية، وهو ما يمكن ربطه بالاندفاعية والمشكلات السلوكية (92).

الحرمان وشبه التوحد

كان للدراسات الإنجليزية والرومانية المعروفة باسم دراسات المتبنين الإنجليز والرومانيين، وهي دراسات لأطفال دور الأيتام الرومانية، أهمية حاسمة في فهم نمو الأطفال بعد الحرمان الشديد المبكر وتطوير المعرفة به. فقد نشأ الأطفال الذين قضوا سنوات حياتهم الأولى في مؤسسات رومانية خلال الثمانينيات والتسعينيات غالباً في بيئات مهملّة للغاية، تغفّر إلى التحفيز والرعاية الأساسية والتعلق الآمن.

[صفحة أصلية 081]

وعندما تبنت أسر في بريطانيا هؤلاء الأطفال، أُتيح للبحث أن يتابع نموهم على المدى القصير والطويل. وأظهرت النتائج المبكرة بالفعل فروقًا كبيرة بين الأطفال الذين تبنتهم أسر قبل سن ستة أشهر والأطفال الذين أمضوا وقتًا أطول في المؤسسة. وثبت أن المدة الطويلة من الإهمال الشديد ترتبط بوضوح بانحرافات نمائية خطيرة.

وكانت مدة الإقامة في المؤسسة عامل خطر حاسمًا أيضًا لدرجة الصعوبات المعرفية والعاطفية والاجتماعية (03). وكان من أبرز النتائج ظهور ما أصبح يسمى شبه التوحد. واستُخدم المفهوم لوصف مجموعة من الأطفال الذين أظهروا صعوبات شبيهة بالتوحد، مثل ضعف التواصل البصري ومحدودية الاهتمامات ومشكلات التفاعل الاجتماعي، لكن مع فروق مهمة.

وكانت الأعراض غالبًا أقل استقرارًا مع مرور الوقت، وأظهر أطفال عدة تحسنًا عندما وُضعوا في بيئة آمنة وداعمة. كما أظهر كثيرون سلوكًا اجتماعيًا غير مثبط صُنّف بوصفه اضطراب تعلق تفاعليًا من النوع غير المثبط، وهو ليس نموذجيًا في التوحد الكلاسيكي. وفي إحدى المتابعات لوحظ أن النمط الشبيه بالتوحد لدى الأطفال الذين تعرضوا للحرمان المبكر يختلف بوضوح عن التوحد الكلاسيكي في التعبير والمسار النمائي، مما أكد أن شبه التوحد ليس مطابقًا للتوحد، بل شكل عرض شبيه بالتوحد تسببه الرعاية السيئة المبكرة والشديدة (13).

[صفحة أصلية 181]

أظهرت المتابعات طويلة الأمد حتى سن المراهقة أن نسبة مهمة من الأطفال الذين عاشوا حرمانًا طويلًا ظلت لديهم صعوبات. وكانت أبرز مجالات المشكلات التأخر المعرفي ومشكلات الانتباه والصعوبات الاجتماعية وصعوبات تنظيم المشاعر. كما مالت الأعراض إلى الظهور مغا بدلًا من ظهورها منفردة، مما أدى إلى صورة سريرية معقدة ودرجة عالية من العجز الوظيفي (23).

وأظهرت المتابعات أن آثار الرعاية السيئة المبكرة غالبًا ما تكون شاملة وطويلة الأمد، ولا سيما لدى من أمضوا أكثر من ستة أشهر في المؤسسة.

وفي المتابعات التي امتدت إلى بداية البلوغ، بين سن 02 و 52 عامًا، ظهرت صورة مشابهة لكنها أوضح. فقد ظلت لدى كثير ممن تعرضوا للحرمان الطويل صعوبات كبيرة، منها السمات الشبيهة بالتوحد، ومشكلات الانتباه والتحكم في الاندفاع، وصعوبات التكيف الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، لوحظ أن بعض الأعراض تغيرت مع مرور الزمن.

ومال شبه التوحد إلى التراجع في التعبير، لكن كثيرًا من الأفراد ظلوا يعانون صعوبات اجتماعية مهمة ومشكلات في العلاقات القريبة. وكان شائعًا أيضًا وجود مشكلات الانتباه وفرط الحركة، ولوحظ أن هذه الأنماط لا يمكن تفسيرها بالكامل بالتشخيصات العصبية النفسية الكلاسيكية، بل ترتبط ارتباطًا خاصًا بالحرمان المؤسسي المبكر.

[صفحة أصلية 281]

وتظهر هذه المتابعات الطولية مجتمعة أن آثار الإهمال المبكر والشديد معقدة وطويلة الأمد غالبًا، لكنها ليست حتمية. وتبين أن بعض الأعراض، مثل شبه التوحد، لها طبيعة فريدة ومسار مختلف جزئيًا عن التوحد الكلاسيكي، وأن التدخلات المبكرة حاسمة لتقليل خطر الصعوبات المستمرة.

الحالات العصبية النفسية والحالات المرتبطة بالصدمة لها أعراض متداخلة قد يختلط بعضها ببعض

هناك مجال آخر ينبغي فيه فهم الصعوبات العصبية النفسية والحالات المرتبطة بالصدمة لدى الأطفال والشباب، وهو احتمال تداخل الأعراض بحيث تختلط الحالات بعضها ببعض. ويخلق ذلك تحديات تشخيصية وخطر تشخيص الأطفال خطأ أو عدم تشخيصهم، ومن ثم عدم حصولهم على العلاج الصحيح (33، 43).

ويتمثل تحدي مركزي في أن أعراضًا كثيرة للصدمة والحالات العصبية النفسية تظهر بطرق متشابهة. فقد تكون صعوبات التركيز تعبيرًا عن اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، لكنها قد تنشأ أيضًا بسبب فرط الاستثارة أو التفارق أو اضطرابات النوم بعد الصدمة (1، 53، 63). وقد ترتبط الاندفاعية وعدم الاستقرار العاطفي باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، لكنها قد تنشأ أيضًا نتيجة تغيرات يسببها الإجهاد في القشرة الجبهية الأمامية واللوزة الدماغية (31، 73).

وقد يُفسر الانسحاب الاجتماعي على أنه اضطراب طيف التوحد، لكنه قد ينشأ أيضًا عن سلوك التجنب في اضطراب الكرب التالي للصدمة، أو اضطراب التعلق التفاعلي، أو التعلق غير المنظم، أو صعوبات تنظيم المشاعر بعد أحداث صادمة متكررة (5، 83).

[صفحة أصلية 381]

وقد يظهر لدى الأطفال الذين تعرضوا لأحداث صادمة ما يشبه أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، مثل التمثل و عدم الانتباه والاضطراب الحركي، من دون استيفاء معايير تشخيص عصبي نفسي (93). وأظهر الأطفال المصابون باضطراب الكرب التالي للصدمة في دراسات عدة ضعفًا في الوظيفة التنفيذية والذاكرة العاملة وتطور اللغة (04، 14). وهذه المجالات مركزية أيضًا في اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة والتوحد، مما يجعل التمييز بين الحالات صعبًا بوجه خاص في الممارسة السريرية (24، 34).

وهناك تداخل كبير أيضًا بين التغيرات العصبية البيولوجية في الصدمة والصعوبات التي تميز الإعاقات العصبية النفسية مثل اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة والتوحد. فقد لوحظ، مثلاً، خلل في محور APH والقشرة الجبهية الأمامية، واضطرابات في نظامي الدوبامين والنورأدرينالين (61، 44).

الحالات العصبية النفسية والحالات المرتبطة بالصدمة تحدث معًا كثيرًا

ولزيادة تعقيد الروابط، فإن الاعتلال المشترك بين الحالات العصبية النفسية والصدمة شائع، وغالبًا ما يسهم في صورة سريرية أكثر تعقيدًا مما يحدث عندما تظهر الحالات منفردة. ويعاني نحو 03-05% من الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة من نوع من اضطرابات القلق، ويصاب ما يصل إلى ربعهم باضطراب الكرب التالي للصدمة إذا تعرضوا لأحداث صادمة (34، 54).

ويظهر الأطفال المصابون بالتوحد في دراسات عدة مستويات أعلى من ردود الفعل الصدمية، ويكون خطر إصابتهم باضطراب الكرب التالي للصدمة ضعف خطر الأطفال غير المصابين بالتوحد (5، 64). وفي الوقت نفسه، يكون الأطفال الذين عاشوا تجارب صادمة واسعة، مثل أشكال العنف أو الإهمال المتكررة، ممثلين بنسبة أعلى بين من يشخصون بالحالات العصبية النفسية (31، 74). وهذا يدل على أن الاعتلال المشترك هو القاعدة أكثر من كونه الاستثناء.

[صفحة أصلية 481]

وتظهر دراسات أيضاً أن الأطفال الذين تعرضوا لأحداث صادمة يحصلون غالباً على تشخيصات مثل اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة أو التوحد. وقد يكون ذلك بسبب التشخيص الخاطئ، إذ تُفسر الأعراض المرتبطة بالصدمة خطأ بوصفها أعراضاً عصبية نفسية، أو بسبب اعتلال مشترك فعلي، حيث تثير الأحداث الصادمة صعوبات مرتبطة بالحالات العصبية النفسية أو تزيدها (1، 43، 63). وقد تُكتشف الحالات العصبية النفسية أيضاً نتيجة لقاء الطفل بالرعاية الصحية، لأن احتياجات رعاية اضطراب الكرب التالي للصدمة تؤدي إلى الاتصال بالرعاية، وهو اتصال ربما لم يحدث لولا ذلك.

روابط تفاعلية تعزز فيها صعوبات الطفل بعضها بعضاً

نستعرض أخيراً المجال الذي يصف كيف لا تحدث الحالات العصبية النفسية والصدمة معاً فحسب، بل قد تعزز آثار كل منهما الآخر، فتؤدي إلى صورة أعراض أكثر تعقيداً وطولاً وصعوبة في العلاج.

وتعني الروابط التفاعلية بين الحالات العصبية النفسية والصدمة أن الصعوبات لا تتعايش فقط، بل تتفاعل بطرق تؤدي إلى صورة أعراض أكثر تعقيداً وطولاً وصعوبة في العلاج. وتصف الأبحاث ذلك بأنه آثار إضافية: فعندما تظهر الحالات العصبية النفسية والصدمة معاً، يزداد العبء بصورة أسية لا خطية (9).

وقد يعاني الأطفال الذين لديهم أصلاً تشخيص عصبى نفسى، مثل اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة أو التوحد، من تفاقم صعوباتهم الأصلية بعد الصدمة. فقد يعاني الطفل المصاب باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة من زيادة كبيرة في مشكلات التحكم في الاندفاع، وانخفاض تحمل الإجهاد، وصعوبة تنظيم المشاعر. ويتميز التوحد بصعوبات في التفاعل الاجتماعي والتواصل والمرونة، وقد أظهرت دراسات عدة أن الصدمة تعزز هذه الصعوبات.

[صفحة أصلية 581]

ويؤدي فرط نشاط اللوزة الدماغية، الموجود في التوحد واضطراب الكرب التالي للصدمة، إلى زيادة الحساسية للإشارات الاجتماعية وصعوبة تنظيم المشاعر (02، 84). وقد تسبب التجارب الصادمة أيضاً تراجعاً في مهارات راسخة، مثل اللغة أو الاستراتيجيات الاجتماعية، أو زيادة القلق أو تعزيز الحساسية الحسية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الصعوبات المرتبطة بالتوحد (5).

وقد تعمل الصدمة أيضاً عاملاً محفزاً. فالسمات العصبية النفسية السابقة التي لم تكن واضحة بما يكفي لاستيفاء التشخيص قد تصبح أوضح وتبلغ المستوى السريري (63، 94). وقد بطور طفل لديه صعوبات تركيز لم تكن تعوق أدائه سابقاً تشخيص اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة بعد تعرضه للصدمة، إذا استوفى المعايير.

ومن الجوانب المهمة في الروابط التفاعلية أن كثيراً من الأطفال ذوي الحالات العصبية النفسية لديهم منذ البداية اختلافات بيولوجية تجعلهم أكثر عرضة للصدمة. وغالباً ما يظهر الأطفال المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة تنظيمًا غير نمطي لمحور APH، بما يعني صورة كورتيزول غير معتادة وحساسية أكبر للإجهاد (21، 05). أما لدى الأطفال المصابين بالتوحد، فتوجد معالجة مختلفة للمنبهات الاجتماعية والحسية قد تجعل التجارب الصادمة صعبة التحمل بوجه خاص، وتزيد مشكلات تنظيم المشاعر (5).

[صفحة أصلية 681]

وعندما تواجه هذه الاستعدادات البيولوجية بيئة غير مواتية، مثل التنمر أو الإهمال أو العنف المنزلي، يكون الأثر غالبًا إضافيًا، وتتفاقم الأعراض العصبية النفسية والمرتبطة بالصدمة معًا (61).

وقد يتعزز التفاعل بين الحالات العصبية النفسية والصدمة من خلال التغيرات فوق الجينية. فقد يرث أطفال الآباء ذوي الصعوبات العصبية النفسية قابلية بيولوجية، وينشأون في الوقت نفسه في بيئات يسودها الإجهاد أو قصور الرعاية. وأظهرت الدراسات أن الصدمة المبكرة قد تؤثر في تنظيم الجينات، أي ما يسمى المَثِيلَة، ولا سيما في الأنظمة التي تنظم استجابات الإجهاد، مما قد يؤدي إلى صعوبات طويلة الأمد في التحكم بالمشاعر والاندفاع (15، 25).

وقد تنتقل هذه التغيرات فوق الجينية بين الأجيال، وبذلك توجد، إلى جانب القابلية النفسية والبيئية الموروثة، قابلية بيولوجية أيضًا (35). ومن المهم تذكر وجود مؤشرات في الوقت نفسه على أن بعض التغيرات فوق الجينية قابلة للعكس في وجود علاقات مستقرة وأمنة وتدخلات موجهة (45).

[صفحة أصلية 781]

حالة عملية

يأتي صبي في الثامنة من عمره مع أمه إلى عيادة الطب النفسي للأطفال والشباب. وقد شجعت المدرسة الأم على طلب المساعدة بسبب الصعوبات الاجتماعية والسلوكية الواسعة لدى ابنها. وتشعر الأم بالقلق أيضًا، لكنها تشعر بالعجز. وقد جاءت وحدها مع الصبي إلى السويد قبل عام، بعد وفاة والد الطفل في الحرب في بلدهما الأصلي. ويعاني الاثنان، ومنتظران تصريح الإقامة، ومنتقلان بين مساكن مستأجرة.

وتخاف الأم بشدة من أن يُطردا إذا صرخ الصبي، ولذلك تتركه يقرر. وإذا لم يحصل على ما يريد، يرمي هاتفها ويعضها ويصرخ.

كان التقييم الأول في العيادة أن الصبي مصاب بالصدمة، وحاول العاملون بطرق مختلفة إعداد علاج لاضطراب الكرب التالي للصدمة. لكن التواصل معه صعب، إذ يتجول في العيادة ويكون عدوانيًا. وحاول العاملون زيادة شعوره بالأمان من خلال العمل مع الأم، لكن الوصول إليها كان صعبًا أيضًا بسبب الإجهاد الشديد والإرهاق والقلق.

وبعد اجتماع مشترك مع الأم والخدمات الاجتماعية والمدرسة والعيادة، اتفقوا على منح الصبي شخص دعم في المدرسة يبقى معه طوال الوقت حتى تتمكن الأم من تركه هناك. وستبحث الخدمات الاجتماعية أيضًا في كيفية دعم الأسرة. وفي المدرسة جلست معلمة تربية خاصة مع الصبي منفردة، ووصفت اعتقادها بأن ذكاءه جيد، لكنه يعاني صعوبة شديدة في التركيز.

[صفحة أصلية 81]

وصفت الأم أنه أظهر فرط نشاط شديدًا منذ طفولته المبكرة. كما اشتبهت في وجود عامل وراثي لاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، لأن لديها ولدى الأب صعوبات كبيرة في السنوات الدراسية الأولى، رغم أن كليهما درس لاحقًا في الجامعة.

وقررت العيادة إجراء تقييم عصبي نفسي واسع لتحديد احتياجات العلاج. وبفضل تكييفات كبيرة، أمكن إجراء اختبارات غير لفظية وتقييم محدود آخر. وكان الصبي يحتاج إلى فترات راحة متكررة، وأجريت أجزاء من الفحص تحت الطاولة، حيث كان يجلس ويأكل رقائق البطاطس التي تعطيه إياها أمه.

قُيِّم الصبي على أنه يتمتع بذكاء طبيعي لكنه غير متساوٍ. وذكُر أنه يستطيع، مع دعم كبير، إكمال عدة اختبارات فرعية بمستوى يتوافق مع عمره. وبناءً على الاختبار والملاحظة والمقابلة مع الأم والعاملين في المدرسة، قُيِّم على أنه يستوفي معايير تشخيص اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة.

كما لوحظت سمات عدة للتوحد، لكن تقرر تأجيل هذا التشخيص في الوقت الحالي، مع التوصية بتدخلات شبيهة بتدخلات التوحد لمعرفة ما إذا كانت تدعم نموه. وظهرت أيضًا بعض أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة، لكنها لم تكن كافية للتشخيص. وأوصي ببدء تكييفات اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة في المنزل والمدرسة، وبمحاولة العلاج الدوائي.

الأسئلة والأجوبة

جمعت في هذا القسم الأسئلة الشائعة. وتتعلق الموضوعات الشاملة بالتحقيق عند وجود أوضاع معقدة، بما في ذلك الصدمة، وبما ينطبق على الأطفال الذين لديهم تجارب الهجرة والفرار. وسأحاول تقديم إرشادات حول كيفية معالجة هذه الأسئلة وكيفية التفكير في أوضاع مختلفة بطريقة تعزز جودة التشخيص والوصول إلى المساعدة للطفل. ونصف أدناه الظروف التي قد تجعل التحقيق أكثر تعقيداً، ونقدم نصائح للمهنيين.

1. هل يمكن إجراء تحقيق في جميع الحالات؟

من الأسئلة المتكررة في الممارسة السريرية ما إذا كان من الممكن حقاً إجراء تحقيق في جميع الحالات. والإجابة البسيطة هي أنه يمكن، من حيث المبدأ، إجراء تحقيق دائماً، لكن الغرض والنطاق ودرجة اليقين في الاستنتاجات قد تختلف.

ويعني التحقيق أساساً جمع المعلومات بطريقة منظمة وتحليلها ودمجها بهدف إجراء تقييم. ويمكن فعل ذلك دائماً، حتى في الظروف المعقدة ذات الأساس المحدود. والمهم أن تكون واضحاً بشأن الأسئلة التي تسعى إلى الإجابة عنها، والمعلومات المتاحة، وأوجه عدم اليقين المتبقية. فالوعي والشفافية حاسمان.

ولا يستطيع أي تحقيق تقديم إجابات مطلقة، لكنه يستطيع دائماً المساهمة في توضيح الصعوبات الحالية للطفل ووظائفه واحتياجاته إلى الدعم. وحتى التحقيق الأولي أو غير المكتمل قد يكون ذا قيمة، لأنه ينشئ أساساً لتدخلات قد لا تتوافر بدونه.

2. هل يناسب التحقيق جميع الحالات؟

يتعلق سؤال ملاءمة التحقيق أساساً بالغرض منه وبالاحتياجات السريرية ذات الأولوية في الوضع الحالي. وينبغي أن يوجه التحقيق دائماً سؤال: ما الفائدة التي يحصل عليها الطفل من هذا التقييم الآن؟ وماذا قد يعني عدم إجرائه؟

[صفحة أصلية 091]

توجد حالات يمكن فيها اعتبار التحقيق غير مناسب مباشرة. وينطبق ذلك بوجه خاص عند وجود حالات حادة أو مهددة للحياة ينبغي أن تكون أولوية لحماية الطفل. وقد يتعلق الأمر بخطر حاد للعنف أو بإهمال رعاية مستمر، حيث يجب أولاً ضمان تدابير الحماية، أو بطروف جسدية تحتاج إلى رعاية فورية، مثل الجوع المهدد للحياة في اضطرابات الأكل، أو خطر انتحار حاد، أو أزمة نفسية خطيرة. وفي هذه الحالات قد لا يكون التحقيق غير فعال فحسب، بل قد يؤخر التدخلات الأكثر إلحاحًا والمنقذة للحياة.

لكن لا ينبغي اعتبار الوضع الحياتي غير المستقر في حد ذاته سببًا للامتناع عن التحقيق إذا كان طويل الأمد ولا يتوقع تغييره في المستقبل المنظور. فقد يكون لدى طفل في أسرة فرت وتعيش الآن في عدم يقين بشأن تصريح الإقامة احتياج إلى تحقيق في صعوبات التركيز أو أعراض الصدمة. وقد يؤدي تأجيل التقييم حتى تصبح الظروف أكثر استقرارًا إلى عدم حصول الطفل على الدعم خلال فترة نمائية حرجية.

وخلاصة الأمر أن الامتناع الكامل عن التحقيق نادرًا ما يكون مناسبًا. وعند وجود حالة حادة يجب إعطاؤها الأولوية أولاً، لكن في الحالات الأخرى قد يكون السؤال هو كيف يمكن إجراء تحقيق ذي معنى، بالنظر إلى احتياجات الطفل الحالية.

3. هل يمكن إجراء تحقيق مع ظروف معقدة؟

يجب أن يرتبط سؤال إمكان التحقيق أو ملاءمته دائمًا باحتياجات الطفل. والمهم ليس استيفاء جميع شروط التحقيق المثالي، بل ما إذا كان التحقيق يستطيع زيادة فهم صعوبات الطفل واحتياجاته. والغرض من التقييم النفسي أو العصبي النفسي هو أساسًا بناء فهم يؤدي إلى تدابير كافية وفعالة.

ولا ينبغي النظر إلى التحقيق على أنه مسألة كل شيء أو لا شيء. وحتى عندما يكون الأساس محدودًا، مثلًا بسبب حواجز اللغة أو نقص التعليم المدرسي أو الإجهاد النفسي الاجتماعي المستمر، قد يقدم التحقيق معلومات قيمة عن أداء الطفل الحالي واحتياجاته.

[صفحة أصلية 191]

وعملًا، يتعلق الأمر غالبًا بوضوح صياغة الغرض: هل ينبغي أن يوفر التحقيق أساسًا لتشخيص، أم لفهم نقاط قوة الطفل وضعفه، أم لتخطيط دعم ملموس؟ وقد يكون التفكير في هذه الأسئلة مهمًا بوجه خاص عندما يوجد عدم يقين بشأن إمكان إجراء تحقيق موثوق.

ومن الأساسي توضيح الأسئلة التي تريد الإجابة عنها، والطرق التي يمكن استخدامها، وكيفية التعامل مع أي أوجه عدم يقين. وبهذه الطريقة، يستطيع حتى التحقيق الذي يبدو غير مكتمل أن يسهم في أساس أفضل لاتخاذ قرارات بشأن التدخلات.

4. هل يمكن إجراء تحقيق مع وجود إجهاد شديد مستمر؟

الأهم هنا معالجة الوضع الحاد أولاً حتى يحصل الطفل على الحماية والرعاية الأساسيتين. لكن كثيرًا من الأطفال يعيشون تحت إجهاد طويل الأمد، مثل الفقر والسكن غير المستقر والإجهاد المرتبط بالهجرة أو النزاعات المتكررة في المنزل، ولا يتوقع أن تُحل هذه الأوضاع في المستقبل المنظور. وإذا انتظرنا استقرارًا يبدو أنه لن يأتي أبدًا، فقد يُحرم هؤلاء الأطفال من التحقيق أو التدخلات التي قد تكون حاسمة لنموهم.

ومن منظور العدالة، من المهم بوجه خاص التأكيد على ألا يُحرم الأطفال الذين لديهم عوامل خطر متعددة من التحقيق. فقد يؤدي انتظار ظروف أفضل إلى رعاية غير متساوية، ينتهي فيها الأطفال المحرومون أصلًا إلى أن يكونوا الأبعد عن الدعم والعلاج. وقد لا يهدف التحقيق في هذه الحالات دائمًا إلى تحديد تشخيص دقيق، بل قد يكون هدفه الأساسي وصف مستوى الأداء الحالي واحتياجات الدعم.

[صفحة أصلية 291]

5. هل يمكن إجراء تحقيق مع وجود حدث صادم مستمر؟

كما في حالة الإجهاد المستمر، يمكن إجراء التحقيق، لكن يجب إعطاء الأولوية لضمان سلامة الطفل الحادة. وبعد ضمان السلامة، ينبغي تقييم الاحتياجات الأكثر إلحاحًا. وعندما تتزامن الصعوبات بوضوح مع حدث صادم معين، قد يكون من الأولوية بدء تدخلات موجهة للصدمة قبل التحقيق الشامل.

وفي الوقت نفسه، من المهم عدم الخلط بين الاستجابات الحادة للصدمة والصعوبات المستمرة في الأداء. فلا ينبغي حرمان الأطفال الذين واجهوا صعوبات طويلة الأمد في التركيز أو التفاعل الاجتماعي أو اللغة من تحقيق عصبي نفسي لمجرد أنهم تعرضوا أيضًا لأحداث صادمة. وقد يسهل الحصول على الدعم الناتج عن التشخيص الصحيح التعافي من التجارب الصادمة.

6. هل يمكن إجراء تحقيق مع وجود صدمة معروفة سابقًا؟

لا تمثل الأحداث الصادمة في التاريخ الطبي عائقًا في حد ذاتها أمام التحقيق في الصعوبات العصبية النفسية. ويعبر كثير من المهنيين عن القلق من الخلط بين الأعراض المرتبطة بالصدمة والحالات العصبية النفسية، وهو قلق مفهوم، لكنه قد يؤدي إلى تحفظ تشخيصي مفرط.

وقد يعطي تاريخ ظهور الأعراض بعض الإرشادات في التشخيص التفريقي. فأحيانًا تكون الصعوبات موجودة قبل التعرض للصدمة، وأحيانًا تكون الصدمة قد طبعت الطفولة كلها، وفي حالات أخرى لا تصبح الصعوبات العصبية النفسية واضحة إلا لاحقًا عندما تزداد المطالب على الكفاءات المعرفية والاجتماعية أو ينخفض الصمود بسبب ضغط آخرى.

[صفحة أصلية 391]

وبما أن بعض الأعراض العصبية النفسية تكون سلوكيات مناسبة للعمر في السنوات الأولى، فقد تكون الأعراض موجودة فترة طويلة لكنها تظهر فقط بوصفها انحرافاً عندما يكبر الطفل. وهذا يؤكد أهمية التقييمات الفردية والمتوازنة والحذر من الاستنتاجات السببية.

ولتشخيص حالة عصبية نفسية، يجب أن تكون الصعوبات مستمرة، وأن تبدأ مبكراً، وأن تحدث في سياقات متعددة. ولا يتعلق الأمر بأعراض منفردة تتداخل مع اضطراب الكرب التالي للصدمة، مثل صعوبات التركيز أو تنظيم المشاعر، بل يجب استيفاء معايير التشخيص كلها ووجود عجز وظيفي واضح مع مرور الوقت.

وعندما توجد الصدمة والصعوبات العصبية النفسية معاً، يجب اعتبارهما حالتين متعايشتين بدل أن يستبعد أحدهما الآخر. فالأطفال ذوو الصعوبات العصبية النفسية أكثر عرضة للأحداث الصادمة، وقد تؤدي الصدمة بدورها إلى تفاقم الصعوبات الموجودة. وإذا تجنبنا تشخيص الحالات العصبية النفسية، فقد يفقد الأطفال تدخلات مهمة. ولذلك يحتاج الأطفال الذين يعانون إجهاداً شديداً وصدمة ويظهرون صعوبات عصبية نفسية غالباً إلى تحقيق أدق وتدخلات أكثر، لا أقل.

[صفحة أصلية 491]

7. إذا أُجري تحقيق ثم عُرف لاحقًا وجود صدمة، فهل يمكن اعتبار التقييم صحيحًا؟

نعم، إذا استمرت الصعوبات. فالتشخيصات ليست ملصقات ثابتة، بل ينبغي أن تعكس مستوى أداء الطفل الحالي واحتياجاته الحالية إلى الرعاية. وإذا تعافى الطفل بعد اكتشاف الصدمة ولم يعد يظهر أعراضًا أو عجزًا وظيفيًا، فلا يكون من الطبيعي الاحتفاظ بالتشخيص.

لكن لا ينبغي إعادة النظر في التشخيص لمجرد ظهور معلومات جديدة عن أحداث صادمة؛ بل يجب أن يستند التقييم دائمًا إلى مستوى أداء الطفل الحالي واحتياجاته. وإذا استمرت الصعوبات بدرجة تتطلب تدخلات، يظل التشخيص ذا صلة وحاضرًا.

8. إذا وُجدت أحداث صادمة وإهمال شديد طوال الطفولة، فكيف ينبغي التفكير؟

قد يصعب معرفة ما جاء أولاً، لكن عند التركيز على احتياجات الطفل إلى التدخل ينبغي اعتبار كل أشكال الإجهاد مؤثرة، وأن الطفل الذي تعرض لأذى واسع يحتاج إلى تدخلات أكثر لا أقل. وقد تكون القاعدة العملية الجيدة أن نبدأ من الاحتياجات لا من السبب.

وقد ينشأ بعض الأطفال في بيئات يستحيل فيها تحديد «قبل» و«بعد» واضحين فيما يتعلق بالتعرض للأحداث الصادمة. وقد يتعلق الأمر بإجهاد نفسي اجتماعي مستمر، وتجارب صادمة متكررة طوال الحياة، وإهمال شديد منذ الطفولة المبكرة، أو تعرض حتى أثناء الحمل، مثل العنف ضد الأم أو التعرض للكحول والمخدرات داخل الرحم. وقد تنقص أيضًا المعلومات عن نمو الطفل المبكر.

وبجعل ذلك التمييز بين الصعوبات العصبية النفسية الأولية والعواقب الناتجة عن الصدمة والإهمال أو تأثيرات البيئة الأخرى صعبًا جدًا. وعند الرضع والأطفال الصغار تكون مجموعة التعبير محدودة بوظائف أساسية مثل التواصل والتغذية والنوم والتنظيم، وهي صعوبات قد تحدث في مشكلات العلاقات والانحرافات العصبية النفسية معًا.

[صفحة أصلية 591]

ومن المخاطر الأخرى المبالغة في تفسير الروابط بين الأحداث الصادمة والأعراض. فقد يبدو أن الطفل حصل على صعوباته بعد حدث معين، بينما كانت المشكلات موجودة أصلاً وأصبحت أكثر وضوحاً عندما زادت المطالب على القدرات مع العمر، أو عندما بدأ الأقران يتفوقون على الطفل نمائياً. وقد تخلق هذه الظاهرة روابط سببية خاطئة.

وقد تؤثر الصدمة العابرة للأجيال في الطفل أيضاً. فقد تنتقل صدمة الوالدين بصورة غير مباشرة من خلال حدود القدرة على الرعاية، مثل ضعف دعم التنظيم في الأوضاع التهديدية، وعبر آليات بيولوجية، منها تغيرات فوق جينية تؤثر في نظام الإجهاد.

وفي هذه الحالات المعقدة، يصبح من الأساسي مراعاة التعرض التراكمي للمخاطر. وقد تزيد عوامل الخطر المتعددة، سواء كانت جينية أو نفسية اجتماعية أو بيولوجية، احتمال المشكلات الشديدة وطويلة الأمد. ولذلك من المهم أن يحصل الأطفال الذين يستوفون معايير حالة عصبية نفسية على التشخيص والتدخلات المصاحبة، حتى عندما لا يمكن تحديد السبب الدقيق للصعوبات. وقد يؤدي حجب الدعم بسبب عدم اليقين بشأن ما جاء أولاً إلى مزيد من تعقيد نمو الطفل.

9. كيف يمكن معرفة السبب؟

قد لا يكون ذلك ممكناً دائماً، لكن المراجعة الدقيقة لمعايير التشخيص توفر أفضل أساس ممكن لتحديد جميع الصعوبات واحتياجات الطفل إلى التدخلات. ورغم أن آثار الصدمة لدى الأطفال قد تتضمن أعراضاً متداخلة مع الصعوبات العصبية النفسية، فإنها ليست الشيء نفسه.

والأهم هو الالتزام بمعايير التشخيص. فإلى جانب معايير الأعراض، يجب أن يوجد عجز وظيفي مقيم واستمرار مع مرور الوقت. وإذا استوفيت المعايير، فلا حاجة إلى التوقف عند أسئلة افتراضية عن أداء الطفل في ظروف مثالية.

وقد يصعب الفصل بين بعض الأعراض، فاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة واضطراب الكرب التالي للصدمة يتضمنان صعوبات التركيز. وقد توجد الصعوبات منفصلة، لكنها قد تعزز بعضها بعضاً عندما تحدث الحالتان معاً.

[صفحة أصلية 691]

وتعد صعوبات النوم عاملاً إضافياً قد يتعايش مع اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة واضطراب الكرب التالي للصدمة، ويضعف مستوى الأداء بحد ذاته، من خلال تفاقم الصعوبات التنفيذية في اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وإعاقة التعافي من اضطراب الكرب التالي للصدمة.

وقد يؤثر التوحد واضطراب الكرب التالي للصدمة في بعضهما بعضاً أيضاً؛ إذ يتضمن اضطراب الكرب التالي للصدمة إعادة التجربة، بينما يتميز التوحد بقلّة المرونة والسلوكيات المتكررة. وقد يواجه الشخص المصاب بالحالتين صعوبة أكبر في التعافي من إعادة التجربة، في حين قد يضعف اضطراب الكرب التالي للصدمة المرونة ويؤدي إلى تدهور عام في الأداء المرتبط بالتوحد.

ومن المهم ألا نفترض وجوب تمييز الأسباب أو تحديد ما جاء أولاً دائماً. فالأهم هو فهم التدخلات التي قد تكون فعالة. وسواء كانت الصعوبات فطرية أو مكتسبة أو مزيجاً منهما، ينبغي أن تحدد احتياجات العلاج الأسلوب. وإذا وُجد عدم يقين، يمكن تجربة التدخلات الأكثر إلحاحاً والاستعداد لإعادة النظر إذا لم تنجح.

وعموماً، كلما زادت الصعوبات زادت المخاطر المتركمة، وزادت الحاجة إلى التحقيق والعلاج العملي. ومجرد عدم معرفة كيفية علاج الصورة السريرية كلها لا يجعل الامتناع عن علاج ما يمكن علاجه أمراً أخلاقياً.

01. هل ينبغي إجراء التحقيق أم العلاج أولاً؟

لا توجد إجابة عامة، بل ينبغي أن تستند الأولويات دائماً إلى ما هو أكثر إلحاحاً وفائدة للمريض الفردي. والأهم عدم تأجيل التحقيق والعلاج معاً لأن الصعوبات تبدو معقدة، فقد يبقى الطفل دون تدخلات وهو ينتظر استقراراً قد لا يأتي أبداً.

وليس الأمر دائماً خياراً بين هذا أو ذاك. فكثيراً ما يمكن أن يتقدم التحقيق والعلاج بالتوازي، ولا سيما إذا كان الطفل يعاني صعوبات واسعة قد تسوء من دون تدخلات. وكانت هناك في السابق مبالغة في التأكيد على ضرورة الاستقرار الطويل قبل العلاج الموجه للصدمة، لكن الأبحاث الأحدث تظهر أن العلاج السلوكي المعرفي الموجه للصدمة قد يكون فعالاً حتى مع الإجهاد النفسي الاجتماعي المستمر.

[صفحة أصلية 791]

وقد يتعلق الأمر أيضًا بما هو متاح. فإذا كان هناك تدخل متاح، فلا ينبغي جعل أحد التدخلين شرطًا للآخر. وإذا توفر تدخل يتوقع أن يكون فعالًا وكان الطفل والأسرة قادرين على تلقيه، فلا ينبغي الانتظار، وينطبق ذلك على التحقيق والعلاج معًا.

11. متى ينبغي التحقيق في الصعوبات المعرفية لدى الأطفال المعرضين للأذى؟

تتمثل نقطة الانطلاق المهمة في إجراء التحقيقات عندما يمكن ربط النتائج بتدخلات فعالة يحتاج إليها الطفل. وفي العلاج النفسي لا توجد تدخلات موجهة للملفات المعرفية الفردية، لكن يمكن تكييف الرعاية على أساس فهم شامل لنقاط قوة الطفل وضعفه.

وفي المدرسة تصبح التحقيقات المعرفية مهمة بوجه خاص عندما يتعلق الأمر بنوع التعليم، لأن الأطفال ذوي العجز في الوظيفة الفكرية لهم الحق في التعليم الابتدائي المعدل. ويتطلب تشخيص ذلك، من بين أمور أخرى، تقييمًا باستخدام اختبار قدرة معياري.

وقد تُقدم التدخلات التعليمية العامة بدلًا من ذلك من دون اختبار شامل. وإذا لم توجد تدخلات مرتبطة بنتيجة الاختبار، ولم يكن متوقعًا أن يسهم التحقيق في تغيير العلاج أو التعليم، فقد يكون هناك سبب قليل لإجراء الاختبار. وقد يؤدي الاختبار دون غرض واضح إلى إحباط أو وصم أو وصم لا يفيد الطفل.

[صفحة أصلية 891]

وقد يثير جمع معلومات لم يُخطط لاستخدامها أسئلة أخلاقية للفرد والمجتمع، ولا سيما في ظل محدودية الموارد.

21. هل يمكن إجراء تحقيق عصبي نفسي لدى الأطفال الذين فروا؟

يشكل الأطفال الذين عاشوا الفرار مجموعة معرضة للأذى بوجه خاص، إذ تتقاطع لديهم غالبًا عوامل نفسية اجتماعية معقدة مع خطر الأحداث الصادمة والإجهاد المرتبط بالهجرة. وقد يكون هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للاعتلال النفسي والصعوبات النمائية، بينما تعقد ظروف حياتهم الوصول إلى الرعاية الكافية.

وقد يكون إجراء التحقيقات العصبية النفسية في هذه المجموعة تحديًا، لكنه مهم أيضًا لضمان الوصول إلى التدخلات ذات الصلة ومكافحة الرعاية غير المتساوية.

ويخشى المهنيون أحيانًا من تشخيص الحالات العصبية النفسية خطأ عندما توجد الصدمة أو الإجهاد المستمر في تاريخ الطفل. وقد يؤدي ذلك إلى عدم حصول الطفل على أي تشخيص، وبالتالي فقدان الدعم والعلاج اللذين كان يمكن أن يحسنا الأداء والتوقعات.

[صفحة أصلية 991]

لكن التشخيص لا يتعلق بتحديد الأسباب الدقيقة للأعراض، بل بوصف الصعوبات الحالية للطفل وتقييم استمرارها وأثرها الوظيفي، واختبار ما إذا كانت معايير التشخيص مستوفاة.

ولذلك ينبغي ألا يتخلّى المهنيون عن المهمة بسبب التعقيد، بل أن يتعاملوا مع الوضع بطريقة منظمة. وينبغي التركيز على وصف أداء الطفل هنا والآن، ورسم احتياجاته، والنظر في التشخيصات المحتملة، وعرض التدخلات حتى مع عدم اليقين، ثم المتابعة وإعادة النظر عند الحاجة.

وكما أوضحنا سابقاً، نادراً ما يكون الانتظار لظروف أكثر استقراراً خياراً مناسباً. وقد يؤدي الانتظار لدى كثير من الأطفال إلى عدم تقديم الدعم، لأن وضعهم الحياتي قد يظل غير مستقر مدة طويلة. وقد يكون النهج العملي القائم على التدخلات المرتبطة بالاحتياجات المرصودة هو الأفضل.

[صفحة أصلية 002]

31. هل يمكن إجراء تحقيق للأطفال الذين لا يملكون تصريح إقامة؟

غالبًا ما تكون عملية اللجوء حالة تتسم بعدم اليقين، ومحدودية حرية التصرف، والضغط النفسي الاجتماعي الواسع، وقد يعاني أفراد عدة من الأسرة في الوقت نفسه. وقد يزيد هذا عدم اليقين غياب السكن الثابت والصعوبات الاقتصادية والوصول المحدود إلى موارد المجتمع. كما قد تُعاش عملية اللجوء نفسها بوصفها مرهقة ومشككة، لأن الأسرة قد تضطر إلى رواية أحداث صادمة لإثبات أسباب طلب الحماية.

وقد يعيش الأطفال الذين لا يملكون تصريح إقامة في هذا الوضع غير المستقر مدة طويلة جدًا، وأحيانًا طوال نشأتهم. ويعني الانتظار حتى يستقر الوضع غالبًا أن الطفل لن يحصل على التحقيق أو التدخلات التي قد تليه. وهذا يخاطر بتأخير الدعم وترسيخ الصعوبات والمساهمة في رعاية غير متساوية.

41. ما مدى سرعة إمكان التحقيق مع الأطفال الوافدين حديثًا؟

لا يوجد حد زمني ثابت لموعد إمكان إجراء التحقيق أو وجوبه لدى الأطفال الذين وصلوا حديثًا إلى السويد. والحاسم هو احتياج الطفل الحالي والمعلومات اللازمة لتخطيط تدخلات مناسبة. وقد يتعلق الأمر أحيانًا برسم خريطة مبكرة للنمو ومستوى الأداء لضمان الوضع المدرسي الصحيح، مثل المدرسة الابتدائية المعدلة للأطفال ذوي الإعاقة الفكرية.

[صفحة أصلية 102]

وفي حالات أخرى يتعلق الأمر بأطفال تظهر عليهم علامات واضحة لصعوبات عصبية نفسية، لكنهم لم يخضعوا للتحقيق ولم يحصلوا على دعم في بلدهم الأصلي، ربما بسبب عدم توافر التعليم المعدل أو الرعاية. وتكتسي التدخلات المبكرة أهمية خاصة، لأن الصعوبات التي لا يُنْتَبَه إليها قد تؤدي إلى مشكلات ثانوية، مثل الاعتلال النفسي والفشل الدراسي والإقصاء الاجتماعي.

51. ما الذي ينبغي مراعاته بشأن الخلفية المدرسية للطفل؟

ابداً بالتحقيق في خبرات التعلم من أي تعليم سابق. وإذا لم يذهب الطفل إلى مدرسة سويدية، فمن المهم معرفة نوع المدرسة وظروفها، وكيف كان أدائه مقارنة بأقرانه، والمعارف التي اكتسبها.

وعندما لا يملك الطفل خبرة مدرسية أو يملك خبرة محدودة جداً، ينبغي التمييز بوجه خاص بين القدرات والمهارات. ولا يمكن أن يستند التقييم بالقدر نفسه إلى المعارف المدرسية المكتسبة، بل إلى قدرة الطفل على التعلم الجديد والمعارف التي اكتسبها في مجالات أخرى. فالقراءة والكتابة مهارات تعتمد على التعليم، ولا تصلح وحدها لتقييم القدرات المعرفية الأساسية.

ويمكن استخدام الاختبار الديناميكي، الذي يبتعد عن الإجراء الموحد ويقيّم قدرة الطفل على التعلم الجديد بدل الاعتماد على النتائج المعيارية. فيُحدد الأداء التلقائي أولاً، ثم يُفحص مقدار تحسنه بعد التعليم أو النمذجة أو الدعم. ويعطي ذلك صورة أدق عن الموارد والقدرات المعرفية، ويمكن استخدامه عند غياب معايير مقارنة موثوقة.

[صفحة أصلية 202]

61. هل يمكن إجراء التحقيق عند غياب التاريخ الطبي؟

إن نقص المعلومات عن النمو المبكر تحدّ شائع، ولا يعني أن التحقيق مستحيل. ويمكن طلب معلومات إضافية من الخدمات الاجتماعية ورياض الأطفال والمدرسة والأوصياء والأقارب، أو من وثائق بلد الأصل.

وعندما تكون معلومات الخلفية محدودة، ينبغي التركيز بوجه خاص على وصف أداء الطفل هنا والآن، وعلى استمرار الصعوبات وتأثيرها في الوظيفة. ويمكن لتقييم الأداء واستمراره أن يعوض جزئياً نقص التاريخ. وينبغي توثيق الأساس المستخدم والمعلومات المفقودة وكيف تؤثر في التقييم.

71. ماذا ينبغي مراعاته إذا كانت اللغة الأولى للطفل غير السويدية؟ وهل يمكن استخدام مترجم؟

لا ينبغي أن تصبح الحواجز اللغوية سبباً للامتناع عن التحقيق والتدخلات. وقد يلزم تكييف المنهجية واستخدام مصادر متعددة للمعلومات وتوضيح حدود تفسير النتائج. وإذا لم يكن الطفل يتحدث السويدية، فيجب استخدام مترجم، مع توثيق الانحرافات عن الإدارة الموحدة وتفسير النتائج بحذر. ويمكن لمعلم اللغة الأم تقديم صورة مفيدة عن تطور لغة الطفل مقارنة بأقرانه.

[صفحة أصلية 302]

81. ما مدى صلاحية أدوات التحقيق الموحدة للأطفال ذوي الخلفيات اللغوية والثقافية المختلفة؟

قد تكون الاختبارات مفيدة، لكن يجب تفسيرها مع الوعي بمصادر الخطأ والقيود. فالحواجز اللغوية والتعليم السابق والخبرة الثقافية في حل المشكلات والألفة بالمهام قد تؤثر جميعًا في النتائج. ولذلك يجب استكمال الاختبارات بالملاحظات النوعية والمقابلات مع الأوصياء والمعلمين والطفل وملاحظات من بيانات متعددة.

[صفحة أصلية 402]

ويجب دائماً تفسير أداء الطفل في الاختبار في سياقه الحالي. وحتى إذا لم يعكس الاختبار كامل إمكانات الطفل في سياق آخر، فقد تكون النتيجة ذات صلة بأدائه في بيئته الحالية، وتتمتع بصلاحية عملية أو بيئية معينة.

المراجع

1. الجمعية الأمريكية للطب النفسي. الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية. الطبعة الخامسة، مراجعة النص؛ 2202. 2. L mörtslleH وآخرون. التعرض المتعدد للأذى لدى الأطفال ذوي الاضطرابات العصبية النمائية. 9102؛ 61(31):0822. 3. N recnepS وآخرون. الحالات المعطلة والتسجيل لإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم. scirtaideP. 5002؛ 611(3):906-316. 4. J namredeiB وآخرون. مؤشرات استمرار اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. 3102؛ 821(1):87-78. 5. snreK MC وآخرون. أحداث الطفولة الصادمة واضطراب طيف التوحد. 5102؛ 54(11):5743-6843. 6. N drofnuB وآخرون. اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وتنظيم المشاعر. 5102؛ 81(3):581-712. 7. DM silleB eD، RS sreeB. الوظيفة العصبية النفسية لدى الأطفال المصابين باضطراب DSTP المرتبط بسوء المعاملة. 2002؛ 951(3):384-684. 8. R gnissuB وآخرون. عوائق اكتشاف الأطفال ذوي أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. 3002؛ 03(2):671-981. 9. esuarK DE وآخرون. معالجة الصدمة المعقدة لدى الأطفال ذوي الاضطرابات العصبية النمائية. 8102؛ ص. 372-052. 01. JM nawoG-sggirB وآخرون. التعرض للأحداث التي قد تسبب الصدمة في الطفولة المبكرة. 0102؛ 32(6):527-337. 11. SA netsaM. السحر العادي: الصمود في النمو. نيويورك؛ 4102. 21. SS gnoW، GV noirraC. هل يمكن للإجهاد الصادم تغيير الدماغ؟ 2102؛ 15(2):32S-82S. 31. HM rehcieT وآخرون. آثار إساءة معاملة الطفولة في بنية الدماغ ووظيفته واتصاله. 6102؛ 71(01):256-666. 41. AS neerG وآخرون. القلق وفرط الاستجابة الحسية لدى الأطفال المصابين بطيف التوحد. 3102؛ 25(11):8511-2711. 51. etihW، AC yksfezaM. WS. تنظيم المشاعر في اضطراب طيف التوحد. 3102؛ 32(1):51-42.

61. JE yrorCcM وآخرون. البيولوجيا العصبية والوراثة لإساءة المعاملة والشدائد. 0102؛
 15(01):9701-5901. 71. HM rehcieT وآخرون. البيولوجيا العصبية النمائية لضغط الطفولة
 والصدمة. 2002؛ 52(2):793-624. 81. DM silleB eD وآخرون. علم الصدمات النمائي: نمو
 الدماغ. 9991؛ 54(01):1721-4821. 91. LJ nosnaH وآخرون. الإجهاد المبكر وتغيرات اتصال
 الحصين. 0102؛ 03(22):6647-2747. 02. N mahnettoT وآخرون. التربية المؤسسية الطويلة
 وحجم اللوزة الدماغية. 0102؛ 701(12):909-319. 12. SN pilihP وآخرون. انخفاض اتصال
 الشبكة الافتراضية في الاعتلال المرتبط بالصدمة. 3102؛ 32(1):42-23. 22. SR soonyP وآخرون.
 نموذج الاعتلال النفسي النمائي للإجهاد الصادم لدى الأطفال. 9991؛ 64(11):2451-4551. 32.
 rannuG، SB newEcM، HJ nosirroM. الدماغ تحت الضغط. 3102؛ 97(1):61-82. 42. WS segroP، M.
 K odeveuQ. البيولوجيا العصبية للإجهاد والنمو. 7002؛ 85(541-371). 52. نظرية تعدد المبهمات
 والاعتلال النفسي النمائي. نيويورك؛ 1102. 62. PT eniahcuaeB وآخرون. نظرية تعدد المبهمات
 والاعتلال النفسي النمائي. 7002؛ 47(2):471-481. 72. AK nilhguaLcM وآخرون. شدائد
 الطفولة والنمو العصبي. 4102؛ 74(875-195). 82. HM rehcieT وآخرون. إساءة معاملة الطفولة
 وانخفاض سماكة القشرة. 4002؛ 65(2):58-08. 92. S elttihW وآخرون. إساءة معاملة الطفولة
 ونمو الدماغ. 4102؛ 171(5):465-475. 03. M rettuR وآخرون. أنماط شبه توحدية بعد الحرمان
 المبكر الشديد. 9991؛ 04(4):735-945. 13. M rettuR وآخرون. استجابات الأطفال للحرمان
 المؤسسي العميق. 7002؛ 84(21):0021-7021. 23. MJ renpperK وآخرون. عدم الانتباه وفرط
 النشاط ومتلازمة الحرمان المؤسسي. 7002؛ 34(4):139-549. 33. DJ droF وآخرون. إساءة
 معاملة الأطفال وDSTP وأعراض DHDA. 0002؛ 5(3):502-712.

[صفحة أصلية 602]

43. SM agnireehcS وآخرون. العوامل المؤثرة في تشخيص DSTP لدى الأطفال. 6002؛
361(4):156-446. 53. PA echnirPeD وآخرون. الوظيفة التنفيذية والتعرض للصدمة. 9002؛
33(6):163-353. 63. JT recnepS وآخرون. اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة والاعتلال
المشترك. 7002؛ 23(6):136-246.

عُدِّبَ فِي طِفْلَتِهِ

[صفحة أصلية 702]

عُدِّبَ فِي طِفْلَتِهِ

[صفحة أصلية 802]

فرديناند غاروف هو حاصل على دكتوراه في علم النفس ومعالج نفسي. عمل في علم نفس الأزمات والصدمة في فنلندا وعلى المستوى الدولي. وأوفد للعمل في بلدان مثل الشيشان وأوغندا ونيبال وسيراليون والأردن. ويجري أبحاثاً في علم نفس الأزمات والصدمة.

رونك تامجيدي هي أخصائية نفسية مرخصة في مركز الصليب الأحمر السويدي لعلاج المتضررين من الحرب والناجين من التعذيب في أوبسالا، حيث تعمل في العلاج النفسي للأطفال والبالغين وفحوص إصابات التعذيب. وكانت مديرة مشروع «الأطفال الذين نجوا من التعذيب».

الفصل السابع العلاج المكثف للصدمة لدى الأطفال

أظهر العلاج المكثف للصدمة، الذي قد لا تتجاوز مدته خمسة أيام، في دراسات أجريت على البالغين أثراً مساوياً لأثر علاجات تستمر سنوات. فهل يناسب هذا البرنامج المرهق الأطفال الناجين من التعذيب؟

[صفحة أصلية 902]

رغم التقارير التي تفيد بزيادة تعذيب الأطفال (1)، وبأن الأطفال الذين يتعرضون للتعذيب معرضون لآثار ضارة خطيرة بوجه خاص (2، 3)، فإن الأطفال المتضررين من التعذيب، والأطفال المنتمين إلى جماعات تتعرض للتعذيب بدرجة أكبر، ممثلون تمثيلاً ناقصاً جداً في الأبحاث، بما في ذلك أبحاث العلاج النفسي (4-9). ولذلك توجد حاجة كبيرة إلى أبحاث تطور وتقيم علاج إصابات التعذيب لدى الأطفال، مثل علاج اضطراب الكرب التالي للصدمة (DSTP)، وهو تشخيص نفسي شائع بين الأشخاص المتضررين من التعذيب (10).

وتتزايد الأدلة على فعالية العلاجات المكثفة والقصيرة لـ DSTP لدى البالغين، بمن فيهم الناجون من التعذيب (11، 21)، ولدى الأطفال الأكبر سناً (31، 41). أما البحث المتعلق بالأطفال الأصغر سناً فلا يزال، حسب معرفة المؤلفين، محدوداً جداً. وعلى هذه الخلفية، طُوِّر برنامج علاجي مكثف، يتضمن مكونات من العلاج السلوكي المعرفي المركّز على الصدمة (TBC-FT)، واختُبر في مركز الصليب الأحمر السويدي لعلاج المتضررين من الحرب والناجين من التعذيب في أوبسالا.

الخلفية والأسس النظرية للعلاج المكثف للصدمة

ما العلاج المكثف للصدمة؟

يعني العلاج المكثف تقديم علاج نفسي قائم على الأدلة ثلاث جلسات على الأقل في الأسبوع، مما يتيح تنفيذ البروتوكولات القائمة على الأدلة خلال شهر أو أقل (61). وغالباً ما يُستكمل برنامج العلاج المكثف المركّز على الصدمة خلال 5-8 أيام، ويتكون عادة من جلستي علاج مركّزتين على الصدمة يوميًا. كما تُقدّم غالباً أنشطة بدنية وتنقيف نفسي يتلقى فيه الشخص معرفة عن الصدمة ومعلومات عن علاجها. ويجري كل ذلك في بيئة حساسة للصدمة، يحاول فيها العاملون بوعي إنشاء محيط آمن وقائم على الثقة والدعم للأشخاص الذين عاشوا أحداثاً صادمة (71، 81). وتوجد أيضاً أبحاث حول زيادة ضغط العلاج واختصاره أكثر (81، 91).

البحث والدليل

تُبَيَّنَت فعالية العلاجات المكثفة والقصيرة للصدمة في تخفيف أعراض DSTP والاكتئاب لدى البالغين والأطفال الأكبر سنًا على السواء (31، 41، 02، 12). وبخلاف العلاج المعتاد، يبدو أن الشكل المكثف يسهم في خفض الأعراض بسرعة أكبر (61)، وفي خفض معدل الانقطاع عن العلاج (31، 41، 22). كما ثبت أن هذه العلاجات تزيد الوصول إلى العلاج المتخصص، وتقلل العبء الزمني والمالي، وتوفر مرونة وخيارات أكبر للعيادات والأسر (32).

وعلاوة على ذلك، أظهرت الأبحاث أن العلاجات المكثفة والقصيرة تكون فعالة وآمنة أيضًا للأطفال ذوي الإعاقة الفكرية الخفيفة (71). كما ثبت أن علاجًا مكثفًا قصيرًا جدًا، أقل من أربع ساعات إجمالاً، قد يكون فعالاً للأطفال الذين يعانون من أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة نتيجة حدث صادم واحد (52).

ولا توجد حتى الآن دراسات منشورة عن العلاجات المكثفة والقصيرة للأطفال الأصغر سنًا. ويتطلب تنفيذ علاج كهذا تكييف أساليب العلاج القائمة للأطفال المصابين باضطراب الكرب التالي للصدمة مع الشكل المكثف للعلاج (71).

تحديد المشكلة والأسئلة البحثية

المشكلة

أثبت العلاج المكثف والقصير للصدمة فعاليته لدى البالغين والأطفال الأكبر سنًا المصابين باضطراب الكرب التالي للصدمة. وخلال الفترة 1202-3202، أُجريت دراسة تجريبية في مركز الصليب الأحمر السويدي لعلاج المتضررين من الحرب والناجين من التعذيب في أوبسالا، وأظهرت أن العلاج المكثف للصدمة كان مقبولاً وفعالاً بصورة أولية لدى البالغين الذين أصيبوا بالصدمة نتيجة التعذيب والحرب و/أو الفرار (21).

[صفحة أصلية 112]

ويقدم مركز العلاج الرعاية للأطفال الذين مروا بهذه التجارب أيضًا. وبما أنه لا توجد دراسات بحثية قُيِّمت حتى الآن أثر العلاجات المكثفة والقصيرة للصدمة لدى الأطفال الأصغر سنًا، فمن المفيد تطوير برنامج علاجي من هذا النوع وتقييمه في المركز. وقد نتيج دراسة تجريبية ناجحة نشر البرنامج في مراكز علاج أخرى داخل الصليب الأحمر السويدي ولدى جهات علاجية أخرى على المستويين الوطني والدولي. والأمل أن يسهم هذا العمل في نهاية المطاف في تخفيف معاناة مزيد من الأطفال.

الهدف والأسئلة البحثية

كان هدف الدراسة التجريبية تطوير برنامج علاجي مكثف للأطفال الذين يعانون اضطراب الكرب التالي للصدمة نتيجة التعذيب والحرب و/أو الفرار. وكانت أهداف الدراسة: • تقييم الصحة النفسية للأطفال قبل العلاج المكثف وأثناءه وبعده. • تقييم البرنامج بناءً على تجارب الأطفال وأفراد الأسرة. • تقييم البرنامج بناءً على قدرة مركز العلاج على تنظيم الرعاية.

التطوير والتكيف مع برنامج العلاج

الفئة المستهدفة ومعايير الإدراج

تتكون الفئة المستهدفة من الأطفال بين السابعة والثانية عشرة الذين أصيبوا بالصدمة نتيجة التعذيب والحرب و/أو الفرار، ويستوفون معايير تشخيص اضطراب الكرب التالي للصدمة وفق التصنيف الدولي للأمراض، الإصدار الحادي عشر (62). ويجب الحصول على موافقة ولي أمر الطفل، كما يجب أن يشارك في العلاج مقدم رعاية مناسب للطفل، ويفضل أن يكون ولي الأمر إن أمكن.

ويقيم المعالج المسؤول ملائمة مقدم الرعاية بالتشاور مع فريق العلاج، من حيث قدرة البالغ على المشاركة ودعم الطفل أثناء العلاج. وليس من غير المعتاد أن يكون مقدمو الرعاية لهذه الفئة أنفسهم مصابين بالصدمة؛ ولا يستبعد ذلك المشاركة في حد ذاته، لكن يُقِيم الملاءمة في ضوء مشكلاتهم النفسية المحتملة.

[صفحة أصلية 212]

وتشمل معايير الاستبعاد خطر الانتحار المرتفع أو مشكلة إدمان نشطة لدى الطفل أو مقدم الرعاية المشارك. كما يُستبعد من تسبب عمدًا في الأحداث التي أصابت الطفل بالصدمة، أو أظهر سلوكًا سلبيًا خطيرًا تجاه الطفل لا يُتوقع أن ينخفض أو يتوقف قبل العلاج أو أثناءه.

مكونات العلاج السلوكي المعرفي المركز على الصدمة

يقوم البرنامج المكثف على مكونات من العلاج السلوكي المعرفي المركز على الصدمة (TBC-FT)، وهو أسلوب علاجي للأطفال من 3 إلى 71 عامًا المصابين باضطراب الكرب التالي للصدمة ومشكلات مرتبطة بالصدمة. ويشمل الأسلوب مقدمي رعاية الطفل ومكونات تزيد قدرتهم على دعمه (51).

ويتمتع TBC-FT بدعم بحثي قوي (72)، ويوصى به خيارًا أول لعلاج اضطراب الكرب التالي للصدمة لدى الأطفال في الإرشادات الوطنية والدولية (82، 92). ويعتمد أساسًا على الأساليب السلوكية والمعرفية، ويُقسم عادة إلى ثلاث مراحل: التثبيت والمعالجة والتكامل، وتشمل المراحل مجتمعة تسعة مكونات.

والهدف مساعدة الطفل ومقدم الرعاية على الاقتراب من ذكريات الطفل الصادمة بطرق جديدة توفر خبرة ومعرفة جديدتين، بما يؤدي إلى خفض أعراض DSTP وزيادة الأداء اليومي وتقوية علاقات الطفل، ولا سيما مع مقدمي الرعاية (51).

دور مقدمي الرعاية المهم في العلاج

توجد اليوم معرفة وخبرة واسعة بالأهمية الفورية والحاسمة لبيئة الرعاية في فرص تعافي الطفل بعد التجارب الصعبة والمخيفة (03). وقد يسهل دعم مقدمي الرعاية تعافي الطفل أو يعيقه.

[صفحة أصلية 312]

وتظهر الأبحاث أن مشاركة مقدمي الرعاية وقدرتهم على دعم أطفالهم أثناء TBC-FT تؤثر في فعالية العلاج وسرعة تحقيقه واستمراره مع مرور الوقت، وفي احتمال انقطاعه مبكرًا (51). كما أن المرض النفسي الشديد لدى مقدمي الرعاية قد يؤدي إلى نتائج علاجية أسوأ للطفل (52).

وقد وجهت معرفة أهمية مقدم الرعاية لاستجابة الطفل لعلاج الصدمة تصميم العلاج المكثف للأطفال في مركز أوبسالا. ومن أمثلة ذلك معايير الاستبعاد التي تسهل اختيار المشاركين المناسبين، ومحتوى العلاج المكثف الذي يتضمن دعمًا كبيرًا لمقدم الرعاية، بما ينسجم مع دراسات العلاج المكثف للأطفال الأكبر سنًا (31، 02).

برنامج العلاج: العملية والهيكل

يُنفذ البرنامج في مركز الصليب الأحمر السويدي لعلاج المتضررين من الحرب والناجين من التعذيب في أوبسالا.

التقييم والتحضيرات

يسبق العلاج المكثف تقييم ملاءمة الطفل ومقدم الرعاية للمشاركة. ثم تُجرى زيارات تحضيرية يكيّف تكرارها ومدتها وفق احتياجاتهما. وتركز المحادثات على أخذ التاريخ، وتقييم المشكلات النفسية، والحصول على الموافقة المستنيرة من ولي الأمر، وتقييم مشاركة الطفل والوالد وفق معايير الإدراج والاستبعاد.

[صفحة أصلية 412]

وبعد اتخاذ قرار مشترك بالمشاركة، تبدأ التحضيرات. ويملأ الطفل ومقدم الرعاية استمارات التقييم، وتُحدد ذكريات الطفل الصادمة، ويقمّم الطفل الانزعاج الذي تثيره على مقياس وحدات الضيق الذاتية من صفر إلى عشرة. وأخيرًا يحصلان على تنقيف نفسي موجز عن الصدمة وDSTP، ودعم في إيجاد تقنية لتنظيم المشاعر والتدرب عليها.

هيكل العلاج

يستمر العلاج خمسة أيام عمل متتالية: من الاثنين إلى الخميس 00:01-54:41، والجمعة 00:01-00:41. وتضاف جلسات تحضيرية ومتابعة قبل أسبوع العلاج وبعده. ويتكون كل يوم، باستثناء الجمعة، من سبع جلسات: ثلاث مشتركة وأربع فردية للطفل ومقدم الرعاية. ويشارك كل منهما في خمس جلسات يوميًا. وجميع جلسات الجمعة مشتركة.

وتُنقل المعلومات السريرية ذات الصلة باستمرار بين المعالجين المشاركين. ويشمل العلاج ما يسمى تدوير المعالجين، أي أن عدة معالجين يشاركون في علاج الطفل ومقدم الرعاية خلال الأسبوع.

جلسات العلاج

الشكل 1: برنامج العلاج

- يبدأ كل يوم بجلسة مشتركة لمراجعة حال الطفل ومقدم الرعاية وتقديم التنقيف والدعم عند الحاجة، مع قائمة تحقق قصيرة لرصد الآثار السلبية المحتملة.
- بعد استراحة، تُجرى جلسة فردية للطفل لإنشاء السرد الصادم، وأخرى لمقدم الرعاية لتعلم مهارات الرعاية.
- بعد استراحة تعقد جلسة مشتركة تتضمن التنقيف النفسي والاسترخاء والمشاعر والتعرض في الحياة الواقعية.

[صفحة أصلية 512]

- بعد استراحة الغداء تعقد جلسات فردية أخرى، ويواصل الطفل العمل على السرد الصادم، وتُقدّم وحدة الأفكار.
- يعمل مقدم الرعاية بالتوازي على السرد الصادم ويتلقى دعمًا للاستعداد لليوم الأخير عندما يشارك الطفل قصته.
- ينتهي اليوم بنشاط مشترك ممتع يقوي العلاقة، مثل الرسم أو الغناء أو التمارين الجسدية واللمس الآمن.
- يبدأ اليوم الأخير بجلسة مشتركة وتقييمات فردية عند الحاجة، ثم يشارك الطفل سرده الصادم مع مقدم الرعاية.

ويُختتم العلاج بحفل للاحتفاء بعمل الطفل، مع مشروبات ووجبات خفيفة وشهادة يأخذها الطفل معه.

المتابعات

في الأسبوع التالي لانتهاء العلاج، يُدعى الطفل ومقدم الرعاية إلى متابعة أولى لمراجعة حالتها واحتياجات الدعم حتى المتابعة التالية بعد أسبوعين. وتُجرى قياسات الدراسة بعد أسبوعين وستة أسابيع من انتهاء العلاج، كما تُجرى مقابلة عن تجارب المشاركين.

[صفحة أصلية 612]

تكييفات العلاج السلوكي المعرفي المركز على الصدمة مع الشكل المكثف

رغم الطموح إلى تطوير العلاج المكثف بما يقترب قدر الإمكان من TBC-FT، كانت بعض التعديلات ضرورية لاختصار العلاج وتكثيفه. وفي الوقت نفسه، تُعد المرونة وقابلية التكيف من القيم الأساسية في TBC-FT، مما يبرر بعض التعديلات اللازمة لتكييف الطريقة مع ظروف واحتياجات الفئة المستهدفة.

تعلقت التعديلات بترتيب مكونات العلاج؛ فقد جرى تجاوز تقسيم المراحل، أي التثبيت ثم المعالجة والتكامل، لتعمل المكونات بالتوازي خلال أسبوع العلاج. كما نُفذت بعض المكونات التي تقدم عادة بصورة فردية، مثل مكونات مرحلة التثبيت، بصورة مشتركة مع الطفل ومقدم الرعاية. وُمجّ مكون الأفكار مع جلسة بعد الظهر التي يُعالج فيها السرد، لأن محتوى المكونات مترابط، ولأن الدمج أتاح إدراج التعرض في الحياة الواقعية خلال أسبوع العلاج.

وأخيرًا، لم يُدرج مكون المستقبل والأمان في الجدول، ويمكن تنفيذه بعد أسبوع العلاج أو في اليوم الأخير إذا سمح الوقت.

[صفحة أصلية 712]

ويتمثل الفرق الكبير بين العلاج المكثف وTBC-FT التقليدي في تدوير المعالجين. فإلى جانب المعالج المسؤول، يلتقي الطفل ومقدم الرعاية عدة معالجين خلال أيام العلاج الخمسة. ويهدف ذلك أساساً إلى تخفيف العبء عن المعالجين اللذين كانا سينفذان جميع الجلسات، كما يزيد احتمال استمرار العلاج رغم مرض أحد المعالجين أو غيابه. وذكر بالغون خضعوا لهذا النوع من العلاج مزايا إضافية، منها تعدد العلاقات القائمة على الثقة، وزيادة دعم المعالجين، وتوافر وجهات نظر متعددة، وتقليل الاعتماد على معالج واحد، وتقليل مشاعر العار (21، 13).

تنفيذ البرنامج وتقييمه

جمع البيانات وأدوات القياس

تُقيم فعالية البرنامج بمقاييس تقيس أعراض DSTP وأعراض الاعتلال النفسي الأخرى لدى الأطفال قبل العلاج المكثف وأثناءه وبعده. وتُجرى مقابلات شبه منظمة بعد العلاج، مع تقييمات يومية أقل شمولاً. وتتوافر مقاييس التقرير الذاتي بالسويدية، وثملاً بمساعدة مترجم عند الحاجة. ويحضر المعالج المسؤول عند ملء المقاييس لمساعدة المشاركين.

[صفحة أصلية 812]

يجمع المعالجون معلومات الخلفية عن الأطفال ومقدمي الرعاية من مقابلات التقييم الأولى في مركز أوبسالا، ومن الملفات، وتُستكمل أثناء الزيارات التحضيرية. وتُقيّم الخبرات والمشكلات المرتبطة بالصدمة في بداية العملية لمعرفة ما إذا كان الطفل يستوفي تشخيص DSTP ويحتاج إلى العلاج.

مقاييس الأطفال

يُعد مقياس صدمة الأطفال والمراهقين 2 (2-STAC) أداة قصيرة لأعراض DSTP وفق 5-MSD و11-DCI ولأعراض DSTP المعقد لدى الأطفال بين 7 و71 عامًا. ويتضمن أسئلة عن الأحداث التي قد تسبب الصدمة وفق تعريفات 5-MSD و11-DCI.

ويستخدم المعالجون أيضًا قائمة تحقق صباحية لتوثيق الآثار السلبية المحتملة، مثل زيادة إيذاء الذات أو الانتحارية أو الحاجة إلى رعاية نفسية حادة. كما يستخدمون وحدات الضيق الذاتية (DUS)، حيث يقيم الطفل انزعاجه قبل العمل على السرد الصادم وأثناءه وبعده، من صفر إلى عشرة.

[صفحة أصلية 912]

مقاييس مقدمي الرعاية

يقيس استبيان نقاط القوة والصعوبات (QDS) سلوك الطفل ورفاهه وتأثر حياته بالأعراض والصعوبات. وقد تُرجم إلى السويدية. ويقيس استبيان القبول والفعل (II-QAA) التجنب العاطفي والمرونة النفسية، وقد تُرجم واختُصر إلى ستة أسئلة.

مقاييس المعالجين

يملأ المعالجون نموذجًا عن الجنس والمهنة والتعليم، ولا سيما التدريب السابق في TBC-FT، والخبرة السابقة في تنفيذه. كما تُستخدم مقاييس قبول التدخل وملاءمته وجدواه (MIA و MAI و MIF)، وقد دُمجت في أداة من 21 سؤالاً.

المقابلات النوعية

تُجمع البيانات النوعية عن عملية العلاج من مقابلات المشاركين والمعالجين، بهدف وضع توصيات لتنفيذ العلاج المكثف للفئة المستهدفة (93). وتُستكشف المقابلات عناصر البرنامج التي عُدّها الأطفال ومقدمو الرعاية مفيدة أو غير مفيدة، والأحداث الحياتية التي قد تكون أثّرت في العملية (04). كما أُعد دليل لمناقشة جماعية يُستكشف عناصر البرنامج من وجهة نظر المعالجين.

تحليل البيانات

لتقييم تغيير الأعراض على مستوى المجموعة، يُحلل حجم الأثر داخل المجموعة (14). وتُقيّم التغييرات المهمة سريريًا على مستوى الفرد باستخدام مؤشر التغيير الموثوق (24، 34)، ويُستخدم التحليل الموضوعي لتحليل المقابلات المسجلة (44).

الاعتبارات الأخلاقية

تتطوي تجربة برنامج علاجي جديد على مخاطر محتملة: • قد يؤدي الطابع المكثف، مع الجلسات اليومية خمسة أيام متتالية، إلى ضغط عاطفي وتعب للأطفال ومقدمي الرعاية. • قد يؤدي العلاج الموجه للصدمة، ولا سيما في مدة مضغوطة، إلى زيادة مؤقتة في أعراض DSTP عند مواجهة التجارب الصادمة ومعالجتها، لكن لا توجد علاقة بين الزيادة المؤقتة وانقطاع العلاج أو سوء النتائج. • قد يؤدي الشكل المكثف الجديد إلى نتائج سلبية غير متوقعة، رغم اتباع البروتوكول المعايير القائمة، لكن الحالات الموثقة لتفاقم الأعراض بعد العلاج قليلة جدًا.

[صفحة أصلية 122]

وقد تفيد المشاركة أيضًا، إذ يُتوقع تحسن الصحة النفسية، وخفض الأعراض بسرعة أكبر من العلاج المعتاد، وتعميق المشاركة وتسريع العملية العلاجية، وتقليل العبء على الحياة اليومية. كما يشارك مقدمو الرعاية في العلاج ويثقفون التثقيف النفسي والدعم والمهارات، مما قد يعزز ثقتهم ويحسن ديناميات الأسرة. ويسهم المشاركون في تطوير المعرفة بالعلاج المكثف للأطفال.

وتشمل تدابير تقليل المخاطر كفاءة المعالجين، والفحص والتقييم الشاملين، واعتماد TBC-FT وبروتوكولاته القائمة على الأدلة، وتعيين معالج مسؤول يدعم المشارك طوال الدراسة، وإتاحة علاج إضافي وفق البروتوكولات إذا استمرت المشكلات.

وتحاول الدراسة سد فجوة معرفية مهمة بشأن فعالية العلاج المكثف للأطفال المصابين بـ DSTP ذوي تجارب التعذيب والحرب والفرار، وهي فئة قد تعيش الفقر وعدم الاستقرار وغياب الأوراق وخطر الترحيل. وقد تجعل هذه الظروف العلاج التقليدي أقل توافقًا ونجاحًا، ولذلك قد تكون نتائج الدراسة مهمة لتحسين خيارات العلاج.

[صفحة أصلية 222]

مانويل: دراسة حالة

لتوضيح البرنامج نعرض حالة مريض مجهول الهوية نسميه مانويل. وهو طفل في سن المدرسة مصاب بـ DSTP، وكان مع والده من أوائل من خضعوا للعلاج في المركز. وتظهر النتائج أن العلاج حقق الأثر المنشود.

التقييم والتحضير

التقى المعالج المسؤول مانويل ووالده ثلاث مرات، بمجموع 003 دقيقة، بصورة مشتركة وفردية. بدأ مانويل مهذباً ومتحفظاً ثم أصبح أكثر استرخاءً ومبادرة. وقُيِّمَ على أنه يستوفي تشخيص DSTP المرتبط بخمس ذكريات صادمة اختيرت للمعالجة. وقُيِّمَ انزعاجه منها بين 9 و01 من عشرة. وفي الأسبوع السابق تلقى هو ووالده تثقيفاً نفسياً عن الصدمة وDSTP، وتدرّبا على التنفس العميق.

[صفحة أصلية 322]

العلاج

تلقى مانويل ووالده العلاج وفق البرنامج المكثف، وكانت المحادثات مع مانويل بالسويدية ومع والده بمساعدة مترجم.

في اليوم الأول كان مانويل قلقاً ولم يرغب في بدء العلاج، لكنه وافق بعد تشجيع والده وتذكيره بأنه يستطيع تغيير رأيه. والتقى المعالجين المشاركين في لعبة للتعارف. أنشأ في الصباح أول سرد صادم، وعمل عليه بعد الظهر. احتاج إلى أسئلة للبدء، ثم تذكر تفاصيل أكثر، وارتفع DUS أثناء العمل. وصاغ أسئلة أراد طرحها على والده، بينما عمل الأب على القلق والقبول والرعاية الذاتية. وفي نهاية اليوم أراد الاثنان العودة.

[صفحة أصلية 422]

في اليوم الثاني كان مانويل متوترًا مساءً، لكنه ذهب بسهولة إلى المركز صباحًا. وصاغ أسئلة عن ذاكرة اليوم وتدرَّب على التعبير عن احتياجاته. واطلع والده على السرد والأسئلة، وتلقَّى دعمًا للرد وفق قيمه واحتياجات مانويل ومهارات التربية في TBC-FT. وارتفع DUS أثناء العمل، كما حدث في اليوم الأول.

في اليوم الثالث تحسن النوم، وبدأ مانويل يسأل والده بنفسه عن تاريخ الأسرة، وهو موضوع كان يتجنبه. وانخفض DUS في نهاية العمل مقارنة بالبداية. وفي اليوم الرابع كان قلقًا بسبب نزاع أسري، لكن DUS انخفض أثناء معالجة ذكرى جديدة، وقال إن الشعور الصعب في معدته أصبح أقل وأنه ليس خطيرًا. وفي اليوم الخامس شارك مانويل قصته مع والده، الذي استمع وأكد تجاربه ومدح شجاعته. واختتم الأسبوع بحفل وشهادة.

[صفحة أصلية 522]

المتابعة والنتائج

بعد خمسة أيام كانت عطلة نهاية الأسبوع هادئة، ولم تزد الأعراض. وأفاد مانويل ووالده بتجربة إيجابية عمومًا. قال مانويل إن الحديث عن الذكريات جعل التفكير فيها أقل ألمًا، وإن العلاج كان متعبًا لكنه لا يتمنى أن يكون أقصر. كما أراد معرفة موضوعات الجلسات مسبقًا ولقاء جميع المعالجين.

[صفحة أصلية 622]

وفي جميع المتابعات أبلغ الاثنان عن انخفاض مخاوف مانويل، وقدرته على مواجهة مواقف كان يتجنبها، مثل السباحة والاتصال بأشخاص جدد والحديث عن الأمور الصعبة. ورأى الأب أن مانويل أصبح أقل توترًا وأن العلاقة بينهما تحسنت. كما ذكر مانويل أن والده أصبح أقل حزنًا وأنه يفهم مشاعره بصورة أفضل.

[صفحة أصلية 722]

القياسات

توضح الأشكال التالية نتائج استمارات مانويل ووالده قبل العلاج بأربعة أسابيع إلى ثلاثة أيام (1T)، وبعد أسبوعين (2T) وستة أسابيع (3T). حصل مانويل على 14 نقطة في مقياس STAC عند 1T، ثم 31 و 11 عند 2T و 3T، أي دون حد الضغط التالي للصدمة. وحصل والده على 33 عند 1T ثم 5 و 8، وهما أيضاً دون الحد.

وفي QDS، الذي ملأه الأب، انخفضت النتيجة من 42 إلى 31 ثم 21، مع تحسن واضح في فرط النشاط والتركيز والمشاعر. وفي QAA انخفضت النتيجة من 04 إلى 22 ثم 62، مما يشير إلى زيادة القبول والمرونة النفسية.

التوصيات والمنظور المستقبلي

دروس الدراسة التجريبية

رغم أن العلاج المكثف والقصير للأطفال المصابين بـ DSTP قُيِّمَ على أساس محدود جدًا، أظهرت النتائج أثرًا مرغوبًا في حالة مانويل. فبعد العلاج لم يعد يستوفي تشخيص DSTP، وأبلغ هو ووالده عن فوائد عدة، ولا سيما تقوية العلاقة.

وربما أسهمت كثافة العلاج في تسريع هذه العمليات، إذ أتاحت تدريبًا متكررًا على المهارات، ومساعدة مبكرة ومتكررة على كسر التجنب المرتبط بالصدمة، ووقتًا مشتركًا للحديث عن موضوعات صعبة كانت تُتجنب سابقًا.

[صفحة أصلية 922]

كما زادت كثافة العلاج توافر المعالجين للمشاركين أثناء العلاج، وأتاحت متابعة العملية عن قرب وتلبية احتياجات الدعم مباشرة. ومن الأمثلة دعم مانويل في صياغة أسئلة لوالده ودعم الأب في كيفية الرد عليها، ثم تجربة ذلك وتقييمه وإعادة النظر فيه خلال الأسبوع.

وأنشأ العلاج على الأرجح مساحة مشتركة لمحادثات مانويل ووالده اللاحقة. ورغم ظهور ضغوط جديدة في الأسرة، ذكر كلاهما أن مشاركة الصعوبات أصبحت أسهل.

التحديات

ينطوي اختبار وتنفيذ برامج علاجية جديدة على تحديات للمعالجين والمؤسسة. ومن ذلك إشراك الطفل ومقدم الرعاية معاً بدل مشارك بالغ واحد، والحاجة إلى عمليات نقل معلومات أكثر، ومتطلبات أعلى للتخطيط والبنية والتعاون.

[صفحة أصلية 032]

ومن التحديات أيضًا تكيف الطرق العلاجية المعروفة مع أشكال جديدة دون التضحية بالآثر المثبت للطريقة. ولذلك ينبغي موازنة هذه الجوانب وتقييمها في الأبحاث المستقبلية.

البحث والتطوير مستقبلاً

يمكن للأبحاث المستقبلية تقييم ما إذا كانت فوائد الشكل المكثف أكبر من العواقب السلبية لتعديل طريقة قائمة على الأدلة مثل TBC-FT، ومقارنة ذلك بالعلاج المعتاد وبمجموعات الأطفال المختلفة المصابين بـ DSTP.

وقد تكون النتائج ذات صلة بأطفال أصيبوا بالصدمة بسبب أحداث أخرى، مما يوسع الفائدة غير المباشرة للبحث. كما يهدف العمل إلى التعاون مع مراكز علاج عدة، بما قد يؤدي إلى تطبيق البرامج المكثفة على نطاق أوسع إذا ثبتت فعاليتها وقبولها.

المراجع

1. مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. اتجاه مقلق يظهر زيادة عدد الأطفال ضحايا التعذيب. جنيف؛ 6102. 2. BM wolnE وآخرون. التعرض للصدمة الشخصية والنمو المعرفي لدى الأطفال حتى سن الثامنة: دراسة طولية. 2102؛ 5001:66-2101. 3. EJ zednéM. تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب. جنيف: الأمم المتحدة؛ 5102. 4. JJ rettO ned وآخرون. توثيق تعذيب الأطفال والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 3102؛ 72:422-23. 5. N letaP وآخرون. التدخلات النفسية والاجتماعية والصحية لضحايا التعذيب. 4102؛ 713900DC. 6. P selaS-zeréP. توثيق التعذيب لدى الأطفال والشباب. 9102؛ 92:1-51. 7. NC esoB ، R idijdmaT. الأطفال الذين نجوا من التعذيب: مراجعة منهجية. ستوكهولم؛ 3202. 8. E ffohpU وآخرون. تعزيز الصحة النفسية والوقاية والعلاج للاجئين وطالبي اللجوء. 0202؛ 854310DC. 9. EM uleV وآخرون. فعالية العلاجات المركزة على الصدمة للأطفال اللاجئين. 5202؛ 61:2634942. 01. Z leetS وآخرون. التعذيب والأحداث الصادمة والنتائج النفسية لدى السكان المتضررين من النزاع والنزوح. 9002؛ 203:735-945.

11. P dleH، SJ nehcaW. تقديم مكثف للعلاجات المعرفية السلوكية. 3202؛ 03:113-313.
21. P göhgniT وآخرون. قبول وأثار أولية لعلاج مكثف قصير للصدمة لدى اللاجئين. 4202؛ 36-45:43.
31. ME knitneR وآخرون. فعالية برنامج علاجي مكثف يجمع التعرض المطول و RDME للمراهقين والشباب المصابين بـ DSTP. 5202؛ 61:8741542. 41. Y tleP nav وآخرون. فعالية برنامج مكثف يجمع التعرض المطول و RDME للمراهقين. 1202؛ 21:6787191. 51.
- AJ nehoC وآخرون. علاج الصدمة والحزن الصادم لدى الأطفال والمراهقين. الطبعة الثانية؛ 7102.
61. SJ nehcaW، P dleH. أسئلة رئيسية لتشكيل البحث المستقبلي وتنفيذ العلاجات المكثفة. 3202؛ 024-714:03.
71. M srevE-smoO وآخرون. علاج سريري مكثف للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة الفكرية الخفيفة. 1202؛ 711:030401. 81. VC grebneduoW وآخرون. فعالية برنامج مكثف يجمع التعرض المطول وإزالة التحسس بحركة العينين وإعادة المعالجة. 8102؛ 9:5227841.
91. JS namderF وآخرون. علاج جماعي مكثف متعدد الأزواج لاضطراب DSTP. 0202؛ 15:417-007. 02. MM dlevretseW وآخرون. فعالية العلاج المكثف القصير للمراهقين ومقدمي الرعاية. 5202؛ 41:51166e.

[صفحة أصلية 332]

12. I gnilessjiT وآخرون. فعالية وتحمل برنامج علاج صدمة مكثف للمراهقين المصابين بـ DSTP. 4202؛ 86:81-18. 22. SJ nehcaW وآخرون. تكييف الإطار الزمني للعلاجات القائمة على الأدلة لـ DSTP. 9102؛ 6:701-811. 32. I xuaetlaC وآخرون. العلاج السلوكي المعرفي القصير والتكيف العلمي للأطفال والشباب. 4202؛ 13:94-27. 42. ME knodnerooV وآخرون. نتائج العلاج المركز على الصدمة لدى مرضى DSTP المعقد. 0202؛ 11:5593871. 52. C sooR ed وآخرون. مؤشرات ومعدلات نتائج العلاج لـ DSTP لدى الأطفال بعد حادث منفرد. 1202؛ 21:8318691. 62. منظمة الصحة العالمية. التصنيف الدولي للأمراض، الإصدار الحادي عشر. جنيف؛ 2202. 72. BFJ nnameleihT وآخرون. مراجعة منهجية وتحليل تلوي لـ TBC-FT للأطفال والمراهقين. 2202؛ 431:998501. 82. هيئة الصحة والرعاية الاجتماعية. المبادئ التوجيهية الوطنية للاكتئاب واضطرابات القلق. ستوكهولم؛ 1202. 92. echnaillA enilediuG lanoitaN. مراجعات الأدلة للتدخلات النفسية والاجتماعية وغير الدوائية للوقاية من DSTP لدى الأطفال. لندن؛ 8102.

[صفحة أصلية 432]

03. JE nworB وآخرون. العلاج السلوكي المعرفي المركز على الصدمة: دور مقدمي الرعاية. 0202؛ 772:93-54. 13. H dnulÖ، M namrednA. تجارب المرضى مع تدوير المعالجين في العلاج المكثف المركز على الصدمة. أوميو؛ 3202. 23. C reshcaS وآخرون. التحقق من مقياس صدمة الأطفال والمراهقين 2 (2-STAC). 2202؛ 0855012:31. 33. M gnaY وآخرون. فائدة المقاييس النفسية الفيزيولوجية في توجيه علاج أعراض الصدمة. 1202؛ 662-942:13. 43. J eploW. ممارسة العلاج السلوكي. نيويورك؛ 3791. 53. TW htoR، PS rrO. التقييم النفسي الفيزيولوجي: تطبيقات سريرية لـ DSTP. 0002؛ 042-522:16. 63. R namdooG. استبيان نقاط القوة والصعوبات: ملاحظة بحثية. 7991؛ 685-185:83.

73. WF dnoB وآخرون. الخصائص السيكموترية الأولية لاستيتيان القبول والفعل الثاني. 1102؛ 886-676:24 JB renieW وآخرون. التقييم السيكموترى لثلاثة مقاييس لنتائج تنفيذ التدخلات. 801:21؛ 93 HI neseroH وآخرون. العلاج الخارجى المكثف لاضطراب DSTP: تحليل موضوعى لتجربة المريض. 2202؛ 9363402:31. 04 R ttoillE. أبحاث تجارب العملاء للعلاج 8002؛ 242-932:81 BS sirroM، PR nohSeD. دمج تقديرات حجم الأثر فى التحليل التلوي. 2002؛ 521-501:7. 24 P xaurT، SN nosbocaJ. الأهمية السريرية: نهج إحصائي لتحديد التغير المهم فى أبحاث العلاج النفسى. 1991؛ 91-21:95. 34 M treploW وآخرون. مقارنة مؤشرات التغير المهم سريريا فى خدمات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين. 5102؛ 101-49:02. 44. 101-77:3. 6002. استخدام التحليل الموضوعى فى علم النفس. 101-77:3. 6002. V ekralC، V nuarB.

[صفحة أصلية 632]

الصليب الأحمر السويدي

يوجد الصليب الأحمر في 191 بلدًا لمساعدة الناس في الأزمات والكوارث. وفي السويد نعمل في جميع أنحاء البلاد، ونحن أكبر منظمة إنسانية تطوعية، مع أكثر من 005,81 متطوع في 682 جمعية محلية.

ومن مجالاتنا ذات الأولوية الصحة والرعاية. نعمل من أجل الحق في صحة جيدة ومتساوية، ونقدم الرعاية الصحية وأنشطة الرفاه والدعم النفسي الاجتماعي الذي يساعد الناس على عيش حياة يومية ذات معنى. ومن الأجزاء المهمة في هذا العمل مؤسسات الرعاية المتخصصة للمتضررين من الحرب والناجين من التعذيب، وخدمة إحالة الرعاية للأشخاص الذين لا يحملون أوراقًا والمهاجرين.

مركز الصليب الأحمر لإعادة تأهيل المصابين بالتعذيب والحرب

المركز تعاون بين الصليب الأحمر السويدي والمدرسة العليا للصليب الأحمر، ويهدف إلى تطوير علاج صدمات أفضل للأشخاص المتضررين من التعذيب والحرب.

[صفحة أصلية 732]

المدرسة العليا للصليب الأحمر

تتمثل سمة المدرسة الفريدة في التعليم والبحث والتعاون في التمريض والصحة من منظور عالمي، مع وضع الإنسان في المركز والانفتاح على العالم. وتستند المدرسة إلى تقليد طويل، إذ أعدت منذ عام 7681 ممرضين ذوي تقدير عالٍ.

عُدِّبَ فِي طِفْلَتِهِ

[صفحة أصلية 832]